“十三五”国家重点出版物出版规划项目
国家自然科学基金重大项目

应对老龄社会的基础科学问题研究丛书

主编　彭希哲

中国老龄社会的治理与政策选择

彭希哲　胡湛　朱勤　敬乂嘉　等/著

科学出版社
龍門書局

(C-0050.01)

应对老龄社会的基础科学问题研究丛书

中国老龄社会的治理与政策选择

www.sciencep.com

ISBN 978-7-5088-5876-0

9 787508 858760 >

定 价：128.00 元

科学出版社互联网入口
经管分社：(010)64012800 销售：(010)64031535
E-mail：jingguanfa@mail.sciencep.com

“十三五”国家重点出版物出版规划项目
国家自然科学基金重大项目

应对老龄社会的基础科学问题研究丛书

主编　彭希哲

中国老龄社会的治理与政策选择

彭希哲　胡　湛　朱　勤　敬乂嘉　等/著

科学出版社
龍門書局
北京

内 容 简 介

本书是国家自然科学基金重大项目的集体研究成果。随着人口老龄化成为中国社会的常态，它带来的所谓挑战主要源自变化的人口年龄结构与现有社会经济架构之间不匹配所产生的矛盾，这使治理模式与公共政策的调整乃至重构成为必须。本书由此从治理及政策安排的视角出发重新审视中国人口老龄化态势，进而在剖析现有治理研究囿限的基础上论述了老龄社会治理思路转型的必要性，分析了多元治理主体的作用机制，以此为基础探讨了老龄社会的政府角色、家庭政策、社区服务、长期照护体系、就业与消费变迁、区域协调机制等议题，并对具体的战略部署要点及可能的政策选择进行了系统阐述。

本书适合中国老龄社会研究领域的学者、大学和专科学校师生、政府官员和社会公众阅读参考。

图书在版编目（CIP）数据

中国老龄社会的治理与政策选择 / 彭希哲等著. —北京：龙门书局，2021.8

（应对老龄社会的基础科学问题研究丛书 / 彭希哲主编）

“十三五”国家重点出版物出版规划项目　国家出版基金项目　国家自然科学基金重大项目

ISBN 978-7-5088-5876-0

Ⅰ. ①中… Ⅱ. ①彭… Ⅲ. ①人口老龄化-社会管理-研究-中国 ②老年人-社会政策-研究-中国 Ⅳ. ①C924.24 ②D669.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2020）第 228879 号

责任编辑：魏如萍　陈会迎 / 责任校对：贾娜娜

责任印制：霍　兵 / 封面设计：无极书装

科学出版社
龙门书局　出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码：100717
http://www.sciencep.com

三河市春园印刷有限公司　印刷

科学出版社发行　各地新华书店经销

*

2021 年 8 月第　一　版　开本：720×1000　1/16

2021 年 8 月第一次印刷　印张：12 3/4

字数：260 000

定价：128.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

丛书编委会

主　编：彭希哲

副主编：（以姓氏笔画为序）

左学金　何文炯　曾　毅　翟振武

编　委：（以姓氏笔画为序）

于景元　左学金　李树茁　李善同

杨　泽　吴开亚　何文炯　汪寿阳

胡　湛　彭希哲　辜胜阻　曾　毅

翟振武

作 者 名 单

（依章节顺序排列）

彭希哲　复旦大学人口与发展政策研究中心，教授
胡　湛　复旦大学老龄研究院，教授
郭德君　重庆医科大学医学人文研究中心，教授
敬乂嘉　复旦大学全球公共政策研究院，教授
邵洲洲　上海第二工业大学经济与管理学院，讲师
吴开亚　复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地，研究员
高俊岭　复旦大学公共卫生学院，副教授
朱　勤　复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地，研究员
周新宏　复旦大学人口与发展政策研究中心，博士
苏忠鑫　复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地，助理研究员
宋靓珺　复旦发展研究院，助理研究员
王雪辉　复旦大学社会发展与公共政策学院，青年副研究员
彭　聪　上海社会科学院社会学研究所，助理研究员
龚　遥　复旦大学社会发展与公共政策学院，博士研究生
乐　昕　复旦大学马克思主义学院，副教授
郭　静　复旦大学社会发展与公共政策学院，硕士研究生

主要作者简介

彭希哲，英国伦敦政治经济学院人口学博士、复旦大学文科资深教授。复旦大学人口与发展政策研究中心主任、复旦发展研究院常务副院长、复旦大学社会发展与公共政策学院首任院长。曾任中国人口学会副会长、上海市社会科学界联合会副主席、上海人口学会会长、原国家卫生和计划生育委员会公共政策专家咨询委员会委员等。长期在中国人口动态与老龄化、人口与可持续发展、社会性别平等与反贫困、户籍制度改革、人口流动与劳动就业等相关领域从事教学科研和决策咨询工作。1992 年开始享受国务院政府特殊津贴，荣获中华人口奖科学技术奖、中国老年学和老年医学学会杰出贡献奖、复旦管理学杰出贡献奖等。多次主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社会科学重大攻关项目等，并获得国家部委及省市级科研成果奖励。在《中国社会科学》、《中国人口科学》、《社会学研究》、《公共管理学报》、*Science*、*Population and Development Review*、*Public Administration Review*、*Journal of Policy Analysis and Management* 等国内外期刊上发表多篇学术论文。

胡湛，复旦大学老龄研究院教授。主要从事人口与公共政策领域的跨学科研究，获中国高校人文社会科学研究优秀成果奖、国家“万人计划”青年拔尖人才、上海市哲学社会科学优秀成果奖、上海社科新人奖等奖励或荣誉，专著入选“经典中国国际出版工程”。

朱勤，复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地研究员。主要研究领域为人口老龄化与公共政策模拟分析等。著有《人口老龄化与碳排放：劳动供给与消费模式的影响》《中国人口、消费与碳排放研究》。发表论文 30 余篇，被引 2000 余次。获中国人口科学优秀成果一、二等奖，《资源科学》创刊四十周年十大高影响力论文奖。入选上海市浦江人才计划。

敬乂嘉，复旦大学全球公共政策研究院院长、国际关系与公共事务学院陈树渠公共管理讲席教授、教育部长江学者特聘教授，入选上海市“领军人才”项目。担任 *Public Administration Review* 副编辑（2015～2017 年）、*International Public Management Journal* 联合编辑、《复旦公共行政评论》主编，以及 *Global Public Policy and Governance* 主编。

“应对老龄社会的基础科学问题研究丛书”序

人口老龄化是一个世界性议题，它是人口再生产模式从传统型向现代型转变的必然结果，也是当今社会经济发展和社会现代化的一个重要趋势，并已成为中国社会的常态。在目前的社会经济制度安排下，我们仍对这种前所未有的人口学变化及其所带来的影响缺乏必要和及时的反应、适应和调整，中国人口老龄化的特殊进程亦使得这种挑战更显严峻。

人口老龄化首先表现为人口问题，我们不仅要对人口进行更深入的研究与调控，更要考虑到社会、经济、环境等多元要素对老龄化进程的制约。老龄化的影响已经逐渐渗透到中国社会的各个方面，并与各种历史的、当前的和未来的社会发展要素不断地相互影响，形成一个超复杂的经济社会系统问题。因此，应对老龄社会需要统筹中国社会的各种资源以形成合力，对整个社会的组织和运行进行改革和再设计，以使中国社会在老龄化的背景下继续健康、协调地运行和发展。

为此，国家自然科学基金委员会经过两年的论证，于2014年启动了重大项目“应对老龄社会的基础科学问题研究”（71490730）的招标工作。其主要目标有两方面。

其一，立足中国经济、社会和环境的现实，针对中国老龄社会的自身特征，在全球化、市场化、信息化的时代背景下，充分考虑中国人口转变和社会转型的进程，响应城乡统筹、代际和谐发展的时代要求，深入研究面向社会整合和可持续发展的应对中国老龄社会的重大基础科学问题，进行理论创新和前瞻性研究，提出符合中国实践的新理论和新方法。

其二，根据我国转变经济发展方式、保障和改善民生的重大需求，针对老龄化的发生发展规律、现在及未来老年人群体的新特征、老龄社会的社会支持系统与经济形态，以及相关制度安排和政策重构等科学问题展开系统研究，支撑国家宏观决策和治理实践需求，并造就一支在国内外有影响的跨学科研究队伍。

最终，经过选拔和评审，以复旦大学作为牵头单位并联合中国人民大学、北京大学、浙江大学、上海社会科学院所组成的跨学科研究团队承担了这一重大项目，首席科学家为复旦大学的彭希哲教授，经费量1800万元，执行期自2015年起至2019年止。项目涵括5个相互独立却又紧密关联的专项课题：

课题一“特征、规律与前景——老龄社会的人口学基础研究”（71490731）由中国人民大学承担，负责人为翟振武教授；课题二“健康老龄化——老年人口健康影响因素及有效干预的基础科学问题研究”（71490732）由北京大学承担，负责人为曾毅教授；课题三“代际均衡与多元共治——老龄社会的社会支持体系研究”（71490733）由浙江大学承担，负责人为何文炯教授；课题四“公平、活力与可持续——老龄社会的经济特征及支持体系研究”（71490734）由上海社会科学院承担，负责人为左学金研究员；课题五“整体性治理——应对老龄社会的公共政策和公共管理体系重构研究”（71490735）由复旦大学承担，负责人为彭希哲教授。整个项目的核心团队成员超过 50 人，聚集了一批人口学、管理学、经济学、社会学、心理学、医学、生物学、数学、环境科学、信息科学、政治学等领域的一流专家学者，其中不乏教育部长江学者、新世纪百千万人才工程专家等顶尖人才。经过团队成员五年多的鼎力合作，产生了一大批高质量的科研成果，在《中国社会科学》、*The Lancet*、*Demography*、*Governance* 等国内外重要学术期刊发表论文近 400 篇，由其形成的决策咨询报告多次得到国家领导人批示，获得第八届中华人口奖、第七届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）、第七届中国人口科学优秀成果奖、第三届中国老年学奖、第七届钱学森城市学金奖等各类国家及省部级奖项近 60 种，并参与资助了两项大型老龄社会追踪调查：CLASS（China Longitudinal Aging Social Survey，中国老年社会追踪调查）和 CLHLS（Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey，中国老年健康影响因素跟踪调查）。

为了推动这些成果在更大的范围内共享，促进相关学科领域的发展和高水平研究队伍的建设，为老龄社会相关的制度、政策与法规的设计、制定和运行提供理论指导与方法支撑，项目组和科学出版社合作，论证设计了“应对老龄社会的基础科学问题研究丛书”出版计划，并于 2018 年入选“十三五”国家重点出版物出版规划项目，2020 年获得国家出版基金支持。丛书计划持续出版系列老龄科学研究领域的学术专著，并于 2021～2022 年推出第一批 17 部。

作为国家自然科学基金重大项目“应对老龄社会的基础科学问题研究”的重要研究成果集群，本丛书的出版是多方通力合作、协同努力的结果。我们首先衷心感谢国家自然科学基金委员会的大力支持，感谢吴启迪、何鸣鸿、李一军、高自友、杨列勋、刘作仪等基金委时任领导的鼓励与指导，感谢于景元、辜胜阻、汪寿阳、李善同、李树茁、杨泽等学术领导小组专家的指点与建议，感谢吴刚、霍红、方德斌、卢启程、杜少甫、张江华等基金委工作人员的细致工作和周到服务，感谢原新、丁金宏、李娟、林义、黄鲁成、凌

亢、冯帅章等专家学者的帮助，感谢复旦大学、中国人民大学、北京大学、浙江大学、上海社会科学院的支持及在管理上提供的便利，感谢复旦大学公共管理与公共政策研究国家哲学社会科学创新基地、复旦大学人口与发展政策研究中心、中国人民大学人口与发展研究中心、北京大学国家发展研究院、浙江大学老龄和健康研究中心、上海社会科学院经济研究所的团队支持，感谢全国老龄工作委员会、中国老龄协会、国家卫生健康委员会、民政部、人力资源和社会保障部、国家统计局及各级政府部门的帮助，感谢兄弟院校和合作科研机构及团队的帮助，感谢项目组全体成员和参与项目工作的博士后及研究生们的辛勤劳动。此外还要感谢科学出版社的认可及支持，尤其是马跃和魏如萍老师对于我们申报“十三五”国家重点出版物出版规划项目和国家出版基金的鼎力协助。我们将再接再厉，为推动建设一个“不分年龄人人共建共治共享”的社会而奋斗。

“应对老龄社会的基础科学问题研究”项目组

2020 年 12 月

前　言

人口老龄化已成为中国社会的常态，它所带来的挑战并不完全来自老年人或者老龄化本身，而更多源于变化的人口年龄结构与现有社会经济架构之间的不协调所产生的矛盾，这使治理模式与公共政策的调节乃至重构成为必须。然而，由于人口老龄化的影响已经渗透到中国社会的各个领域，并由此形成一个超复杂系统问题，所以其治理干预绝不仅是局部的、静态的政策调整、修订或完善，而必须从整体性的战略视角来重构目前我们为解决老龄问题而实施和运作的公共政策体系。

为了回应这一重大议题，国家自然科学基金重大项目“应对老龄社会的基础科学问题研究”（71490730）设置了专项课题“整体性治理——应对老龄社会的公共政策和公共管理体系重构研究”（71490735），由复旦大学人口与发展政策研究中心团队承担。本书即是这一重大课题的集体研究成果之一，它尝试从治理及政策安排的视角出发重新审视中国人口老龄化态势，进而在剖析现有治理研究囿限的基础上论述老龄社会治理思路转型的必要性，分析多元治理主体的作用机制，以此为基础探讨老龄社会的长期照护体系构建、就业与消费转型、区域协调机制等议题，并对具体的战略部署要点及可能的政策选择进行系统阐述。需要说明的是，为了避免与重大项目中其他专项课题的研究内容撞车，本书并未具体涉及养老金、医疗保险等专项政策举措的论述。

经过全体成员五年多的共同努力，课题组按照既定的设计方案取得了丰硕成果，完成了最终成果报告，并通过精简以使逻辑紧凑，从而形成本专著。它包括九章：第1章“对中国人口老龄化的再认识”由彭希哲、胡湛执笔；第2章“老龄社会的治理理念与战略构想”由胡湛、彭希哲、郭德君执笔；第3章“老龄社会的治理体系与政府角色”由敬乂嘉执笔；第4章“老龄社会的中国家庭与家庭政策”由胡湛、彭希哲、邵洲洲、吴开亚执笔；第5章“老龄社会的社区环境与社区养老服务”由高俊岭、朱勤、周新宏、苏忠鑫执笔；第6章“老龄社会中的长期照护服务”由宋靓珺、王雪辉执笔；第7章“老龄社会的就业与消费形态变迁”由彭聪、龚遥、乐昕执笔；第8章“养老公共服务资源配置的区域均衡”由郭静、朱勤执笔；第9章“中国老龄社会治理的政策选择”由彭希哲、胡湛执笔。杨柳、吴连霞、檀榕基、王伟、杨玲、吴敏捷、汪然、沈凯俊、许弯弯、肖丹、任媛媛、杜紫弦、沈畅、王尚慧、贾鲁晶、葛伊

妮、徐静等一批博士后和博士/硕士研究生等参与了大量资料收集、数据分析、成果整理和文字润色工作。

我们特此衷心感谢国家自然科学基金委员会管理科学部的全力支持，感谢各级老龄工作部门、兄弟院校及科研机构的帮助，感谢课题组全体成员及参加课题研究工作的博士后和研究生们。我们将筚路蓝缕，继续聚焦“中国思考”，为推动形成新时代中国老龄社会治理的“中国方案”而不断努力。

彭希哲

2020 年早春

目　录

第 1 章　对中国人口老龄化的再认识 …… 1
1.1　人口老龄化的常态化 …… 1
1.2　治理视角下的中国人口老龄化 …… 3
第 2 章　老龄社会的治理理念与战略构想 …… 10
2.1　反思老龄社会治理的研究困境 …… 11
2.2　研究实践中的认知误区及偏差 …… 13
2.3　应对老龄化的治理格局和战略思路转变 …… 20
第 3 章　老龄社会的治理体系与政府角色 …… 27
3.1　老龄社会治理特征及政府定位 …… 27
3.2　中国老龄社会治理体系的发展 …… 30
3.3　未来老龄社会治理的政府工作要点 …… 46
第 4 章　老龄社会的中国家庭与家庭政策 …… 48
4.1　当代中国家庭变迁与家庭政策 …… 48
4.2　老龄化背景下的中国家庭发展困境 …… 57
4.3　中国家庭养老的承载能力评价 …… 62
4.4　老龄社会的家庭政策重构要点 …… 76
第 5 章　老龄社会的社区环境与社区养老服务 …… 81
5.1　社区环境对老年人的影响 …… 81
5.2　老年友好型社区建设 …… 83
5.3　社区养老服务体系的构建 …… 92
第 6 章　老龄社会中的长期照护服务 …… 97
6.1　老年长期照护需求的宏观变化趋势 …… 97
6.2　我国老年长期照护需求的现状与问题 …… 100
6.3　长期照护服务影响因素的实证研究 …… 103
6.4　完善长期照护服务体系的对策建议 …… 109
第 7 章　老龄社会的就业与消费形态变迁 …… 115
7.1　老龄社会的劳动力结构格局 …… 115
7.2　老龄社会就业形态的变迁与发展 …… 119
7.3　老年消费新态势及家庭消费结构变化 …… 126

7.4　老龄化背景下产业结构形态变迁及发展 …… 132
第 8 章　养老公共服务资源配置的区域均衡 …… 139
8.1　养老公共服务资源供给水平测度 …… 139
8.2　养老公共服务资源供给的区域差异分析 …… 145
8.3　区域养老服务资源的供需匹配分析 …… 150
8.4　促进区域养老服务均衡发展的对策建议 …… 156
第 9 章　中国老龄社会治理的政策选择 …… 160
9.1　完善老龄社会的治理格局 …… 160
9.2　战略部署要点及其政策选择 …… 162
参考文献 …… 175

第 1 章　对中国人口老龄化的再认识[①]

给岁月以生命，而不是给生命以岁月。

——布莱兹·帕斯卡尔

从有文字记载的历史来看，人类社会始终以年轻人居多，世界人口的年龄结构在相当漫长的岁月里保持相对稳定。直至 1865 年前后法国的老年人口（60+岁）比重达到 10%，法国成为历史上首个步入老龄社会的国家，随后不到百年间，西方发达国家悉从其势，这种现象自 20 世纪后半叶起在发展中国家及地区亦趋于蔓延，目前已经随着社会经济的发展和人口转变的加快而进入了急剧变化并持续发展的阶段。1950～2000 年，全球 60 岁以上的老年人口数量增加了三倍而至 6 亿，随后在 2006 年超过 7 亿，2015 年达到 9 亿，并预计在 2050 年激增至 20 亿～21 亿，史无前例地超过儿童（0～14 岁）的人数，占全球人口总量的 22%（United Nations，2017）。其中，亚洲的老年人口数量将在 2050 年达到 12 亿，占全球老年人口总量的 60%；中国 60 岁及以上老年人口的数量也将从 2010 年的 1.78 亿增长到 4 亿以上，分别占中国人口总量的 30%以上和世界老年人口总量的 20%以上（United Nations，2017）。这种人口结构的变化在人类历史上前所未有，它使我们的世界迅速地变老，并成为全球面临的共同问题。派弗曾断言，“人口老龄化继续发展下去所产生的冲击将不亚于全球化、城市化、工业化等人类历史上任何一次伟大的经济与社会革命”（Pifer and Bronte，1986）。

面对这样一个超复杂议题，学者们从不同的视角和路径开展了大量研究，发展出不同的理论解释和对策建议。从本质上讲，中国乃至全球人口结构的老化在相当长的时期内都是不可逆转的，我们无法从根本上扭转人口老龄化的趋势，而只能在适应它的前提下，合理规避其给经济社会发展带来的各种风险，这无疑使治理模式及公共政策的调整乃至重构成为必须。

1.1　人口老龄化的常态化

卫生条件的改善、医疗技术的推广、生活水平的提高及保健意识的增强，

① 本章作者为：彭希哲、胡湛。

大大降低了人类的死亡率，使人类寿命普遍延长。这一进步被视为20世纪最为重要的社会发展成果之一。世界人口的平均预期寿命已从1950～1955年时的46.6岁提高到了2005～2010年的67.6岁（United Nations，2017）。其中：发达国家人口出生时的预期寿命从66岁提高到77岁，延长了11年；发展中国家则从41岁提高到66岁，延长了25年。中国在这方面的变化尤其显著，1949年中华人民共和国成立时中国人口的预期寿命还不足40岁，而2010年这一数字已跃升至近75岁，并预计在2040～2050年达到80岁（CPP，2017）。

在人类寿命普遍延长的同时，人们的生育行为也发生了显著变化。在经历了第二次世界大战（以下简称二战）后的人口快速增长以后，发达国家与发展中国家的人口生育水平依次开始下降，全球的总和生育率已从1965～1970年每名妇女生育5.0个子女下降到2005～2010年每名妇女生育2.6个子女（UNFPA，2009）。这种全球范围内的生育转变有效降低了“人口爆炸”的危险，尽管世界人口总量仍在持续增长，但其增长速度已经大大减缓，2005～2010年全球人口自然增长率仅为1.1%。人口生育行为的变化在中国更为突出，自20世纪70年代以来，中国人口生育水平显著下降，全国的总和生育率从1970年的5.8下降到目前的1.5左右。中国人口的膨胀性增长得到了有效抑制，人口自然增长率目前远低于世界平均水平，2005～2010年仅为0.5%左右[①]。计划生育政策和项目的实施无疑是中国生育率下降最为关键的推动力之一，与此同时，经济社会的发展、妇女地位的提高、教育的普及、家庭规模的缩小、人口流动的加剧，以及生活观念和生活方式的改变，都直接或间接地对生育率的下降发挥着作用。

人口增长模式的这些变化不可避免地加速了老龄化进程，人类社会开始全面进入老龄化阶段。作为一种必须面对的客观趋势，人口的老龄化在任何国家和地区都概莫能外，差别只是出现的早晚和进程的快慢。2015年全球尚有115个国家和地区未进入老龄化阶段，但至2050年这一数字将可能骤降为33个。不仅如此，全球的老年人口每年正以2%的速度增长（DESA of United Nations，2002），不仅高于同时期的整体人口增长率，而且超出其他各年龄组的增长速度[②]。

就中国而言，根据国家统计局所发布的数据，2000年时60岁和65岁及以上人口比重已分别达到10.0%和7.0%，标志我国正式步入老龄社会，其后的人口老龄化水平便不断提高，2010年第六次人口普查（以下简称“六普”）时达到8.9%（65+岁）和13.3%（60+岁）[③]，而至2018年末这一数字已变为

① 《2010年第六次全国人口普查主要数据公报（第1号）》：http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/201104/t20110428_30327.html，2011年10月1日。

② 近期老年人口剧增在一定程度上是由二战以后“婴儿潮”时期超大出生人群逐渐进入老龄所致。

③ “60+岁”“65+岁”为“60岁及以上”“65岁及以上”的简写形式，其余年龄解释类似。

11.4%（65+岁）和 17.9%（60+岁），其中 60 岁和 65 岁及以上的人口规模已分别接近 1.7 亿和 2.5 亿，33 个省区市（数据不包括台湾）中已有 30 个地区的老年人口比例超过 10%。从长远看来，中国老年人口的数量在未来的 30 年间仍将持续快速增长，并预计在 2050～2060 年达到峰值，即使以后的人口老龄化速度会有所放慢，但总的趋势是 2100 年时中国人口中老年人口比例将维持在 34%的水平（杜鹏等，2005；CPP，2017）。在一个相当长的时期内，中国乃至全球人口老龄化的趋势在总体上是不可逆转的，老龄化现象将在整个 21 世纪持续存在。然而，随着人类社会经济的进一步发展，以及现代医学和科学技术（尤其是生命科学）的进一步突破，人口寿命进一步延伸的可能性将继续扩大，而恢复到传统社会的高生育率和大家庭模式的概率微乎其微，至少现在已经很难想象中国乃至人类社会将会再次“年轻”。

毫无疑问，人口老龄化已成为中国乃至人类社会的常态。它不仅是社会经济发展的必然趋势，也是人口再生产模式从传统型向现代型转变的必然结果[①]，甚至可以说是社会现代化的一个重要标志。人口老龄化绝不是一种短期现象，无论今天或是未来，每个人都注定生活在一个老龄化社会，那种“年轻”的社会已经一去而不返了。既然如此，我们就应该正视人口老龄化并适应人口老龄化，对这一社会基本特征进行深入的研究，使人类社会在老龄化的前提下继续健康、协调地运行和发展。然而遗憾的是，今天仍有许多研究者认为人口老龄化是一种不正常的社会态势，并将其视为沉重的负担；许多研究也都是在传统的逻辑框架内探讨防止或延缓老龄化的种种途径，这其实是用 20 世纪的思路和方法来应对 21 世纪的挑战，难以真正解决问题。

1.2　治理视角下的中国人口老龄化

人口老龄化是一种长期不可逆转的全球化发展趋势，且已成为中国社会的常态（彭希哲和胡湛，2011）。从本质上讲，老龄化没有好坏之分，所谓的“问题”或“挑战”不完全来自老年人或者老龄化本身，更多源于变化了的人口年龄结构与现有社会经济架构之间的不匹配所产生的矛盾，因而需要治理模式和公共政策的调整乃至重构以适应之。综合当前国内外权威机构和学者的研究，对中国人口老龄化的趋势预测大致相似（图 1-1），即中国将不可逆转地进入老龄化深化并持续的长期过程，区别仅在于数字上的一些出入，对其发展规律的基本判定也趋于类似，如基数大、速度快、区域不均衡、高龄老人和失能老

① 传统型人口再生产模式的主要特征是高出生率和高死亡率，而现代型人口再生产模式的主要特征则是低出生率和低死亡率，其结果必然导致人口老龄化。

人增多、空巢化和独居化加剧等，但从治理及公共政策的视角出发，对以下问题仍应特别关注并进一步形成共识。

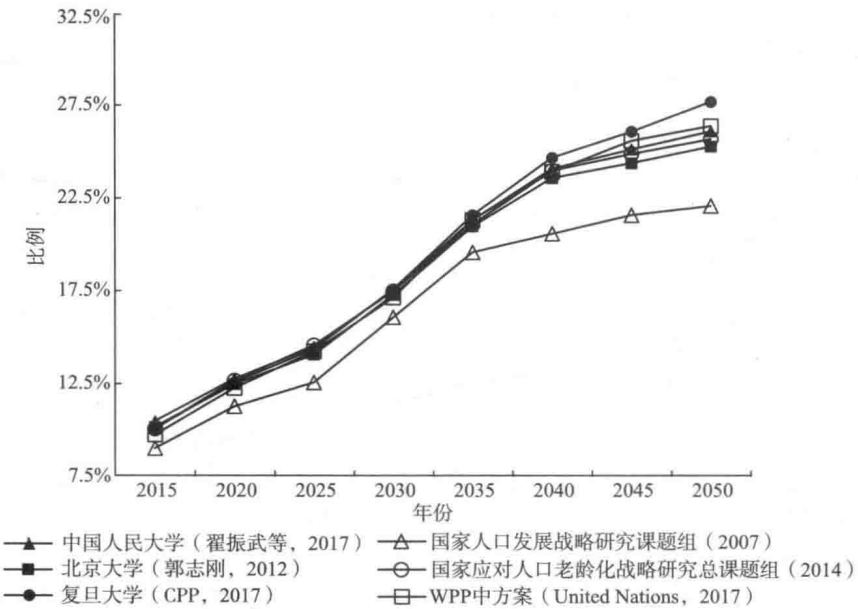

图 1-1　中国人口老龄化趋势预测（65+岁，2015～2050 年）

由《国家人口发展战略研究报告》（2007 年）、《国家应对人口老龄化战略研究总报告》（2014 年）、郭志刚（2012）、复旦大学 CPP（China's population prospects）数据库（2017 年）所做的预测数据汇总整理所得

1. 中国正处于老龄化急速发展期，“未备先老”或“慢备快老”凸显

中国总人口在未来十多年内仍将继续增长，老年人口的增长速度快于总人口。2015～2050 年，中国老年人口（65+岁）总量将从 1.4 亿激增至 3.65 亿左右[①]，预计在 2050～2060 年达到峰值，之后的老龄化速度有所放缓，进入所谓的高位平台期，至 2100 年老年人口比例仍将维持在 34%的高水平。在这一过程中，2015～2035 年是老龄化增速最快、波动最大的时期，也是社会抚养比相对最低[②]、老年人口结构相对最年轻的时期[③]，尤其 2018～2022 年还将出

① 联合国 2015 年预测 2050 年中国 65 岁及以上老年人口为 3.71 亿，比例为 27.6%；郭志刚 2012 年预测 2050 年中国老年人口（65+岁）为 3.54 亿，比例为 25.2%；中国人口与发展研究中心 2007 年预测结果为 3.22 亿和 22.7%；本章用随机概率预测中位数为 3.65 亿和 27.6%，80%的概率区间为 3.23 亿～4.06 亿和 25.4%～29.2%（郭志刚，2012；国家人口发展战略研究课题组，2007）。

② 2015 年我国的社会抚养比约为 0.44，即每 100 名劳动适龄人口支持 44 名老人和孩子，但至 2050 年前后，社会抚养比将可能增至 1.0 以上。

③ 2010～2015 年 60～65 岁的老年人口约占全部老年人口的 35%，60～70 岁的老年人口约占 59%，20 世纪 50 年代“婴儿潮”出生人口进入高龄（80+岁）阶段还有 10 年左右。

现暂时的“底部老龄化”和“顶部老龄化”同时弱化现象[①]（图 1-2），应对老龄社会的战略和战术储备应在此期间完成，2040 年后老龄化增速将略趋于缓和。从目前来看，影响这一目标实现的主要障碍不全是“未富先老”，而主要是“未备先老”或“慢备快老”。事实上，不少西方国家在尚未达到中国现有人均国内生产总值（gross domestic product，GDP）水平时已建立起比较健全的基本社会保障制度，例如 2009～2012 年时中国经济发展水平已与西欧 12 国（法国、德国、英国等）1965 年相当，但这些国家均早于 1960 年建立了基本覆盖全民的社会保障制度（陈友华，2012）。我们现有的制度安排对人口老龄化及其所带来的变化仍缺乏结构化和系统性的反应及适应。

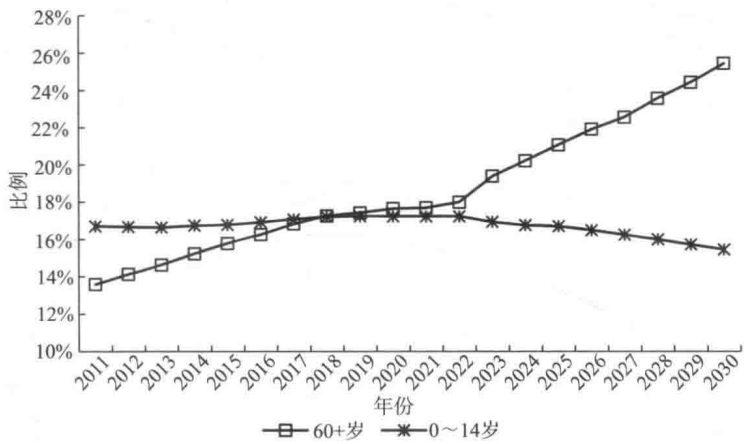

图 1-2　“顶部老龄化”与“底部老龄化”同时弱化现象（2018～2022 年）

2. 老年人口增加是影响未来抚养比上升的主导因素，并可能由此倒逼劳动就业模式重塑

我国目前及未来一段时期内老年人口的增长主要源自 20 世纪五六十年代的出生高峰人群，60 岁或 65 岁及以上人口规模分别于 2016 年和 2026～2032 年超过 0～14 岁少儿人口，且 2025 年之后老年人口自身结构的老化开始凸显[②]，最迟由 2030～2035 年开始，我国劳动适龄人口的抚养重点将明显向老年人口倾斜，2050 年以后的老年抚养比将增加至现在水平的两倍以上。目前按传统概念推算的劳动力供给已经出现拐点，潜在劳动力总量将持续缩减且结构趋于老化[③]。虽然生育政策调整也会带来少儿人数增加和未来劳动年龄人口上升，

① 对不同出生队列人口的分析及预测表明，新进入老年的人口在 2018～2022 年显著减少（对应 1958～1962 年出生人群），而生育政策调整后 0～14 岁少儿比例在此期间仍处于上升期。

② 2025 年之后，老年人口结构将开始出现明显的高龄（80+岁）比例增加、低龄（60～69 岁）比例降低。

③ 15～59 岁的传统概念下劳动年龄人口规模在 21 世纪内预计缩减 3 亿左右，其中 2 亿的缩减将发生在近 20 年内，而与此同时，45 岁及以上的劳动年龄人口比例将稳步上升。

但这些调整至少要到2030年之后才会对老年抚养比产生相对有限的影响，主导抚养比上升的依然是老年人口增加和老年抚养比提高。

此外，需要特别指出的是，我国劳动适龄人口在老龄化的背景下总体呈现下降趋势，但中短期内我国的劳动力供给依然充足，未来20年间将始终稳定在9亿以上。随着我国产业结构优化升级的深化，对劳动密集型产业的廉价劳动力需求正逐渐下降，而对资本和技术密集型产业的高端劳动力需求则逐步上升，劳动力供给结构与需求结构不匹配的现象开始凸显，未来社会经济发展对劳动力规模的刚性要求趋于弱化。与此同时，以人工智能和物联网为代表的科技进步正对劳动就业的传统结构模式形成冲击，这种技术性破坏将在缓解未来劳动力危机的同时淘汰部分传统职业，并由此产生新的就业方式和职业形态，就业模式的多元化和层叠化[①]将趋于普遍。面对这些结构性的变革，已无法仅仅依靠加强传统劳动力教育投资和加快农村劳动力转移来应对，而必然涉及对中老年人力资源（特别是中高端人才）的开发利用、对某些行业从业人员的转移安置与再教育，甚至劳动力市场的重构等一系列更为复杂的议题。

3. 老龄化的区域差异增加了应对复杂度，但也创造了政策回旋空间

我国人口老龄化的地区差异主要受本地人口转变和人口迁移流动两大因素的影响，并表现为由东向西的梯次特征，而城乡差异则体现出明显的城乡倒置特征（图1-3）[②]，这与经济社会发展水平导致的生育率差异和城镇化的

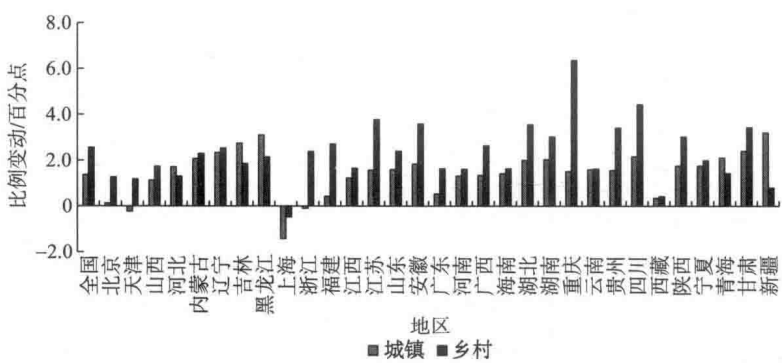

图1-3　2000～2010年老年人口比例变动情况（65+岁）

① 层叠化是指个体同时具备多种就业身份，可并行且相对独立。例如，互联网经济的发展已使传统正规就业群体中的许多人同时具备了其他非常规就业身份，如利用业余时间开网店、代购、代驾、开网约车等。

② “六普”资料显示，2000～2010年，我国城镇老龄人口比重从6.36%升至7.68%，增加了1.32个百分点；乡村则从7.10%升至10.06%，增加近3个百分点。乡村现有老龄人口比重比城镇高出三成，十年间乡村老龄人口比重增幅更是高出城镇1.3倍。无论从老龄化水平还是从老龄化发展速度来看，乡村均远远高于城镇。

加速推进密切相关。根据测算，2000～2010 年人口的乡-城转移对我国农村人口老龄化的贡献率为 43.4%（朱勤，2014），是该阶段农村人口老龄化的主导因素，而这种人口转移又有效降低了城市老年人口比重。

这些现象虽然不一定具有长期性，但在我国新型城镇化战略推进期间会持续发酵，并加剧区域差异，其间的老龄化压力将通过人口流动更多地传导至中西部地区（主要是农村）。尽管这会在全国层面增加应对老龄化的复杂度，但也为城镇地区有效延长了人口红利窗口期。必须指出的是，虽然有人提出从全国宏观层面来看中国人口红利已消耗殆尽，但区域差异及其所导致的人口流动与动态聚集使得不同地区机会窗口的开启与关闭时间并不一致，部分地区（如东南沿海）在一定时期以内尚有相对充沛的红利，这种时间上的梯次差异将可能会为应对人口老龄化创造出灵活的政策腾挪空间。

4. 家庭模式变迁将增加未来养老制度安排的不确定性

无论中国还是外国，居家养老都是最主要的养老形式，几乎所有的老年人或多或少地通过家庭或社区得到相应的养老服务。一方面，尽管中国家庭正在不断变小，却并不必然意味着其功能的磨损和凝聚力的缺失，传统家庭伦理和家庭文化仍具有强大的凝聚力，家庭的代际纽带亦一贯强韧，而现代科学技术对日常生活方式的影响也极大地扩展了家庭的空间联系，家庭成员（主要是亲子）之间的传统互助网络仍以新的形式在继续（彭希哲和胡湛，2015），这是中国式养老中不可或缺的重要支柱。另一方面，随着我国家庭户规模的不断缩减[①]、家庭结构格局的不断简化、老年人居住模式出现结构转变[②]、非传统类型家庭大量涌现[③]，家庭在未来养老制度安排中的作用机制有待重新研究。1982～2000 年我国家庭户的户均老年人数量稳定保持在 0.22～0.24 人，至 2010 年陡增至 0.41 人，与此同时的户均孩子数量却从 1982 年的 1.48 人陡降至 2010 年的 0.51 人，平均每个家庭少了差不多 1 个孩子，中国家庭正在经历少子老龄化进程（表 1-1）。在家庭政策及相关服务仍系统性缺位的情况下，这些现象将给未来养老制度安排带来极大不确定性，其机遇与风险并存。

① 1982 年、1990 年、2000 年和 2010 年的家庭户平均规模依次为：4.41 人、3.96 人、3.44 人和 3.09 人。

② 我国家庭户结构的基本格局已从 1982～2000 年的“核心户为主、扩展户居次、单身户补充”转变为 2000～2010 年的“核心户为主、单身户与扩展户居次”，随着单身户、夫妇户的大量增加和多代扩展家庭长期维持较大比重，二代核心家庭户的比例有较大降幅（2000～2010 年降幅达到 13.7%）。

③ 如 4-2-1 家庭（以及正在出现的 8-4-2-2 家庭）、纯老家庭（尤其是二代纯老和三人及以上纯老家庭）、隔代家庭、失独家庭、大龄单身家庭、单亲家庭、丁克家庭、同居家庭乃至同性家庭等。

表 1-1　我国家庭户人口结构变化（1982～2010 年）

年龄	家庭人口年龄结构				家庭户均人口规模/人			
	1982 年	1990 年	2000 年	2010 年	1982 年	1990 年	2000 年	2010 年
0～14 岁	33.6%	27.7%	22.9%	16.6%	1.48	1.10	0.79	0.51
15～64 岁	61.5%	66.7%	70.1%	74.5%	2.71	2.64	2.41	2.18
65+岁	4.9%	5.6%	7.0%	8.9%	0.22	0.22	0.24	0.41
合计	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	4.41	3.96	3.44	3.10

5. 老年人口健康水平不断提升，但其政策价值仍有待挖掘

2010 年，我国男性和女性老年人口（60+岁）的余寿分别为 20.04 岁和 23.14 岁，生活自理预期寿命为 17.22 年，平均带残存活时间约为 2.53 年（张文娟和魏蒙，2015b），相比 2000 年均稳步提升。不同口径的老年人口失能率区间为 10.48%～13.31%[①]，其中中重度失能老年人比例未超过 3%（1.55%～2.99%），至 2020 年前后各类亟须照顾的老年群体[②]将可能接近 2000 万的规模。对此需要特别指出的是，人口寿命提高在带来效益的同时也会产生成本及压力，即“胜利的成本”（cost of success）乃至“胜利的失败”（failure of success）[③]，而现有的制度安排模式尚未对我国老年人口健康水平提升这一现实进行必要的调适，对其效益未有效利用，对其可能带来的压力也未及时反应，这尤其反映出社会保障系统和老年科技发展的滞后性，并可能由此形成所谓“长寿风险”问题。

6. 现役老年标准与当前社会现实脱节，助长了对老龄化的偏见

联合国自 20 世纪中叶起所推行的老年定义依赖于单一的生理年龄指标，并由此形成人口老龄化的判定标准，这在很大程度上反映当时预期寿命的限制和各国政府对养老保障的考量。从确定这些标准至今，人类社会已经历巨大的人口、健康及疾病谱转变，经济社会关系也产生了重大变革，因而进入 21 世纪以来重新定义老年/老龄化一直是国际社会关注的前沿。IIASA 和 MPIDR 等

① 2010 年中国城乡老年人口状况追踪调查数据的老年人口失能率最高，达到 13.31%；2011 年中国老年健康影响因素跟踪调查数据的失能率最低，为 10.48%；2010 年“六普”数据的老年人口失能率为 11.20%（张文娟和魏蒙，2015a）。

② 包括中重度失能、中重度失智、失明失聪群体。

③ “胜利的成本”是指人类寿命提高（即所谓“胜利”）在带来效益的同时也是有成本的，如健康状况较差的高龄老人存活率提高就会给社会长期照料和亿万家庭生活质量带来严峻考验。一种更悲观的理论则认为，老年人寿命延长将导致老年人群中残障比例增加，是一种“胜利的失败”（Zeng et al.，2017）。

国际权威学术研究机构便倡议用“Prospective Aging”[①]或“Midway-Age”[②]替代传统指标。以 Prospective Aging 为例，用其重新判断中国的人口形势将发现：中国的老年起点从 2015～2020 年的 61.5 岁逐步提升至 2045～2050 年的 67.5 岁，人口老龄化水平尽管仍呈上升态势，幅度却多有缓和，至 2065 年之后才会出现小高峰，其时人口老龄化水平将达到 27.10%，随后便逐步降低，而劳动适龄人口在 21 世纪后半叶即开始小幅回升，并始终维持在 63%～64%的稳定水平（图 1-4）。

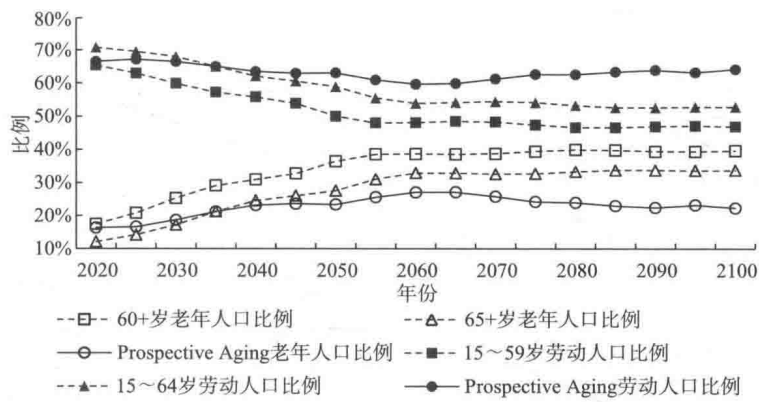

图 1-4　传统标准与 Prospective Aging 体系的老年/劳动人口比例（2020～2100 年）

与此同时，世界卫生组织（World Health Organization，WHO）亦正在不断修正对健康的看法，目前已将其重新定义为“健康不仅仅是消除疾病或虚弱，而是一种身体、精神与社会环境适应的完好状态”。然而在实际情境中，我们却仍普遍更多地关注老年人的疾病、虚弱及因此导致的基本生活能力丧失，这显然已与国际现行的主流评价体系相脱节，一个科学完整的“大健康”概念应该是立体而非单一的，涉及多维度与多层次，不仅包括身心适应和社会参与，更需要老年友好型环境的支撑。

不难看出，一旦跳出旧概念和旧框架的桎梏，我们对中国人口老龄化态势将会有一个全新的认识，这不仅源于中国人口再生产模式的变动，也是国家治理模式改进、人民生活方式改变及科技发展的合力使然，并必然影响到与老龄化相关的国家治理模式和制度政策的设计。

① IIASA（International Institute for Applied Systems Analysis，国际应用系统分析研究所）的 Prospective Aging 重新定义老年标准为：人口平均期望寿命减去 15 年，即当人口的期望余寿小于或等于 15 年时视为进入老年期，该老年定义将会随着人口预期寿命的持续延长而动态变化（Sanderson and Scherbov，2008）。

② MPIDR（Max-Planck Institute for Demographic Research，马克斯-普朗克人口研究所）的 Midway-Age 是指生命表里一半人口恰好可以活到的年龄，该指标能更好地反映死亡率的变动。

第 2 章　老龄社会的治理理念与战略构想[①]

作为一个世界性议题乃至难题，老龄化研究的重要性正日益凸显。*Science* 杂志于 2011 年组织专刊探讨全球人口问题，特别将人口老龄化作为重中之重，并持续关注之；*Nature* 杂志曾于 2010 年推出老龄化专栏，提出“老龄生物人口学”（Biodemography of Aging[②]）和“老化的遗传”（The Genetics of Aging）等重要议题；NIA/NIH（National Institute on Aging/ National Institutes of Health，美国国家老龄化研究所/美国国立卫生研究院）自 1990 年起资助“高龄老人死亡率的人口模型和分析”（Oldest Old Mortality: Demographic Models and Analysis）重大研究项目；世界经济论坛（World Economic Forum，WEF）专门成立了“老龄社会全球议程委员会”（Global Agenda Council on Ageing Society），定期推出系列研究报告；欧盟近年启动了包含 12 个国家的“欧洲老龄研究领域网络”（European Research Area in Ageing，ERA-NET）跨学科项目。这些大规模研究为全球社会（主要是西方发达国家）深入理解老龄化提供了非常有益的理论和数据基础，大量系统而丰富的对策、政策与治理研究亦由此展开。与之相对应，近年来我国政府和学界亦已开展了多项大型老龄化研究，不仅形成了《国家人口发展战略研究报告》和《国家应对人口老龄化战略研究总报告》等重要成果，也通过中国老年健康影响因素跟踪调查（Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey，CLHLS）、中国健康与养老追踪调查（China Health and Retirement Longitudinal Study，CHARLS）和中国老年社会追踪调查（China Longitudinal Aging Social Survey，CLASS）等项目为深入研究老龄社会奠定了翔实的数据基础，不同领域的学者由此从不同学科出发对中国老龄化问题进行了较为系统性的探索，并已形成大量丰硕的学理性成果。但论及具体的对策政策研究，不少研究却常常过高估计老龄化问题的严重程度，不同程度地存在着将老龄化视为“问题”或“挑战”的倾向，形成了一系列对于老龄化发展和老龄社会治理的认知误区及偏差，其对策与政策研究较多着眼于单项或局部的静态政策问题，存在若干治理困境，相应治理研究亦有囿限。

① 本章作者为：胡湛、彭希哲、郭德君。

② 为保持原文的准确性，未对 aging 和 ageing 二词进行统一。

2.1　反思老龄社会治理的研究困境

首先，应对中国人口老龄化的基础治理理论尚未廓形。中国人口老龄化的深化进程与建设社会主义现代化强国的时间表基本同步，传统建立在年轻人口占绝对主体基础之上的社会治理模式和制度安排架构都需要根据老龄化的发展态势做出相应调整乃至重构，老龄社会的治理内嵌于新时代的公共治理。2013 年中共十八届三中全会将“推进国家治理体系和治理能力现代化”[①]作为全面深化改革的总目标之一，强调从社会管理到社会治理的转变，2017 年中共十九大报告更明确提出“加强和创新社会治理”以打造“共建共治共享的社会治理格局”[②]。这些理念与方案不仅为中国新时代的公共治理确立了路径，也为老龄社会的治理提供了宏观理论框架。然而，“治理”概念本身具有问题导向和结果导向的特点（燕继荣，2017；李强，2014；郁建兴和关爽，2014），具体的治理体系将根据现实议题的变化而不断演化，以与社会发展现状不断适配。尽管从中央到地方都已针对老龄工作形成了初步的宏观治理格局，但现有涉老制度与政策安排仍未脱离政府主导型和管控型的社会管理模式，很多基本的理论问题更未解决，如现行老年和老龄定义是否合理、老龄社会的就业形态和福利模式是否会颠覆、传统文化在老龄社会中的作用机制等，这使得应对中国人口老龄化的基础治理理论尚未形成，具体的治理体系尚未落实，因而难以实现从一元主导到多元共治、从查漏补缺到持续发展、从管控维稳到共建共享的治理格局转变。

其次，现有社会认知混沌，存在误判人口及老龄形势的风险。人口老龄化是近年引起社会各界高度关注的一个相对较新的议题，在社会上和研究中，悲观论和政府全能全责论仍有不少市场，一些似是而非的理论观点也时有涌现，例如：希望仅仅通过提高生育率来遏制老龄化发展，却忽视了老龄社会已成为一种不可逆转的常态；断言中国家庭功能及其凝聚力已普遍磨损而致使家庭养老功能丧失，却对家庭网络在新历史时期的新表现形式视而不见；等等。更多的研究则习惯性地将老龄化问题看作只是老年人的问题，即如何为现在和未来的老年人口提供经济赡养和公共服务，由此形成的政策建议和相关职能部门也更多关注老年人工作的开展和老龄事业的发展，而非对整个老龄社会的应对

①《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》：http://www.gov.cn/jrzg/2013-11/15/content_2528179.htm，2013 年 11 月 15 日。

②《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》：http://www.12371.cn/2017/10/27/ARTI1509103656574313.shtml，2017 年 10 月 27 日。

（吴玉韶，2018）。事实上，这些现象大多源于传统的概念、工具和框架与当前社会现实日益脱节，而我们却依然固守而未及时更新，这种不匹配尤其体现在现行老年及老龄标准上，它们直接决定了涉老政策的内涵和外延。

最后，现有涉老制度与政策安排的研究尚未形成中国方案。治理模式及其相关制度安排有鲜明的国家特征，虽然那些先期进入老龄化的西方发达国家为后进者提供了丰富的经验和“前车之鉴”（Lee and Mason，2011；Pifer and Bronte，1986；Schultz，2001；Cox and Jakubson，1995），但对于中国这样的人口大国，基本国情、社会架构、发展阶段和文化特征等方面的差异使得我们无法生搬硬套其制度及政策模式，何况不少西方国家自己也正因此陷入债务泥潭而至今不拔。如何在尚未实现现代化的条件下应对老龄社会的诸多挑战，中国目前尚无系统的他国经验可资模仿。近年来我国政府和学界已开展多项大规模老龄研究，不同领域的学者从不同学科出发对中国老龄化议题进行了较为系统的探索，并形成大量丰硕的学理性成果，其中具体的对策政策研究则相对集中于以生育政策为重点的人口政策调整、与老年人相关的政策调整和单一部门的政策调整等方面（彭希哲和胡湛，2011）。不难想象，这些对策研究仍不同程度地存在着将老龄化视为“问题”或“挑战”的倾向，较多着眼于单项或局部的静态政策问题，尚未形成基于中国思考的整体性框架。正如前文所强调的，人口老龄化已成为中国社会的常态，其进程涉及个体发展的各个阶段和人口结构的各个层次，不可能只因生育政策的调整而得到根本性逆转，也不可能仅仅通过优化老年人福利而消弭其压力，更不可能依靠传统“部门政策”的单打独斗而扭转当前治理困境。与西方发达国家不同，中国是在经济未发达、就业不充分和社会保障未完善的情况下进入老龄社会的，这要求中国寻求一种更加多元的应对老龄化的整体性治理模式及政策体系（Mason and Lee，2004；Jackson et al.，2009；蔡昉和孟昕，2004；邬沧萍和王萍，2009；田雪原等，2006），而中国独特的政治体制、人口规模、经济体量、文化传统和家庭观念也是我们必须关注的特征，并由此形成整体性应对方案。

此外，现有研究及实践对人口社会变迁过程中的不确定性把握不够。治理是一个不断与社会发展现状和制度变迁形势相互适配的动态过程。尽管人口老龄化已成为中国社会的常态，对其基数大、速度快、区域不均衡、高龄老人和失能老人多、空巢化和独居化加剧等规律和现象也正在逐步形成共识，但中国的老龄化毕竟仍在不断发展之中，其治理过程尚有一系列不确定性需进一步把握，如前文提到的就业结构与模式面临结构性转变、老龄化区域差异的动态发展、家庭模式变迁对未来养老制度安排的影响、老年人口健康水平的变化等方面。这些不确定性将在相当长的时期内伴随中国老龄社会的治理进程，应对其有效把控和合理应对，并由此形成中国方案中的中国特色。

2.2　研究实践中的认知误区及偏差

人口老龄化及其影响具有较大的弥散性和渗透性，常常涉及一系列跨越功能边界的非结构化公共事务，并形成诸多超复杂系统问题，对其应对的治理模式与政策安排必须基于这一特征展开。然而所有的治理与政策变迁都不可能在一夜之间完成，其间更需要政府治理理念和社会主流观念的不断调适。因此尽管老龄议题在近年已引起社会各界高度关注，政府出于民生大计亦对其极为重视，但囿于固有的治理困境，研究与实践中的共识仍未普遍达成，尚存在若干亟待商榷的认知倾向。随着老龄化的进一步深化和社会转型的加速，识别并厘清当前研究和实践中的认知误区和理解偏差正变得愈加重要和必要，这将是老龄社会治理理念转型和社会观念更新的前提条件之一。

2.2.1　老龄化及其治理研究中的认知误区

中国自 2000 年进入老龄社会至今已逾 20 年，这意味着我们对于老龄化已形成直观认识，相应研究与实践亦日趋深广。然而，整个社会在应对老龄化的过程中却仍存在诸多认知误区或理解偏差，倾向于将其视为“问题”、“挑战”、“负担”乃至“危机”，相当多的学术探索委身于此框架之下寻求防止或延缓老龄化的种种途径，大量的政策探讨亦由此过多聚焦于单项或局部的政策调整或调节，例如养老压力及针对老年人的各类支助措施等，有一定工具理性特征，而与老龄化密切相连的其他问题或者同一问题的其他方面则经常被忽视，对整个老龄社会基本规律的系统研究和对政策体系的整合性研究仍相对欠缺，不少工作于今已显得杯水车薪，并可能导致我们对未来老龄社会发展路径的误判。

综合而言，现有老龄研究与实践中亟待商榷的认知倾向乃至认知偏差或缺失主要表现在以下四个方面。

1. 对老龄社会的常态化欠缺共识，悲观论与危机论在研究实践中仍有市场

进入 20 世纪后，在现代化和现代性的逻辑作用下，人类寿命大幅延长而生育水平显著下降，两者叠加使得不同国家与地区的人口年龄分布普遍向老龄化倾斜。因而从本质上讲，老龄化是人类再生产模式转型和经济社会发展的必然结果，它在任何国家和地区概莫能外，差别只在于出现之早晚和进程之快慢（彭希哲和胡湛，2011）。学界对于未来中国老龄化发展趋势的整体判断亦基本趋同，老龄化已经成为一种长期不可逆转的基本国情。

显然，人口老龄化从本质上讲没有好坏之分，甚至在某种意义上还可被视

为现代化的重要标志乃至社会发展的重要成果（胡湛和彭希哲，2018）。然而遗憾的是，当前老龄研究与实践中仍充斥着不少负面乃至悲观的情绪。这一方面源于社会大众在心理上的不适应，另一方面则是目前以中青年为核心形成的社会架构对老年人比例增多这一现实仍存在不同程度的不匹配。这些“不匹配”更因“不适应”而被主观夸大，老龄化因而与“悲观”、“危机”及“负担”和“压力”画上了等号，尤其对于人口老龄化将造成经济发展延缓的担忧甚嚣尘上。事实上，不少西方发达国家在尚未达到中国现有人均经济水平时已为应对老龄化建立起了相对健全的全民社保体系（陈友华，2012），因而用“未备先老”或“慢备快老”来形容中国当前的老龄化应对现状可能更为准确（胡湛和彭希哲，2018）。此外，也有相当多的证据揭示老龄化对宏观经济发展并未带来不可逾越的挑战，在一些西方发达国家，老龄化甚至与其经济增长显现出一定程度的正相关，中国最近几十年间的经济高速增长亦与人口老龄化的发展进程相同步。这恰恰说明人口与发展之间的关系不是线性的，不需要无谓地自我设障。正如戴利和汤森所指出的，“人们经常议论老年人口的保守性和反动特征，年轻人的进步和活力，这都是无稽之谈”（戴利和汤森，2001）。

2. 将老龄问题等同于老年人问题乃至养老问题，将老龄社会治理等同于老年人工作的开展和老龄事业的发展

老龄化的挑战常常被视为老年人数量增多所引发，老龄化的应对问题也常常被当作只是解决老年人的问题甚至只是养老问题，将这些议题过度聚焦于特定群体显然违背了现实逻辑。人口老龄化尽管暗含老年人口增多等数量性议题，但它在本质上是一个结构性问题，即人口年龄分布的结构性变动。老龄社会的老年人口比例尽管相较于传统为多，但依然是一个不同年龄阶段的人口群体共存共生的社会，而对于个体而言，老龄是其生命周期的必然阶段，这一年龄阶段与其他阶段的关联性在老龄社会的背景下更能突显其意义。已有大量研究表明老年人的健康水平取决于其年少时的健康行为积累，养老金的收支平衡依赖于当前劳动力群体的劳动产出（彭希哲和邬民乐，2009），因而老龄社会的可持续发展需要通过对不同生命周期人口的持续投资和引导而夯实。将老龄化议题过度聚焦于老年人群体既会造成不必要的社会焦虑和社会恐慌情绪，也不符合代际公平和共建共治共享的治理理念。

正是由于片面地将老龄化问题等同于老年人的问题，当前老龄社会治理研究与实践亦较多关注老年工作的开展和老龄事业的发展，而非老龄社会的整体性应对（吴玉韶，2018）。老年工作与老龄事业聚焦于如何为老年人口提供经济赡养、公共服务及精神慰藉等支助，这当然是政府重视民生并为应对当前的现实养老压力而产生的一种自然选择，然而老龄化所意味的年龄结构变迁将涉

及人口结构的各个层次和个体发展的各个阶段，仅仅关注老年人口显然无法全面应对老龄社会的诸多挑战。人生的不同年龄阶段是一个相互关联、彼此重叠的过程，只有将个体发展的各个阶段和人口结构的各个层次联系起来考虑，重视老龄社会的全民性和整体性，才能够夯实老龄社会治理模式的基础。

3. 较多推崇拿来主义，忽略了中国在老龄社会治理中的特殊性乃至优势

中国进入老龄社会相对较晚，在应对经验相对匮乏的情况下，参照或参考国际社会的通用性思路或一般性对策无可厚非。然而随着老龄研究的不断深化和实践经验的不断积累，我们必须清醒地认识到，人口老龄化在不同国家和地区的发展有其共性，但更多的则是个性化差异，国际社会的应对经验固然存在普遍性，但具体国家的具体治理格局必须基于其各自基本国情。西方发达国家大多于 20 世纪上半叶进入老龄化阶段，其时处于工业时代的尾声，纵观其治理经验，研究者极为关注西方社会日益深重的养老压力及其所引发的一系列发展困境（Lee and Mason，2011；Pifer and Bronte，1986；Schultz，2001），而由于福利刚性并囿于制度结构，这些研究往往聚焦于制度安排中市场与国家的二分。实践却表明，市场追求效率，市场经济发展成果自动惠及所有社会成员的现象并没有呈现；福利国家虽由政府提供相对完善的社会养老保障，却较大磨损了家庭养老功能，并招致财政危机与代际冲突，“找回家庭”反而成了重要的制度安排（Mishra，1984；Midgley and Tang，2001）。制度安排有着鲜明的国家特征，虽然这些提前进入老龄化的西方国家为后进者提供了丰富的“前车之鉴”，但对于中国这样的人口大国，基本国情、社会架构、发展阶段和文化特征等方面的差异使得我们无法生搬硬套其制度及政策模式，何况不少西方国家自己也正因此陷入债务泥潭而至今不拔。

与西方发达国家不同，中国是在信息时代进入了老龄社会，这为应对该挑战提供了全新的可能和机遇，但亦同时面临经济未发达、就业未充分和社会保障未完善等约束条件。如何在尚未全面实现现代化的条件下应对老龄社会的诸多挑战，中国目前尚无系统的他国经验可资借鉴，而只能基于我国的基本国情和社会现实形成中国方案。客观而言，当代中国在老龄社会治理中具备一定特殊性乃至优势，例如：①新中国成立后的长期发展，尤其是改革开放后逐步积累形成的海量发展红利，为老龄社会治理提供了稳固的经济基础；②事实已反复证明，中国政府在处理一些事关全局和涉及长期发展的复杂问题上，具有其他国家难以比拟的动员力和灵活性，这是老龄社会治理中最坚强可靠的主体力量；③以孝道为核心的传统文化给中国老龄治理提供了特殊的治理资源，将为老龄社会治理提供强大的文化伦理支撑和稳定的价值理念输出；④中国的大国优势与区域多样性可能会为老龄化治理腾挪出宝贵的时间与空间，这一

国家禀赋性优势将较大提高老龄政策体系的灵活性；⑤从更长远来看，以信息技术和生命科学为代表的科技革命正在深度改变现有的生产生活方式、产业格局、社会结构，并将可能成为中国经济增长的新引擎，同时为老龄社会治理提供更多的创新可能与技术支撑。

4. 在实践中过度关注人口老龄化应对的技术性，忽视了老龄社会治理的全民性和整体性

囿于体制资源等现实约束，并在上述认识误区和理解偏差的作用下，大量对策研究将老龄化的应对较多地视为一个技术性问题，常常过高估计老龄化问题的严重程度，且不同程度地存在着将老龄化视为“问题”或“挑战”的倾向，较多着眼于单项或局部的静态政策问题，并相对集中于三个方面。①以生育政策为重点的人口政策调整。人口生育政策的实施在规范我国人口生育行为乃至推动人口转变的过程中发挥了巨大功用，许多研究也自然而然地将应对老龄化的希望寄托于人口政策的改革完善，近期对普遍二孩政策的解读也大多聚焦于此。通过人口政策及其相关福利政策的适度调整的确能够在一定程度上改变人们的生育行为，并借此延缓老龄化的速度，为未来世代赢得应对老龄化问题的时间。然而，人口老龄化是人类寿命延长与生育水平下降共同作用的结果，其进程不可能因生育政策的调整而得到根本性逆转。②与老年人相关的政策调整。老龄化问题常常被看作只是老年人的问题，即如何为现在和未来的老年人口提供经济赡养和公共服务。现有政策聚焦于老年人口也是政府应对现实的、短期的老龄化压力而产生的一种自然选择。但老龄化已成为中国社会的常态，这一社会基本结构形态的改变涉及个体发展的各个阶段和人口结构的各个层次，仅仅调整对老年人的公共政策显然无法全面应对老龄社会的诸多挑战。③相关部门的政策调整。囿于体制资源等现实约束，相当多的老龄治理实践落脚于“部门政策”的调节或调整，如社会保障部门、民政部门、卫生部门等。然而在现实中，不同的政府部门往往专注于各自的功能和职能定位，相关部门之间职责交叉但界限不明确的情况时有发生，由于缺乏整合，出现政策冲突或政策衍生问题的例子并不少见，这更加剧了现有政策体系的碎片化与空心化，对其政策效能发挥反而产生了负面影响，并在一定程度上加剧了对老龄化压力的社会焦虑。

2.2.2　现有认知误区与偏差的主要机制分析

就人类认识发展的客观规律而言，社会需求永远是社会科学乃至科学发展的原动力。恩格斯曾指出社会一旦有技术上的需要，这种需要就会比十所大学更能把科学推进向前，当下老龄化研究的涌现正是其明证（中共中央马克思恩

格斯列宁斯大林著作编译局，2009）。然而现实社会始终是变动不居的，尽管在任何一个具体的时点或视角下，人们或许会根据经验或常识得出所谓的“客观”认知，但随着认知主体的发展与重构，这些认识和理解也需要继续深化乃至于出现革命性颠覆，人类的科学发展史中对此有无数印证，罗素（1982）还由此提出在认识过程中不能过度依赖经验。从这个意义上讲，对于人口老龄化这样一个相对较新的议题，出现认知误区和理解偏差是无可厚非的，然而具体到当前我国社会经济发展的现实情境和老龄社会治理的现实诉求，我们有必要在新的历史时期对这一问题进行分析性的认识总结，以正本清源、承前启后。

1. 社会认知发展所固有的慢同步特点

出于实用主义，现有研究倾向于将老龄化置入具体情境中而识别为一个相对独立的认知对象，遵循“问题-答案”式的思维路径，从而将老龄化的具体应对转化为一系列线性的技术性问题，如将老龄化压力等同于老年人压力乃至养老金压力、将老龄社会治理等同于老年人工作开展和老龄事业发展均属此列。无论在自然科学还是在社会科学领域，这种问题意识诚然是推动认识前进和发展的不竭动力，其积极作用毋庸置疑，然而对于许多超复杂结构或非结构化的认识问题，这种线性路径则往往趋于片面而不能从整体上对相关问题进行更为深入的研究。人口结构是一切社会结构的基础构件，更是社会变迁和科技发展的先决条件之一（Weeks，2011），因而人口结构的老龄化将涉及一系列超复杂系统问题，其影响更具有较大的弥散性，将可能渗透到人类社会生活的方方面面。尤其人口老龄化本身亦仍在不断发展之中，其认识边界呈现动态性，未来社会经济和科学技术的发展及老年人群体的演化都有可能超出人类现有历史经验，更为老龄社会的发展可能性增添了迷思。这不仅决定了我们不可能一劳永逸地解决老龄化带来的所有压力，更意味着我们必须在研究和实践的过程中不断修正我们的认识，而这种认识还将反过来不断调整乃至重构老龄化议题的内涵与外延。在这样的背景下，社会上有些人对于老龄化这一相对较新的议题因不甚了解而导致望文生义或断章取义，拒绝承认老龄化的常态化，乃至形成恐慌和恐惧的心理，这些都是可以理解的，社会共识的形成本就是一个逐渐及逐段发展的长期过程，存在固有的慢同步现象。

此外，对老龄化消极认知的背后还涉及一个认识和评价主体的问题。尽管老龄社会的老年人口比例有所提高，但社会的主体构成依然是非老年人群体。在这样的结构形态下，对老龄化的认知其实主要反映的是非老年人群体的态度与观念。当然，其中也不排除老年群体自身的态度和观念（甚至有些老年人还可能对老龄化及老年人存在负面认知），但因其所占人口比例相对较低而对整

体社会认知的影响有限。假如我们互换认识和评价主体，结果可能将截然不同，这不仅折射出认识主体对于认识活动的重要影响，也说明新现象、新事物、新议题本就很少会伴随掌声呈现。

2. 制度资源储备相对缺位引发若干社会焦虑

前已论及，人口老龄化本身并不构成问题，但其与现行以中青年为核心而设计运行的社会治理架构和制度结构相互不适应所产生的矛盾则多以挑战或压力的面貌呈现。从这个意义上讲，人口老龄化应对与老龄社会治理的关键在于制度及政策安排的适应、适配乃至重构。然而中国社会是在经济尚未发达、就业尚未充分及保障系统尚未完备的条件下迎来人口老龄化的，且相对于我们的社会经济发展水平而言，老龄化发展速度又明显过快，更将当前制度资源的相对缺位在短时期内予以放大。根据国家统计局所发布的数据并适度推算，60岁及以上老年人口占中国人口的比重在2000年首次突破10%，在2010年、2015年和2018年分别升至13.3%、16.2%和17.9%，老年人口的规模及比重还将在未来三十年持续快速增长，2030～2035年之后的高龄化（80+岁）趋势将趋于凸显，2050～2060年的人口老龄化可能会达到峰值，其后将略有回落并进入长期的高位平台期，这使得现有制度安排架构下的劳动就业市场和社会保障体系都将经受重大考验。根据世界银行的预测，2001～2075年中国基本养老保险的收支缺口累计将达9.15万亿元[①]，势必给国家财政带来严峻的挑战。与此同时，中国政府自20世纪80年代以后开始建立的社会保障体系的覆盖面仍显狭窄。尤其值得注意的是，中国的城乡二元经济结构所形成的二元社会结构，还使城市居民所享受的各类社会保障福利远未能覆盖到农村地区。我国财政用于社会保障的资金投入，大部分拨付给了城市居民，用于农村社会保障的公共支出非常有限，自2009年开始试点的新农保（新型农村社会养老保险）尽管进展很快，至今的覆盖面仍相对有限。随着老龄化进程加快和城乡人口迁移流动的持续，中国农村在养老、医疗等方面的压力相对于城镇将更加突出，特别是在西部地区。不仅如此，医疗保健和社会服务的相对滞后，以及传统家庭养老功能的弱化，也对中国的社会服务体系提出新的要求。仅养老机构的床位数量一项，便难以满足当前老年人群体的服务需求，这种情况于农村地区尤甚。

可见，利用当前老龄化发展的波动期和窗口期以尽快完成相关治理及制度资源储备，跳出传统制度和政策工具的束缚，与国家其他发展战略相融合，使之不局限于为老年人提供保障和服务，而是涉及社会保障、劳动就业、医疗健

①《项怀诚：养老体系面临考验，社保基金任重道远》：http://finance.sina.com.cn/fund/sbjj/20051024/09512058332.shtml，2005年10月24日。

康、科技教育等体系的重大持续变革，已成重中之重。

3. 社会文化变迁对社会观念和代际关系的影响

从历史上看，中国是一个按照人际关系和血缘关系而非地域原则进行统治的国家（梁治平，1997），其传统文化孕育出浓重的尊老成分，即所谓的孝文化或崇老文化。在传统社会中，这种文化模式具有强烈的伦理性和制度性特征，它不仅规范人们的行为，还主导了中国的主流社会价值（姚远，1999）。孝文化直接参与塑造中国人“家”的观念，使亲子关系成为中国家庭关系的核心，而不同于欧美国家的以夫妇关系为家庭轴心。亦因此，赡养父母对中国人来说是天经地义的职责，是自己对父母养育之恩的延期回报，由此而发展出的中国家庭养老文化绵延千载。然而，随着中国由传统社会向现代社会过渡，传统社会价值和家庭伦理已随之重塑，甚至在现代化理论和现代性的话语框架下，“传统”有时还被视为“现代化”的障碍之一，传统的养老文化和孝文化在不同层面受到了不同程度的冲击，而人口老龄化的出现则无异推波助澜。

尽管大量的个案研究与社会调查认为，老年人在家庭中权威的减弱似乎并未导致中国现代家庭养老方式发生重大变化，无论是住在一起还是分开居住，中国的老年人仍与他们的成年子女保持着频繁的交互关系（Whyte，2005）。但中国传统孝文化与崇老文化的衰退，使得以亲子关系为主要形式的家庭关系不得不“用血泪来丝丝切断”（费孝通，1998），老年父母与其成年子女之间浮现出越来越广泛的“等价交换”关系。有研究表明，父母对子女的投资及帮助（如早年的教育投资、经济援助，以及近期的照看孩子、做家务等家庭服务）同子女为父母提供养老帮助之间存在因果关系（陈皆明，1998）。人口老龄化促使中国的家庭养老由文化模式走向行为模式，具有越来越大的随意性（姚远，1998）。另外，在中国人口转变和社会转型并进的复杂背景下，家庭规模不断缩小，传统大家庭已不复存在，家庭功能不断弱化，提供给家庭成员的在生命周期不同阶段的支持和资源也逐渐减少，家庭内部的代际关系被迫实现社会化，这种过程在中国远比其他国家和地区更加深刻和迅速。以“孝”为核心的中国传统文化只能调节家庭内部资源的代际转移与分配，对社会资源的配置却无能为力（吴帆和李建民，2010）。伴随中国人口老龄化进程的推进，用于老年照料等的家庭资源与社会资源都变得相对稀缺，已经社会化了的代际关系可能会更多地表现为冲突而不是认同。目前中国的不同社会群体对老年人的主观评价，以及他们对老年人生存现状的客观评价，都存在一定的老年歧视（ageism）倾向（吴帆，2008）。人口老龄化进程的加速，使中国人对老年人的社会认知迅速地由伦理本位转向为道德本位，而道德的约束力在今天的中国尤其值得怀疑，以至于探望老人这一基本的家庭代际交往都必须通过法律来加

以规范，一些无视老年人需求、虐待老人的现象更时有发生。这种代际的断裂性或不连续性，已使得代际矛盾和冲突成为一种骤生的社会现实而凸显（周晓虹，2008）。在这些现象的背后，渗透出将老龄化等同于压力、负担、危机的观念乃至于将其妖魔化的倾向亦不足怪。

4. 传统生死观对老年观或老龄观的影响

中国传统文化伦理所隐含的若干理念和思维模式对当前老龄观和老年观的形成亦有不可忽略的影响，传统典籍中“未能事人，焉能事鬼？”“未知生，焉知死？”“圣人深虑天下，莫贵于生”等表述均对此提供了注脚。《论语》中“死”的出现频率要远高于“生”，孔子尽管没有避开死，但在对待生死的态度上却明显体现出对于现世生命的高度关注。这些对现世关注远高于来生的“贵生”思想体现在诸多方面，并充分渗透进传统的生命观和死亡观之中。“贵生”思想在历史上产生了积极的社会效应，并通过伦理规范进而要求人们珍惜生命和当下的生活。然而，人终究不可避免地要走向死亡。生与死构成生命之两极，在生与死不断抗衡的过程中，对死亡的体悟其实是理解完整生命历程的一把钥匙，海德格尔的“向死而在”就从生存论和本体论的角度对死亡赋予了更为积极的内涵（海德格尔，1999）。相比较而言，传统文化伦理及思想观念却使中国人在日常生产生活中很少论及死亡，死亡在本土文化语境中往往携带着莫名的禁忌和无端的恐惧。这种死亡忌讳具有引申性，作为距离死亡最近的群体，普通民众“讳老”和“忌老”的心理在很大程度上亦由此而来，并在生活中惯性地将“老”与“衰弱”画上了等号。在此背景与情境下，尽管医疗与科技的进步正使人口健康水平不断提高、寿命延长的可能性不断得以放大，然而我们对于生命末期的关怀却常常被忽略，我们对老年人最后生命历程的理论储备和现实经验由此显得不足。随着老龄化的加剧和老年人的增多，这些传统规训无疑将经受越来越多的伦理诟病。

2.3　应对老龄化的治理格局和战略思路转变

人口年龄结构是社会结构中最基本的形式，当其发生重大改变时，必然带来社会、经济乃至文化系统的全方位变化，进而要求制度和政策安排的相应调整乃至重构。人们观念的转变和制度形态的演变都需要过程，使得这种调整往往滞后于人口结构的改变。正是在这个意义上，人口老龄化所带来的挑战并不完全来自老年人或者老龄化本身，而更多源于现有的社会治理模式和公共政策体系不能满足老龄社会的发展需求。目前，中国特色社会主义已进入新时代，在社会主要矛盾转化的同时，社会经济面貌、科学技术水平和人民群众的生产

生活方式也发生了全面变革。作为社会发展的重要成果之一，中国的人口老龄化进程正与这划时代的变革相同步，并已经成为中国社会的常态。然而伴随着从社会管理到社会治理的社会建设路径升级，我国老龄治理格局却囿于其惯性和现实瓶颈及困境，仍未全面实现治理转型。在这样的背景下，积极应对中国人口老龄化必须跳出在传统逻辑框架内探讨防止或延缓老龄化的路径依赖，不仅应避免局限于“在旧框架内解决新问题”的思路，更要抛掉局部的、静态的治理模式调整或政策调节思路，从而从全局的、动态的视角来重新思考整体性治理的战略布局。立足于中国的现实情境，新时代老龄治理的核心应聚焦于整体性和可持续性，并兼顾其动态适应性和中国属性。因而应尽快形成政府主导下的多元共治格局，从“单打独斗”转为合作整合，重视全民参与和社会自治，在代际及群际均衡的基础上强调老龄社会的可持续发展，并始终根据社会发展状况不断调整其治理形态，通过不断提升大众获得感和增进社会和谐而最终达成老龄社会的“善治”。

具体而言，综合前文对公共政策视角下中国人口老龄化的反思和对现有治理研究囿限的分析，本章认为其新的治理思路中应首先实现转型的要点如下。

2.3.1　从强调“中国特征”向构建“中国优势”转变

系统应对老龄社会对全球社会仍是一个亟待解决的新问题，先期老龄化国家确有许多成功经验可为我所借鉴，我国学术界和政府部门近年在有关养老问题上的咨政建议和政策举措亦大多以先期老龄化国家的经验为对标或基础，这在我国老龄科学和相关政策研究的发展初期是一个必然选择。然而治理模式转型和制度体系改革是一个持续的过程，各国之间存在某些共同趋势，但更多表现出显著的差异和个性特征，无法简单地模仿引用。老龄化是一个全球性的发展趋势，但中国国情及所处时代的特殊性，使应对老龄化的中国方案必须基于中国思考。中国有强大而稳定的政府，其组织能力和资源配置能力使得在应对养老金等复杂议题时具备较大的灵活性和创新可能性（如国有资产划转充实社保基金），这也是我们的制度优势在应对人口老龄化上的集中体现。中国的大国优势与区域多样性也将为老龄社会治理提供宏观战略的施展舞台，并为资源配置提供巨大灵活性和政策腾挪空间。我们还有悠久的养老、孝老和敬老、尊老文化传统，这些传承数千年的中国文化是中华文明得以延续的重要基础，也将奠定中国式养老的价值理念基础，并极大拓展养老资源乃至应对老龄社会的资源格局。不仅如此，家庭始终是中国社会的中坚力量，中国家庭对代际责任和代际公平的诉求会在消化吸收社会转型成本的同时保持社会稳定，这将为我们应对老龄社会提供独特的优势和资源，并关系到当下中国社会能否在老龄化

的前提下顺利完成传统与现代的历史转换。应对老龄化的中国治理方案无疑应基于这些中国特征，并逐渐将其转换为中国优势。

2.3.2 从“碎片化管理”向“整体性治理”转变

应对中国人口老龄化的治理模式和政策体系并不是孤立的策略或对策集合，而是中国整体发展战略中的有机组成部分，它并不外在于“创新驱动发展/区域协调发展/可持续发展”、“科教兴国/人才强国”及“乡村振兴”等国家战略，也不是与“健康中国”、“新型城镇化”乃至“一带一路”等无关的问题，对老龄化的应对治理应更多置入国家整体发展框架中加以思考和布局，这自然需要首先突破传统体制机制的固有制约。

目前以部门为主导而形成的各种与老龄化有关的公共政策及管理不断呈现碎片化（fragmentation）及空心化（hollowing out）的趋势（郑秉文，2009），各类老龄政策在不同部门发展序列中的排位及政策优先对象的确定都要取决于相关部门对老龄事务的理解，更遑论部门权责交叉和政策摩擦的现象，这会使老龄社会治理模式和公共政策转变的许多基础性工作难以开展，源头性问题难以得到解决。老龄化的影响已经渗透到中国社会的各个领域，它所呈现的是一套跨越功能边界的非结构化公共事务问题，分工细密、层级分明、专业导向和行政驱动的传统政府管理模式难以实现有效的治理。因而，需要引入整体性治理（holistic governance）的战略视角来调节乃至重构目前我们为解决老龄问题而实施和运作的公共政策和公共管理体系。整体性治理是在 20 世纪末开始崭露头角的公共管理与公共政策理论的新范式（Perri et al.，2002），是在网络化治理、协作治理、合作治理、参与治理等微观治理形态上进一步形成的宏观治理格局。它首先对新公共管理运动所主张的分权、市场化和民营化进行了反思和调整，强调政府进行全面协调的必要性及能力；其次在传统的行政协调上引入新的协作伙伴和工具，丰富了协调对象和方式，并极为重视现代信息技术在治理中的作用；此外还改变了民众作为单纯服务消费者的角色，将他们转化为积极的公共服务生产者和治理主体，突破了传统公共行政学的本位主义（竺乾威，2008；陈振明和薛澜，2007）。当前我国的大部制改革、区域联动发展、部门间议事协调机制、一站式服务创新和基层民主创新，都部分体现了整体性治理的思路（敬乂嘉和陈若静，2009），但在老龄领域从整体性治理视角开展的研究实践还较薄弱，仅有个别研究显现。

本章认为在当前条件下实现老龄社会的整体性治理转型应尤其强调公共政策的跨功能性和跨部门性（或逆部门性）以实施整体战略，并以此为基础统筹不同社会子系统的资源以形成合力。一方面，西方发达国家的大量实践表明，以某一部门为基础制定的公共政策项目在实施过程中，必须有其他部门的配合

与支持，只有这样才能够达到该政策所要实现的目标（OECD，2002）。实现老龄社会整体性治理的关键在于发现和克服相关公共政策与管理实践中的“隙缝”和“漏洞”，通过放大政策合力效应以形成有效的治理网络，这要求政府通过自我调整乃至重构成为具有引导性、杠杆性和判别性的核心角色，从而形成跨功能、跨部门的治理机构或联合行动。另一方面，整体性治理需要强大的政府、市场和社会（包括家庭和社区），也需要它们之间对相关公共事务的基本认同、信任和亲密无间的合作（Osborne et al.，2013）。人的需要是通过多种渠道或系统来满足的，公共政策要想发挥持久有效的作用，就必须促进和协调各种不同资源共同发挥作用，而不是仅依靠某一项目、某一部门或某一社会系统来承担责任（张秀兰等，2007）。

2.3.3　从“贵生贱死”向“优生优死”转变

千百年来中华民族历经沧海桑田，但以孝道为核心之一的传统价值体系发展却未曾中断，并不断演化而成为中华传统美德的核心要件。孝道的传承不仅留下了丰厚的伦理遗产，也传下了许多动人的文化记忆。尤为可贵的是，孝道在推行的过程中并未走向狭隘化，反而从微观逐渐向宏观涌现，孟子的“老吾老，以及人之老”（《孟子·梁惠王上》）就是对此之良解。孝道尽管始于家庭，但在引导和推行时却未局限于内，而是外化为治理资源，其目的是使整个社会形成良好风尚。随着现代社会的转型和老龄化的深化，我们不应摒弃这一优秀传统，反而更需要构建与之相适应的伦理价值体系以充分彰显我们对于老年人和老龄社会的价值立场。当然，传统孝道中确有与现代社会发展不相适应的理念和要求，孝道要在老龄社会中发挥价值和功能，重构就成了不可或缺的过程（彭希哲和郭德君，2016），即在借鉴传统并立足现实的基础上构建与时俱进的现代孝伦理体系（彭希哲和郭德君，2018）。事实上，自近代以来，孝道在家庭及社会生活中的地位不断滑落，这一过程尽管与其在漫长历史中的主导地位和深远影响相比而较为短暂，但若从变化的剧烈程度来讲，则未有如近现代以来变化之大者。正是在这种历史和现实的反差不断扩大之际，我们更须以谨慎冷静的姿态重新审视传统文化，如此方能真正把握传统文化中具有较大恒定性和影响力的要素及工具，这既是老龄社会治理创新中所亟须的优质文化伦理资源，也是中华文化复兴乃至于中华民族伟大复兴的应有之义。

贵生贱死的思想在传统生命伦理学中占据了相对主导的地位。事实上，生命的有限性至少在当下仍然无法突破，我们应当理性地看待生命全程，生与死都是生命必须经历的不同环节。尤其作为距离生命终端相对较近的群体，老年人更须在生命的下半场直面死亡，这是无法逃避的现实。但是，现有的政策落脚点和社会注意力仍主要放在“生”上，健康老龄化和积极老龄化等宏观政策

框架亦不外如是，这对于消解人们对于老龄化的疑虑和恐惧自有其重大的积极意义。虽然如此，这毕竟在一定程度上折射出整个社会对于“死”的关注仍然不够，因为完整的生命观不可避免地内含着死亡观。从更深远的意义来讲，死亡意识的培养同时能使人在一个更为完整的视野下把控生命的具体节奏，从而过上一种更有意义的生活。因此，在老龄社会中，若每个人在内心深处拒斥死亡、在理性思考中悬置死亡，则显然是不适宜的，从这个角度而言，实现从贵生贱死到优生优死的转型，使人们能够积极地面对生命、平静地接受死亡，这也应是积极老龄化框架的进一步拓展。此外，理性生命观和死亡观的培育并不特定于老年人，而应覆盖不同年龄群体及贯穿人的整个生命周期。只有将生命观和死亡观的教育和引导置入个体的成长与社会的发展过程之中，才能真正营造起积极应对老龄社会的理性社会氛围，并由此发现乃至创造出若干新的应对资源与工具。生命观与死亡观的完善并不仅旨于提升老年人的生活和生命质量，更通过更新社会价值和社会观念而对传统文化伦理进行升级，并反过来重新诠释“老”、诠释“生”乃至于生命全程。

2.3.4 从聚焦于“老年人”向强调“全人口全生命周期”转变

与年轻型的社会一样，老龄社会也是一种正常的社会形态，只是老年人口超过了传统比重而已。应对老龄化的战略思考和治理选择可以粗略地分为两类：一类是在老年人口占较大比重的社会形态下的各类制度与政策安排如何适应和调整，以实现全民共同发展和社会福利最大化；另一类则主要是如何满足老年人口的经济安全、医疗保健、精神慰藉等方面的需求。这两类治理问题亟须整合，因而凸显了全人口全生命周期理念的重要性。从某种程度上讲，全人口全生命周期理念也是整体性治理的应有之意，但强调全人口全生命周期是为了强调老龄治理模式及相关政策体系的可持续性和代际公平原则。将老龄化问题过度聚焦于为老年人口提供经济保障和公共服务既易造成不必要的社会恐慌情绪，也不符合代际均衡的发展理念。一方面，人口老龄化的巨大惯性决定了老龄社会的应对战略不应是一种应急策略，还必须考虑到经济社会的可持续发展。尽管一些聚焦于老年人口的应急措施在缓解短期的现实压力方面非常必要，但从可持续发展的角度出发，老龄战略应充分考虑全年龄段人口的需求与价值，致力于寻求将再分配功能和生产性功能内在整合的发展型政策模式，在降低社会运行成本的同时，平衡短期应急目标与中长期发展战略。

另一方面，老龄化问题绝不是老年人的问题，未来老年人的健康和医疗保健支出问题在很大程度上需要通过对现在年轻人的健康投资和行为转变来改善，老年人的养老金问题需要通过提高年轻人的劳动生产率和推动老年劳动力的经济参与来缓解，老年照料负担的问题需要给家庭和社会资源合理而有效的

投入才能得到良好的解决。人生的不同年龄阶段是一个相互关联、彼此重叠的过程，只有将个体发展的各个阶段和人口结构的各个层次联系起来考虑，才能够夯实老龄社会政策设计的基础。WHO 相继提出“健康老龄化”（healthy aging）和“积极老龄化”（active aging）作为应对老龄社会的战略性目标，学界也提出过“生产性老龄化”（productive aging）和“成功老龄化”（successful aging）等战略命题[①]，这都在一定程度上体现了全人口全生命周期的理念。

2.3.5　从“以人口变动适应制度”向“以制度变革适应人口”转变

人口对一个国家的社会和经济发展、政治和文化传承均发挥着重要作用，人口众多亦是我国最重要的基本国情之一，但过分强调人口因素对中国社会各项发展所发挥的所谓主导性或决定性影响，并由此形成一种“以人口变动适应制度”的治理模式及政策调节逻辑，习惯性地通过干预人口发展来实现制度目标，则显然失之偏颇。事实上，一个国家或地区的人口发展是一个极为复杂的过程，与社会经济系统互构而共生，远不能为线性的因果逻辑所概括。早在 20 世纪初，不少学者、政府决策者乃至民众就已认识到，人口不是开启一切社会问题的钥匙，不能脱离社会制度抽象地看待人口问题。然而对待老龄社会治理这一复杂议题，“以人口变动适应制度”的政策调节逻辑当前仍为许多研究者所秉持，例如将调整生育政策、鼓励育龄人群生育作为扭转人口老龄化进程的最重要政策举措就是其典型之一[②]；再以养老金改革为例，现有系统的本质永远是一种靠后代养老的制度安排，因而就业人口的增长或稳定及就业时间的延长是养老金可持续性的人口学保障，以延迟退休为代表的现有政策调整大多出自此逻辑。随着生育率的长期走低、就业形态与模式的结构性变动，传统概念中的正规就业的增长空间已经越来越有限，而科技发展和人民生活方式改变也正在缩短人们的有效工作时间，依靠改变人口要素来满足传统制度安排的要求已变得越来越难。前文已强调，人口老龄化是中国社会的常态，我们对其只能适应而无法逆转。现有“以人口变动适应制度”式的政策调节模式，主要源于对老龄社会常态化这一重要前提认识的不足，其本质无异于强迫一个老年

① “健康老龄化”侧重成长的延续性，强调晚年的生活能力取决于早年生活的积累；“积极老龄化”也译为“活力老龄化”，其框架包含三大行动支柱：健康（health）、保障（security）和参与（participation），并尤其重视参与，它使老龄化问题不再局限于老年人，而成为全民参与的主题；“生产性老龄化”也译为“产出性老龄化”，强调年龄不应影响个体生产性的发挥，鼓励所有年龄阶段的人群积极参与社会经济发展；“成功老龄化”与“健康老龄化”在界定上存在交叉重叠，两者的政策倡导存在差异，“成功老龄化”更强调低疾病率、高体能/智能和积极参与（WHO，2002；Rowe and Kahn，1997；林卡和吕浩然，2016）。

② 需要说明的是，根据人口发展态势适时调整生育政策对于应对人口老龄化十分必要，通过改变人们的生育行为可延缓老龄化的速度，平缓因出生数量波动而造成的对社会经济的惯性影响，并为未来世代赢得应对老龄化问题的时间，但人口老龄化的进程不可能仅仅因生育政策的调整而得到根本性逆转。

人口已成为主体的社会，却不得不在一套以年轻人口为核心的制度架构中继续运行，因而其体制机制常有削足适履的倾向。在新的时代背景下有必要迅速转变思路以使老龄治理模式及政策调节逻辑逐渐向“以制度变革适应人口”转型，在适应人口老龄化的过程中，通过政策整合和制度创新及重构来协调这种变化的人口年龄结构与现有制度体系之间的矛盾。

另外，采用“以人口变动适应制度”的治理模式和政策调节逻辑来应对老龄社会在一定程度上也是被既有的思维定式所束缚，还在用工业时代的思维方式分析后工业时代和信息时代的社会形态，因而对老龄化的判断常常是负面的，应对之策也主要是短期的和非生产性的。目前社会上广泛存在着对老龄化的过度忧虑与不必要的恐慌，这些现象所基于的假设是：个体或群体一旦超过60岁/65岁，将从生产者或劳动力立即转化为被抚养者或负担人口。这种片面关注生理年龄的老年人和老龄化定义，忽视了老龄化的多元性、层次性、阶段性、动态性，以及巨大的个体和群体差异。这不仅始于人们对待“衰老”的粗糙的传统观念，也源于现有涉老政策体系的设计运行仍基于传统的评价指标和政策工具。不仅如此，考虑到我国发展不平衡所呈现的巨大区域差异，传统的老龄化指标无法反映老龄化对某一区域的真实影响，更难以体现其应对老龄化所具备的资源和能力。有鉴于此，有必要重新定义和定位“老年人”和“老龄化”，科学反映个体老化和人口老龄化的动态过程，突破现有老龄研究的桎梏、转变传统政策干预的套路，并逐步弱化大众对待老龄化的不必要的悲观态度。只有当公共政策不再机械地将“老年人”和“老龄化”与“负担”和“挑战”相等同，才能真正形成积极应对老龄化的良好环境。在这样的环境中，老年人不仅仅是需要支持和照顾的对象，延长退休年龄不仅仅是为了补充和平衡养老金，老龄化所带来也不仅仅是负担和挑战，同时蕴含机遇与希望。

第 3 章　老龄社会的治理体系与政府角色[①]

老龄化是人类社会不断发展和进步所形成的积极成果之一，但亦由此导致了若干不可忽视的问题。中国在 1978 年进入改革开放阶段之后，经济社会形态迅速变迁，现代化进程大幅提速，在妇女总和生育率迅速下降和人口预期寿命显著提高的情况下，中国在世纪之交时步入老龄社会。2015 年我们放开了二孩生育政策，该政策在改善人口年龄结构上的作用相对较为有限，老年群体的规模继续扩大，高龄化发展趋势日益明显。时值中国进入老龄社会 20 周年之际，有必要进一步反思，应该如何对老龄社会的发展进行有效干预，使我们的公共治理格局得以更加有效地回应老龄化的挑战。

当前针对老龄社会的公共政策与治理体系的研究已有不少，主要是从具体的政策领域出发，分析相关政策的效果及其调整方向。不少研究具有很高的质量，并产生了诸多积极的行政效应，但仍不能从整体上反映中国对老龄社会发展的治理回应，以及其中政府所应承担的角色（彭希哲和胡湛，2011；胡湛和彭希哲，2018）。不论是老年人的个体需求，还是老龄社会的整体需求，都在诸多不同维度上存在协调和整合的迫切需求，因而我们必须以更加全局化的视角来重新检视其现状及未来发展方向。

本章将综合运用治理理论，从行动者及其资源的视角出发，在理论上分析中国应对老龄社会的治理格局，以及其中关键的治理要素，并凸显政府所扮演的角色。本章的经验证据主要来自 1982 年到 2015 年的中央层面老龄政策文件，以及一些地方的政策实践。在经验分析基础上，本章将对未来老龄社会的治理提出政策建议。

3.1　老龄社会治理特征及政府定位

3.1.1　老龄化的复杂性需要复合治理体系

老龄化是复杂的社会经济现象。这种复杂性体现在以下几个方面。其一，老龄化本身是人类前所未有的发展现象，这使我们在代际制度、经济

① 本章作者为：敬义嘉。感谢肖丹、任媛媛和杜紫弦的资料收集和整理工作。

社会安排等方面均没有先例可循；其二，老龄化发生在人类经济社会加速变迁的时代，尤其是当前人类正处在以通信和数据技术发展为代表的第四次产业革命时期，再加上前所未有的全球化影响，增加了诸多变数；其三，现代社会对于个体（尤其是老年人）权利和社会可持续发展的强调因老龄化的深化而进一步凸显，这要求公共治理对于老龄化的回应趋于积极、精细、全面和可持续。

中国老龄化的发展还包含了更多的复杂性。首先，中国人口老龄化的速度相对过快。除了现代化所带来的自然后果外，20 世纪 70 年代以来实行的计划生育政策，通过高强度政策干预的形式极大削弱了老龄化所面临的生育“拉”力，迅速压低了妇女的总和生育率（郭志刚，2011）。这使得中国比印度提前约 40 年进入老龄社会，而后者的人口年龄结构在 70 年代初与中国类似。这种快速变化使得社会对老龄化的整体反应和调整能力受到限制。其次，中国的老龄化发生在社会大转型时期。这一时期，中国的家庭人口结构、产业结构、城市化水平、人口流动情况和社会生活状况都发生了巨幅调整，老龄化还与这些变化存在内在的相互联系和影响。最后，中国的整体发展水平与其老龄化水平存在一定程度的脱节，即通常所说的“未富先老”或“未备先老”，我们尚未跨越“中等收入陷阱”便进入了老龄化，这可能会在某些方面制约中国在应对老龄化上所具有的资源和技术能力（田雪原，2013）。

与老龄化的全局性和复杂性相对应，对其应对和治理的格局更应是复合性的，且这种复合性的内涵亦趋于多元。它首先是从老龄化面临的问题和由此产生的需求出发，要求在一个相对稳定的时期内能够对这些问题和需求做出全面协调的政策回应，也要求在较长的时间范围内，能够不断地对动态性变化和新衍生的问题和需求做出有效回应，尽量减少政策的滞后性和短期性。老龄社会治理体系能够提供多样化的资源，包容多样化的机制，其组合能够回应问题和需求的复杂性，其调整能够回应问题和需求的变化。这样的治理格局往往需要从一开始便尽量明确治理主体及其间的关系，而首要问题即是“谁来主导”和“谁来协调”。因此，老龄社会的治理体系，究其本质首先必须明确政府的角色定位。

3.1.2　政府在老龄社会治理体系中的角色

对老龄化及类似的现代社会问题的治理，工业化时代以来的现代国家主要强调公共主体即政府的作用，福利国家时代到来以后更是如此。政府作为一种治理方式，重点在于其政治的权威性和资源的充沛性，但由于其等级、规则、垄断等特征，以及在新的条件下的资源短缺，也会最终导致其治理的溃败（Tullock，1965；Osborne and Gaebler，1992）。20 世纪 90 年代以来，“更多

的治理”和“更少的政府”成为改革公共部门的一个重要取向。治理的基本取向是要强调政府的引领性作用和托底性义务，力争使其成为社会发展的中枢，将各方面的资源和机制衔接、协调和融合起来。其中，最为关键的是引入市场的经济资本和社会的社会资本，弥补政府在资源、信息、能力、生产力乃至合法性上的不足，形成复合的治理体系，将政治与行政资源、市场资源和社会资源有机整合，形成应对特定问题的全方位行动体系（Putnam et al.，1994；Savas，2000）。同时，政府本身的治理方式也需要经历重要的调整，要将其他部门的有效机制引入政府治理过程中，即公共部门改革本身构成了跨部门合作的基础。

因此，在老龄社会的治理体系构建上，以政府角色为转移，存在如表 3-1 所示的基本治理模式（敬乂嘉，2009）。当治理资源来自政府或其他具有国家权威的公共主体时，属于政府治理；当治理资源主要来自非国家的治理主体如企业、非营利组织或社区团体时，属于自治理；而当治理资源来自上述两种主体或其混合体，并存在相互交换、结合与共享时，属于合作治理。不同的治理方式往往针对不同的治理事务或情形，当其相互之间形成互补和配合时，就形成了元治理的复合治理局面。现实中，政府在不同的治理模式中均扮演了重要的角色。

表 3-1　老龄社会治理的基本模式

治理模式	治理资源来源	政府角色
政府治理	源自国家及其机构	实现公共部门体系内的政策与管理的统筹协调
合作治理	源自国家与非国家组织	运用多种协调机制，调动和实现多部门合作
自治理	源自非国家的组织	通过引育扶持与监督问责，鼓励民间社会对问题的自我解决
元治理	源自国家及其机构	对三种治理方式进行协调配合，在问题、需要和治理模式之间进行组合

资料来源：根据敬乂嘉（2009）[173] 调整

中国政府在老龄社会治理体系的构建中一直承担核心的角色。在 20 世纪 80 年代，老龄化程度较低，经济社会体制改革刚刚启动，老龄治理问题主要集中在对国有单位离退休人员的安排和适应市场化发展的社会保障体系的初步建立。政府一方面仍然是几乎唯一的老龄化治理主体，另一方面因为经济社会体制改革而相对缩减了其社会职能。在 20 世纪 90 年代，市场主体的逐步成熟，公私伙伴关系和民营化的发展，使得走市场道路解决老龄问题成为一个思路，社会化养老等实践开始萌生。我国在 1999 年正式成立的全国老龄工作委员会，作为国务院议事协调机构，承担了老龄政策问题的统筹规划和协调推进

工作，是老龄社会治理体系化建设的重要工作机制。到 21 世纪，随着国家社会职能的再认识与和谐社会理念的提出，以及财政收入的较快增长和社会组织的较快发展，通过政社合作来应对老龄问题得到认可和发展，养老的资源和服务供给得到强化。随着国家治理体系与能力现代化成为公共治理的改革核心，政府在老龄治理上的顶层设计、总体布局、统筹安排和协调推进等功能得到进一步增强。

3.2　中国老龄社会治理体系的发展

从应对老龄社会的治理体系建设的角度出发，本章将检验政府治理、合作治理和自治理等治理模式在中国的实际发育情况，并初步探索复合治理体系（元治理）的发育状况。为此本章从时序角度出发，大致以自然十年为区间，分析从 1982 年到 2015 年的老龄社会治理发展历程，即大约按照四个不完全相等的阶段进行时序分析。

本章的数据主要来自 1982 年至 2015 年中央政府及其组成部门发布的涉及老龄问题的规范性政策文件。本章将对这些政策文本进行分析。政策文本是政策的档案化和物质载体。政策文本的行文方式、话语逻辑、用词等都能够表明政策的变迁历程和演化逻辑，政策文本的外在表现形式如数量、发布主体等也能从侧面表明政策的变迁和治理的演进。

通过对国务院、中国老龄协会、民政部、人力资源和社会保障部等官方网站的查询，以及利用法律法规数据库“北大法宝”、搜索引擎等工具，在对政策进行相关性研判的基础上，本章最终确定 1982～2015 年的 1293 份有关老龄政策的文本作为分析对象，具有一定的代表性。以 1982 年为起点，主要是因为“82 宪法”的颁布，其中明确规定“公民在年老、疾病或者丧失劳动能力的情况下，有从国家和社会获得物质帮助的权利。国家发展为公民享受这些权利所需要的社会保险、社会救济和医疗卫生事业”，这为保障老年人权益提供了基本法律依据。同年，我国成立了中国老龄问题全国委员会，其是由政府部门、群众团体、科研机构和新闻单位联合组成的社会团体，负责对中国老龄问题进行调查研究、综合规划、组织协调和督促检查，并参加有关老龄问题的国际性和地区性专题会议，开展多边或双边技术援助和技术合作。因此，从基本法律结构和治理架构看，1982 年为我国老龄政策发展的重要节点。图 3-1 显示了 1982 年以来各年出台政策文件的数量变化。

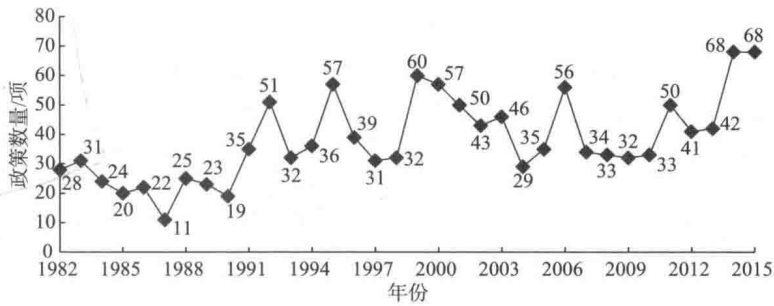

图 3-1　历年发布的老龄政策数量（1982～2015 年）

本章的主要分析方法是在对历年中央层面出台的政策文件进行编码的基础上，就各时期的特征进行时序分析，从而对老龄社会治理体系的情况和变化进行分析总结。在时期划分上，主要以各自然十年为分，即 1982～1989 年、1990～1999 年、2000～2009 年及 2010～2015 年。在运用中央政策文件的同时，本章也将利用一些其他数据进行补充分析。

3.2.1　政府治理的发展与演进

老龄问题的政府治理是以政府为主体所进行的政策制定与实施。1982 年以来的老龄政策发展，反映出政府在老龄问题上治理介入的深度和广度不断扩展，也反映出老龄问题的复杂性和严峻性不断增加。

1. 政府治理的强度不断提升

政府出台的老龄政策的数量在一定程度上反映了对老龄问题的重视程度和投入强度。自进入 20 世纪 90 年代以来，政府年出台政策的数量一直处在高位，在 2000 年正式进入老龄社会后，更是出现了一个高峰。在本章数据范围的最后两年即 2014～2015 年，则达到峰值（68 项）。从 4 个时段看，出台政策数量总量总体呈上升趋势，年平均出台政策数量也在增长（表 3-2）。其中，从 90 年代开始，专门针对老龄人口的政策数量在老龄政策中的比例有所下降，这反映了老龄问题在不同政府事务中出现的弥散趋势，即不同部门在制定其政策时，会考虑政策与老龄问题的交集，并在政策中包含相关的规定。

表 3-2　老龄政策文件的数量与类别（1982～2015 年）

年份	总数/项	老龄政策/项	涉老政策/项	老龄政策占比
1982～1989 年	184	108	76	59%
1990～1999 年	392	269	123	69%
2000～2009 年	415	193	222	47%

续表

年份	总数/项	老龄政策/项	涉老政策/项	老龄政策占比
2010～2015 年	302	135	167	45%
总计	1293	705	588	55%

注：表中老龄政策指专门针对老龄问题出台的政策；涉老政策指非专门针对老龄问题，但在政策中有直接涉及老龄问题的内容和规定

在出台的政策文件形式上，包括党的文件、法律、行政法规、国务院规范性文件、部门规范性文件、部门规章和司法文件等，表明了政策来源的多元性（表 3-3）。特别值得注意的是，国务院层面的政策制定增长较快，国务院规范性文件的数量增长较快。政策的数量主体是部门规范性文件和国务院规范性文件。

表 3-3　老龄政策文件的形式（1982～2015 年）（单位：项）

文件形式	1982～1989 年	1990～1999 年	2000～2009 年	2010～2015 年	合计
党的文件	34	33	20	6	93
法律	4	6	7	3	20
行政法规	0	2	14	8	24
国务院规范性文件	38	45	101	119	303
部门规范性文件	108	303	249	151	811
部门规章	0	2	7	9	18
司法文件	0	1	3	1	5
其他	0	0	14	5	19
总计	184	392	415	302	1293

2. 政府治理的领域不断扩展和变迁

老龄化带来多方面的问题和需求，相应的政策投入领域也是繁多的。表 3-4 归纳了 15 类老龄政策领域及其时序分布。整体看，改革开放以来，养老保险、离退休老干部事务和养老服务是三个最主要的政策领域，分别占政策总数的 35.7%、27.2%和 11.8%，总占比达到约 3/4（74.7%）。

表 3-4　老龄政策的政策领域分布（1982～2015 年）

政策领域分布	1982～1989 年	1990～1999 年	2000～2009 年	2010～2015 年	总计
参与社会发展	15 项（8.2%）	4 项（1.0%）	8 项（1.9%）	7 项（2.32%）	34 项（2.6%）

续表

政策领域分布	1982～1989 年	1990～1999 年	2000～2009 年	2010～2015 年	总计
法律责任	0 项（0）	6 项（1.5%）	11 项（2.7%）	5 项（1.66%）	22 项（1.7%）
计划生育	0 项（0）	0 项（0）	3 项（0.7%）	1 项（0.33%）	4 项（0.3%）
家庭责任	0 项（0）	0 项（0）	2 项（0.5%）	2 项（0.66%）	4 项（0.3%）
离退休老干部事务	113 项（61.4%）	149 项（38.0%）	78 项（18.8%）	12 项（3.97%）	352 项（27.2%）
历史遗留问题	2 项（1.1%）	0 项（0）	0 项（0）	0 项（0）	2 项（0.2%）
社会救助与优待	2 项（1.1%）	5 项（1.3%）	14 项（3.4%）	17 项（5.63%）	38 项（2.9%）
文体服务	2 项（1.1%）	6 项（1.5%）	9 项（2.2%）	7 项（2.32%）	24 项（1.9%）
养老保险	13 项（7.1%）	184 项（46.9%）	170 项（41.0%）	95 项（31.46%）	462 项（35.7%）
养老服务	1 项（0.5%）	6 项（1.5%）	47 项（11.3%）	99 项（32.78%）	153 项（11.8%）
医疗保健	12 项（6.5%）	9 项（2.3%）	31 项（7.5%）	18 项（5.96%）	70 项（5.4%）
宜居环境	0 项（0）	2 项（0.5%）	9 项（2.2%）	3 项（0.99%）	14 项（1.1%）
优抚	19 项（10.3%）	11 项（2.8%）	5 项（1.2%）	1 项（0.33%）	36 项（2.8%）
综合	5 项（2.7%）	7 项（1.8%）	23 项（5.5%）	24 项（7.95%）	59 项（4.6%）
其他	0 项（0）	3 项（0.8%）	5 项（1.2%）	11 项（3.64%）	19 项（1.5%）
总计	184 项	392 项	415 项	302 项	1293 项

具体来看，各时段的政策重点出现了明显的变化。20 世纪 80 年代有 61.4% 的政策均为离退休老干部事务，反映了在计划经济体制向市场经济体制转型的初期，对老干部福利待遇的维护成为老龄政策的核心，也是政治稳定的重要方面。随着经济市场化的推进和单位制的逐步解体，以及人口流动的大幅增加，社会化的养老保险在 90 年代成了老龄政策的新重心，数量占比接近一半。该阶段离退休老干部事务的政策仍然占比接近 40%，一方面说明了其持续的重要性，另一方面也是因为相关政策往往比较具体，导致其数量较多。到 21 世纪第一个 10 年，养老保险成为无可比拟的重心，离退休老干部事务的重要性有所降低。2010 年以来，形势再次发生变化，养老服务崛起成为最重要的政策领域（32.78%），占比略微超过了养老保险（31.46%），而此时离退休老干部事务的政策数量已经变得微不足道。

因此，整体而言，老龄社会的治理发生了如下几个主要变化。第一，老龄政策从特惠走向普惠，即从人口中占据极少数的离退休老干部，扩展到面向人口中占绝大多数的一般老龄人口。第二，从行政方案走向社会方案。针对老干部的政策措施主要是行政与财政手段，而养老保险引入了社会保险的模式。第

三，从经济保障走向服务供给。养老保险主要是聚焦老有所养中的经济收入来源问题，在该问题逐步得到制度保障的发展形势下，优质、可靠、安全的老年服务逐渐吸引了更多的政策关注。

3. 政府治理的协调性不断提高

老龄问题是复杂的社会现象，老年服务多样化并且相互关联，因而老龄问题的整体性往往由于政府部门的职能分工边界而无法得到回应。基于此，部门间合作在老龄政策的制定和实施上具有很强的重要性。为此，本书课题组对1982～2015 年有关政策的发布部门进行了统计，该信息既能揭示老龄政策的核心部门，也能够反映出老龄政策在部门间的交叉和协调（表 3-5）。

表 3-5　老龄政策的发布机构及其频次

发布机构中的第一部门	计数/项	第一和非第一部门	计数/项
国务院（含办公厅）	330	国务院（含办公厅）	374
民政部	170	财政部	248
劳动和社会保障部	142	民政部	240
财政部	66	劳动和社会保障部	165
劳动部	65	人事部	109
中国共产党中央委员会组织部	57	劳动部	80
人事部	55	人力资源和社会保障部	71
人力资源和社会保障部	54	全国老龄工作委员会	65
中国共产党中央委员会	49	中国共产党中央委员会组织部	62
全国老龄工作委员会	40	卫生部	51
劳动人事部	32	中国共产党中央委员会	51
卫生部	31	劳动人事部	48
全国人民代表大会	20	中国人民解放军总政治部	44
中国保险监督管理委员会	12	中国人民解放军总后勤部	28
国家卫生和计划生育委员会	10	国家发展和改革委员会	25
建设部	10	国家税务总局	24
煤炭工业部	10	建设部	22
国家发展和改革委员会	9	全国人民代表大会	20
最高人民法院	8	中国共产党中央军事委员会	20
国家税务总局	7	国家卫生和计划生育委员会	17

续表

发布机构中的第一部门	计数/项	第一和非第一部门	计数/项
国家体育总局	7	中国保险监督管理委员会	17
文化部	7	中华全国总工会	17
邮电部	5	教育部	16
中国人民银行	5	文化部	16
中国残疾人联合会	4	中华全国妇女联合会	13
交通部	4	公安部	12
司法部	4	中国残疾人联合会	12
住房和城乡建设部	4	国家体育总局	11
国务院侨务办公室	4	中国人民银行	11
国家教育委员会	3	煤炭工业部	10
教育部	3	司法部	10
能源部	3	中国共产主义青年团中央委员会	10
商务部	3	国务院侨务办公室	10
水利部	3	中国人民解放军总参谋部	9
中国共产党中央委员会宣传部	3	中国共产党中央委员会宣传部	9
中国人民解放军总政治部	3	住房和城乡建设部	8
国家机关事务管理局	3	最高人民法院	8
国家人口和计划生育委员会	2	国家教育委员会	7
公安部	2	国土资源部	7
国家计划委员会	2	商务部	7
国家经济体制改革委员会	2	中共中央直属机关事务管理局	7
国家科学技术委员会	2	国家计划委员会	7
国家新闻出版广电总局	2	国家中医药管理局	6
国家宗教事务局	2	交通部	6
监察部	2	科学技术部	6
中华全国妇女联合会	2	国家计划生育委员会	5
铁道部	2	国家广播电影电视总局	5
中央精神文明建设指导委员会	2	国家经济贸易委员会	5
电力工业部	1	国家经济体制改革委员会	5
对外贸易经济合作部	1	邮电部	5

续表

发布机构中的第一部门	计数/项	第一和非第一部门	计数/项
发展家庭服务业促进就业部际联席会议办公室	1	中国银行业监督管理委员会	5
中国共产主义青年团中央委员会	1	国家工商行政管理总局	5
国家工商行政管理总局	1	监察部	4
国家机构编制委员会	1	水利部	4
国家劳动总局	1	中国银行	4
国家民族事务委员会	1	中央精神文明建设指导委员会	4
国家体育运动委员会	1	铁道部	4
国土资源部	1	国家人口和计划生育委员会	4
农业部	1	中央机构编制委员会办公室	3
全国敬老爱老助老主题教育活动组织委员会	1	国家科学技术委员会	3
全国企业兼并破产和职工再就业工作领导小组	1	国家旅游局	3
审计署	1	国家食品药品监督管理总局	3
国家食品药品监督管理总局	1	国家统计局	3
中央机构编制委员会	1	国家新闻出版广电总局	3
中国共产党中央委员会统一战线工作部	1	能源部	3
中共中央直属机关工作委员会	1	农业部	3
中共中央直属机关事务管理局	1	国家药品监督管理局	3
中国关心下一代工作委员会	1	中国老龄协会	3
中国老龄问题全国委员会	1	中国证券监督管理委员会	3
中华全国总工会	1	国家机关事务管理局	3
中国共产党中央军事委员会	1	国家文物局	2
中国人民解放军总参谋部	1	工业和信息化部	2
中国人民解放军总后勤部	1	国防科学技术工业委员会	2
国家计划生育委员会	1	国家发展计划委员会	2
		国家开发银行	2
		国家劳动总局	2
		国家体育运动委员会	2
		国家质量监督检验检疫总局	2

续表

发布机构中的第一部门	计数/项	第一和非第一部门	计数/项
		国家宗教事务局	2
		审计署	2
		国家质量技术监督局	2
		中国工商银行	2
		中国民用航空总局	2
		国家机构编制委员会	2
		城乡建设环境保护部等 31 个部门	1
总计频次	1293	总计频次	2170

注：本表中的不同时期部门，因机构改革可能存在前后传承的关系

表 3-6 从政策的发布单位数量来看部门间的协作。在 1982～2015 年的 1293 项政策中，有 389 项（占 30%）政策是由 2 个及以上部门联合制定和发布的，表明老龄政策有相当数量都是在部门间的讨论和协作过程中产生的。这还不包括本身具有部门间协作能力的国务院（含办公厅）、中国共产党中央委员会和全国老龄工作委员会等部门所制定的政策。从 4 个时期来看，并没有明显的差异，但较多部门如 10 个及以上部门作为政策发布机构的情况，在 20 世纪 90 年代以来才出现。

表 3-6　部门联合发布政策的情况（1982～2015 年）（单位：项）

政策发布单位数目	1982～1989 年	1990～1999 年	2000～2009 年	2010～2015 年	总计
1	128	249	294	233	904
2	51	65	62	35	213
3	10	25	28	10	73
4	10	17	16	7	50
5	3	9	5	8	25
6	0	2	0	1	3
7	0	1	1	1	3
9	1	0	2	2	5
10	0	3	4	3	10
11	0	1	1	0	2
16	0	0	0	1	1
17	0	1	1	0	2
19	0	0	0	1	1

续表

政策发布单位数目	1982～1989 年	1990～1999 年	2000～2009 年	2010～2015 年	总计
21	0	0	1	0	1
合计	203	373	415	302	1293

此外，老龄政策的跨部门协调还特别体现在于 1999 年成立的全国老龄工作委员会。作为国务院议事协调机构，全国老龄工作委员会的一个关键职责是对涉老问题进行多部门协调。通常，全国老龄工作委员会由一位国务院副总理任主任，并由若干部级单位的副职领导作为成员，办公室设在民政部（2018 年调整后设在国家卫生健康委员会）。全国老龄工作委员会的工作机制和结构实质上是一种内嵌于行政体系的政策网络，可以更直观地反映在老龄事务上的政府内协调情况。根据 1999 年《国务院关于成立全国老龄工作委员会的通知》，以及在 2003 年、2008 年和 2018 年下发的《国务院办公厅关于调整全国老龄工作委员会组成人员的通知》，图 3-2 显示了全国老龄工作委员会的治理网络结构。该图中的 4 个中心方块代表了 4 个时期的全国老龄工作委员会，圆圈是其组成部门，三角则是组成部门中的全国老龄工作委员会办公室所设在的部门。从图 3-2 可以看出，全国老龄工作委员会结构相对稳定，成员数量持续增长。虽然该图显示在 2018 年的机构改革中，有相当数量的部门首次进入全国老龄工作委员会（见图 3-2 右侧），但其中相当部分是发生了更名的原成员单位。

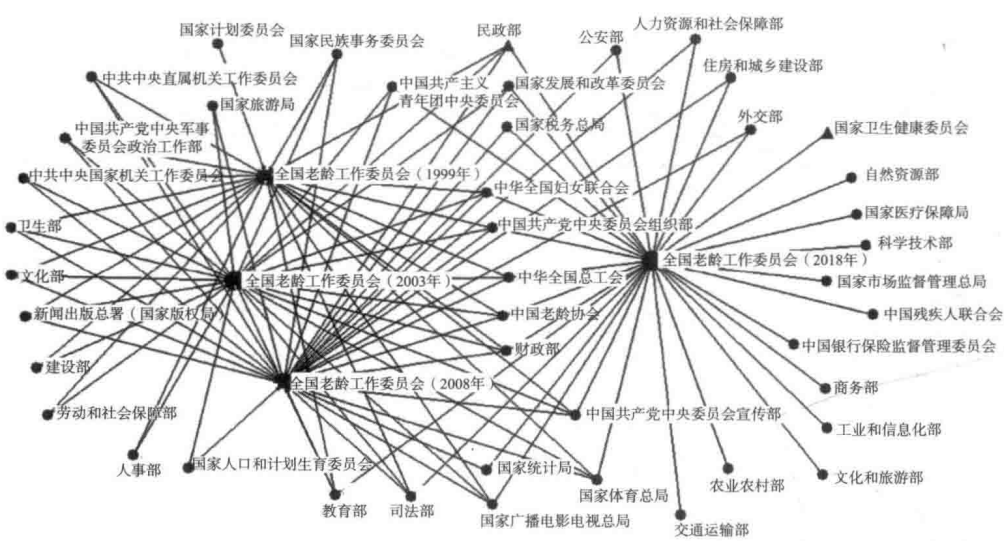

图 3-2　全国老龄工作委员会的治理网络结构（1999 年，2003 年，2008 年，2018 年）

本图中的不同时期部门，因机构改革可能存在前后传承的关系

为进一步观测全国老龄工作委员会的部门网络，表 3-7 对其 4 个阶段的网络结构进行了列示和统计。总的来看，4 个阶段中，全国老龄工作委员会的组成部门逐渐增加，分别为 22 个、25 个、28 个、31 个，包含国务院组成部门、国务院直属机构、国务院直属事业单位，也包括了党的机构、群团组织，组织结构对应了老龄事务的多元性和复杂性。全国老龄工作委员会的组成部门相当稳定，很多“退出”的情况，主要是部门调整尤其是大部制改革所致，如文化部和国家旅游局均不在 2018 年组成部门之列，但实际是被新设立的文化和旅游部所替代。表 3-7 所体现的动态变化，主要反映了两方面发展。第一，政府对老龄化社会治理的复杂性认知不断增强，因此不断将新的部门引入到该政策网络中，以期获得对政策的全面协调和同步推进。第二，全国老龄工作委员会办公室长期设在民政部，但 2018 年该办公室改设在新成立的国家卫生健康委员会，同时国家卫生健康委员会内设老龄健康司。这个变化反映出国家目前在老龄工作上的重点，已经由以前的社会保险和社会福利转向老年人的医疗和健康等方面。

表 3-7　全国老龄工作委员会的治理网络结构

成员单位	1999 年	2003 年	2008 年	2018 年
财政部	√	√	√	√
国家体育总局	√	√	√	√
中国老龄协会	√	√	√	√
中国共产党中央委员会宣传部	√	√	√	√
中国共产党中央委员会组织部	√	√	√	√
司法部	√	√	√	√
教育部	√	√	√	√
国家广播电影电视总局	√	√	√	√
中华全国妇女联合会	√	√	√	√
中华全国总工会	√	√	√	√
民政部	全国老龄工作委员会办公室	全国老龄工作委员会办公室	全国老龄工作委员会办公室	√
新闻出版总署（国家版权局）	√	√	√	
卫生部	√	√	√	

续表

成员单位	1999年	2003年	2008年	2018年
文化部	√	√	√	
国家民族事务委员会	√	√	√	
中国共产党中央军事委员会政治工作部	√	√	√	
中共中央直属机关工作委员会	√	√	√	
中共中央国家机关工作委员会	√	√	√	
劳动和社会保障部	√	√		
建设部	√	√		
人事部	√	√		
国家计划委员会	√			
国家发展和改革委员会		√	√	√
中国共产主义青年团中央委员会		√	√	√
国家人口和计划生育委员会		√	√	
国家旅游局		√	√	
公安部			√	√
住房和城乡建设部			√	√
人力资源和社会保障部			√	√
外交部			√	√
国家税务总局			√	√
国家统计局			√	√
工业和信息化部				√
农业农村部				√
自然资源部				√
国家卫生健康委员会				全国老龄工作委员会办公室
交通运输部				√
科学技术部				√

续表

成员单位	1999 年	2003 年	2008 年	2018 年
商务部				√
文化和旅游部				√
国家医疗保障局				√
国家市场监督管理总局				√
中国银行保险监督管理委员会				√
中国残疾人联合会				√
总计部门数/个	22	25	28	31

注：本表中的不同时期部门，因机构改革可能存在前后传承的关系

3.2.2　合作治理的发展与演进

老龄社会的合作治理涉及老龄政策的决策和执行等多个方面。基于我国政治体制的基本特征和发展阶段，当前在该领域的合作治理主要体现在政策的执行和操作领域。合作治理主要是在涉及老龄问题的各方面事务上，政府有组织、有步骤地引入市场经济组织和社会服务组织，使其参与相关服务的提供和事务的解决，以改变从计划经济延续下来的以政府和家庭为主的传统。

老龄领域对外部组织和能力的引入历史较短，从 20 世纪 90 年代才逐步开始，主要是将社会力量进入到专门为老年人提供养护、康复、托管等服务的福利性、非营利性的老年服务机构的设立和运营中，包括老年社会福利院、敬老院、养老院、老年服务中心、老年公寓等，以缓解老年服务机构供不应求的局面。在一些地方实践的基础上，民政部在 1999 年颁布实施了《社会福利机构管理暂行办法》，开始系统性地引入社会力量兴办老年服务机构。2000 年财政部、国家税务总局发布了《财政部 国家税务总局关于对老年服务机构有关税收政策问题的通知》，这些老年服务机构获得了减免税待遇及捐赠税前抵扣的待遇。

此后，引入社会力量和社会资本的一个重心始终是兴办老年机构及相关老年服务业和老年产业。例如，2005 年民政部印发的《关于支持社会力量兴办社会福利机构的意见》和 2010 年国务院印发的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》等。2012 年民政部印发《民政部关于鼓励和引导民间资本进入养老服务领域的实施意见》，鼓励民间资本参与居家和社区养老服务、举办养老机构或服务设施、参与提供基本养老服务，以及参与养老产业发展。政府和社会资本的合作模式（public-private partnership，PPP）得到提

倡和推广。

近年来，政府购买老年服务是另外一个主要发展趋势。2008 年全国老龄工作委员会办公室等 10 个部门联合下发《关于全面推进居家养老服务工作的意见》，提出积极培育和发展居家养老服务组织，按照政府职能转变以及与企业、事业、社团分离的原则，对居家养老服务中能够与政府剥离的服务职能都要尽可能交给社会组织和非营利机构，以及市场和企业。此后，购买老年服务在各地得到较为广泛的采纳。2011 年国务院办公厅印发《国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划（2011—2015 年）的通知》，要求开放社会养老服务市场，采取公建民营、民办公助、政府购买服务、补助贴息等多种模式，引导和支持社会力量兴办各类养老服务设施。在 2013 年《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》印发后，2014 年财政部等联合印发《关于做好政府购买养老服务工作的通知》，确立了购买养老服务的工作框架。总体看，21 世纪以来，老龄政策文件中所采纳的政策工具，越来越多地使用市场的、社会的或准市场的、准社会的工具。

顶层框架的逐步完善对基层实践起到了引领和保障作用。目前，政府与社会组织合作发展最快和效果最明显的领域是政府购买养老服务，其合作的深度、广度和规范程度都引人瞩目。上海市作为政府购买公共服务领域的探路者，相关实践一直走在全国前列。1996 年，上海市浦东新区政府通过外包形式，由上海基督教青年会运营“罗山市民会馆”，打破了以往依靠政府单方面投入和管理的机制，开创了上海市“政府主导、各方协作、社团管理、市民参与”的社区服务新模式。2000 年，上海市率先在机构养老方面探索政府购买公共服务，对民办养老院的床位给予开办和运营补贴。此后政府购买养老服务逐步发展。2007 年上海市静安区将居家养老体系建设列为政府一号实事工程，以政府购买公共服务为核心的居家养老建设已经形成较为成熟的体系和制度。“乐龄助餐”是做得最好的服务之一，其以“老年用餐项目推进办公室”作为中介组织，为实现街道、市场和社区组织的连接发挥了独特优势。上海市提出了“9073”计划，即到 2010 年实现 90%的老年人由家庭自我照顾，7%的老年人享受居家养老服务，3%的老年人实现机构养老。

2009 年 5 月，在前期政府购买社会服务实践和经验总结的基础上，上海市民政局拨出 3500 万元福彩公益金的预算进行社区公益服务项目招投标试点，并在以后年份不断扩大招标规模。政府购买服务采取公开和竞争性的招标方式，主要在安老、扶幼、济困、助残等福彩公益金支持的社会服务领域开展。表 3-8 总结了 2009～2014 年上海市社区公益服务项目中的养老项目的实施情况。

表 3-8　上海市社区公益服务项目中的养老项目实施情况（2009～2014 年）

年份	合同数量/个	投标数量/个	平均合同价格/元	总成本节约/元	总成本节约率
2009～2010 年	61	196	409 367	1 567 807	5.91%
2011～2012 年	78	218	423 190	1 233 689	3.60%
2012～2013 年	91	192	471 492	1 631 612	3.66%
2013～2014 年	88	157	430 906	993 494	2.55%
总计	318	763	436 496	5 426 602	3.91%

资料来源：根据上海市社区服务中心的档案资料自制

注：2010～2011 年该项目暂停实施

通过引入外部的服务生产者，以合作方式提供服务，政府转变为服务的界定者、供给者和监督者，而把直接提供服务的过程交给合同商，利用其运营能力优势，实现更好的合作服务提供。这种水平的合作模式（如图 3-3 的右边部分）与传统的政府提供模式相比（如图 3-3 的左边部分），通过充分利用市场竞争下的优胜劣汰机制和老年服务所需要的各种复杂服务能力，有可能取得更好的服务效果。在长期的购买服务合作过程中，政府和外部组织可以逐步发展和深化共同决策和共同治理的局面，即政府将外部组织引入公共决策的过程中（敬义嘉，2014）。

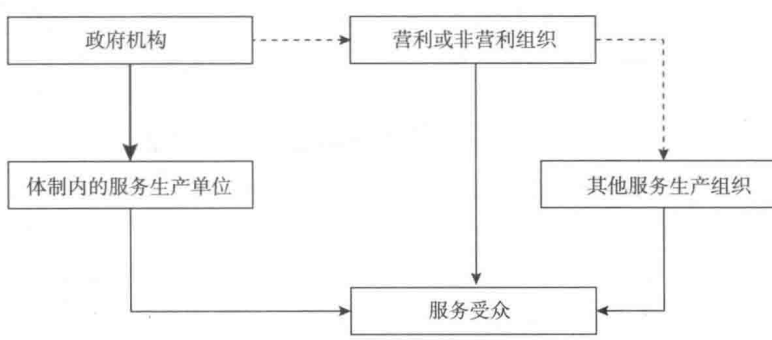

图 3-3　老年服务提供的政府模式和市场模式

粗实线代表行政指派关系，虚线代表合同关系，细实线代表服务提供

3.2.3　自治理的发展与演进

自治理是指主要由非国家的组织所实现的公共服务提供和社会事务治理。自治理是对现代国家治理的补充，它既存在于国家无力到达或不想到达的地方，也存在于社会希望能够自治而避免或减少国家介入的地方。自治理发展的程度受到多方面因素的影响，如国家财政的能力、国家和地方的文化传统、自

治理组织的发育程度等。从我国的情况来看，老龄事务的自治理发展存在有利和不利的条件。包括国家财政能力在内的国家能力的增强，既提高了国家参与和干预老龄事务的主动性，也带来公民对国家在养老服务提供上的更多期望；但是从整体来看，与老龄化的急速发展和由此产生的治理需要相比，国家能力尚有很大不足。虽然社会组织、公益文化等得到更多认可，但是“大政府”的文化传统在中国仍然有很大市场。近年来老年社团组织和服务机构增长速度很快，但其往往对政府有较大依赖性，社会与社区联结性差，在业务发展和专业性追求上缺乏激励，公益性特征不明显。这些因素都使得在自治理的需求和供给上还存在很大的缺口。

当前，推进老龄事务自治理的首要任务是要培育老龄组织及其领导和管理人才，使他们能够独立或在政府协助下解决社区和社会中存在的各类老龄事务，并提供公益性的老年服务。在推动老龄社会组织发展上，行政手段和市场手段各有其优劣，也都得到了应用。通过行政手段促进社会组织发展的方法是迅速和可控的，但这种方法也会造成政府的过度干预及社会组织发展活力的不足。因此，行政手段往往被准行政手段所替代。例如，上海市静安区社会组织联合会是一个枢纽型社会组织，受静安区民政局领导，下辖静安区内五个街道的社会组织联合会及区内的文化、教育、养老等不同领域的联合会，形成“5+X”的结构，为当地社会组织提供一系列支持和服务，包括组织孵化、注册协助、能力建设、培训服务、信息交流、宣传推广、网络建设和资源共享等。截至2016 年 1 月底，全区共有 980 家社会组织，比 2012 年增长 140%，其中规范化建设 5A 级 19 家、4A 级 46 家、3A 级 86 家，主要分布于社会服务、教育、体育、文化、工商服务业、科学研究、卫生等领域，成为参与社会治理、促进社会和谐的一支重要力量。此外，以柏万青志愿者工作室为代表的一些老年社会组织在当地乃至全国都享有很高的知名度。

市场和准市场手段的采纳为社会组织的发展提供了更大的灵活性、参与性和自主性。一个特别的范例是公益创投的兴起。上海市民政局在 2009 年首先启动了公益创投项目，目标是对初创期的社会组织提供组织发展支持。公益创投是发源于西方的基于市场的社会创新模式。尽管该项目由上海市民政局资助，但整个运营管理过程都交给了恩派公益组织发展中心，而后者是一个相当草根化和专业化的社会组织。在首年项目期间，恩派公益组织发展中心通过标准程序，为 57 个社会组织提供了总计 1000 万元的资助，这些组织中的相当部分从事老年方面的服务。之后，公益创投模式在全国扩散，深圳、广州、东莞、昆山等很多地方均采纳该模式来培育社会组织。

由于我国长期以来严格的社会管理体系，包括基层广泛存在的街居体制，在扩展老龄社会自治理的同时，必须要解决其与现有社会管理体制之间的零和

博弈问题。因此自治理的发展只能是渐进推进的，其整体特征是与国家之间的高度协调和配合。

3.2.4　元治理的初步格局形成

当政府治理、合作治理和自治理以有机方式形成互补和配合时，就形成了元治理的局面。本章利用老龄政策中所运用的政策工具，分析老龄事务治理中的元治理格局和政府决策。结合我国老龄政策的实际发展情况，依据政策实施主体及机制的差异，将养老政策工具划分为行政工具、准行政工具、市场工具和社会工具四种类别（表 3-9）。行政工具是指政府直接提供服务或进行规制，治理资源主要来自政府，如提供补贴、设定标准和发布规定等；准行政工具较行政工具而言，其强制性较弱，政府主要是提供信息和资源，并对市场和社会开放，如购买服务等；市场工具是引入市场资源和机制，如由私人公司提供商业保险等；社会工具则是指家庭、社会组织和社区主体开展老龄事务治理并提供服务。

表 3-9　老龄政策中的政策工具分类和示例

政策工具	种类细分	示例
行政工具	提供补贴	对城镇低收入残疾人个体户缴纳基本养老保险费给予适当补贴
	设定标准	将农村养老保险个人账户计息标准和退保计息标准进行调整
	发布规定	要求企业和个人缴纳的养老保险费，转入社会保险管理机构在银行开设的“养老保险基金专户”
准行政工具	提供信息	全面抓好宣传贯彻《中华人民共和国老年人权益保障法》工作
	购买服务	通过市场化方式，把适合的老年人照顾服务项目交由具备条件的社会组织和企业承担
市场工具	商业保险	推动商业保险机构提供企业（职业）年金计划等产品和服务
社会工具	家庭	国家建立健全家庭养老支持政策，鼓励家庭成员与老年人共同生活或者就近居住
	社会组织	放宽外商捐资举办非营利性养老机构的民办非企业单位准入
	社区	鼓励和引导单位、社区（村）、家庭和个人行动起来，形成政府积极主导、社会广泛动员、人人尽责尽力的良好局面

表 3-9 反映了政府在推动老龄问题元治理中的积极角色，即政府积极地就不同老龄事务配置相应的政策工具，从而推动不同类型治理资源的进入和治理模式的采纳。此外，同一项政策可能会使用一种以上的政策工具，通过政策工具的搭配，形成不同治理资源与模式的搭配。表 3-10 清晰地显示出，随着时间推移，行政工具的使用呈下降趋势，并在 2010 年后不再是政策工具的主体；

而准行政工具、市场工具和社会工具的应用则不断增加，已经从行政工具的补充成为政策工具在数量上的主体。

表 3-10　老龄政策中的政策工具使用（1982～2015 年）

年份	行政工具	准行政工具	市场工具	社会工具	总计
1982～1989 年	180（96.3%）	4（2.1%）	1（0.5%）	2（1.1%）	100.0%
1990～1999 年	339（76.0%）	94（21.1%）	1（0.2%）	12（2.7%）	100.0%
2000～2009 年	314（58.6%）	154（28.7%）	20（3.7%）	48（9.0%）	100.0%
2010～2015 年	163（38.1%）	142（33.2%）	52（12.1%）	71（16.6%）	100.0%
总计	996（62.4%）	394（24.7%）	74（4.6%）	133（8.3%）	100.0%

注：由于数据进行了四舍五入修约，因此比例合计可能存在不等于 100.0%的情况

表 3-11 显示了对政策工具的复合使用。如果一项政策仅使用了一种政策工具，我们将其定义为单一性政策，而将使用了两种及以上政策工具的定义为混合性政策。该表显示，单一性政策始终是我国老龄政策的主体，但比例逐渐下降；混合性政策则逐步增加。

表 3-11　老龄政策中的单一性和混合性政策（1982～2015 年）

年份	单一性政策	混合性政策	总计
1982～1989 年	179 项（97.8%）	4 项（2.2%）	183 项
1990～1999 年	339 项（86.3%）	54 项（13.7%）	393 项
2000～2009 年	312 项（75.2%）	103 项（24.8%）	415 项
2010～2015 年	207 项（68.5%）	95 项（31.5%）	302 项
总计	1037 项（80.2%）	256 项（19.8%）	1293 项

对政策工具的分析显示，我国老龄政策中存在明显的元治理思维，且不断根据经济社会发展的实际情况进行动态调整。政府是老龄事务元治理的动力基础和理性核心。

3.3　未来老龄社会治理的政府工作要点

本章基于政策文本资料，对 1982 年以来中国对于老龄议题的治理体制发展脉络和现状进行了分析总结。中国的老龄问题、政府职能与结构演变，以及

政府、市场和社会关系等与西方显著不同，因此在治理格局上，虽然理论和现实上均存在政府治理、合作治理和自治理等不同的治理形态，但其各自的发育程度和相互关系，与西方社会都有较大差异。整体来看，政府治理仍然是当前老龄社会治理的核心，并且仍然在经历大幅调整和完善，以实现老龄治理的现代化。政府仍然是应对老龄化的关键力量，其工作重点逐步转向老年健康和养老服务等领域。合作治理则迅速成长，正成为政府在新时代实现其老龄职能的关键抓手，但主要是在政策实施阶段和服务生产层面，外部组织尚缺乏足够的专业能力和政治地位来构建深层次的合作治理格局。自治理作为政府治理的一种替代模式，尚缺乏成熟的制度支撑和稳定的资源来源，但其社会合法性正在潜滋暗长中。元治理作为一种对老龄事务的全面均衡治理，政府是协调中枢，并正在发挥基础性作用。

对老龄治理体制的分析表明，为了促进所谓的“善治”，对所谓“更少或更小的政府”必须正确理解。“更少或更小的政府”是一个动态的调整和平衡，政府可能在直接的操作运营领域有序退出，但在政策制定和资源供给上，仍然承担主要的甚至扩大的责任。“善政”是“善治”的前提。今后老龄社会的治理，需要的是一个“更强的政府”，能够有效顺应老龄社会需要，主动调整治理架构，丰富治理模式，从而形成不同治理主体同步发展和协同合作的良性治理格局。

为此，今后在老龄社会治理格局塑造上，政府可以考虑强化两个领域的工作。首先应逐步建立健全老龄社会福利体系的政策框架。政府要更加善于对老龄社会的各项问题进行研究、预测和规划，对老龄社会福利与服务的内容进行设计，找准老龄工作重点和政府责任重心，通过政策制定和政府组织与制度构建，形成有利于老龄社会治理的政策与制度激励，逐步形成基于科学研究的动态调整的老龄政策整体性治理体系和各政策主体沟通联动的实施体系，主要运用政策工具和杠杆对老龄人群和各老龄工作主体进行行为调节。在政策制定和实施上，政府要始终坚持和加强其核心竞争力，确保其政策领导力和规划控制力；同时，逐步探索将企业、社会组织和公民制度化地引入公共决策的过程中。

其次，政府还应逐步建立健全老龄社会福利体系的多元执行体系。一方面，政府仍然要承担老龄工作的基础性的、托底性的、监管性的工作，要承担市场与社会无激励、无能力和不适合的工作。另一方面，政府要通过资源供给、政策支持、信息提供等多种方式，将市场和社会可以高效提供的服务，采取多种灵活方式合作提供。此外，提供良好的监管环境和政策激励，指导和鼓励为老服务领域的市场和社会组织的发展和业务创新，在丰富老龄社会资源投入的同时，减轻财政压力和政府负担。政府可以对老龄社会的服务性工作进行全方位的梳理，在政府、市场、社会、家庭和个人的多元化提供和共同生产上进行顶层设计和逐步推进。

第 4 章　老龄社会的中国家庭与家庭政策[①]

作为社会制度的核心之一，家庭或直接或间接地投射出人类历史和社会发展的基本轨迹。中国自古便有“集人成家，集家成国”的说法（吕思勉，2007），这种“家国同构”的传统逻辑使家庭在中国不只是生产与再生产的经济单元，而且还是秩序单元、教化单元和福利单元，并负有社会化和保护其成员的责任。在相当长的历史中，中国的家庭制度都保持其巨大的内在稳定性，不少理论也都认为家庭不可能迅速发生巨变（Whyte，2005）。但新中国成立之后，尤其是改革开放以来，深刻的社会经济变迁重新刻画了中国家庭乃至整个中国社会的形貌，中国政府更通过人口与社会政策的制定与实施直接参与了家庭活动，成为中国家庭变迁的巨大推力。中国的家庭变迁与快速的人口转变相同步，并深深地内嵌于中国社会转型的进程之中（胡湛和彭希哲，2012）。不仅如此，转型期的中国社会还赋予家庭重要的福利与保障职责，而对家庭的支持却非常有限，家庭在整个公共政策领域中甚至是一个较少被提及的概念（张秀兰和徐月宾，2003），中国家庭已面临诸多发展困境。

从某种意义上讲，重视并支持家庭应当成为中国老龄社会治理的一个重点乃至特点。诺贝尔奖获得者阿马蒂亚·森曾指出，中国必须在建设其未来的同时不背弃其过去（森，2002）。从某种意义上讲，家庭便映衬着中国的过去与未来，它是最具中国特性的本源型传统（徐勇，2013），更是当代中国社会转型与制度变迁的历史起点和给定条件。经历了剧烈变迁之后，中国的家庭及家庭政策如何在超越传统局限性的同时注重传统的延续性，将直接关系到当下中国社会能否在老龄化的前提下顺利完成传统与现代的历史转换。而这些，都需要首先对当代中国家庭变迁具有相对宏观的理解。

4.1　当代中国家庭变迁与家庭政策

4.1.1　对传统中国家庭的再认识

尽管大家庭（即联合家庭）曾被普遍地认为是中国历史上的主流家庭形态，

① 本章作者为：胡湛、彭希哲、邵洲洲、吴开亚。

但大量的历史数据已对其证伪。早在战国时期，各诸侯国主要出于军事的考量即提倡早婚以增加出生人口，并开始关注核心家庭与生育之间的关系。不仅如此，不同于欧洲传统的长子继承制[①]，诸子均分家产的制度在中国从战国之后便被一贯推行。商鞅变法时更采取“民有二男以上不分异者，倍其赋”的政策，以此强制父子、兄弟分家建立小家庭。秦统一后直至明清，中国家庭历经“汉型家庭—唐型家庭—宋型家庭”的模式变迁。尽管在魏晋南北朝曾短暂出现过少数“千人共籍”“百室合户”的特大型家庭，宗族伦理与基层治理需求也使得三代及三代以上的直系家庭长期占据一定比例，但由父母与未成年子女组成的核心家庭户却一直是民间的主要家庭形态之一（王天夫等，2015）。不仅如此，由于存在户等制度和按户抽丁税等政策设计，百姓虚假分家或合户以避徭役税赋的做法在各朝各代都难以杜绝，政府推行按户分田、按土地征税（如计田出夫、摊丁入亩）等政策更进一步促进了民间分家立户（张国刚，2007）。有研究表明，最晚至 18 世纪中后期，中国核心家庭户所占比例已超过 50%（王跃生，2000）。这说明古代中国的法规制度既有维系大家庭的一面，也有促其分居立户的一面，但这些影响都主要体现在户口籍帐中登记的人口变动上，民间大多还是按照实际生活需求组建家庭。

进入近代，小家庭主流化的趋势更加显著，随着清末和民国时期的城镇发展和社会变动，核心家庭户和 5 人及以内的主干家庭已成为当时家庭户类型的主流形态。与此同时，当时的一些社会理论家还认为中国传统家庭观念和大家庭模式是建设现代化国家的重大障碍，西方核心家庭被视为现代家庭的理想形式，家庭改革进而与强国梦紧密相连（沈奕斐，2013），这些文化因素无疑对当时的家庭模式产生了一定影响。

新中国成立初期，土地改革导致大量农村家庭分家立户，中国家庭户数量激增、规模锐减。此后，高生育率和不断下降的死亡率使得家庭规模略有增大，直至 20 世纪 70 年代后随着生育率变化，家庭规模开始了持续快速的缩小。这一时期，一系列以集体主义为主导的社会变革将个人从家庭中脱离出来嵌入城市单位/社区或农村人民公社，进一步弱化了原先家庭承担的诸多功能。即便如此，由于受到国家实际福利支付能力等的限制，在新中国成立的前三十多年间，个体的生存与生活依然受制于家庭，家庭被规定为个体难以脱离的消费共同体与福利共同体，家庭与单位或公社共同成为国家生活资源配置制度与个体生活需求之间的中介，有学者称之为福利家庭化（陈映芳，2010）。

不难看出，由于历史条件和制度环境的不同，中国传统家庭的边界具有很

① 中国传统中也有长子继承制，但不同于欧洲的长子继承制。中国的长子继承制，是长子继承世袭爵位宗室身份，而财产则实行诸子均分制，并且以国家律令的形式作规范。然而，欧洲传统社会的长子继承制包括了继承财产，以防家族封地和财产实力因后代的分割导致变小、变弱。

大的模糊性和不确定性，但其内核仍体现出某种一致性。其一，大家庭从来都不是中国家庭的主要类型，小家庭（主要是核心家庭户和 5 人及以内的主干家庭）居多的情况在中国历史早期就已出现，并非近现代骤现。其二，有相当多的理论认为，经济发展、文化传播和国家对社会的改造是促进家庭变迁的三大机制（Goode，1963），中国的情况亦印证了这种论断，但国家改造在近现代中国家庭变迁中的作用更为显著。此外，从中国历史早期起，政府所主导的人口变动便反复与家庭变迁互嵌，并直接影响了分家立户的可能性和不同家庭类型的比重（曾毅，1987）。其三，中国家庭在历史中常被工具化，国家对其改造亦由此时有自相矛盾处。这一传统具有较大的惯性，国家、政府往往会出于治理需求而对家庭实施工具性操作，并成为家庭变迁的巨大推力。

4.1.2　老龄化进程中的家庭政策与家庭变动

改革开放之后，快速的人口转变与剧烈的社会变迁持续影响着中国家庭的发展。一方面，人们经常有一种误解，即中国的人口政策中已经蕴涵了家庭政策。事实上，尽管人口政策与家庭政策经常在某些领域中同时发生，但它们之间更多体现为一种互补而非包含关系（孙常敏，2010）。我国政府自 20 世纪 70 年代开始推行的人口计划生育政策及项目，其本质是通过对家庭进行生育调节来达到有效控制人口规模增长的目的，如破除“养儿防老”的观念就是计划生育的宣传逻辑之一。与此同时，计划生育还催生了大量独生子女家庭，加速并加剧了中国家庭的小型化，这一进程更由于中国社会经济的快速发展而进一步提速。

另一方面，随着城市单位制和农村人民公社制度的解体，政府主导的社会保障和社会福利项目日益成为城乡居民日常生活的必需，政府已经成为最大的公共服务和福利保障的提供者，而大多数的公共服务和福利保障均以个人为基础并大都以就业作为其准入门槛，且在家庭成员之间不得转移。家庭福利很长时期仍主要表现为补缺模式（胡湛和彭希哲，2012），即将重点放在了问题家庭与那些失去家庭依托的边缘弱势群体上，如城市的“三无对象”和农村的“五保户”[①]等，而那些拥有家庭的社会成员，则必须首先依靠家庭来保障其生存与发展需求，政府和社会只有在家庭出现大范围的危机或困难时才会以应急的方式进行干预。

近年来，政府对家庭功能的强调正与日俱增，“减轻国家负担、增加家庭和个人责任”逐渐成为多支柱社会保障体系的主导思想，地方政府也习惯性地

① 城市的“三无对象”指市区内无家可归、无依无靠、无生活来源的孤寡老人、残疾人、未成年人、精神病人；农村的“五保户”指享受保吃、保穿、保住、保医、保葬（孤儿保教）待遇的家庭。

将社会福利打包给家庭，相关压力和矛盾也顺带被一并转移，这在各种有关城市住房政策、普及教育、公共服务均等化等制度安排中都有着明显的体现（陈映芳，2010）。家庭在重新变得重要的同时，也被迫消化了大量社会转型的成本，其规模、结构和稳定性发生了很大变化。在实际的政策实施中，不仅缺少对非问题家庭普遍而形式多样的支持，而且在一定程度上忽略了家庭变迁导致家庭脆弱性增强的事实，忽视了家庭在养老、抚幼等方面的经济与社会成本。从某种意义上讲，这意味着拥有家庭的人反而得不到政策的直接支持（张秀兰和徐月宾，2003）。

家庭的种种变迁日益成为摆在学术研究者和政策实践者面前的重要议题，但对其进行面面俱到的深度解读却又极其困难。一方面，不同国家或民族语言中“家庭”的内涵与外延不尽相同，费孝通先生早在 1930 年就指出，英文中的“family”完全不同于中文的“家”，为此他还提出用“extended family”（扩展家庭）作为“家”的译法（费孝通，1998），家庭对中国人的意义不仅在于夫妻之间，更在于亲子及代际之间。另一方面，家庭研究缺乏量化资料，尽管家庭关系立足于姻缘、血缘，但在空间上却可能是割裂的，研究对象的不易确定造成了数据资料的不易获取。出于实用主义，家庭户（household）[①]由此在很大程度上被作为家庭的代表或近似指标（胡湛和彭希哲，2014）。

无疑，我国的人口普查为家户研究提供了丰富的研究资料，本章亦由此结合 1982～2010 年历次人口普查数据，分析我国当代家庭户变动的主要趋势。从这些普查资料来看，中国改革开放之后 30 年多来的家庭户变动体现出诸多新情况新特征，尤其以下三个方面是公共政策所不可回避的主题。

1. 家庭规模小型化与结构简化

在计划生育政策实施、人口迁移流动加剧等因素的多重作用下，我国家庭户数增长速度明显高于人口增幅，家庭户规模在近几十年来呈现出不断小型化的趋势。1982 年“三普”时 5 人及以上家庭户比重仍近半，但 1990 年以来 1～3 人户的比重开始快速上升，至 2010 年已达到约 65%。这使得 2010 年我国家庭户平均规模仅为 3.10 人，比 1982 年少了 1.31 人，减幅近三成，而这一阶段的家庭户数增幅则近一倍（表 4-1）。此外，家庭户规模的缩减趋势在城市和农村趋同，且收缩都比较迅速，曾经在农村常见的大家庭正在快速消失。

① 家庭户定义的核心是居住关系，即居住在同一门户里。

表 4-1　我国家庭户规模变动状况

年份	户数/万户	户均规模/人	1 人户	2 人户	3 人户	4 人户	5 人户	6 人及以上户
2010	40 151.7	3.10	13.66%	24.37%	26.86%	17.56%	10.03%	6.63%
2000	34 049.1	3.44	8.30%	17.04%	29.95%	22.97%	13.62%	8.11%
1990	28 830.0	3.96	6.27%	11.05%	23.73%	25.82%	17.75%	15.38%
1982	22 537.9	4.41	7.97%	10.08%	16.05%	19.54%	18.35%	28.00%

资料来源：1982～2010 年全国人口普查抽样数据

注：由于数据进行了四舍五入修约，因此比例合计可能存在不等于 100.00%的情况

在此背景下，一代户和二代户是当代我国家庭户的主体。但随着二代户比重持续下降、一代户比重大幅提升，我国家庭户结构正进一步趋于简化，家庭户内的代数趋减。就具体结构类型来说，尽管核心家庭户仍是中国家庭的主要形式，但随着单身户的大量增加和多代扩展家庭长期维持较大比重，我国家庭户结构的基本格局已从 1982～2000 年的“核心户为主、扩展户居次、单身户补充”转变为 2000～2010 年的“核心户为主、单身户与扩展户居次”，如表 4-2 所示。

表 4-2　我国家庭户结构的变动状况

家庭户结构	1982 年	1990 年	2000 年	2010 年
一代户：				
单身户	8.0%	6.3%	8.3%	13.7%
夫妇户（一代核心户）	4.7%	6.4%	12.7%	18.5%
其他一代户	1.2%	0.8%	1.3%	1.2%
一代户小计	13.9%	13.5%	22.3%	33.4%
二代户：				
父母与未婚子女（标准核心户）	48.2%	54.4%	46.3%	33.4%
单亲父母与未婚子女（缺损核心户）	4.6%	3.6%	2.9%	2.7%
分居父母与未婚子女（缺损核心户）	6.9%	4.0%	3.2%	3.3%
其他二代核心户	2.5%	1.9%	1.1%	0.5%
二代核心户小计	62.2%	63.9%	53.5%	39.9%
父母与已婚子女（二代直系户）	3.8%	3.3%	2.3%	3.1%

续表

家庭户结构	1982 年	1990 年	2000 年	2010 年
祖父母与孙子女（隔代户）	0.7%	0.7%	1.9%	2.3%
其他二代户	0.6%	0.2%	1.0%	3.3%
二代户小计	67.3%	68.2%	58.7%	48.6%
三代及以上扩展户：				
三代户	16.4%	16.5%	16.6%	16.5%
其他扩展户	2.4%	1.8%	2.4%	1.6%
扩展户小计	18.8%	18.3%	19.0%	18.1%
合计	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

资料来源：1982～2010 年全国人口普查抽样数据

注：由于数据进行了四舍五入修约，因此比例合计可能存在不等于 100.00%的情况

需要指出，我国各类核心家庭户[①]的总体比重在 1990～2010 年降幅明显。从历次普查资料来看，一代夫妇核心户和二代标准核心户分别是升幅最大和降幅最大的家庭类型。2010 年夫妇核心家庭户占全部家庭户的比例增至 18.5%，而二代核心家庭户的比重则锐减为 39.9%。“五普”以来二代核心家庭户数量的下降主要是单身户和夫妇核心家庭户的大量增加所致。这些都充分表明在中国人口转变和社会转型的过程中，随着低生育率的持续和城市化的推进，以及住房条件的改善和家庭观念的转变，越来越多的大家庭“裂变”为小家庭。

尽管核心家庭户一直是中国家庭的主要形态，但扩展家庭户仍占较大比重，尤其是其中的三代家庭户是我国维系得最稳定的家庭类型，1982～2010 年一直保持在 16.4%～16.6%。然而，今天的三代家庭户与传统的三代家庭户存在本质区别，最重要的一点就是“共居而不共财”（王跃生，2006），这也将直接或间接地影响到家庭模式与功能的变迁。

2. 家庭老龄化与居住模式变化

人口老龄化已成为现代社会的常态（彭希哲和胡湛，2011）。在这一大背景下，中国家庭老龄化的现象也在不断加剧，主要表现为有老年人的家庭比重上升和家庭中老年人口比重增加。“六普”资料显示，2010 年中国有 60 岁和 65 岁及以上老年人的家庭数量分别为 1.23 亿户和 8803.6 万户，占全部家庭的 30.6%和 21.9%，比 2000 年有明显提升。其中，约 2/3 的家庭户中有 1

① 包括一代夫妇核心户、二代标准核心户和二代缺损核心户等。

个老年人，但有多个老年人的家庭户增长趋势明显快于有单个老年人的家庭户。

与此同时，随着低生育水平长期持续，家庭内的孩子却越来越少，中国家庭正在经历少子老龄化的进程。

随着时间的推移，家庭的少子老龄化将进一步加剧家庭养老困境。目前我国养老保障的覆盖广度和支持力度还非常有限，来自家庭内部的代际支持仍是我国老年人保障和照料的主要来源，大部分老年人也都与他们的子女同住（包括孙子女）。1990 年老年人（65 岁及以上）与子女同住的比重与 1982 年基本相当，但是 2000 年和 2010 年老年人与子女同住的比重则相继下滑了近 10 个百分点和 15 个百分点（表 4-3）。从 2000 年到 2010 年，80 岁及以上高龄老年人与子女同住的比重分别为 75.8%和 63.8%，其中 2000 年的比重与 1982 年和 1990 年相比保持了相对稳定，但至 2010 年却骤降 12 个百分点。

表 4-3　我国老年人家庭的居住安排模式

老年人家庭居住安排模式	1982 年	1990 年	2000 年		2010 年	
	65 岁及以上	65 岁及以上	65 岁及以上	80 岁及以上	65 岁及以上	80 岁及以上
独居老人	12.2%	9.6%	9.6%	12.4%	12.5%	17.5%
老年夫妇（一代核心户）	13.7%	17.1%	23.9%	11.2%	29.2%	16.8%
老年夫妇与未婚子女（标准核心户）	6.9%	6.6%	5.0%	1.7%	3.6%	1.7%
单个老年人与未婚子女（缺损核心户）	4.6%	3.8%	3.1%	4.6%	2.3%	3.1%
其他二代核心户（扩大核心户等）	3.4%	2.7%	2.3%	2.1%	2.8%	2.0%
老年人与已婚子女（二代直系户）	3.5%	3.7%	5.2%	12.3%	6.9%	13.6%
老年人与孙子女（隔代户）	3.8%	3.7%	5.2%	6.2%	5.6%	5.0%
老年人与子女及孙子女（三代直系户）	47.2%	47.4%	41.4%	38.0%	32.8%	30.0%
其他扩展家庭户	3.8%	4.8%	3.6%	10.9%	3.2%	8.4%

资料来源：1982～2010 年全国人口普查抽样数据。此外需要说明，本章中的老年夫妇不仅包括夫妇双方均为老年人的情况，也包括仅一方为老年人的情况

虽然与子女同住仍是老年人居住安排的最主要类型，但其比例在 1990～2010 年来持续降低，尤其是“多代同堂”的比重在 2000 年首次降到了半数以

下，至 2010 年更降到了四成左右，不再是绝对主导的老人居住安排模式。与之相对应，老年人独立生活的家庭户比重却持续提高，2010 年已超过四成。其中，老年夫妇家庭户的比例在 1990～2010 年提升了 12.1 个百分点，是增幅最快的老年人居住类型。总的来说，老年人独立居住模式和传统意味强烈的“多代同堂”模式已开始并列成为我国当前老年人居住安排的两大类型。

老年人独居现象的不断增多，原因有两种。一方面是生育水平持续下降导致少子化严重，减少了家庭人口；另一方面的原因是住房条件改善，从物质上使独居更成为可能，尤其是较年轻和健康的老年人或老年夫妇倾向于自己单独居住。“六普”资料也显示，65～79 岁的低龄老年人中超过九成基本健康并具有生活自理能力，相对降低了他们对子女照料的依赖性；同时，工作流动的加快，子女外出求学、务工等迁移现象越来越多。尽管联合国曾提出“老年人独立居住的趋势不仅符合发达国家国民喜好独立生活的愿望，而且也越来越成为发展中国家国民的一种主动选择”[①]。但在社会福利制度缺位或不完善的情况下，中国在“独居老人”这一议题上有着明显的问题化取向，因为它已不仅是个人问题、家庭问题，更是一个亟待解决的政策命题。

3. 非传统类型家庭大量涌现

全国人口普查数据还显现出我国家庭户类型多样化的趋势，主要表现为非传统类型的家庭大量涌现，如纯老家庭、空巢家庭、隔代家庭、丁克家庭、大龄单身家庭、单亲家庭等。在生育率持续走低、人口老龄化加速、人口迁移流动加剧的背景下，这些非传统家庭的类型和数量很可能会越来越多，并越来越难以应对中国社会转型过程中所产生的各项结构性冲击。

纯老家庭是指全部由老年人组成的家庭户。“六普”资料显示，2010 年我国有全部为 65 岁及以上老年人组成的纯老家庭户近 3000 万户，约占家庭户总数的 8.1%，占全部有老人家庭户总数的三成。除了常见的纯老空巢家庭，有两类纯老家庭形态特别值得重视：一类是低龄老人与高龄老人组成的二代纯老家庭户（一般是低龄老人与自己的高龄父母同住）；另一类是老人与兄弟姐妹同住的一代纯老家庭户，这些家庭户中的老人很多都是膝下无子女或者子女常年工作在外。不难看出，传统的家庭养老模式正以新的形式继续存在并发展，当生育资源所转化出的家庭养老资源日渐稀释，而相关的社会保障又远未完善，老年夫妇相依为命、老年人与同龄兄弟姐妹、低龄老年人和自己的高龄父母选择生活在一起相互扶持。

又如隔代家庭是指祖父母与孙子女同住但没有中间一代的家庭户。其比重

① 中国老龄问题全国委员会办公室：《联合国老龄问题资料汇编》，内部资料，2002 年。

在 2010 年为 2.26%，虽只比 2000 年增加 0.37 个百分点，其数量却增加了 260 多万户，更是 1990 年和 1982 年的 4.70 倍和 5.75 倍。隔代家庭户明显集中在农村地区，这说明当前农村中青年夫妇二人一同外出务工并将子女留给家乡的父母照看的情形增多。这种隔代家庭尽管从形式上应归于二代家庭户，但从代际关系上看，其属性却更接近于三代家庭户。因为中间一代虽然并未与他们的父母和子女住在一起，但他们与留守乡间的隔代家庭户的经济互动都比较频繁，也经常回家探望他们的父母和子女，由此在一定程度上承担了抚幼和赡老的责任。而且从某种意义上讲，由于中间一代大多选择赴我国东南沿海等较发达地区的城市务工，其收入远高于在家乡时的水平，因此也提高了其承担家庭责任的能力，但这种家庭模式对老人健康、子女教养乃至社会公平等方面的负面影响正吸引了越来越多的社会关注。

从对改革开放以来家庭政策和家庭户变动的梳理中不难看出，当代中国经历的是人口与家庭的“双变迁”，快速而激烈的人口转变加快了家庭户变动的进程，并引入诸多不确定性。稳定的超低生育水平、快速的人口老龄化、剧烈的人口迁移和新型城镇化进程，以及经济包括住房条件的改善等，是我国家庭户变动的最主要影响因素，老龄化和人口迁移流动对家庭户变动的影响将更加深刻。当代中国家庭户数量、规模、结构及居住模式的变动都是在少子化或独子化现象相对普遍，以及老龄化成为常态的情境下进行的，再加上人口迁移流动所导致的家庭成员之间的地域分割，家庭成员在生命周期不同阶段从家庭中获取的可资利用的资源正在减少。虽然这并不必然导致家庭成员间经济关系的弱化，但他们之间的生活互助肯定会受到制约。

不仅如此，中国家庭变迁还内嵌于社会转型之中。农村家庭联产承包责任制使得家庭在 20 世纪 70 年代末再次成为中国农村最基本的经济和社会单元。然而随着单位制的解体，个体已由过去的“单位的人”重新变成现在“家庭的人”，除了国家负责的一些有限的保障职能，很大一部分养育服务都需要家庭来承担，家庭成员间的传统互助模式仍然是应对外部风险的前提和基本形式。与此同时，社会变迁无疑改变了各人口群体特别是年轻人口的家庭观念，重塑了家庭关系与家庭功能，亲子和夫妻之间的权利格局不断变化，代际之间对文化和传统价值观的传递趋于减弱，小家庭在抚育后代、赡养老人及家务劳作等职能面前逐渐变得独力难支。互联网和现代科技革命对家庭模式正在形成新的冲击，网络信息技术广泛地渗透到人际交往、习惯养成和文化传承等传统的家庭功能领域，改变着家庭成员之间的交往和互助方式，这在增强家庭凝聚力的同时，也使家庭面临极大的脆弱性。

4.2　老龄化背景下的中国家庭发展困境

与西方国家不同，家庭在中国不只是生产与再生产的经济单元，还是秩序单元、教化单元和福利单元，并负有社会化和保护其成员的责任。而在人口与社会双转型的过程中，政府出于自身需要对家庭模式实施了强制性干预（杨笛，2011），这使中国家庭在制度层面被高度工具化，却缺乏有效的政策支持家庭自身的发展。尽管“家本位”“家国同构”等传统文化使中国家庭在制度不健全的情况下仍以这样或那样的方式竭力为家庭成员提供保障并帮助其抵御风险、适应变迁，但却越来越不足以应对人口、家庭、社会多重变迁所带来的结构性冲击。

囿于篇幅，我们重点分析了老龄化背景下中国家庭所凸显的独特性，这些特征为中国家庭的未来发展带来了若干不确定性。确实其走向与路径亟须治理和政策安排的调整乃至重构，其间的机遇与风险并存。

4.2.1　“少子化”背景下的家庭“老龄化”

在老龄化常态化的大背景下，中国家庭老龄化的现象也在不断加剧。“六普”资料显示，2010 年我国 60 岁和 65 岁及以上老年人的家庭数量分别为 1.23 亿户和 8803.6 万户，而据测算，至 2040 年有 60 岁和 65 岁及以上老年人的家庭数量将可能分别超过 1.75 亿户和 1.3 亿户。不仅如此，纯老家庭（全部由老年人组成的家庭）“六普”时已近 3000 万户，传统中少见的 3 人及以上的纯老家庭户也在不断增多，且主要集中在农村。

从单个家庭来看，1982～2000 年的户均老年人数量稳定保持在 0.22～0.24 人，几乎没有变化，而至 2010 年陡增至 0.41 人/户。但与此同时，户均孩子的数量却从 1982 年的 1.48 人陡降至 2010 年的 0.51 人，平均每个家庭少了差不多 1 个孩子。考虑到这一期间家庭户规模的不断缩减，显然每个家庭内的老年人比重正快速上升，而孩子却越来越少，中国家庭正在经历少子老龄化的进程。

不难想象，在少子老龄化的背景下，未来中国家庭的抚养压力不断增大，因为在制度不完善的情况下，相当多的老年人在不能工作时必须依靠自己的积蓄或子女获得支持。不仅如此，那些高龄老人更需要大量的日常生活照料，而目前这些照料服务或直接或间接地大多来自他们的子女。不同口径的测算显示，我国未来 40 年的总抚养比与老年抚养比均呈长期上升的趋势，且影响抚养比上升的主导因素是老年抚养比的提高。毫无疑问，中国家庭正在或即将陷入前所未有的养老困境，这一困境甚至还会随时间的推移而放大。尽管政府一

直尝试改革甚至重构养老保障体系，但如果生育率一直过低的话，那么任何社会保障体系都很难具有持续性，生育率高低将成为未来老龄中国的社会保障制度能否成功的一个关键。如何在尚未实现现代化的条件下应对老龄社会的诸多挑战，中国目前尚无成功的他国经验可资借鉴。

有大量的研究指出，结合西方国家的教训和中国自己的经验与传统，重视并支持家庭应当成为中国养老制度安排的一个重点（张秀兰和徐月宾，2003；胡湛和彭希哲，2012；彭希哲和胡湛，2015）。在传统文化的作用下，中国家庭的很多养老资源乃是通过生育资源所转化，并不全是政府的责任，尤其对于中国的老人来说，“花儿女的钱”和“花国家的钱”有着截然不同的含义，而通过家庭获得情感和心理上的满足更是任何专业的社会服务都无法取代的。缺少家庭责任的养老政策是残缺的政策，既不能使老年人获得完整的福利，还会造成社会和政府财政的过重负担。这些理念已根植于中国的文化土壤，关键在于政府及政策的有效引导与支持。需要特别说明的是，在家庭少子老龄化的趋势下强化家庭的养老责任，并不只是简单地将国家或社会应当承担的责任转嫁给家庭，而是要明确主体边界，扩展或延续家庭的功能，在政府、市场、社区等与家庭合作的框架下，整体统筹这些不同社会系统的作用。换句话讲，不同治理主体对个体的福利支持本就属于不同的形式、不同的层面，他们之间不存在简单的替代关系（Cox and Jakubson，1995）。但问题在于，在制度长期缺位的情况下，老龄化的加剧和少子化的普遍使得大量中国家庭面临极大脆弱性，中国家庭在养老责任面前已经举步维艰。

从本质上讲，赡养老人对任何一个家庭来说都是一个需要动用很多资源的事情，这些资源的短缺是影响家庭发挥功能的重要因素，但政府和社会却并未从政策上对这一资源需求予以明确承认，在忽视家庭成本的同时也使传统家庭能力进一步被弱化。政府应当尽快强化对家庭的制度性支持，除了保障普通家庭的基本养老需求外，还要试图消除现行福利体制固有的不平等，提高对最有需求的家庭的支持力度（如纯老家庭、老年人多的家庭、空巢家庭及残疾老年人家庭、有养老责任的独生子女家庭等），并消除妨碍有养老责任的夫妇就业的不利因素。只有真正支持和强化家庭的功能与责任，才能激活家庭的潜力并延续重视家庭的优秀传统。

需要反复强调的是，在家庭少子老龄化的趋势下强化家庭功能和家庭责任，并不只是简单地将国家或社会应当承担的养老责任转嫁给家庭，而是扩展或延续家庭的功能，在政府、市场、社区等与家庭合作的框架下，统筹这些不同社会系统的作用。换一个角度来讲，国家与家庭对老年人的福利支持本就属于不同的形式、不同的层面（Cox and Jakubson，1995），他们之间不存在机械的替代关系。支持家庭，并在养老政策中强调政府、市场等系统与家庭的合作

关系，不仅很好地诠释了“统筹”的内涵，而且使中国绵延千载的传统养老文化得以传承与进化。

4.2.2　家庭的“形式核心化”与“功能网络化”

在当代中国家庭规模小型化和结构简化的背景下，以夫妇或夫妇与子女构成的核心家庭已成为当代中国家庭户的主要形式，不少学者也由此提出“中国家庭核心化”的论断。但越来越多的研究表明家庭规模变化并不能代表家庭模式变动，简单地将户均规模缩小等同于家庭核心化的论断显然有很多问题。许多学者转而寻求其他折中性指标，如有学者曾提出家庭核心化的实现应同时满足两个条件：一是核心家庭在家庭总数中所占比例超过 50%；二是生活在核心家庭中的人口超过家庭总人口的 50%（王跃生，2007）。按这一标准，中国社会已基本实现了家庭核心化。但也有学者指出，核心家庭比例和数量的增加并不一定意味着核心化，也有可能是人口结构和居住模式变化的反映，这是采用家庭户指标分析家庭模式变化时存在的一个重要缺陷（郭志刚，1995）。尽管从中国的具体情况来看，家庭与家庭户有其一致性，尤其用家庭户资料分析家庭规模、结构及其发展趋势是有效的，但涉及“核心化”这一概念时，由于还涵盖家庭关系及功能，因此很难将代表居住模式的家庭户指标与家庭相等同。

事实上，就原生意义的“现代核心家庭”概念来说，它不仅是指居住模式，更与一整套价值体系、生活方式和物质条件等因素紧密相关（Macfarlane，1978），是西方家庭现代化理论的核心之一。按其理论，核心家庭与扩大的亲属制度相联系的义务关系被削弱，有益于西方工业化社会所需的职业流动和地域流动，而且这种家庭制度能够促进个体平等、独立和自由，与工业化所需的价值观念相吻合（Parsons，1943）。在这个意义上，将中国家庭核心化研究建构在居住模式数据之上，强调家庭对社会的适应，而忽略家庭关系、功能及观念的变迁，显然是片面的。笔者认为，把中国家庭模式的变迁路径归结为核心化可能有以下原因。

一方面，以核心家庭与工业化之间的相互适应为核心观点的家庭现代化理论在家庭研究中长期占据主导地位（唐灿，2010）。这一理论继承了现代化理论的“一元化”模式和“单线演进”发展逻辑（谢立中和孙立平，2002），即工业化使西方社会的传统家庭制度瓦解，由此经历了一种从大家庭向小家庭变化的过程，独立于家庭以外亲属关系网的核心家庭大量涌现，全世界不同民族、种族、文化的国家和地区都会经历同样的发展阶段和历程。家庭现代化理论的代表人物古德曾断言，中国的家庭因为工业化的影响而必然核心化（Goode，1963）。然而从 20 世纪 70 年代开始，这一理论受到越来越多研究者的批评。

批评者认为，用核心家庭来覆盖家庭形式的多样性是“虚伪”的，将其作为所有家庭的理想形式更是欠妥（Scanzoni，1987）；工业社会中的亲属关系对家庭和个人来说依然重要，工业化的出现和家庭关系变弱之间并不存在直接关系（Janssens，1993）；大规模的人口与社会调查还破除了“小家庭是现代社会显著特征”的神话，大量数据表明西方社会的核心家庭在过去几百年中一直占主导地位。后来，连古德都不得不承认，关于工业化之前大家庭占主导的说法是一种臆造，并不是只有核心家庭才算现代家庭，现代社会的家庭有不同的形态（古德，1986）。遗憾的是，这些批评与反思并未在国内得到足够的重视（沈奕斐，2013）。

另一方面，如前所述，从新文化运动开始，家庭革命就一直和强国梦紧密联系在一起，西方的核心家庭被当时的人们视为现代家庭的理想模式，直至中华人民共和国成立后，很多人都仍然坚信“如果中国要建设工业化和现代化，那么必须瓦解大家庭”（Glosser，2003），而出于社会建设的需要，小家庭（主要是核心家庭）更直接为国家所提倡。与此同时，家庭现代化理论的话语体系中，“传统”不仅与“现代”相对立，更是“现代化”的重大障碍。而工业化之后西方家庭研究所形成的一个共识是，“现代社会的显著特征是核心家庭占主导地位”（Litwak，1960），家庭的大小由此成为评判家庭现代性的便捷测量工具（唐灿，2010）。中国的历次人口普查数据又恰如其时地表明核心家庭已是中国比重最大的家庭类型，完全符合现代化理论对“现代社会”的预期，也回应了中国社会对现代化的追求与渴望。

事实上，西方发达国家近代家庭核心化的一个重要制度基础是其相对完善的福利与保障体系，这些制度安排保证了核心家庭中的个体可以不依赖于扩大的家庭亲属网或其他人便能够生活，并对个体的生老病死都有比较完整的保障，基本公共服务和福利制度建立在核心家庭的基础之上。但在中国，以单位和公社为主体提供的福利保障在改革开放之后转化为以个人为中心的社会保障和公共服务，目前面向家庭的福利政策主要表现为补缺模式，即将重点放在了问题家庭与那些失去家庭依托的边缘弱势群体上面。在此背景下，核心家庭很多功能的完成必须依赖其亲属网络，并尤其体现在养老和抚幼等方面，其家庭功能的完成呈现网络化特征，也有学者使用“家庭网”、“网络家庭”、“亲属圈家庭”和“核心家庭网络化”等概念对此概括（潘允康和阮丹青，1995）。

这种家庭功能的网络化与中国传统的家族和亲属网络有着本质区别。首先，尽管两者都基于亲属关系，但中国传统家族和亲属网络蕴含大量伦理规范，具有主宰个体及其核心家庭的权力，而当代以功能为导向的家庭网络则以核心家庭为主要的独立经济和决策单位，网络联结方式松散且没有特定规范。其次，与传统家族和亲属网络不同，当代核心家庭功能网络的形成逻辑较单一，即以

互助互惠的工具性诉求为主（唐灿和陈午晴，2012），类似于莫斯（2002）所描绘的“馈赠-回礼行为”。最后，判别网络中亲属关系远近的标准发生变化，传统按血缘、姻缘展开的差序格局逐步被以经济因素为核心的理性原则所替代（王思斌，1987）。此外，与传统的扩大的亲属网络不同，当代核心家庭的功能网络较多以亲子关系为核心，血缘和姻缘并重，以核心家庭中的夫妇与其双方父母家庭的互动为主，这在城市中尤为突出，并集中体现在养老抚幼和结婚买房等方面。

不难看出，中国的家庭变迁远比西方复杂，并呈现更为多元的模式和路径。在中国，“传统”和“现代”并不像现代化理论所认为的相互对立（杨笛，2011），而是相互磨合甚至相互补充的。夫妇和夫妇-子女家庭户虽然是主流，但这些所谓的核心家庭似乎有其“形”而欠其“实”，他们并未实现真正的独立，亲属关系也没有走向衰落，仍表现出密切的互动，家庭网络化现象更不断加剧。因此，中国的家庭尽管在变小，却并不一定意味着核心化，充其量只是一种形式上的核心化，而其功能的完成却需要其亲属网络的参与，这种形式核心化和功能网络化现象是未来家庭政策必须要正视的核心命题。

4.2.3　“去家庭化”与“再家庭化”的博弈

从本质上讲，当前中国家庭形式与功能的脱嵌，固然源于人口、家庭、社会多重变迁所带来的结构性变化，以及“传统”与“现代”相互磨合后所形成的暂时妥协，但整个社会政策体系导向及其对家庭的长期漠视无疑也是重要原因。

发达国家在二战之后重新认识到家庭作为社会稳定基石的重要性，家庭政策的发展脉络大致呈现出从“去家庭化”到“再家庭化”的演化路径，并趋于相互融合，以期在国家与家庭的均衡关系中支持国民权益的实现（Briar-Lawson et al.，2001）。中国家庭政策的发展则呈现工具理性色彩。新中国成立后，国家对传统家庭制度进行了广泛改造，但在削弱家庭对个体的控制的同时保留了家庭对其成员的约束或保障功能。改革开放之后，政府作为公共服务的直接提供者面临巨大的体制和资源挑战，社会政策开始重视家庭在个人发展和福利保障方面的功能，但制度的惯性仍使政府时常出于自身治理的需要对家庭-个体关系进行工具化操作。尽管家庭政策在影响人口发展、提供家庭保障和促进性别平等等方面有所建树，但仍未脱离补缺型模式的局限，进而体现出“再家庭化”与“去家庭化”的高度博弈。

一方面，随着城市单位制和农村集体化的解体，家庭越来越多地替代国家或集体来担负个体的社会保护责任。一般而言，国家在家庭福利中的退出需要两个必要的前提：一是社会上有相应的载体来承载政府退出的功能，二是政府

对这些载体有有效的监控和评估手段（徐月宾和张秀兰，2005）。但由于社会组织和福利制度的发育尚未能填补政府退出所形成的空间，最终大部分国家所退出的公共服务，如养老、抚幼、医疗、教育等，通过市场化而转由家庭承担（唐灿和张建，2013），这无疑使中国的家庭被重新赋予了重要的保障和福利职责，面临巨大的责任和风险，扩大的家庭成员之间的传统互助模式再次成为中国家庭应对风险和适应变迁的重要屏障，“再家庭化”的进程由此而生。有限的以家庭为对象的保障政策也大多表现为对特殊困难家庭的关注及介入，即将困难视为家庭的私域问题（Moroney，1979），政府只在家庭或个体不堪重负时才出手相救。

另一方面，中国“再家庭化”的同时，“去家庭化”也在同步进行。与发达国家家庭政策在黄金时期因福利干预过度而使家庭功能失衡的“去家庭化”不同，中国的“去家庭化”是政府或有意或无意的功利化操作而导致了家庭功能的普遍磨损。新中国成立后的“去家庭化”主要源于国家当时的社会建设需求，尽管改革开放之后这种取向已式微，但社会观念和传统的惯性及政策的路径依赖依然延续着这个过程。我们在强调重视家庭是中华民族优秀传统的同时，却没有完整的家庭政策体系予以制度性支持，这无疑是价值理念与政策制度的严重背离。中国在过去 30 多年间实行的具有“去家庭化”特征的人口政策是影响中国家庭模式变化的重要因素，这一政策对中国家庭的影响还会长期存在，其突出问题将是大量独生子女家庭在未来如何应对社会经济进一步转型的挑战。

此外，现有家庭政策还具有分散化和碎片化倾向。在中国现有的行政管理体制下，与家庭相关的社会政策往往出自不同的政府部门，而这些部门又大多专注于自身的功能和职能定位，相关部门之间职责交叉但界限不明的情况时有出现，家庭在发展序列中的排序及家庭政策优先对象的确定都要取决于相关部门对家庭事务和家庭功能的理解，不同部门的政策乃至同一部门的不同政策交替出现“再家庭化”和“去家庭化”取向并不鲜见，政策之间相互制约乃至冲突的现象时有发生。

4.3　中国家庭养老的承载能力评价

不难看出，中国家庭在老龄化的背景下已遭遇若干发展困境，并衍生出一系列压力或挑战，养老议题备受关注。养老是人口老龄化研究的核心议题，而家庭养老在中国养老体系中的主体地位仍未动摇。家庭养老是家庭功能的重要组成部分，同时家庭功能的完善与发展又是家庭养老得以实现的基础，两者相

辅相成。因而定量化地研究家庭承载能力能够将家庭养老功能可视化，从而对老龄社会的家庭政策和养老制度安排提供有效而精细的决策支持。本节构建了老龄化背景下家庭承载力的综合评价体系，包含 3 个方面（家庭形态、家庭禀赋、家庭政策）共 21 个具体评价指标，并运用投影寻踪综合评价法对 2015 年中国 31 个省级行政单位的家庭发展状况进行测度与评价。结果显示地区间家庭承载能力的分布差异显著，东部沿海地区的家庭承载能力较中西部地区强，中西部地区家庭规模相对较大、家庭成员之间的相互支持相对较频繁，东部地区家庭在经济收入、人力资本方面的优势明显。人口流动通过影响家庭规模、家庭稳定性、代际关系和家庭收入等指标而参与塑造了各地区家庭形态指数的分布特征，经济发展水平则决定了家庭禀赋指数的强弱，现有的家庭政策对家庭发展的支持作用有限。

4.3.1　家庭承载力指数的提出

在人口转变和经济社会转型的过程中，当代中国家庭的规模、结构、功能模式等均发生了剧烈变化。一方面，原有单位制所提供的替代家庭功能的机制退出，重新彰显了家庭的重要性；另一方面，家庭规模正在不断缩小，人口流动性增强，家庭稳定性相对下降，家庭内部调整资源配置的弹性减弱，传统的家庭功能大多外化（孟宪范，2013）。尤其人口老龄化不仅改变了原有家庭结构和生活模式，亦使养老育儿等功能性问题凸显，家庭制度、家庭情感、家庭责任等更受到更大冲击，中国家庭处于压力增加和能力下降的失衡状态。学界一直尝试通过强化家庭量化研究以明确现状并找出问题的症结所在，通过创建指标或指数来衡量家庭发展状况的理念由来已久，目前国内外与家庭承载力概念相关的指标主要有家庭发展能力、家庭负担和家庭功能等。家庭发展能力是指家庭配置其成员资源以满足家庭生活与发展需要的能力，与家庭承载力有着密切联系，研究者首先是对其概念进行定义，其次选取二级指标建立家庭发展能力评价指标体系，最后提出提高家庭发展能力的福利政策体系的建议（吴帆和李建民，2012）。家庭功能是家庭作为一个主体在人类生活和社会发展的方方面面所起到的作用，其概念内涵包容性强，却存在测量困难的问题，即无论从何种角度予以评价均难以完整评价家庭功能的全貌（刘军，2012）。还有研究者从幸福指数、养老负担的角度研究家庭状况（陶涛等，2014；封婷和郑真真，2015；穆怀中，2001）。从文献来看，现有相关家庭指数的编制工作较多是从相对单一的角度（如养老、生活质量、老龄人口等）对一些家庭相关统计指标进行分类和加权，且大多止步于指数体系的构建上。

在家庭结构变迁和公共政策相对缺位的背景下（彭希哲和胡湛，2015），中国家庭很可能陷入家庭功能磨损的困境。随着生育水平的降低和预期寿命的

延长，家庭结构的变化持续影响着家庭功能的发挥，从而影响着家庭成员的生存环境和家庭的发展能力。衡量家庭发展状况无疑需要同时考虑家庭内部的结构模式和外部环境的影响，我们由此基于已有的家庭功能、家庭变迁、家庭政策等相关研究，提出家庭承载力指数，构建一个涵盖家庭形态、家庭禀赋、家庭政策等领域的指标体系以综合测度家庭承载能力，意在衡量家庭抵抗风险的能力和健康持续发展的潜力。家庭承载力是从供给的角度考察家庭承担压力或抵御风险的资源与能力，是反映家庭综合发展能力的综合性指标体系，对其科学定量评价主要有以下意义：①家庭发展建立在多因素协同作用的基础之上，对家庭承载力的定量研究可确切地找出制约家庭发展能力的主要因素；②建立一套具有综合性、指导性和可操作性的家庭承载力指数具有引导政策支持家庭健康发展的战略意义，可视为制定和实施家庭政策的参考工具；③家庭承载力的评估可反映家庭政策对家庭承载力的调控效果，可按照家庭承载力指数对不同区域进行分类、分级评价，有助于增强政策实施的准确性和科学性，增强调控政策的功效。

4.3.2　家庭承载力指数的构建

如何评判一个地区的家庭承载能力，并据此完善相应的家庭政策是一个与时俱进的课题。家庭承载能力是家庭综合运用各类家庭禀赋资源的复杂过程，各相关指标互相作用、互相影响，最终决定家庭的实际承载能力，采用任何单一指标反映家庭承载状况都是不全面和不准确的。此外，我国不同地区的社会经济发展并不平衡，政策并不协调，亦使我们需要一套能针对不同省份家庭发展和承载能力的整体状况进行客观描述和全面比较的指标，以推动家庭和经济社会的均衡协调发展，并对家庭发展困境进行预警以有利于完善家庭政策体系。

家庭是最基本的社会单元，家庭发展内嵌于社会经济发展，并反过来影响社会经济发展，家庭承载能力评价因而需兼顾家庭发展的“外环境”和“内环境”。目前的家庭发展评价研究相对较多聚焦于家庭内部特征变量，在一定程度上忽略了外部网络、环境和政策对家庭的支持。因此，中国家庭承载力指数在内容上将综合考量内部的结构性、质量性指标与外部的支持性指标，以期全方位、多角度地对我国的家庭承载能力进行综合指数度量。我们综合比较了现有相关研究成果并通盘考虑影响家庭承载能力的各类因素，将家庭置于人口与经济社会发展的系统框架内确定一级指标，借鉴家庭人口学、家庭经济学、家庭社会学，以及家庭政策、家庭生态系统等领域的研究成果选取二级指标，再综合考虑数据的可获得性，尤其是国家人口普查和抽样调查中家庭相关的数据，反复筛选二级变量的代表性变量作为三级指标，从而建立起一套中国家庭

承载力指数体系。

我们将结合数据的可获得性及数据的特征采用指标聚类的方法，利用评价指标体系具体而清晰地体现中国家庭的现状，综合评价指标体系的构建是整个家庭评价研究的成败关键，指标选取要做到：一是突出家庭的特点，评价指标与评价目标保持一致性；二是避免为追求指标的全面，罗列过多的指标；三是指标的选取要考虑后续数据的可获得性。该指数体系由家庭形态、家庭禀赋和家庭政策 3 个一级指标和 10 个二级指标构成，每个二级指标都有具体的表征变量，涉及家庭内部的人口结构、家庭拥有的资源和外部的政策环境，它们直接反映家庭的发展能力和对压力的承载力。

1. 家庭形态指数

家庭承载力研究首先需要对家庭内部结构形成详细的描述及判断。家庭的形态包含着家庭的成员构成及各成员之间的关系，是实现家庭功能的组织方式和运作机制（陈淑芬，2006）。家庭形态指标是家庭承载力指数体系的基础，是从人口学角度衡量家庭的结构，包括家庭户的规模、结构和家庭关系。不管是物质转移、照料服务，还是情感性支持，家庭户的存在都是养老的基础，家庭户的相关指标是家庭养老强度的表现指标（刘骥，2009），该部分的指标都是以家庭户为单位的。①家庭户规模及构成主要反映了家庭成员的多少及人口结构，用家庭户平均规模来衡量。家庭分化水平正在提高，家庭分化最概要的指标，就是由总人口及其分化出的总户数所决定的平均家庭户规模（郭志刚，2008）。②代际间支持程度，家庭代际互动是家庭整个生命周期中的要素，目前我国社会组织和福利制度的发育尚未能有效承担家庭照顾幼儿和养老的功能，因此家庭内的代际结构能反映家庭承载力程度，选取拥有 5 个及以上成员家庭户比例和一代户比例作为衡量指标，家庭户人口越多，家庭内部对老年人支持的强度就越大。③家庭关系，主要反映老年人与子女日常往来的形式，通过独居老人比例和子女赡养父母的比例，反映老年人的居住模式和子女赡养老人的方式，该指标与家庭养老强度之间存在紧密联系。在老年人家庭中，家庭的经济、人力养老负担会随着老年人口的年龄增加而急剧升高（封婷和郑真真，2015）。

家庭形态是家庭结构和家庭关系的总和，不同的家庭形态决定于不同的社会，反映的是社会的生活方式（潘允康和林南，1987）。社会现代化和工业化进程是促使家庭变化的根本力量。家庭形态主要是考察家庭规模和家庭结构的变化，不同要素的不同组合，形成家庭的不同结构和不同类型。家庭规模和家庭结构影响着家庭功能的实现，但不能以此认定家庭规模和家庭结构变化具有决定性作用，应该看到社会经济变迁过程中诸多因素对家庭的综合影响和作

用。在传统家庭中，家庭规模、结构和生活模式更有利于家庭功能的实现，家庭成员紧密度更高，反映为形态指数会更高，这种家庭形态为家庭承载力提供了更坚实的基础。

2. 家庭禀赋指数

家庭发展能力和潜力在很大程度上取决于其资源禀赋状况，家庭功能的实现亦大多建立在家庭财富、社会资源等基础之上，因此我们选取家庭禀赋作为家庭承载力的核心指标，而没有直接对家庭功能进行测量，家庭功能的衡量需要对家庭功能进行一一列举，这是无法实现的。家庭禀赋是个人发展能力的拓展，是个人禀赋的外延，是家庭成员可以共同利用的资源，是家庭拥有选择机会、选取发展策略和应对风险环境的基础（石智雷和杨云彦，2014）。该部分包括家庭经济资本、家庭人力资本和家庭社会资本。①经济基础决定上层建筑，良好的经济基础是家庭发展能力的重要因素之一。家庭经济资本由平均家庭收入、平均每一就业者负担人数、恩格尔系数衡量。家庭的抚养比指非劳动年龄人口与劳动年龄人口数之比，非劳动人口包括幼儿及老年人口。老年人随着年龄增长，自理能力将逐渐降低，对照料的需求逐渐增多，疾病的治疗带给家庭一定的经济压力；幼儿的抚养成本越来越高，幼儿的比例是家庭功能发挥的重要影响因素。恩格尔系数是国际上常用的一种测定贫困线的方法。恩格尔系数是家庭食品支出与总收入的比值，它随家庭收入的增加而下降。②家庭人力资本。人力资本为蕴含于人身上的各种生产知识、劳动与管理技能及健康素质的存量总和，健康是生活、劳动的基础，失能人员意味着家庭财富、人力资源的消耗，大大制约家庭积累物质财富和社会资本。该部分用就业者教育年限和失能家庭户比例来衡量，其中教育年限由就业人口的受教育程度转化而来。一般教育程度高者，其协调家庭关系能力、经营管理家庭资产能力、社会交往能力要高于低教育程度者，从而教育程度是家庭成员处理家庭事务的重要变量。③家庭社会资本包括家庭获取社会资本及与外界环境的良好互动能力，主要与产业结构、职业结构和社会网络活性有关，其中产业结构用非农产业比衡量，指制造业（第二产业）与服务业（第三产业）之和在 GDP 中的比重，这是计算工业化指数的产业结构指标。职业结构参考职业分类社会经济地位指数，用职业层级较高的就业人口比例来衡量。职业层级高意味着一份稳定可靠的收入，另外，在社会层面是家庭社会地位的象征，高职务不仅给家庭带来优厚的经济收益，也能给家庭带来可观的社会效益，社会资源在职位晋升、子女教育、就医等方面合理利用可以促进家庭的发展，提高家庭应对风险的能力。

3. 家庭政策指数

家庭政策是指以家庭为对象或目的的政策，包括对婚姻行为、生育行为、家庭关系、儿童保护等直接施加影响的法规，为目标家庭（如多子女家庭）或家庭中成员（如孕产期夫妇、儿童、老人）提供的收入支持和公共服务等（陈卫民，2012）。家庭政策是家庭功能得以实现的外部环境支持，家庭生命周期的不同阶段需要解决不同问题、承受各种压力，完善的家庭政策体系能提高家庭承载力，缓解家庭负担以实现家庭生活状况的改善。在缓解家庭负担上，我国的家庭政策主要分为一般性家庭福利政策、妇幼福利政策、养老与医疗保险政策及居住保障政策，该部分根据这 4 个方面构造家庭政策指数：①首先是妇幼福利政策，家庭的规模和结构最初是由女性生育子女数量直接决定的，家庭的生育功能既是家庭功能的主要部分，又对其他家庭功能的发挥有很大影响作用，因而生育政策常常成为家庭政策的重点领域。在我国生育相关的家庭政策主要是计划生育家庭奖励和生育保险，该部分选取 3 岁以下儿童和孕产妇系统管理率来衡量，该数据是对各地区妇幼保健工作的体现。②养老保险和医疗保险是国家为了预防和分担居民年老、疾病的主要社会保障制度，具有稳定家庭生活的功能，这部分用养老保险参与率、养老金替代率、基本医疗保险覆盖率和医疗保险费用分担率来衡量。③居住保障政策是政府实施一些特殊的政策措施帮助单纯依靠市场解决住房有困难的群体，居住是家庭发展最基础的保障，该指标选择经济适用房开工面积占总建筑面积比和公共物品消费支持程度，以此评价保障型住房改善中低收入住房困难家庭居住水平的普及程度。④一般性家庭福利政策，包括以最低生活保障制度为核心的对城乡困难家庭的收入支持政策和相关配套政策、对“零就业”家庭的就业支持政策、农村老年人基础养老金政策和城乡高龄老人的津贴补助政策、城市住房保障和以家庭为单位的公积金贷款政策等（陈卫民，2012）。这类政策主要通过直接的政府转移支付发放到居民家庭，从统计年鉴上的人均转移性收入数据来看，政府转移支付部分仍占据主导地位，因此可直接用统计年鉴中人民生活部分的可转移收入来衡量政府对家庭的福利支出（徐会奇等，2014）。家庭承载力评价指标体系及指标测度值见表 4-4。

表 4-4　家庭承载力评价指标体系及指标测度值

分类及具体评价指标	性质
家庭形态指数	
家庭户规模	
家庭户平均规模	高优

续表

分类及具体评价指标	性质
家庭户结构	
拥有5个及以上成员家庭户比例	高优
一代户比例	低优
居住模式	
独居老人家庭户比例	低优
子女与父母的交往频次	低优
家庭禀赋指数	
家庭经济资本	
平均家庭收入	高优
平均每一就业者负担人数	高优
恩格尔系数	低优
家庭人力资本	
就业者教育年限	高优
失能家庭户比例	低优
家庭社会资本	
产业结构	高优
职业结构	高优
社会网络活性	高优
家庭政策指数	
妇幼福利	
孕产妇系统管理率	高优
3岁以下儿童系统管理率	高优
养老与医疗保险	
养老保险参与率	高优
养老金替代率	高优
基本医疗保险覆盖率	高优
医疗保险费用分担率	高优
居住保障	
经济适用房开工面积占总建筑面积比	高优
公共物品消费支持程度	高优

续表

分类及具体评价指标	性质
其他一般性福利	
转移收入	高优

注："高优"为指标测度值越大越好；"低优"为指标测度值越小越好

4.3.3　家庭承载力指数的测算

1. 数据处理方法

围绕评价的目的与流程、评价指标体系的构建、评价指标权重与价值的确定、数据的来源与处理、评价信息的集成和评价结果的运用等维度，已经形成了一些相对比较成熟的理论与方法体系。目前国内外提出的综合评价方法已有几十种之多，但总体上可归为两大类，即主观赋权评价法和客观赋权评价法。前者多是采取定性的方法，由专家根据经验进行主观判断而得到权数，如层次分析法、模糊综合评价法等；后者根据指标之间的相关关系或各项指标的变异系数来确定权数，如灰色关联度法、主成分分析法等（虞晓芬和傅玳，2004）。层次分析法受评价专家主观上的不确定性及认识上的限制，模糊综合评价法、灰色关联度法不能解决评价指标间造成的评价信息重复问题，指标选择对评判结果影响很大，主成分分析法假设指标间关系是线性的，并不适用于本节数据。根据目标数据的结构特征，本节选用直接由原始样本数据驱动并被广泛应用于处理由非线性、非正态多维数据构成的评价问题的投影寻踪综合评价法将多个指标转化为一个承载力指标。

投影寻踪综合评价法是从不同的角度去观察数据，寻找能够最大限度地反映数据特征和最能充分挖掘数据信息的最优投影方向。该方法是在未知权重系数的情况下，通过把高维数据投影到低维（1～3 维）子空间上，对于投影到的构形，采用投影指标函数来衡量投影暴露某种结构的可能性大小，寻找出使投影指标函数达到最优时（能反映高维数据结构或特征）的投影值，然后根据该投影值来分析高维数据的结构特征。避免了专家打分的人为干扰因素，省去了利用专家打分评定的步骤，更为准确和便捷，因而在定量评价指标数据的处理上更具有优势。

投影寻踪综合评价法的计算步骤如下。

样本评价指标集的归一化处理，计算公式为式（4-1）：

$$x(i,j)=\frac{\left[x^{*}(i,j)-x_{\min}(j)\right]}{\left[x_{\max}(j)-x_{\min}(j)\right]} \quad i=1,2,\cdots,n;\ j=1,2,\cdots,p \qquad (4\text{-}1)$$

式中，$x^*(i,j)$为第 i 个样本的第 j 个评价指标值；n、p 分别为样本的数目和评价指标的数目；$x_{\max}(j)$、$x_{\min}(j)$分别为样本集中第 j 个评价指标的最大值和最小值。

构造投影目标函数$Q(a)$，实质是把 p 维数据$x(i,j)$综合成为以 $a=[a(1), a(2),\cdots,a(p)]$为投影方向的一维投影值$z(i)$，计算公式为式（4-2）：

$$z(i)=\sum_{j=1}^{p}a(j)x(i,j)\quad i=1,2,\cdots,n \tag{4-2}$$

式中，a 为单位长度向量。

在综合投影时，要求投影值$z(i)$的散布特征为：局部投影点尽可能密集，最好凝聚成若干个点团，而在整体上投影点团之间尽可能散开。于是，投影指标函数为式（4-3）：

$$Q(a)=S_zD_z \tag{4-3}$$

式中，S_z为投影值$z(i)$的标准差；D_z为投影值$z(i)$的局部密度。计算公式为式（4-4）和式（4-5）：

$$S_z=\left[\frac{\sum_{i=1}^{n}\left(z(i)-E_z\right)}{n-1}\right]^{0.5} \tag{4-4}$$

$$D_z=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p}\left(R-r_{ij}\right)u(t)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{p}\left(R-r_{ij}\right)u\left(R-r_{ij}\right) \tag{4-5}$$

$$r_{ij}=\left|z(i)-z(j)\right|$$

式中，E_z为系列$z(i)$的均值。R 为局部密度的窗口半径。r_{ij}为样本之间的距离。$u(t)$为单位阶跃函数，$t=R-r_{ij}$，当 $t\geqslant 0$ 时，$u(t)=1$；当 $t<0$ 时，$u(t)=0$。这里需指出的是，局部密度的窗口半径 R 取值既要使包含在窗口内投影点的平均个数不能太少，避免滑动平均偏差太大，又不能使它随着指标数 n 的增大而增加太多，因此密度阈值 α 可以取 0.1、0.01、0.001 等。

通过求解投影指标函数最大值来估计最佳投影方向，以最大可能揭示高维数据某类特征结构。计算公式为式（4-6）和式（4-7）：

$$\max Q(a)=S_zD_z \tag{4-6}$$

$$\text{s.t.}\sum_{j=1}^{p}a^2(j)=1\quad a(j)\geqslant 0 \tag{4-7}$$

式中，s.t. 为约束条件，这是一个以 $a(j)$ 为优化变量的复杂非线性优化问题，一般常用模拟生物优胜劣汰规则与群体内部染色体信息交换机制的加速遗传算法来求解比较简便和有效。

把由式（4-6）和式（4-7）求得的最佳投影方向值 a^* 代入式（4-2）后即得到各评价样本的投影值 $z(i)$，这即是中国不同地区的家庭综合承载力指数，据此可对评价指标样本集进行统一评价，对家庭承载力的三大组成部分——家庭形态指数、家庭禀赋指数和家庭政策指数一一按由大到小原则排序，可深入探讨综合指数存在差异的原因。

2. 数据来源

对于家庭规模和家庭结构变迁的研究较多使用全国人口普查、专项调查和统计年鉴资料，本章的家庭形态、家庭人力资本和社会资本指标的数据主要来自《2015 年全国 1%人口抽样调查资料》，该人口抽样调查资料有家庭户的详细数据，不仅包括各省区市家庭户的规模、结构相关数据，还包括家庭户中老年人口的健康状况、经济来源。各省区市的就业数据也来自该人口抽样调查资料，根据各省区市就业人口的产业分布、职业分布数据可获得家庭社会资本状况。各省区市家庭收入、养老与医疗保险数据和经济适用房及转移性收入的数据来自《中国统计年鉴 2015》。3 岁以下儿童系统管理率和孕产妇系统管理率的数据来源于《中国卫生和计划生育统计年鉴 2015》，各省区市的平均每一就业者负担人数、恩格尔系数是通过查阅各省区市 2015 年的统计年鉴整理所得。

3. 结果与分析

1）家庭承载力的综合指数

图 4-1 是全国各地区与全国平均水平的家庭综合承载力指数，从地理分布来看，东部地区与中西部地区的家庭综合承载力差异很明显。全国范围内家庭承载力最弱的是中南和西南地区，除了广东、四川和陕西，其他都在全国平均水平以下，尤其是西藏、贵州、云南、广西、河南、重庆、海南都是负值。华东地区的差异性很大，上海、江苏和浙江的家庭承载力在全国处于较高水平，而安徽、福建、江西和山东在全国处于低水平。家庭承载力较高的大都分布在华北地区和东北地区，北京、天津、辽宁、吉林和黑龙江的家庭承载力在全国属于较高水平，但这些地区家庭承载力的来源并不相同，具体原因还需分析家庭承载力的不同组成部分。

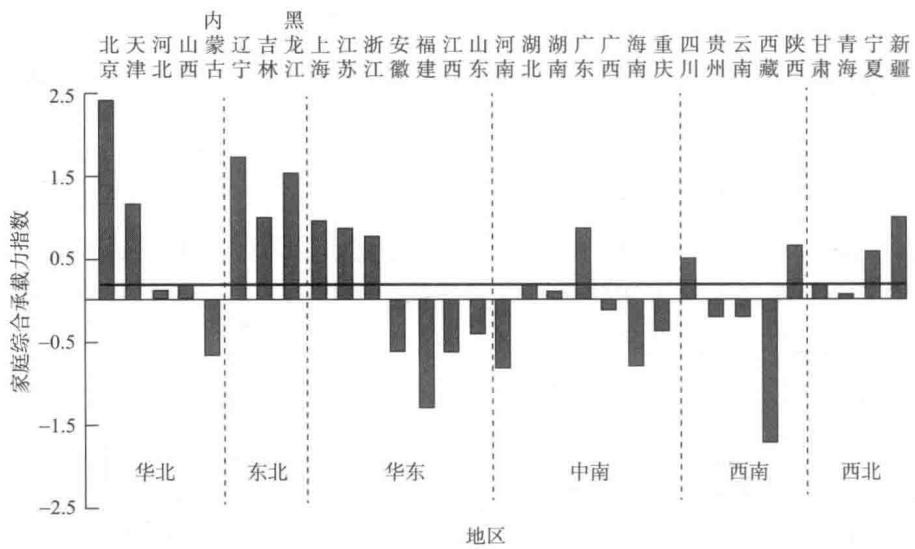

图 4-1　不同地区的家庭综合承载力指数及全国平均水平

2）家庭形态指数

图 4-2 显示家庭形态指数方面有明显的地区分布特点，整个华北和东北地区家庭形态指数为负值，中南、西南和西北地区中除了重庆和宁夏，其他地区家庭形态指数都为正值，反映了东部地区依靠传统的家庭支持体系的不足，中西部家庭的承载能力主要来源于家庭规模、家庭内部的相互支持。家庭形态指数与流动率的相关性为 0.705，人口流动较大的省份，家庭形态指数

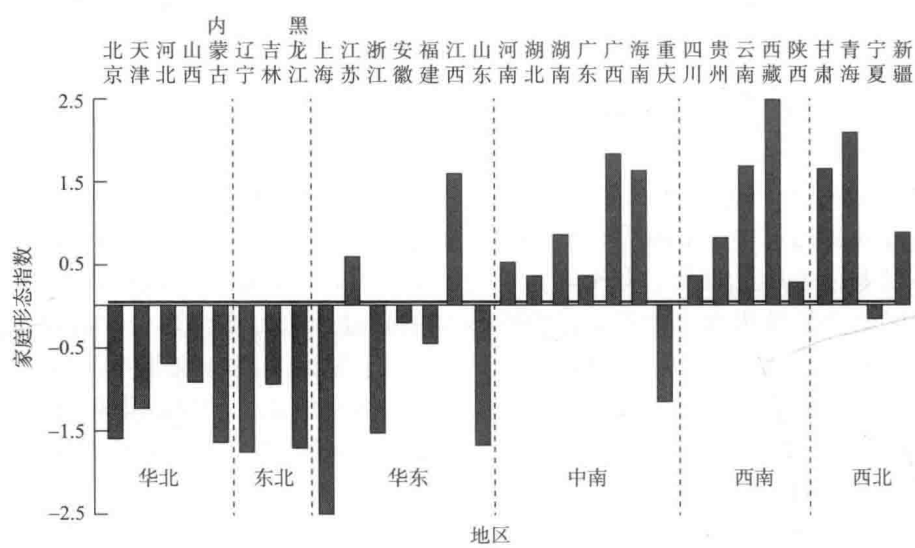

图 4-2　不同地区的家庭形态指数及全国平均水平

低，流动率最大的四个省市——上海、北京、浙江和山东是所有省区市中形态指数较低的。在流动率大的地区，中国的家庭传统会以另一种形式——中国式家庭网表现出来，处于家庭网中的各个家庭是相对独立的，在保持各自生活方式的前提下，以日常生活中的频繁交往和相互援助为其主要特征（潘允康和林南，1987）。

家庭形态有深刻的历史背景，宏观因素通过微观因素影响家庭结构变迁，家庭形态是家庭结构和家庭关系的总和，反映的是家庭的生活方式。由于中国近年来经历了经济社会变革、人口大规模迁移流动，整个社会大背景变化对各个地区的家庭结构、家庭稳定性产生了巨大冲击，不同地区的人口迁移模式、经济发展水平差异形成了各地区家庭形态特征。人口流动对家庭形态的影响主要有四个方面：一是家庭规模，人口流动即家庭成员的外出使得家庭类型向更小的家庭类型转变。在人口流动过程中，家庭规模趋于“小”化，结构趋于“简”化。我国东、中、西部地区人口迁移流动的模式是中、西部地区的人口向东部地区流动，家庭成员外出使中部地区隔代家庭增加，东部地区单人家庭比重上升，流动率低的地区家庭传统资源保存完好。二是家庭稳定性，个人、部分家庭成员的迁移和流动影响着家庭结构的变化，家庭型人口的迁移和流动不影响家庭结构变化。流动率高的地区，家庭结构简单化、不完整化，家庭内部关系向外部转移，成为家庭之间的关系。家庭结构向不完整转变会造成家庭功能弱化。三是代际关系，代际同住意愿是导致家庭结构变化的潜在因素，多数家庭选择子女婚后与父母分开居住，尤其是年轻人跨省流动。居住单位的独立性使得小家庭代替了大家庭。我国城市青年双职工较多，对他们来说，家庭和工作冲突是难以调和的，现阶段我国城市中托幼服务存在“量少、质忧、价高”的问题。在这种情况下，青年人不得已必须与老年人住一起，但只是在孙辈需要照顾时才会有短期的共同居住。平均预期寿命的延长使家庭的代数相应增加，代际关系也相对复杂。四是家庭收入，人口流动有助于劳动力人口的合理分配，从而提高家庭收入水平，高收入地区的家庭结构分解可能性高，低收入地区家庭中多代直系家庭比例相对高（王跃生，2014）。经济越发达的地区，核心家庭中子女的结婚年龄越高使核心家庭的存续期越长，晚婚则使单人户持续的时间更长，从而使单人户在总户数中所占比重提高。工业化越现代化，家庭生活也越现代化，核心家庭多于联合家庭、主干家庭，核心家庭在抚幼赡老方面力不从心。不同的家庭、家庭的不同生命周期阶段状况和需求差异性很大，公共政策需努力结合政府、社会和家庭的力量解决赡老、抚幼问题，积极发展社会福利事业，鼓励家庭间和内部成员在日常生活中的相互支助。

3）家庭禀赋指数

如图 4-3 所示，家庭禀赋方面中南、西南和西北地区除了广东外全部显著

低于全国平均水平，华北的北京、天津和华东的上海、江苏、浙江处于全国的高水平。东部地区与中西部地区是相反的，东部地区强大的家庭禀赋解决了该地区家庭形态结构对家庭发展能力的限制，中西部地区家庭禀赋不足导致家庭承载力无法转为正向的家庭发展能力。家庭禀赋指数与总体承载力指数呈显著正相关性，家庭禀赋指数基本决定家庭承载能力的强弱。东部地区优势非常明显，经济发展水平分化，经济越发达，家庭禀赋指数越高。家庭禀赋指数为正数的基本分布在东部，东部地区除了河北，其他省区市的家庭禀赋指数均为正值，而整个中部和西部地区除了广东家庭禀赋指数外都为负值。东部地区的家庭禀赋指数显著高于其他地区，中西部地区无明显差异。家庭禀赋指数与人均地区生产总值的相关系数为 0.837，说明宏观经济发展水平是决定微观家庭禀赋的主要因素。

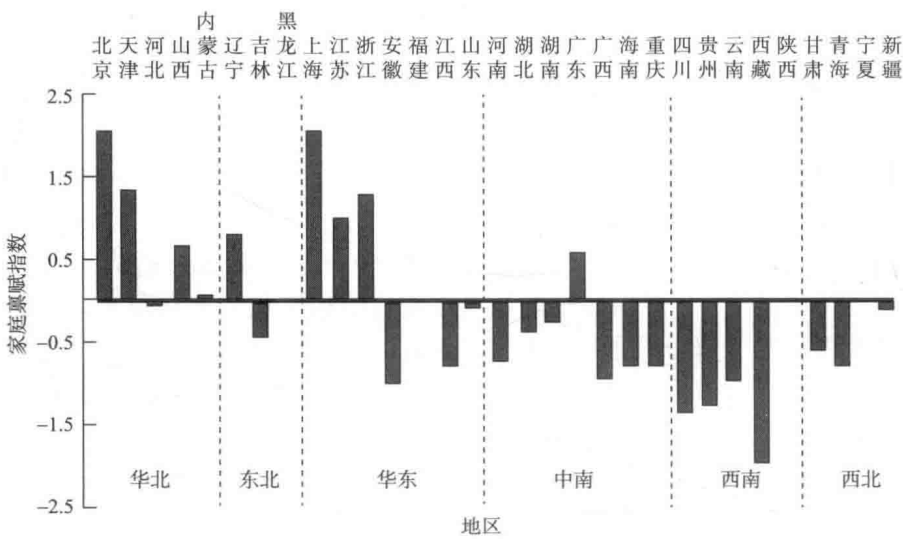

图 4-3　不同地区的家庭禀赋指数及全国平均水平

家庭禀赋对家庭功能的影响主要体现在以下三个方面：①家庭经济收入是满足家庭成员在衣、食、住、行等方面物质需求，应付和处理各种家庭突发事件的根本保障，决定家庭应变能力。②家庭的教育水平决定家庭成员间在信息沟通、情感交流过程中是否顺畅，家庭成员文化程度较高有助于家庭成员的互动，能有效提升家庭亲密度。家庭成员的身心健康状况越好，可用于提升家庭生活质量的消费的资源就越多，家庭功能的实现过程越顺畅。③家庭成员的职业、教育、收入最终都反映为支持家庭发展的社会资本，是家庭在社会结构中使社会行动得以实现的资源，对于家庭发展具有支持与保障功能，可以帮助家庭获得更多的资源。

4）家庭政策指数

如图 4-4 所示，华北地区的家庭政策指数是正值，家庭政策指数较低的主要分布在华东、中南和西南地区。我国不同省区市现行养老保险制度的覆盖率、抚养比、替代率和缴费率都存在较大差异，华北、东北地区政府扶持力度大，对于社会养老保险的财政转移支出较多，配套政策落实得比较好，居民自发参保倾向最强。西南和中南地区的自发养老保险倾向最弱，这些省区市家庭普遍子女数较多，家庭养老意识较强，而社会化养老意识比较薄弱。在妇幼支持政策方面，往往是 3 岁以下儿童和孕产妇系统管理率同时较高或同时较低，东部地区的管理率高于中西部地区。幼儿政策方面托幼问题比较突出，相对于义务教育，各级政府和相关单位对托幼服务并没有明确的责任定位，相关的法律还很缺乏，对托幼的经费投入量难以保证大部分幼儿得到正常托幼服务。尤其是在政府财政经费有限的情况下，学前教育往往得不到足够重视，造成其处于劣势地位。家庭方面，由于家庭不稳定性增强，原有依赖于家庭网络和社会关系相互支持的体系被打破，家庭照料功能被弱化，对公共托幼服务需求日益加大，托幼服务的供给和需求无法达到平衡。

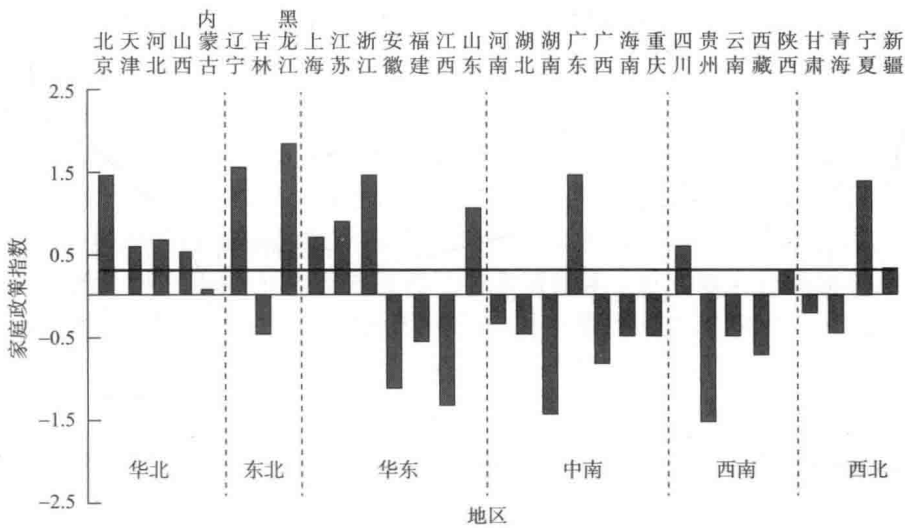

图 4-4　不同地区的家庭政策指数及全国平均水平

这说明我国家庭政策体系不完善，且对家庭发展能力支持的作用非常有限。尽管西南地区的家庭形态指数最高，但其家庭禀赋水平最低，也没有相应的社会福利制度的外部支持。西南地区尽管有传统的家庭形态结构和家庭政策支持，但该地区家庭禀赋水平很弱，导致综合承载力水平较低。

从以上数据结果总的来看，地区间家庭承载力的分布差异显著，不同地区

呈现出与经济社会发展阶段相适应的家庭特征。东部沿海地区的家庭承载力较中西部地区强，中西部家庭的承载力主要来源于传统的家庭规模、家庭内部的相互支持，东部地区依靠传统的家庭支持体系的能力不足，但经济实力、人力资本方面的明显优势，解决了该地区家庭形态结构对家庭发展能力的限制。人口大规模流动通过影响家庭规模、家庭稳定性、代际关系和家庭收入，形成了各地区家庭形态特征，流动率排前四位的省市的家庭形态指数是所有省区市中较低的。家庭禀赋指数主要由该地区的经济发展水平决定，经济越发达，家庭收入越能有足够的保障，家庭成员越能拥有高教育水平、身心健康和高职业等级，有助于家庭关系的和谐，家庭功能实现过程越顺畅，禀赋指数越高。无论是东部地区还是中西部地区的家庭政策方面，其对家庭发展能力支持的作用非常有限，反映了我国家庭政策体系仍欠完善。随着传统家庭模式及亲属网络逐渐被新型家庭功能网络所替代，人口迁移流动对家庭承载力的影响是趋于增强还是减弱，家庭功能与公共政策如何互补支撑家庭发展能力增强，这一系列新的研究课题值得未来继续关注。

4.4　老龄社会的家庭政策重构要点

重视并支持家庭应当成为中国老龄社会治理的一个重点乃至特点。然而不可回避的是，中国家庭在人口和社会转变的过程中发生了剧烈变迁，已经到了最需要支持的时刻，而中国政府自改革开放以来对家庭的支持又一直囿限于一种“含蓄的援助”（胡湛和彭希哲，2012），难以有效稳定家庭和承担家庭功能。随着老龄化的进一步发展，未来扩大社会保障覆盖面的需求必将激增，但家庭支持仍将在中国老年人的养老过程中发挥重要作用，政府理应以政策的形式对家庭做出积极的支持以完成过渡。笔者认为以下几个方面是老龄社会中家庭政策完善乃至重构过程中应当特别关注的主题。

1. 正视家庭发展的多元性，倡导构建新的家庭伦理观

一方面，家庭发展是一个多元动态的过程，家庭政策理应正视并包容这一多元性。从目前来看，生育水平的未来趋势仍是家庭模式变化的基础，尽管国家已放开“普二孩”政策，但进一步的调整势在必行，这将直接影响人口老龄化进程，也决定着未来中国社会保障制度的可持续性。与此同时，新型城镇化的推进和区域经济发展不平衡的延续乃至强化，将决定未来中国人口迁移的基本走势。在人口政策和社会经济发展共同作用下产生的上亿独生子女正在成为中国社会的中坚，以往的“4-2-1”家庭可能会快速转化为“8-4-2-2”家庭。在这些宏观背景下，纯老家庭、隔代家庭、大

龄单身家庭、单亲家庭、丁克家庭、失独家庭，乃至同居家庭、同性家庭等非传统类型家庭将大量涌现，家庭发展的多元化使得传统家庭的定义面临新的挑战。

另一方面，中国传承数千年的家庭伦理和家庭文化是中华文明得以延续的重要基础，但在新的社会经济形态下必须去芜存菁、与时俱进。例如：孝道是中国家庭传统的伦理基石之一，但“二十四孝”所提倡的行为显然不能也不适为今天的年轻一代所接受，我们需要新的孝文化来规范我们的长幼秩序和家庭关系。此外，传统家庭文化中那些僵硬的等级伦理观，亦亟须为平等公平的“血液”所取代。全球化、城镇化、现代化正在影响中国的整体社会形态，也同样影响个体家庭。以互联网为代表的信息技术已经极大地缩短了家庭成员之间的空间距离，使得部分传统家庭功能可以通过网络集成或扩散。现代科学技术的发展和生活方式的改变更在重塑中国家庭内外的交往方式和功能实现，每代人的生存理念和中华民族的文明传承都应在新的家庭伦理中得以体现。而适应新时代的现代家庭伦理无疑是中国核心价值体系中的应有之义，以及新的家庭政策的指导原则。

2. 淡化工具主义的家庭政策取向，引入整体性治理模式

政府针对家庭进行工具化操作的政策取向使我国家庭政策设计囿于应急干预和查漏补缺。越来越多的研究者与实践者已认识到，仅仅依靠工具主义和病理学式的家庭政策及项目难以兼顾现代家庭的多元利益，以个人为基本单位的社会政策和公共服务更无法应对日益复杂的家庭发展趋势。事实上，多年来我国在推动男女平等时提倡将“社会性别视角”纳入决策主流的尝试，完全可为家庭政策改革所借鉴，即在公共政策（尤其是涉及民生和社会建设的各种政策）的制定、实施及评估的全过程引入家庭视角，明确提出“现代家庭建设”的理念，将家庭整体作为家庭政策的对象，以满足现代家庭的发展需求为出发点，平衡国家—家庭—个体之间不同的利益取向，制定不仅能关注弱势家庭、被动应急，且具有预防、发展作用的家庭政策，并逐步走向适度普惠。

为此，政府应进一步转变治理思路，以整体性治理的理念协调政府各部门、城乡各地区及各行动主体的资源，统筹不同社会系统的作用，以设计与家庭政策完善、生育政策调整相匹配的公共资源配置方案。OECD 成员国的大量实践表明，任何社会政策在实施的过程中，必须有其他部门或政策的配合与支持，才能够达到预期的政策目标。具体到家庭政策领域，政府不仅要以家庭的视角来审视、制定和完善相关的法律法规和政策，在政策实施的过程中，还必须充分考虑和评估其对家庭所产生的影响。而注重家庭政策与其他政策安排之间的

协调，减少政策制约并避免政策冲突，无疑也是提高家庭政策的精准性和有效性的重要条件之一。近年来，我国在整合资源、以家庭为对象进行的改革方面已经有一些成功的试点，但还有大量的以家庭为单位的优惠或补偿性政策可以研究和推行。

3. 明确主体边界，支持家庭承担应有的养老责任

我国现有社会政策大多以独立的个人为基本单位。家庭政策应当转而以家庭整体作为政策对象，缺乏与家庭的实质性配合，家庭政策鲜有成功的先例。政府应尽快根据目前已涌现的家庭发展困境推行以家庭为单位的优惠或补偿性政策，例如：尝试推行更多以家庭户为单位的税收优惠措施，尤其要对有养老或育儿需求家庭的经济成本有更多考虑；尝试将家庭规模与结构作为公用消费品（水、电、燃料等）价格和住房政策的制定依据之一，尤其给予承担养老或育儿责任的家庭更多优惠；尝试在社会保险及医疗保险政策中考虑家庭需求，允许部分保险在家庭成员（主要是配偶）之间适当转移，并向老年家庭（如考虑亲子转移）倾斜；论证将家庭成员所承担的某些长期家庭服务（如失能老年人的长期看护等）纳入社会保险范畴的可行性等。需要指出，尽管一些发达国家的家庭政策改革开始倾向于从对家庭整体提供支持转为以具体家庭成员为对象，如英国因单亲家庭和儿童贫困而聚焦儿童福利改革、日本因严重老龄化而侧重对老年人的支持、新加坡为提高生育率而致力于帮助女性平衡工作与家庭等（马春华，2013），但这些改革都是在其家庭政策体系早已将家庭整体作为必不可少的政策考量维度的基础上开展的，中国的家庭政策重构无疑需要先迈出第一步。

此外还应注意到，在传统文化的作用下，中国人往往甘于承担家庭责任。即便在家庭传统能力已遭削弱的今天，城市核心家庭中的年轻夫妇大多仍认为赡养双方的老年父母是子女无法推卸的责任和义务（马春华等，2011）。因此，政府可顺势而为，着力提升家庭延续传统功能的能力，并使我国家庭在社会建设和文化传承等长期发展战略中成为主体。事实上，任何家庭功能的实现都需要家庭有足够的能力和资源，家庭政策不仅要给予现代家庭有效的制度性支持，更应进一步引导全社会达成一种共识，即缺少家庭责任的养老政策是残缺的政策，既不能使人们获得完整的福利，还会造成社会的过重负担（彭希哲和胡湛，2011），并由此形成政策性概念。以养老为例：①目前政府与家庭/个人在养老问题上的责任边界混淆，两者的责任关系经常被理解为此消彼长，让人误以为政府在转嫁负担。必须尽快转变观念和引导方式，强调政府与家庭在养老中的合作关系。②赡养老人对任何家庭来说都需要动用很多资源，资源的短缺是影响家庭发挥功能的重要因素（张秀

兰和徐月宾，2003），政府应从政策（如税收）上更多地对这一成本予以承认。政府应对承担养老责任的家庭进行鼓励和帮助，并构建一个政府、市场、社区和社会组织都有责任、动力和行动来帮助家庭承担应有责任的制度框架。

4. 将支持家庭作为中国构建发展型养老制度的重要抓手

中国的养老问题以经济未发达、就业未充分和社会保障未完善为背景，这要求中国的养老制度不仅要有社会性的再分配功能，还需具备生产性的社会投资功能，因而应当寻求把经济与社会发展内在整合的发展型政策模式，以使老年人养老的现实问题与老龄社会的可持续发展统一起来。引入发展型政策模式是为了使养老制度具有生产性，其主要理念及策略是支持家庭与投资人力资本。笔者认为，结合西方国家的教训和中国自己的经验与传统，重视并支持家庭本就应当成为中国养老制度安排乃至应对老龄社会诸多挑战的一个重点和特点。一方面，养老作为老龄化研究的核心命题，由谁来承担老龄化所带来的财政压力和保障风险是人们最为关注的政策焦点之一。尽管政府、市场等社会福利提供者将不可避免地承担越来越大的养老责任，但任何社会养老政策都无法完全取代家庭在养老中的责任与功能。尤其对于中国的老年人来说，通过家庭获得情感和心理上的满足可能是任何专业的社会服务都无法取代的。缺少家庭责任的养老制度是残缺的制度，既不能使老年人获得完整的福利，还会造成社会财政的过重负担。政府应考虑为承担养老责任的家庭提供直接援助，这样做有以下优点。①有养老需求的中低收入家庭面临较大脆弱性，且总量较大。如果这一群体均能得到一定资助，则需要救助的家庭数量可能会大幅下降。②避免制度的内在不平等导致中低收入家庭无法从再分配系统中公平获利，这也是社会贫困现象的根源之一。③操作简单，避免“家计审查”的困扰及“政策瞄偏”等情况。

另一方面，为了应对人口年龄结构老化的长期不可逆性和 20～30 年后到来的老龄化高峰，保证经济社会的可持续发展，投资人力资本、提高劳动生产率应成为当前最重要的制度安排之一。这无疑涉及教育、卫生及就业等政策的方方面面，而良好的家庭功能却是形成和发展人力资本的首要环境，更与人力资本在新形势下的新内涵（如人的社会能力、精神品质等因素）有着千丝万缕的联系（张秀兰和徐月宾，2003）。不仅如此，家庭稳定还与社会稳定息息相关，已有不少研究表明，在家庭支持强度低的社会中，家庭内部不存在明显的福利再分配，家庭的福利转移很难化解掉养老福利分配体系中的代际不公，从

而使得代际冲突容易显露[①]（刘骥，2008）。可见，无论是应对老龄社会的现实养老问题，还是保证老龄社会的可持续发展与代际和谐，家庭都具有独特且重要的功能。因此，在新形势下将中国的养老制度与家庭功能联系起来进行研究，构建发展型家庭政策，使养老制度得以通过家庭将社会资源分配到具有生产性的社会计划，并在此基础上形成一个建立在政府、市场与家庭的合作关系之上的新型养老制度，具有重要的理论与实践意义。

① 即针对养老金改革所导致的社会分歧，当家庭养老强度较低时，家庭之间不存在明显的福利转移，代际分歧乃至冲突更容易显露；而当家庭养老强度较高时，养老金体系所产生的代际不公可能会被家庭内的福利转移部分消解掉，以阶层分化为形式的分歧才得以成为主流。刘骥（2008）通过对德国、法国、意大利、瑞典、英国共五个欧洲人口大国进行控制变量的案例比较，不仅验证了这一假设，而且发现在欧洲养老金问题所引发的社会分歧中，阶层分化已经逐步让位于代际冲突。笔者据此利用 ABM（agent-based modeling，智能主体建模）仿真技术以中国为情景搭建了动态的微观模型，其运算统计量收集后的分析结果也大致支持了这一假设。

第 5 章　老龄社会的社区环境与社区养老服务[①]

环境对人们的行为生活方式和健康具有重要的影响。老年人往往患有各种慢性病，而且其移动功能、视听功能、感觉功能及免疫功能等衰退，使其对社区环境的依赖程度更大，社区环境对其健康和幸福感的影响也更大。因此，建设老年友好型社区环境对于实现健康老龄化具有重要意义。本章主要阐述社区环境对老年人的影响、老年友好型社区的建设路径及社区养老服务体系的构建与实践要点。

5.1　社区环境对老年人的影响

正如《渥太华宪章》指出的那样："健康由人们在其日常生活、学习、居住、玩耍、相爱的场所内创造；人们可以控制并创造自己生活的环境，并确保环境中的每一个成员获得健康……"研究者很早就认识到环境（如气候变化、空气污染、社区绿化及室内环境等）对人类健康的影响无处不在（Stock and Ellaway，2013）。医学之父希波克拉底在《论风、水和地方》中指出，医生进入一个城市的时候，首先要注意这城市的方向、土壤、气候、风向、水源、水质、饮食习惯、生活方式等，因为这些都会对人体健康产生影响。

大量研究证实：环境不仅可以影响人们的躯体健康、心理健康，而且会影响人们的行为生活方式，如吸烟、饮酒、饮食和身体活动，从而影响人们的死亡情况。如一项 Meta 分析结果显示：贫困社区居民的总死亡率是富裕社区居民的 1.07 倍。

环境影响人们健康的路径是非常复杂的，但对老年人来说社区是其活动的主要场所，对其健康影响最为重要。社区环境主要通过图 5-1 所示的路径对老年人的健康产生影响。社区人口构成与社会环境和物质环境相互影响。首先，社区人口构成，如年龄、受教育水平、职业等会影响社会规范、社区安全、社区凝聚力等社区环境，同时也会影响商铺、工作场所、公共服务场所等，进而影响社区的物质环境。反之，社区社会和物质环境也会影响居民的生活、行为和健康。社区人口构成与环境的交互作用，最终通过四条途径影响居民的健康。

① 本章作者为：高俊岭、朱勤、周新宏、苏忠鑫。

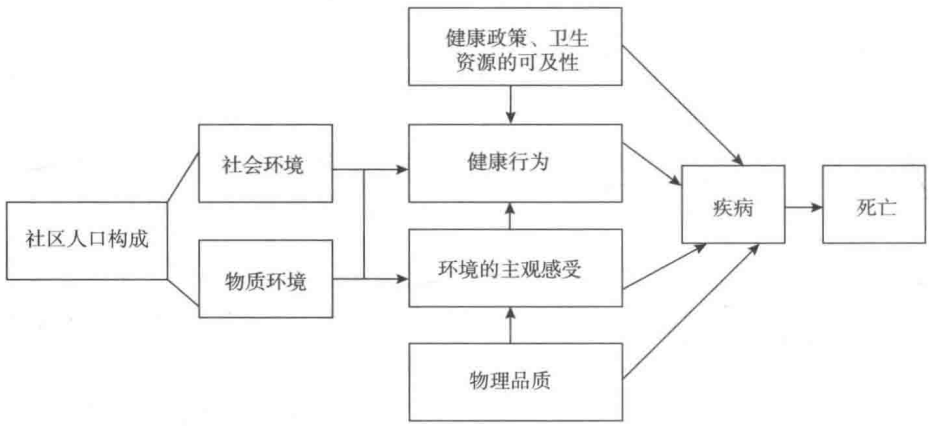

图 5-1　社区环境对居民健康的影响路径

第一，健康政策、卫生资源的可及性。健康卫生服务机构，预防服务，健康教育、筛查等项目在不同社区分布的差异，以及健康政策在不同社区的差异，可能导致健康行为和健康状况的差异。例如，丹麦的哥本哈根从 1991 年就开始对女性进行乳腺癌钼靶筛查，但在其他地区直到 2007 年才开始这项筛查项目，而乳腺癌钼靶筛查可降低 25%～29%的乳腺癌死亡率。

第二，健康行为。社区环境可以影响居民的吸烟、饮酒、饮食、身体活动等行为生活方式。社区的物质环境特征可以通过获得促进健康或损害健康的商品来影响个人的健康行为。例如，研究表明，居住在麦当劳、肯德基等快餐店较多的社区的居民，肥胖的发生率也较高；居住在超市或者健康食品可得性较高的社区的居民，肥胖的发生率较低。此外，社区绿化、道路连接性等均可影响居民身体活动水平。社会环境对行为也有重要影响，有研究显示吸烟、饮酒、身体活动可以在人群中彼此传播，而且邻居的影响是最大的。此外，社区安全、社区凝聚力等可以促进社区居民进行身体活动。而且，社区物质环境和社会环境也是相互影响的，如绿化率高、休闲娱乐设施可及性高的社区，居民间的社会支持、社区凝聚力也很高。

第三，环境的主观感受。社区物质环境，如社区连接性、基础设施、公共交通、美观度等会影响人们对其所在地区的主观感受。社区居民对周围环境的积极感受，会使其感到更舒适，心理问题和与周围环境有关的压力会减少，进而促进更健康的生活方式，降低发病率，延长预期寿命。

第四，物理品质。其主要包括空气污染、地面污染、辐射、交通噪声、水质，以及缺乏供暖、卫生设施和基础设施等传统的影响人群健康的因素。由图 5-1 可知，这条路径也是相互影响的，如健康政策、卫生资源的可及性可以影响健康行为，物理品质会影响环境的主观感受。因此，建设健康支持性环境要综合考虑彼此间的关系。

5.2　老年友好型社区建设

5.2.1　老年友好型社区的概念和特征

老年人往往患有各种慢性病，而且其移动功能、视听功能、感觉功能及免疫功能等衰退，使其对社区环境的依赖程度更大，社区环境对其健康和幸福感影响也更大，因此，建设老年友好环境是实现健康老龄化的重要措施。早在2005 年 WHO 就提出了老年友好社区（age-friendly community）的概念（WHO，2015），指导各国的城市规划、建设和管理的过程。我国于 2009 年开展了首批“老年友好型城市（城区）”“老年宜居社区”建设试点活动。随后，在 2011 年，全国范围“老年友好型城市”“老年宜居社区”建设工作全面铺开。2016 年，正式颁布《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》（全国老龄办发〔2016〕73 号）[①]，从适老居住环境、适老出行环境、适老健康支持环境、适老生活服务环境、敬老社会文化环境五个方面对老年友好社会的建设内容进行了阐释。

除了老年友好城市、老年友好社区外，近年来全球各国在老年友好医院、老年友好学校、老年友好家庭等方面开展了大量的研究实践工作。为此，2017 年 WHO 欧洲区办公室在环境老年学中“人–环境适应”理论的指导下，提出了老年友好环境的概念。人–环境适应理论指的是一个人的健康和独立老化的能力取决于他的内在能力与环境之间的关系，如一个老年人由于视力或听力的下降而无法外出进行正常的社交活动，但通过配戴眼镜或助听器可以实现正常的社交活动；再比如一些老旧社区没有安装电梯使得老年人无法下楼，从而无法进行日常活动。

老年友好环境（age-friendly environment）（WHO，2018），是指通过在整个生命全程中促进和保持内在能力，以及帮助具有一定能力水平的人实现其更大能力的发挥来促进健康和积极老龄化的环境，如家庭、社区、城市。在实践过程中，老年友好环境就是通过政策、系统、服务、产品和技术支持，消除影响老年人的物质和社会障碍。老年友好环境的主要特征包括以下几点。

1. 促进健康，在整个生命全程过程中促进和保持内在能力

老龄化的问题不仅仅是老年人的问题，而是全人群的问题。此外，老年人出现的各种健康问题不仅仅是老年阶段的因素引起的，而是在整个生命过程中暴露的各种因素所致。因此，老年友好环境建设必须从生命全程的角度出发，

① 《关于印发〈关于推进老年宜居环境建设的指导意见〉的通知》：http://www.gov.cn/xinwen/2016-11/25/content_5137617.htm，2016 年 11 月 25 日。

促进社区中每个人在生命全程中的健康和内在能力。

2. 促进老年人做他们希望做的事情

老年友好环境建设不仅仅是维持或促进老年人的健康水平，更重要的是提升老年人的幸福感、获得感。保证每个老年人按照自己的意愿做自己想做的事情，是提升幸福感的重要内容，也是老年友好环境建设的重要组成部分。

3. 识别老年人的各种能力和资源

尽管随着年龄的增加，老年人的健康状况和能力呈现下降的趋势，但不同老年人之间的健康状况和能力的差异很大，所以不能武断地基于年龄对老年人进行分类，即年龄歧视。年龄歧视忽视了老年人能力的巨大差异，导致根据年龄划分对所有老年人采取简单化的应对措施，无法满足老年人多样化的需求。清除年龄歧视，可以强化一种观点：虽然老龄化常常会造成功能损失，但也可以是一个充满个人发展、创造力和富有成效的阶段。消除年龄歧视的另一个重要措施是识别和分析老年人当前作用和需求。此外，老年人可以通过多种途径为社会做出贡献，比如照顾家庭、为年轻人提供经验指导等，投资养老或护理等与老年人相关的产业，也是一种新的经济增长模式。

4. 预测并灵活地应对老年人相关的需求和偏好

随着年龄的增长，老龄群体会出现长期而复杂的健康和服务需求。卫生系统针对老年人的多方面的需求提供整合性的服务，其效果要优于单独提供应对各种疾病的服务。这将需要范围广泛的各种服务之间的协调，其中包括健康促进和疾病预防，筛查、早期发现和急救护理，慢性病的持续管理，康复和姑息治疗。不同服务层级之间的协调，以及各种卫生和社会服务之间的协调将是至关重要的。因此，应鼓励老年人自己参与制订服务计划，围绕老年人的需求和偏好设计服务设施。

5. 尊重老年人的决定和生活方式选择

自主权是老年健康幸福的一个核心部分，对他们的尊严、人格的完整性、自由和独立具有巨大的影响。老年人有权做出选择并自主控制一系列问题，包括他们居住的地方，他们维持的社会关系，他们穿的衣服，他们如何安排自己的时间，以及他们是否开始接受一种治疗。

6. 消除不公平、保护脆弱人群

保证每个人都公平享有健康老龄化的机会，不因社会和经济水平而不同，不因出生地和居住地而不同，不因其他社会因素而不同。

7. 促进老年人融入社区生活的各个领域并为社区生活做出贡献

老年人在老龄化过程中的参与有助于建设团结、和平、公平和安全的社会。把他们排除在这些过程之外，不但影响到他们的福祉和贡献，而且可能会严重影响其他几代人的福祉和生产能力。老年人可以对家庭、社区和社会做出众多贡献，如帮助朋友和邻居、指导同辈人和年轻人、照顾家庭成员及更广泛的社会参与等，而且他们还是消费者、劳动者和志愿者。因此，促进老年人的参与，确保他们能够参与并受益于这些过程对老年友好环境建设是至关重要的。

5.2.2　老年友好型社区的建设内容

根据影响老年健康的环境因素，老年友好型社区的建设内容可以分为物质环境、社会环境和信息与服务三个方面（WHO Regional Office for Europe，2018），现分述如下。

1. 物质环境

物质环境在减少物理性和结构性障碍因素对老年人的影响、促进老年人的社会参与方面具有重要作用。因此，支持性物质环境旨在降低失能对老年人生活的影响，帮助老年人找到应对功能下降的新方法。此外，物质环境也可通过鼓励健康行为和社会互动，提高生命全程中的健康和恢复力。早期的老化和健康状况下降是否会导致不良健康结局和残疾，在很大程度上取决于人居住的物质环境。行动能力稍有下降的老年人，如果对周围物质环境不产生过高的需求，他依然可以感到身体状况很好，过上独立的生活。例如，有些老年人由于视力受损而无法安全驾驶，他也可以步行到附近的商店或菜市场购物，或者如果公共交通工具可及性好、标识明确、价格合理且与当地连接良好，他可以使用公共交通工具拜访朋友、家人，进行正常的社交活动。老年友好物质环境包括室外环境、公共交通和移动性、住房三个维度。

1）室外环境

室外环境主要指室外空间和建筑物。室外环境对人们的健康行为及健康具有重要影响，而老年人更容易受到室外环境的影响。欧洲每年有 4.6 万 70 岁老年人死于跌倒，其中 26%的跌倒是环境因素导致的，如住房条件差，公共设施和娱乐设施可及性差等。52%的英国老年人由于室外缺少公共厕所而减少外出活动。在大多数情况下，城市已有的建筑和基础设施的布局是在法规、文化和历史长期影响下建立起来的。因此，老年友好环境建设并不是完全从头开始，为了使城市更适合老年人，了解现有室外环境的障碍、限制和优势是至关重要的，以便在保留已有特征的基础上，对其进行改造以减少障碍。

室外环境的建设需要遵循以下原则：①提高无障碍公共空间和建筑物的可及性和适用性。随着人们年龄的增长，他们通常会对看似很小的物理特征有更高的敏感度，这些特征可能会妨碍或降低他们对室外环境的安全感和信心，从而影响他们外出活动。例如，缺少公共设施或公共设施密度太低，如长条椅、公共厕所、电梯等，会使老年人减少外出活动。此外，公共环境的设计和改造要遵守包容性设计或通用性设计的原则，即公共环境应对所有的人都是可及的、适用的和有益的。②支持社区互动和个人独立。当周围环境有休息的地方、有趣的街头生活和安全感时，老年人可能会经常去户外活动，去散步和结识人，参与日常生活。相反，当房子前面有一条繁忙的街道，尤其是没有红绿灯或穿越时间短时，会造成令人害怕的情况，从而阻碍一些老年人外出活动。对于老年人来说，社区周围有方便可及的商店、服务和便利设施是至关重要的。③建设户外活动场所。在公共场所和开放空间要让人们有更广泛的参与社区生活和社交活动的机会。公共长椅和其他休息机会，以及足够可及的公共厕所，对于提升身处公共空间、功能受限的老年人的自信心是必不可少的。老年人经常活动的社区应建设可以进行娱乐、体育活动和其他休闲活动的场所，从而提升其外出活动的自信心，增加其社会活动和社交活动的机会。此外，良好的绿化、公园等与环境美观度有关的因素不但可以增加老年人的身体活动，而且可以改善其生理和心理健康水平。④建设增进归属感、连续性和自我意识的城市环境。家庭周围的空间不仅仅是一个地理单元和物理属性，它对于居民来说还具有特征、历史、意义和价值。老年人希望在特定的地方变老，这与一种连续性和熟悉一个地方的感觉有关。然而，一个社区的快速变化可能会让人觉得它是新的、陌生的，并威胁到老年人对它的连续性和依恋的感受。依恋和归属感是通过生命全程中邻里间的无障碍体验、社会联系、感觉、记忆、想法和日常生活形成的。在一个地方的经历会影响老年人对它的主观判断，以及他们在这种环境中的参与能力。那些能够保存和回忆对一个地方的意义、价值观和集体记忆的方法，有助于老年人保持一种连续性的感觉，并获得归属感。因此，对于城市规划者和决策者来说，认识到这个地方如何影响老年人户外活动的自信心、归属感、连续性是很重要的。

2）公共交通和移动性

公共交通是生态系统和人口可持续发展的关键战略之一。对于老年人来说，“走出去”的室外活动能力对他们的幸福和健康至关重要。交通对于维持与家庭、朋友的社会联系，以及保持更广泛的生活和参与社会，包括获得卫生和社会服务至关重要。如在美国、英国等发达国家，12.1%的老年人因交通不便而不能按时接受卫生服务，低收入国家这一比例达到 29.1%。

社区提供的活动（包括老人之家、睦邻点、日间活动中心、教堂和公园）、

必要的服务（包括医院、诊所和杂货店）和社交网络，有助于补偿移动性下降对老年人的影响。有研究显示：如果老年人不能轻易到达对他们生活有重要意义的目的地，则可导致老年人的挫折感和不良健康后果。因此，帮助老年人增加移动性不仅有助于减少依赖和孤独，而且可以防止或减缓健康和日常功能的进一步下降。

公共交通和移动性的建设需要遵循以下原则：①增加促进移动性的基础设施。应该鼓励老年人步行出行，因为它既可以促进身体活动也可以促进移动性，它使老年人能够独立地做他们想做的事情，以及参与社会生活。维护和设计良好的人行道和自行车道对促进身体活动至关重要。如果干预措施能够减少机动车交通量、降低交通速度和提高道路安全性，则可以提高人们对移动性的自信心。②大力发展公共交通。有证据表明，对公共交通的干预可以减缓老年人参与社会活动的减少，这些活动包括参观展览、博物馆和图书馆，去餐馆，锻炼或运动，旅行，与晚辈玩耍或帮助他们，参加社区或自愿组织，参加专业活动或工会会议，去上课或听报告。人口老龄化也可以被视为发展公共交通的重要机会。因此，城市需要坚定地执行无障碍标准和指南，通过调整现有的公共交通系统来克服老年人出行障碍。可采取的措施有：增加公共交通的可用性，如提供换乘信息、简化自动售票机操作方法等；在考虑老年人需求的同时，采用包容性设计原则规划公共交通服务，如地铁-公交换乘系统；为老年人和失能人员减免公共交通费用；提升公共交通服务人员的服务意识和技能、增加服务信息也可促进老年人使用公共交通。③提供一门式服务和按需服务。老年人由于功能下降，外出活动的能力降低，积极参与活动的意愿不高，如果为老服务的流程太复杂、涉及部分很多，会进一步影响其外出办事并减少活动。而一门式的应用就是为了简化办事流程，方便群众办事，让办事的居民或单位少跑腿，这种服务看似减少了老年人活动的机会，反而更容易鼓励老年人利用服务，增加其移动性。

3）住房

住房条件对人们的健康具有重要影响。在家里，许多环境因素（如霉菌、噪声、寒冷、拥挤和事故）都会威胁健康。此外，随着年龄的增加，功能受限越发严重，老年人在家中活动的时间更多，对家庭环境的安全性、可及性、位置及独立性要求更高。不适应老年人需求的家庭环境会引发一系列不良后果，包括增加事故和伤害的风险，以及日常生活的困难，这可能导致老年人需要更昂贵的医疗保健服务。中国人的养老观念倾向于选择居家养老，因此住房环境对于促进老年人的健康更为重要。

老年友好型住房需遵循以下原则：①通过改善住房条件来减少不公平。确保为老年人提供公平的住房对于减少健康不公平和保护社会经济压力下的老

年人免受严重健康影响至关重要。有研究显示，拥有房产是 75 岁以上老年人功能受限的重要保护因素。②支持家庭评估、维修、维护和改造。大约一半的跌倒发生在室内，因此家庭环境对预防跌倒至关重要。四个家庭活动领域对老年人来说最为关键：进出房间；在家里走动；爬楼梯；使用卫生设施和厨房设施。研究证据表明，家庭安全干预措施，如危险评估和积极改造住房，可以降低老年人跌倒的风险。我国《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》明确指出：建立社区防火和紧急救援网络，完善老年人住宅防火和紧急救援救助功能，鼓励发展老年人紧急呼叫产品与服务，鼓励安装独立式感烟火灾探测报警器等设施设备。对老年人住宅室内设施中存在的安全隐患进行排查和改造，有条件的地方可对于特困老年人家庭的改造给予适当补助。引导老年人家庭对日常生活设施进行适老化改造。③制定和执行新的房屋建设标准。我国《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》明确指出：在城镇住房供应政策中，对开发老年公寓、老少同居的新社区和有适老功能的新型住宅提供相应政策扶持。鼓励发展通用住宅，注重住宅的通用性，满足各年龄段家庭成员，尤其是老年人对居住环境的必要需求。在推进老（旧）居住（小）区、棚户区、农村危房改造中，将符合条件的老年人优先纳入住房保障范围。加大对住宅小区消防安全保障设施建设力度，完善公共消防基础设施建设。

2. 社会环境

与缺乏长椅或拥堵的人行道等物质环境因素相比较，社会环境因素对老年人健康的影响有时表面上看起来不明显，但是老年友好型社会环境对于鼓励人们进行积极健康的生活及破除健康老龄化的影响因素非常重要。社会环境是老年人健康的一个重要决定因素：加强社会环境建设有助于破除健康老龄化的影响因素，并有助于改善全人群的健康状况。例如，社会网络和支持可以缓冲健康水平下降对生活质量和福祉的影响，使那些健康状况不佳的人仍能以有意义的方式做出贡献，并帮助他们做对他们来说重要的事情。相比之下，社会障碍和排斥会导致老年人被非自愿地孤立，并遭受孤独感，这对老年人的生活质量具有重大影响，并导致健康和积极老龄化中的不平等。在采取循证干预措施的基础上，对各项措施进行评估，以便更好地理解老年人的社会网络及社会参与的影响因素，对于今后加强老年人的社会参与和社会关系至关重要。老年友好型社会环境包括社会参与、包容和非歧视、公民参与和就业三个维度。

1）社会参与

社会参与是指一个人参与社会或社区中与其他人互动的活动。它不仅包括参与正式性的活动和休闲活动，如参加社会、文化和休闲活动，参加会议和宗教活动，也包括进行非正式的社交活动和交流，如邻里联系、通过电话或其他

信息手段与人联系，以及拜访朋友和家人等。老年人的社会参与可以影响情绪和精神健康、身心健康和生活质量。

如果社会参与受到限制，老年人可能会被社会孤立。社会孤立和孤独有很强的联系，也常常被互换使用，但是二者并不完全相同。社会孤立是指个人与他人，如家庭成员、朋友、邻居或其他人缺乏联系。从这个意义上讲，它常常被视为衡量个人社会关系的客观指标。孤独通常被视为一种主观和消极的体验，是个人对个人社会关系的感受。因此，孤独常常被理解为个人社会交往的实际和期望的质量及数量之间的不匹配。

社会孤立和孤独可以彼此独立存在。虽然有些人可能有频繁的社会交往，但仍然感到孤独，而另一些人的社会交往可能很少，也不会感到孤独。有些老年人可能满足于自己的交往，甚至主动寻求远离他人的生活，他们可能不会觉得缺乏社会交往对他们的生活质量有负面影响，因此他们可能不愿意参加社会活动。相反，如果有些老年人喜欢与人接触，或者与亲近的人有更多的接触，则社会参与减少可能导致其产生孤独感。

除社会环境外，老年人本身的特征也可能导致社会孤立和孤独，并可能导致个人及其所在社区出现不良结果。社会孤立往往伴随着其他的健康风险因素，如功能受限、经济困难的发生，这可能进一步增加社会参与活跃和不活跃老年人之间的差异，增加健康不公平，从而影响旨在促进积极老龄化和原居安老的政策的效果。

可通过以下途径促进老年人的社会参与：①增加老年人社会参与机会。老年友好社区要通过各种途径开展一些适合老年人参与的活动，并提高其对活动的知晓度。当地政府也可以利用现有的社区资源、志愿者和项目，支持老年人进行社会参与。利用已参与者的人际传播途径和新的信息技术，招募新的参与者并提高老年人对活动的知晓度。②建设能促进社会交流的支持性社区环境。社区可以为老年人组织的活动提供场地和设施，如老年活动室、社区文体活动中心等。③终身学习。社区为老年人提供终身学习的机会，如老年大学等。

2）包容和非歧视

不分性别、年龄、残疾与否、精神健康状况如何、社会地位和种族，每个人都有权享有健康。然而，社会排斥、孤立、刻板印象和年龄歧视等威胁着健康老龄化，并增加了老年人间的不平等。社会排斥和社会孤立会使老年人，尤其是高龄老年人，以及妇女和少数群体处于弱势地位，并可能影响他们的社会参与。

社会参与活跃的人可以获得和利用各种资源，应对生活中面对的各种压力，缓解压力对健康的不良影响。相反，被社会排斥或边缘化的个人或群体会经历多重不利因素，这些不利因素会限制人们获得健康所需的社会、文化、经济、政治和环境资源，并降低他们的生活质量。

可通过以下途径促进社会包容和非歧视：①尊重和非歧视。禁止公众、媒体、地方企业及地方政府和服务提供商的通信和出版物中出现年龄歧视问题；识别和打击服务提供者、媒体和雇主的年龄歧视；跨部门合作制定老年人权利和长期护理质量标准章程；提高对老龄化问题的认识；加强对老年人虐待、忽视和欺诈的预防；促进代际技能、经验和知识交流。②预防或消除社会排斥。通过补贴、社会援助、打折等措施预防经济排斥；通过社会参与或心理健康服务预防社会孤立和孤独；对照料提供者和有依赖老年人的家庭给予支持，如经济支持、技能培训、提供服务项目等。③针对弱势群体的活动。为弱势群体提供针对性的服务或社会活动，如家庭病床服务。④加强代际交流和技能培训，促进代际交流和沟通。

3）公民参与和就业

除了经济上的需要外，公民参与和就业作为一种个人选择，不仅对身心健康和幸福感有许多好处，它对老龄化社会可持续发展也至关重要。公民参与可以通过政治和非政治的途径提高社区居民的生活质量，但促进公民参与需要改变社区居民的行为生活方式和价值观，提高知识和技能。①参与政治生活和决策。赋予公民发言权，使其在地方决策中发挥积极作用，如：改变组织架构，赋予老年人参与决策的权利；建立跨学科工作组，让老年人共同计划、领导和实施社区行动；设立委员会/理事会，代表社区特殊群体（如妇女、老年人、儿童、青年人或残疾人）的利益；通过小组讨论、社区论坛、参与性研究等方法向老年人进行咨询，确定老年友好环境建设的问题和行动方案。②经济生活与就业。鼓励社会、政府为不同年龄的劳动力提供就业机会，如延迟退休年龄；或鼓励企事业单位为已退休老年人继续提供工作机会，为老年人提供更多的灵活就业机会。建设老年友好型工作场所，创造新的就业和创业机会，如为老年人创造特殊的工作机会与职业发展和培训机会（家政服务、信息服务），提供创业和自营培训课程，鼓励其退休后继续从事专业活动。③参与公共事务。让老年人参与设计和提供与他们相关的生活服务，如让老年人参与为老服务的设计和评价；加强老年人组织领导社区活动的能力培训。鼓励老年人参与社区志愿者组织，促进社会包容，如推广或传播志愿服务的益处及参与机会；建立义工银行、睦邻点、自我管理小组等。

3. 信息与服务

各类政府部门向老年人提供的医疗、保健和社区服务对于促进健康老龄化和实现体面生活至关重要。为了降低服务对老年人的要求，需要很好地整合来自社区不同部门和参与者的服务，因此各部门之间的沟通和协调至关重要。

能够适应老年人的需要和偏好的社区新闻、活动机会的可靠信息，对于老

年人来说至关重要，尤其是对于那些单独生活在社区中的老年人，以及那些可能减少了社会联系的老年人。因此，我国《关于推进老年宜居环境建设的指导意见》明确指出：构建适老信息交流环境。进行信息无障碍改造，提升互联网网站等通信设施服务老年群体的能力和水平，全面促进和改善信息无障碍服务环境，消除老年人获取信息的障碍，缩小“数字鸿沟”。可以通过以下途径构建适老化信息交流环境：①建立老年友好型信息系统。首先增加信息的可及性，如：为当地的活动和服务提供详细信息，特别是农村地区；建立老年友好型互联网；保留面对面服务或人工服务柜台，确保信息的有效传播，如定时更换各种媒体上的信息，为老年人制定针对性的信息，避免使用自动拨打电话信息系统；鼓励老年人进行口头交流；采用老年友好型版面设计，如基于老年人的特征设计各种传播材料；使用清晰、简洁的格式和简单的语言。②创建健康信息中心。为老年人、他们的家人和护理者提供一站式健康信息服务，如健康小屋。提供有关社会参与、志愿服务机会及老年友好服务等与健康老龄化有关的综合信息平台。提供跨部门信息咨询服务，增加利用计算机和在线咨询的机会。③提高自我管理能力。通过讲座、报告、工作坊、讨论会、技能培训、现代信息手段等提高老年人自我管理能力。④提高健康素养。监测健康素养水平、分析老年人获取信息的障碍因素；加强卫生保健和服务提供者的能力建设和沟通培训；开展培训和宣传活动，以提高老年人了解与健康相关信息的能力；通过跨部门合作，提高那些信息获取有困难的群体获取信息的能力。⑤缩小“数字鸿沟”。建立健康老龄化数据指标监测系统；提高老年友好环境建设策略和计划的可及性；开发更人性化的智能手机应用程序，以提高老年人获取信息的可及性和安全性；为老年人提供信息技术相关培训，提高信息技术使用技能；提高互联网和新技术的可及性。

随着年龄的增长，老年人的服务需求更加多样化，而且呈现出长期且复杂的需求。研究显示，针对老龄人群多层次的服务需求，提供整合性的医疗卫生服务的效果要优于针对各种疾病单独提供服务的效果。然而老年人获得服务常常是专门针对急性疾患或症状的治疗，此种治疗采用独立、分离的方式处理各种健康问题，使得不同的卫生保健提供者、医疗机构缺乏协同，不同时点、不同情况下的服务也缺乏一致性。因此，需要通过以下途径为老年人提供整合式服务。①社区协调行动，提供整合式服务。协调整合的为老健康和社会（包括长期护理）服务，已被认为是提高服务效率和服务效果的关键。整合式服务的重要措施包括：建立公共信息系统，用于监测和评估社区中老年人的生活状况、健康和幸福感；为老年人及其家人提供一站式信息服务；建立日托中心和临时护理中心，日托中心可以和住宅设施整合在一起；建立社区信息系统，用于监测和控制护理机构的不良事件；制定或调整针对老年病问题的服务质量标准；

提高老年人、他们的亲属和志愿自助网络的健康素养和增权能力，开展以“患者为中心”的自我管理项目。②提供卫生服务、健康促进服务、预防服务。老年人无法获得可负担的、高质量的卫生和社会服务是当前全球各国面临的共同问题之一，卫生服务利用的不公平依然存在。尽管经济困难的老年人对卫生保健服务的需求更大，但与富裕的老年人相比，他们的卫生需求得不到满足的程度更严重。贫困老年人与富裕老年人对卫生服务利用的情况存在差异，后者所获得的门诊服务是前者的 1.6 倍，获得的住院服务则是 3.8 倍，而且这种差异在患慢性病的老年人中更加普遍[①]。因此，需要将以社区和人口为基础的公共卫生服务重点放在老年人身上；支持社区提供（如租赁）辅助设备，包括现代移动技术；预防保健服务，包括疫苗接种和家访；改善社区老年人获得精神卫生服务的机会；解决老年人康复和姑息治疗方面的差距。③加强家庭护理和非正式护理。提供家庭护理的社区，它们有责任监督家庭护理，提高家庭护理的可及性和质量，以及为非正式护理提供支持，特别是提供连续性服务；它们在提高护理质量和增加护理可及性方面同样具有重要的责任，其中包括雇用满足老年护理要求的工作人员。④居家护理。为独自生活在家和需要长期护理的人提供连续的服务；通过营造尽可能长时间的“日常”生活环境，提供个性化的生活空间，包括（尤其是）痴呆症患者的生活空间，使居家护理日常化，比如配备综合护理服务的共享公寓；在提供居家护理的同时，提供居家健康促进和预防疾病服务，如适当的体育活动、高质量的营养和跌倒预防；促进居家护理机构与卫生保健部门的合作，以避免或减少住院及并发症的发生，如提供充足的营养和护理，以防止住院老年人出现压力性溃疡。⑤加强信息通信技术服务。信息通信技术、电子或移动健康（e/mHealth）在未来建设老年友好环境方面将发挥重要作用。例如：远程安全警报；从家到护士、医生或医院的通信技术解决方案；远程活动传感器；开发新服务的虚拟病房（如家庭医院项目）。

5.3　社区养老服务体系的构建

我国自从 2000 年步入老龄化社会以来，老年人口规模和比重加速上升，未来人口老龄化程度还将进一步深化。同时，高龄、失能失智、独居和空巢老年人数量将进一步增加，老年人在养老、医疗、照护、福利等方面的需求将持续增加。在养老服务供给上，社区具有天然的地缘优势。国家“十二五”和“十三五”期间出台的《社区服务体系建设规划》及《城乡社区服务体系建设规划》

① WHO, China country assessment report on ageing and health(《中国老龄化与健康国家评估报告》): https://www.who.int/publications/i/item/9789241509312，2015 年 2 月 16 日。

均对加强社区公共服务体系建设提出了具体要求，其中就包括养老服务、社区照料服务、病患陪护服务和家政服务等社区为老服务体系的建设完善。社区养老是我国解决人口老龄化问题的重要举措和必然趋势，在社区层面构建整体性的养老服务体系是发展社区养老和福利社区化的必然路径。

5.3.1　社区养老服务的现状及存在的问题

“十三五”时期是我国全面建成小康社会决胜阶段，也是我国老龄事业改革发展和养老体系建设的重要战略窗口期。中共十九大报告提出了“积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展”[①]的要求。目前政府各部门及市场、社会各方在社区为老服务领域实际上制定了大量的政策并投入了大量的资源，尤其是政府各部门以部门主导形成的各种老年福利公共政策。然而，现有体制下不同的政府部门由于各自的职能与功能定位不同，出现了不同部门出台的养老政策之间有权责交叉、界限不明确、资源投入重叠与缝隙并存等现象。政策的碎片化导致为老服务资源的分散化，造成大量的资源投入却无法切实有效满足社区老年人的需求。一方面是碎片化、低水平、重复化的社区为老服务资源供给，另一方面是老年人对集约化、专业化、多样化为老服务的需求希冀，为老服务资源配置上的低效率导致供需双方错位这一结构性问题是为老服务供需矛盾的主要方面，也是构建并完善整体性为老服务体系政策网络亟须解决的关键问题。

本书课题组的调查发现，目前社区养老服务存在的问题主要表现为：①现行体制下社区养老服务资源条块分割严重，资源碎片化，资源浪费与资源短缺并存；②养老服务的市场参与和社会参与不充分，服务专业化程度不高；③专业养老机构对社区的辐射能力不强，机构、社区、居家养老服务的有机连接薄弱；④社区养老服务信息资源条块分割，存在一定的碎片化现象。上述问题一方面与社区的人口、经济、社会发展状况的自身特点相关，另一方面也涉及当前政策、制度与机制层面的一些制约因素，有必要从整体性政策设计的角度探讨如何整合协调落实到社区层面的各类资源，通过专业化的团队高效对接社区各种养老资源与老年人之间的供需匹配，特别是针对社区内不同老年人自身的经济水平、受教育程度和身体健康状况等特征为他们导入与养老有关的政策信息、项目参与、入住设施等服务，从而达到对老年人长期稳定、个性化的照料服务及花费少、质量高的服务目标。

---

① 《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》：http://www.12371.cn/2017/10/27/ARTI1509103656574313.shtml，2017 年 10 月 27 日。

5.3.2　整合式社区养老服务体系的提出

整合式社区养老服务体系整合各部门投放到社区的养老服务资源，统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的养老服务功能，以整合式服务平台精准对接养老服务的供需双方，综合各种社会力量为社区老年人提供全方位、多层次、专业化和精准化的养老服务，使社区成为养老服务资源的连接和组织平台。

整合式社区养老服务体系的主要目标包括：资源整合、多元协同、供需匹配和数据融合等。资源整合是指整合各部门投放到社区的养老服务资源，解决政策碎片化、供给重叠与缝隙。多元协同是指统筹政府、社会、市场、家庭各行动主体的养老服务功能，打通居家、社区、机构养老服务，形成合力。供需匹配是指老年社会工作者嵌入社区，以整合式服务平台精准对接养老服务的供需双方，资源下沉，解决供需矛盾。数据融合是指以统一共享的微观人口数据为核心，建立社区养老服务数据平台，解决信息孤岛、数据冗余与不一致、功能碎片化问题。

整合式社区养老服务体系及平台的构建，遵循“四化”与“四助”相结合的基本理念（图 5-2）。“四化”与“四助”之中蕴含着合作和参与的理念，它既强调政府、市场、社会、家庭和居民各方的参与，更要求各部门、各方面形成合作机制，从而实现为老服务资源的集成与共享（沈潔和澤田ゆかり，2016）。

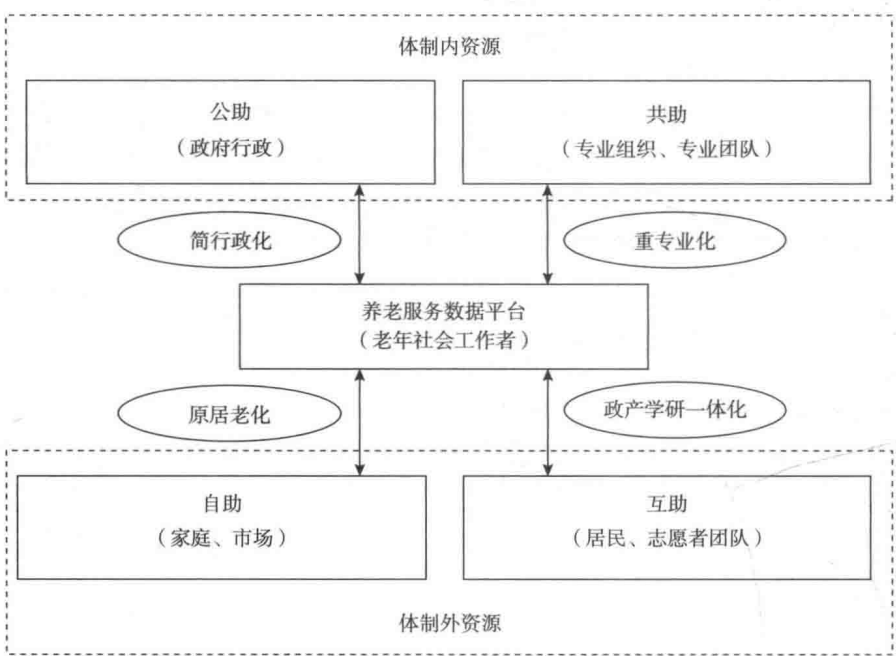

图 5-2　整合式社区养老服务体系的基本理念

“四化”是指简行政化、重专业化、原居老化（aging in place，也译作原居安老）和政产学研一体化。简行政化是指政府应该把治理权逐渐向民间供给组织让渡，增加让市场和社会力量参与的机会，实现“小政府，大社会”，同时减轻政府部门的福利负担。重专业化是指社区福利的发展必须着重专业组织、专业人才团队、专业方式方法的建立与完善，提升专业化水平。原居老化，认为老人应该在其生活的社区中自然老化（吴淑琼和庄坤洋，2001），这符合多数老人不愿离开家庭的养老心理，也与我国居家养老和社区养老的政策趋势相呼应。政产学研一体化强调政府、市场、研究机构、社会组织等多方主体的融合与协作。

“四助”是指公助、共助、互助和自助。公助强调政府行政力量对社区居民福利的援助；共助强调专业组织、专业团队等的帮助；互助是指社区居民之间（包括社区志愿者团队）的邻里互助；自助是指家庭成员之间的自我协助，包括寻求市场的服务供给。公助和共助主要代表体制内资源，而互助和自助更多代表的是体制外资源，“四助”结合要求将体制内资源和体制外资源通过协同合作机制实现资源整合。

国外养老模式的发展历程表明，传统的家庭养老和完全依靠政府提供养老服务的模式在当代社会已经难以实现，因此促进服务主体的社会化，实现政府机构、商业机构、社会非营利机构等多元主体共同发展的社会化养老是未来养老服务的必由之路（刘晓梅，2012）。

整合式社区养老服务体系是一个整合了各部门、各方面为老资源的有机统一政策网络，集成了所有的养老服务行动主体及资源，为社区老年人提供全方位的养老服务供给需求平衡。整合式社区养老服务体系整合的服务类型包括医、养、护服务，个人社工服务，志愿者服务，教育娱乐服务等；所整合的资源包括以政府、市场、社区、家庭等为主体的养老服务资源。

5.3.3　整合式社区养老服务体系的实践要点

整合式社区养老服务体系的社区实践要点包括：社区养老服务基线调查，居家健康照护机构的社区嵌入，社区养老服务数据平台的信息整合，老年社会工作者对于社区养老服务的全程导引。

（1）社区养老服务基线调查主要包括养老服务资源供给与养老服务需求状况的调查。在养老供给方面包括社区养老政策措施、养老机构（包括医疗、卫生、护理等）、养老设施（长者照护之家、日间照料中心等）、养老服务提供者（专业服务公司、非营利组织、志愿者组织）等；在养老需求方面重点摸清养老需求评估等级归类，机构、社区及居家养老需求的满足程度。通过此项调查，一方面可以准确把握现状，有助于发现问题、寻找症结；另一方面，可以为

项目实施一段时期后的实际效果提供对比参照。在基线调查基础上，深入分析试点社区养老服务供给与需求匹配程度，并提出资源整合、供需对接的解决方案。

（2）居家健康照护机构的社区嵌入。在完成对社区养老服务资源的基线调查和养老服务供需分析的基础上，引入社区综合养老服务中心运营的专业力量和社区居家养老健康照护机构，其功能定位如图 5-3 所示。同时，对现有微小型托养机构的环境和设施进行适老性优化改造，辐射居家养老，有效对接社区周边居家老人的生活照料、康复护理需求，以点带面扩大服务对象。

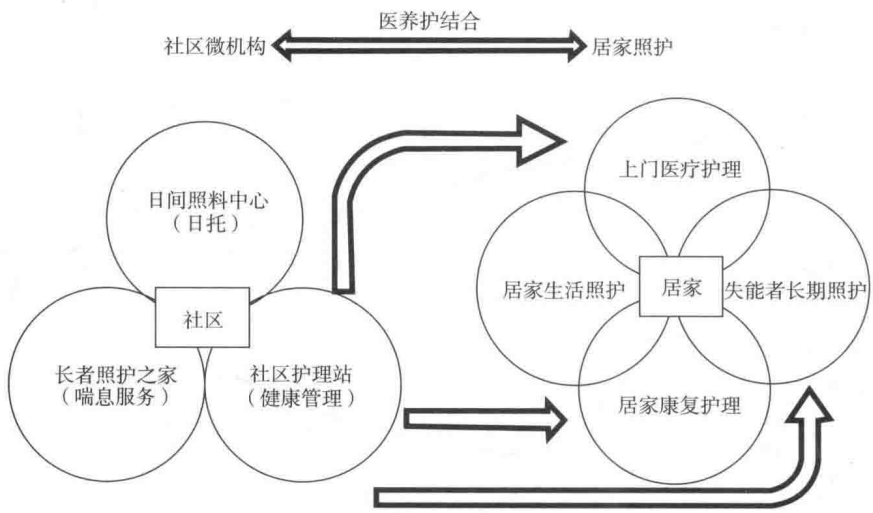

图 5-3　嵌入社区的居家养老健康照护机构

（3）社区养老服务数据平台的设计、开发与应用。在对现有社区各类养老服务系统的数据结构与数据来源进行分析的基础上，基于微观人口信息、机构信息及服务信息，整合分散孤立的为老服务与管理的数据资源，设计社区养老服务数据平台的功能结构与软硬件系统，为基层养老服务工作者、政府养老服务管理者提供养老服务信息的查询、统计、评估、监管、报表生成、挖掘分析等功能。数据平台的开发一般应对接政府相关职能部门，申请获得常住人口信息数据的使用授权，基于统一的微观人口数据设计共享的数据接口和应用服务。

（4）老年社会工作者的设立与运行。服务于社区养老资源整合和供需对接的老年社会工作者是一个带有前瞻性的崭新的岗位设置，对于其角色定位、专业技能要求，乃至收入来源等问题，无论在理论还是在实践上，目前都处于探索阶段。作为探索的第一步，拟先对现有承担养老服务的社区干部进行相关专业培训，在项目实施过程中把握时机，把老年社工制度适时导入，在实践中不断总结经验，优化改进，使整合式养老服务的社区实践尽快成为可持续、可复制的模式。

第 6 章　老龄社会中的长期照护服务[①]

进入 21 世纪以来，中国政府对于老龄事业发展予以高度重视。2011 年首次将社会养老服务体系建设纳入国家专项规划，2013 年国务院专门出台加快发展养老服务业的意见，2015 年又在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中提出要“推动医疗卫生和养老服务相结合，探索建立长期护理保险制度”等，2016 年国家启动了长期照护试点，地方（如上海、南通和青岛等地）开展了大量摸索实践并取得了一定成绩，但囿于其初始政策安排所固有的逻辑困境，且随着“医养护结合”进一步深化开始暴露出诸多问题，因此尚未形成全国范围内可推广的经验模式。长期照护本身是一个系统性很强的完整体系，但在政策安排中却被割裂，由此使卫生系统和民政系统的关系协调成为焦点，不少医疗服务机构和老年服务机构也陷入误区而难以自拔，并可能导致养老服务跌入“医改陷阱”。如何建立形式多样、多元整合、城乡统筹的养老服务体系，有序增加老年服务资源的供给，并合理控制公共服务费用的支出，已迫在眉睫。为此，在未来一段时期内，发展和完善老年照护服务体系将是中国老龄事业的核心任务之一，而科学研判长期照护体系的需求则是基础和核心。因此，本章将在解析我国当前老年长期照护的需求基础之上，结合全面小康社会发展要求，并在实证模型分析的基础上提出未来促进老年长期照护体系全面、健康发展的若干构想，以供学界和政府参考借鉴。

6.1　老年长期照护需求的宏观变化趋势

国家卫生健康委员会发布的《2018 年我国卫生健康事业发展统计公报》显示，2018 年我国居民人均预期寿命为 77.0 岁，比 2010 年提高了 2.1 岁。预计到 21 世纪中叶，我国人均预期寿命将达到 80 岁左右。这既是我国经济社会发展和公共医疗卫生服务事业取得的巨大成就，同时也带来了严峻挑战。随着年龄的增加，衰老和退行性疾病对老年人身体机能的影响将不断增加，部分老年人会丧失生活自理能力，意味着在剩余的生命时间内需要接受家人和社会的照料服务。研究表明，中国老年人余寿的增加伴随着失能时间的延长，老年人

① 本章作者为：宋靓珺，王雪辉。

口数量的迅速增长和寿命的不断延长将导致老年人照料负担的日益加重(张文娟和杜鹏，2009)。目前家庭主要承担照料失能老年人的功能，但随着家庭结构日益小型化，老年人对家庭照料的依赖将难以维持，家庭养老向社会养老的转变是必然的发展趋势。2016 年以来，我国部分地区开始进行长期护理保险制度试点，与之相关的一个核心问题是我国现阶段及较长时期内失能老年人的规模有多大。失能老年人的规模及其发展趋势是评估老年人长期照护服务需求和制订社会养老服务发展规划的重要依据。

关于中国失能老年人的规模，不同学者的预测存在较大差异。如朱铭来和贾清显（2009）预测，2050 年失能人口规模达 3331 万；景跃军等（2017）预测 2054 年失能老年人数量可达 4300 万；胡宏伟等（2015）的预测显示，2050 年将高达 2.19 亿。本章将选取《世界人口展望》（2017 年修订版）中方案关于中国老年人口的预测数据和“六普”调查中老年人失能率作为测算基数。《世界人口展望》（2017 年修订版）报告依据出生率和死亡率预测了中国在 2020～2100 年老年人口各个年龄段的变动情况（表 6-1）。

表 6-1　中方案下中国 2020～2100 年 60 岁及以上人口的变动情况（单位：万人）

年份	60～64 岁	65～69 岁	70～74 岁	75～79 岁	80～84 岁	85～89 岁	90～94 岁	95～99 岁	100+岁
2020	7 668.4	7 358.9	4 543.9	2 703.2	1 666.4	789.7	242.7	50.3	7.9
2030	11 571.8	8 983.5	6 319.8	5 202.7	2 534.7	1 056.5	386.5	92.4	14.2
2040	8 881.0	10 390.7	9 814.0	6 672.3	3 803.8	2 265.0	675.5	144.0	25.9
2050	11 996.9	8 996.6	7 724.1	8 067.5	6 334.1	3 202.9	1 152.1	360.8	51.1
2060	7 433.1	8 980.3	10 673.2	7 267.3	5 305.6	4 240.8	2 169.6	591.5	104.6
2070	7 615.2	7 020.9	6 739.7	7 501.4	7 742.6	4 143.2	2 032.3	901.3	219.8
2080	7 524.4	7 744.9	7 009.7	6 022.2	5 104.6	4 569.4	3 265.4	998.6	258.3
2090	6 363.5	6 673.9	7 006.9	6 781.4	5 493.3	3 869.5	2 329.6	1 225.7	431.1
2100	6 080.4	6 005.7	5 983.2	5 944.7	5 652.4	45 562.8	2 688.5	1 144.6	394.4

资料来源：联合国经济和社会事务部，《世界人口展望》（2017 年修订版）

生活自理能力（activities of daily living，ADL）是通常被用来评价老年人独立生活能力的常用指标。目前，针对老年人生活自理能力的测量主要有两种方案：一是采用日常生活自理能力量表评估老年人多项日常生活活动的依赖程度，如中国城乡老年人口状况追踪调查（Sampling Survey of the Aged Population in Urban/Rural，SSAPUR）、中国老年健康影响因素跟踪调查和中国健康与养老追踪调查等三个老年专项调查均采用量表方式测量老年人生活自理能力；二是采用生活自理能力综合自评方法，如“六普”调查通过直接询问身体健康状况了解被调查者的生活自理能力。上述四项调查中我国老年人口的失能率如

表 6-2 和表 6-3 所示。

表 6-2　三项老年专项调查中老年人失能率

年份	数据来源	轻度失能	中度失能	重度失能
2010	中国城乡老年人口状况追踪调查	11.8%	0.6%	1.0%
2011	中国老年健康影响因素跟踪调查	7.5%	1.3%	1.7%
2011	中国健康与养老追踪调查	7.8%	1.6%	1.9%

表 6-3　“六普”调查中各年龄组老年人失能率状况

年龄组	60～64 岁	65～69 岁	70～74 岁	75～79 岁	80～84 岁	85～89 岁	90～94 岁	95～99 岁	100+岁	总体
失能率	0.9%	1.5%	2.7%	4.3%	8.0%	12.7%	21.0%	26.0%	29.2%	2.9%

“六普”调查中将老年人生活不能自理的数据作为评估老年人失能率的依据，且包括 60 岁及以上各个年龄组的失能率（表 6-3）。总体看，老年人的失能率随着年龄的增加而增加，老年人总体失能率为 2.9%。与上述三项老年专项调查相比，“六普”调查中的老年人失能率接近中度和重度失能率之和。

此处将依据联合国中方案的人口预测数据和“六普”调查中老年人失能率的结果测算 21 世纪我国失能老年人口规模。理想状态下，科学的失能老年人口规模预测需要依据未来老年人口的动态数据和老年人失能率的动态数据测算，但是目前我国对老年人失能的界定标准仍存在较大争议，现阶段对失能老年人数尚缺乏统一的共识。因此，本章采用“六普”所反映的老年人失能数据作为静态的失能率进行分年龄组预测，结果如表 6-4 所示。

表 6-4　2020～2100 年我国失能老年人口规模及年龄分布状况（单位：万人）

年份	60～69 岁	70～79 岁	80～89 岁	90+岁	总体
2020	179.4	238.9	233.6	66.4	718.3
2030	238.9	394.3	337.0	109.3	1079.5
2040	235.8	551.9	592.0	187.0	1566.7
2050	242.9	555.5	913.5	350.6	2062.5
2060	201.6	600.7	963.1	639.9	2405.3
2070	173.8	504.6	1145.6	725.3	2549.3
2080	183.9	448.3	988.7	1020.7	2641.6
2090	157.4	480.8	930.9	933.8	2502.9
2100	144.8	417.1	1031.7	977.4	2571.0

根据“六普”失能率的预测结果，21 世纪我国失能老年人口规模先快速增长后缓慢增加，即老年失能人口总体规模不断增多，但增速呈持续下降趋势。2020 年我国中/重度失能老年人口数约 718.3 万，2050 年失能老年人口数将达到 2062.5 万。21 世纪中叶之后，我国中/重度失能老年人口规模将维持在 2500 万以上。分年龄段看，80 岁及以上高龄老年人口失能比例较高，高龄化明显。在一定程度上而言，人口老龄化并不会导致长期照护服务需求的快速增加，而老年人口的高龄化则是评估老年长期照护服务需求的重要指标。因此，各地区应重点根据本地高龄老年人口规模做出相应的制度安排和政策设计，提高政府决策的科学性与合理性。

6.2　我国老年长期照护需求的现状与问题

长期以来，我国并未将针对失能老人的长期照护服务与面向一般老年群体的养老服务明确区分，两类服务存在交叉和重叠，致使对失能、失智老人的长期照护服务供给严重不足，因此才会出现国家的投入在增大，政策力度在加强，但政策效果并不显著，护理床位缺少与大量新增床位无人问津并存的结构性失衡问题依然严重。出现这种状况一个重要的原因是失能、失智老人精准识别尚未提上重要议事日程，政策靶向不准。因此，如何准确制定失能老人的分级分类标准以提供较为精准的服务类型、服务内容和服务模式是构建和实施长期照护服务体系的关键性基础。

6.2.1　失能评估在我国各试点城市长期照护中的应用

我国的长期照护服务体系刚刚起步，截至 2020 年底在全国 28 个城市正式开展长期护理保险的试点。各个试点城市使用的评估工具方法各有特色，本章根据几个代表城市的运行案例，对其评估工具的差异进行比较（表 6-5）。长期照护保险的发展带动了长期照护评估，如青岛早在 2012 年就率先试水长期医疗护理保险制度，是我国最早开始试点的城市，长春、南通和上海等都在人力资源和社会保障部开展正式试点前就开始探索相关工作。上海的长护险经由在徐汇、普陀、金山三区试点的基础上，制定出了非常详细的需求评估标准。

表 6-5　国内长期照护代表性试点城市的评估工具

项目	青岛	南通	长春	上海
评估量表	1.《日常生活能力评定量表》Barthel 指数评定量表	《日常生活活动能力评定量表》、	《日常生活活动能力评定量表》Barthel 指数评定量表或国家《综合医	《上海市老年照护统一需求评估标准（试行）2.0 版》

续表

项目	青岛	南通	长春	上海
评估量表	2.《青岛市长期护理保险失智老人失智状况评估量表》[《中文简易智能精神状态检查量表》(Mini-Mental State Examination，MMSE 量表)]等	Barthel 指数评定量表	院分级护理指导原则（试行）》或体力状况评分标准（卡氏评分 KPS）	
评估维度	日常生活能力 认知状况（失智）	日常生活能力	日常生活能力 或护理等级 或体力状况	自理能力（日常生活活动能力、工具性日常生活活动能力、认知能力） 疾病轻重程度
评估项目	日常生活活动能力-10 项：行走、洗澡、如厕、穿衣、进食、洗漱、控制大便、控制小便、床椅转移、上下楼梯			日常生活活动能力-20 项：大便是否失禁、小便是否失禁、洗脸/洗手、梳头/化妆、使用厕所、进食、坐立位起身、坐凳椅、平地步行（移动）、穿/脱上衣、穿/脱裤子、上下楼、洗浴等（权重：65%）
	认知：时空定向、短时记忆、注意力和计算力、记忆力、语言能力等		疾病轻重程度、 生活自理能力	工具性日常生活活动能力-8 项：搭乘公共交通、现金和银行账户的管理等（权重：10%） 认知能力-22 项：定向能力、计算能力、记忆力、日常生活中的基本判断能力和情绪精神症状等（权重：25%） 11 种常见老年病分局部症状、体征、辅助检查、并发症 4 个分项（对应的权重分别为 30%、30%、30%、10%）
受益人群标准	《日常生活能力评定量表》低于 60 分（不含 60 分）（失智）MMSE 量表程度为重度，60 岁以上参保人员	《日常生活活动能力评定量表》50 分（含）以下中重度失能人员	《日常生活活动能力评定量表》40 分（含）以下重度失能人员 或国家分级护理中确定为一级护理条件且生活自理能力重度依赖人员 或 KPS 评分低于（含等于）50 分的癌症晚期患者	60 岁以上已领取养老金，自理能力为照护二级至六级

从以上几个城市长护险的评估工具看，存在一些共同的问题：①评估过程仍较为偏重医疗和临床护理，评估工具中借助了不少康复医疗评估指标，因此

在各个城市的实际操作过程中，极易将长期护理与医疗服务混淆，如青岛在区分“家护”、“巡护”、“院护”和“专护”时几乎完全用疾病及医疗护理作为区分。②单一量表不足以充分评估老年人失能的综合表现，青岛虽然还关注了失智老人，但实际上医护、失能、失智的评估是比较分散独立的，长春和南通都还没有考虑认知方面的评估，上海率先开始采用多重量表并分配权重，但这样的权重分配方式的合理性还有待更多操作层面的检验反馈。③普遍缺乏对社会参与和外部环境的关注，在 WHO 失能相关的分类方法和不少发达国家的失能评估中，都会特别考虑老年人的外部生活环境与社会维度，如沟通与交流能力、（不当）行为问题或其他社会接触和活动参与的内容。④最后评估结果大都未能与实际提供的服务等级对接。只有上海直接根据疾病状况和自理能力水平确定照护等级，而在其他更多试点城市，实际上都只规定了长护险受益人群的准入门槛，没有对接上相应的护理服务等级。

6.2.2　评估工具未来发展方向

合理有效地评估老年人口的健康状态和健康需求，是社会养老保障体系决策中的重要依据，政策目标是使国家和社会有限的社会保障和服务资源供给与日益增长的老年人需求相匹配，从而使得政策实施的成本-效益-效果更趋于合理。从国家宏观层面而言，使用一套操作性强的评估工具可以准确地评估中国失能老年人口的规模，为国家相应的公共服务资源投入提供可靠的依据，也有利于科学理性地评估老龄化对中国未来社会经济发展的影响，更有效地制定应对老龄社会的战略布局；从中微观视角而言，能准确地估计老年人失能的持续时间和对各种医疗康复护理服务的实际需求，帮助社会和企业开发合适的商业服务模式，引导社会资本和其他资源进入老年长期照护领域，也利于帮助实现老年人合理安排康复照护活动，并组织好家庭资源，形成全社会参与的格局。

因此借鉴国外实践经验，本章认为在参考国际通用工具［如 InterRAI（International Resident Assessment Instruments，国际居民评估工具）量表，WHO-ICF 框架[①]］的基础上，应充分考虑本国实际国情，创造出符合中国文化和传统特色的理论框架和评估体系。将我国目前普遍使用的评估工具（失能框架）逐渐从单一量表向复合型量表过渡，并通过科学论证合理地设置量表各项目的权重，以期更有效地反映老年人的衰弱程度，最后应将评估结果与相应的长期照护服务相衔接，提高量表的现实运用价值。同时在公共服务层面，致

① 在 2001 年 5 月 22 日第 54 届世界卫生大会上正式发布《国际功能、残疾和健康分类》（International Classification of Function, Disability and Health，ICF）。这是一种从生物-心理-社会医学角度认识损伤所造成的影响的新模式，不仅考虑了身体功能和结构，还纳入了个体活动和社会参与、环境因素等，为从身体健康状态、个体活动和个体的社会功能上探索提供了理论框架。

力于建设更有利于老年人日常生活的外部环境和社会态度，鼓励老年人积极参与社会活动，保持旺盛的功能水平，实现健康老龄化。

6.3　长期照护服务影响因素的实证研究

庞大的失能老年人口规模及特殊的社会经济结构对我国长期照护服务提出迫切需求。传统的家庭养老和服务举步维艰，老年人长期照护从单独的家庭照料走向市场和社会成为大势，在医养结合的基础上，长期照护成为一项惠及万家的社会服务也是一种必然趋势。长期照护体系的构建取决于失能老年人口的现状和实际养老模式，传统的家庭照料如何在新老龄社会下长盛不衰，而社会化长期照护体系如何更好地优化配置有限资源以满足不同失能老年群体的康复护理需求从而使失能老年人群有更多的获得感，是政策制定者和学界普遍关注的焦点；分析不同失能老年群体选择不同护理模式的影响因素，了解哪一部分老年人群更倾向于选择除家庭之外的社会化正式照护服务，则是相关涉老部门制定合理长效的长期照护政策的重要可循依据之一。因此，本章利用 2014 年中国老年健康影响因素跟踪调查数据，考察中国失能老人的基本状况及相关特征，以本土化修正后的安德森健康行为模型为理论框架，对影响中国失能老人长期照料服务选择的诸多因素进行分析、验证，并考察相关影响因素的作用向度和影响幅度，提出相关老龄服务政策建议，以合理引导老年服务资源的配置、促进老年社会的健康发展。

6.3.1　研究设计与模型构建

1. 数据来源

本章采用的数据是北京大学老龄健康与家庭研究中心 2014 年中国老年健康影响因素跟踪调查数据。该数据调查涉及全国 22 个省区市，样本包括 7110 位 65 岁及以上老人。本章选择其中需要长期照料的老年人，即根据调查问卷所测量的日常 ADL 六项指标（洗澡、穿衣、吃饭、如厕、控制大小便和室内走动），以及每项需要他人照料的时间进行筛选。根据国际通行法则，六项指标中至少有一项部分或完全不能自理且需要他人照料时间在 90 天（含）以上的，即属于需要长期照料的老年人。通过筛选，最终选取符合条件的 1056 人作为研究样本。

2. 变量和方法选择

本章的因变量根据问卷中“您目前在六项日常生活活动中需要他人帮助

时，谁是主要帮助者”及“您目前与谁住在一起”，分为非正式家庭照料和正式社会化长期照料。其中，非正式家庭照料是指居住在家中或社区，由配偶、子女、亲戚或邻居朋友等未经过专业护理培训的人员提供的无薪酬的照料；正式社会化长期照料是指居住在家中或社区，但由家庭雇佣保姆或使用社区有偿服务（如社区提供的上门服务及社区日间照料中心、托老所等）作为主要照料来源及集中居住在养老机构（如养老院、敬老院和老年公寓等），由机构专业服务人员提供的有偿服务的照料。将因变量做 0-1 变量处理，即非正式家庭照料赋值为 0，正式社会化长期照料为 1。

因失能老人的长期照护服务涵盖医疗健康服务，本章选择在公共卫生健康领域探求个体因素与健康服务使用关系常用的理论模型——安德森健康行为模型作为基本的理论框架。同时，安德森健康行为模型作为一种在西方产生、发展的理论模型，在中国情境的运用中，仍需要考量中国文化传统（如同住子女数）、家庭和谐（家庭照料者的照料意愿、家庭成员的亲密程度等），以及社区服务供给情况等影响因素在老年人选择不同照护方式时发挥的作用。通过修正安德森健康行为模型在长期照护服务影响因素中的应用，使其更符合中国的文化特征是本章的研究创新之一。因此，本章的自变量在总结前人研究基础上，在安德森使能因素中加入照料者意愿、社区服务供给等变量。根据安德森健康行为模型的分类，将 2014 年中国老年健康影响因素跟踪调查数据中可能影响失能老人对长期照护服务使用的因素分为前倾因素、使能因素和需求因素三类。

3. 变量特征

通过对数据的整理分析，本章的失能老人的样本数为 1056 人，加权后推算得到的总体失能率为 6.42%。从失能老人内部结构来看，失能老人分布在乡镇地区的比例超过八成，为 82.29%，比城市地区高约 64 个百分点；女性失能老人比例比男性高近 30 个百分点；年龄越大，失能老人也越多，所有失能老人中，80 岁及以上的占比达到 57.18%。

按照 ADL 分类定义的失能程度，可以发现相对自理的老人占 37.18%，虽然很多老年人具备相对的自理能力，但仍然可能需要长期照料服务的帮助和支持，使其尽量保持独立生活。由于老年人群内部的异质性，仅使用 ADL 评估损伤级别并不全面，因此引发了我们对单一评估工具是否适用于当下现实的思考。国内已有学者和研究团队在探索对老年人及健康的重新定义，而本章的研究结论则再次验证了国际通行长期照护评估工具（如 WHO 定义的 ICF 分类系统）中国化发展的必要性和紧迫性。

由家庭成员、邻居等提供的无薪的非正式家庭照料是目前我国老年人失能后的主要照料模式，占比达到 84.53%，而正式社会化长期照料占比相对较小，

只有 15.47%。女性失能老人选择非正式家庭照料的比例高于男性，这与中国女性受教育水平较低，思想观念相对较为保守有关，经济条件也限制了她们不太可能选择需要付费的正式社会化长期照料服务；在农村地区，虽有超过八成（82.81%）的失能老人选择非正式家庭照料，但仍低于城市地区约 10 个百分点。这与近几年快速发展的城镇化进程有关，其使得农村地区原本较为丰富的家庭照料资源优势不复存在。中国失能老人的长期照料有着显著的性别和城乡差异，这就使得公共政策的引导更需有的放矢。变量的基本特征如表 6-6 所示。

表 6-6　变量的基本特征

变量	统计值	变量	统计值
长期照料模式		中风	
非正式家庭照料	84.53%	无	72.38%
正式社会化长期照料	15.47%	有	27.62%
前倾因素		心脏病	
年龄		无	73.05%
65～79 岁	42.82%	有	26.95%
80 岁及以上	57.18%	失能程度	
性别		完全依赖	39.83%
男	35.33%	相对依赖	22.99%
女	64.67%	相对自理	37.18%
是否受过教育		使能因素	
未受教育	41.97%	居住地	
受过小学教育	25.65%	城市	17.71%
受过小学以上教育	32.37%	乡镇	82.29%
婚姻状况		去年家庭总收入	
有配偶	38.93%	8 000 元及以下	24.96%
无配偶	61.07%	25 000 元及以下	24.91%
需求因素		50 000 元及以下	28.37%
慢性病种类		50 000 元以上	21.75%
高血压		是否参加养老保险	
无	57.74%	无	56.85%
有	42.26%	有	43.15%

续表

变量	统计值	变量	统计值
是否参加医疗保险		同住儿子数	
无	21.81%	0	75.73%
有	78.19%	1	23.16%
社区是否提供生活照料		2	1.08%
无	80.96%	3	0.03%
有	19.04%	同住女儿数	
社区是否提供医疗服务		0	93.37%
无	66.48%	1	5.83%
有	33.52%	2	0.8%
		3	0.01%
		照料者意愿	
		愿意	90.97%
		其他	9.03%

注：①将问卷中社区提供的“起居照料、日常购物”归入“生活照料”，将“上门看病、上门送药”归入“医疗服务”；②养老保险包括退休金、养老金，医疗保险包括公费医疗、城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合；③百分比加总不等于100%是四舍五入导致的

4. 模型构建

本章采用 Logistic 回归模型，因变量“长期照料模式的选择情况”是二分变量，只取值 0 或 1。p 表示事件发生的概率，这里也就是老人选择正式社会化长期照料的概率。$p/(1-p)$称为发生比（odds ratio），大于 1 时表示发生比不发生的概率大，也就是事件更有可能发生。做 logit 变换，即 $f(p)=\ln\left(\frac{p}{1-p}\right)$，表示对事件发生与不发生概率比值取自然对数。然后构造模型 $f(p)=\alpha+\beta x+\varepsilon$，$x$ 是模型纳入的自变量，ε 表示因变量中无法被自变量解释的误差项。截面数据可能存在异方差，会对变量的显著性产生影响，所以模型中使用稳健标准误。

为了分析前倾因素、使能因素和需求因素对长期照料模式选择的影响方向和程度，本章构建了三个模型，模型 1 只纳入了前倾因素，模型 2 同时纳入了前倾因素和使能因素，模型 3 则同时纳入了前倾因素、使能因素和需求因素。通过不同模型结果的对比，还能单独获得某些因素的影响大小情况。

具体模型如下。

模型 1：$f^1(p)=\alpha^1+\beta_1^1 x_{\text{前倾因素}}+\varepsilon^1$。

模型 2：$f^2(p)=\alpha^2+\beta_1^2 x_{\text{前倾因素}}+\beta_2^2 x_{\text{使能因素}}+\varepsilon^2$。

模型 3：$f^3(p)=\alpha^3+\beta_1^3 x_{\text{前倾因素}}+\beta_2^3 x_{\text{使能因素}}+\beta_3^3 x_{\text{需求因素}}+\varepsilon^3$。

6.3.2　模型模拟结果及分析

模型分析的结果如表 6-7 所示，具体分析如下：第一，前倾因素中只有受教育水平与正式照料服务的使用始终相关，即教育程度越高的老年人越倾向于选择正式长期照护服务，呈现显著的正向关系。通过计算教育的边际概率平均值也可以发现，接受教育能显著地提高失能老人获取正式社会化长期照料的概率，并且在控制了需求和使能因素后，受教育程度越高，该概率也越大，然而，年龄、性别和婚姻状况等社会人口学要素在此并不显著，可能的解释原因是这些变量通过其他中介变量得到了解释。

表 6-7　模拟回归系数

模型	发生比		
	模型 1	模型 2	模型 3
年龄（65～79 岁）			
80 岁及以上	0.27**	0.53	0.62
性别（男）			
女	0.73	1.91	1.78
是否受过教育（否）			
受过小学教育	4.17*	2.91**	3.00*
受过小学以上教育	3.60**	4.19**	5.89**
婚姻状况（有配偶）			
无配偶	1.14	2.54**	1.87
居住地（城市）			
乡镇		10.38***	6.29**
去年家庭总收入（8 000 元及以下）			
25 000 元及以下		0.29	0.19**
50 000 元及以下		0.71	0.28**
50 000 元及以上		15.21***	7.23***
是否参加养老保险（无）			

续表

模型	发生比		
	模型 1	模型 2	模型 3
有		14.76***	10.59***
是否参加医疗保险（无）			
有		0.06***	0.10***
社区是否提供生活照料（无）			
有		14.46***	19.30***
社区是否提供医疗服务（无）			
有		0.32*	0.34*
同住儿子数（无）			
有		0.02***	0.02***
同住女儿数（无）			
有		0.07**	0.08***
照料者意愿（愿意）			
其他（不情愿、不耐烦）		2.62	4.24*
慢性病种类			
高血压（无）			0.21**
中风（无）			0.74
心脏病（无）			0.22**
失能程度（完全依赖）			
相对依赖			0.87
相对自理			0.42
样本量	1056	1056	1056

注：括号内为参照组

*表示 $p<0.1$；**表示 $p<0.05$；***表示 $p<0.01$

第二，使能因素中的经济收入对正式社会化长期照料模式的选择具有明显的“U”形效应。在以往的研究中，收入与长期照料服务使用的关系一直没有定论，部分学者的研究结论是收入水平越高，正式社会化长期照料服务的使用概率越高；但也有学者得出了相反的结论。本章的分析显示，相较低收入老年群体，当家庭收入水平处于中等或中等水平以下时，其选择非正式照料的概率较大；而当收入达到一定水平后，选择正式照料服务的概率就大大提高了。收

入效应存在较为明显的“U”形效应，说明一方面现阶段我国社会化服务的价格仍然超出大部分老年人的实际支付能力，巨大的潜在需求无法真正转化为现实的有效需求；另一方面，随着中国拥有高资产净值的“婴儿潮一代”人口逐渐步入老年，这部分人群对新事物的接受度较高，养老观念较新，对高端养老服务机构的需求也较大。

第三，社区提供不同的服务类型将左右老年人选择不同种类的照料服务。其中，社区提供的生活照料服务将很大程度上决定老人选择正式社会化长期照料的比例，而医疗服务的完善则可能降低老年人对此项服务的使用倾向。这从一个侧面反映了现阶段我国社区在提供一般生活照料服务方面还不能满足失能老人的需求，尽管社区提供此项服务但仍不能阻止老人“被机构化”；而医疗服务则相反，这与近几年我国社区卫生服务站等基层卫生工作的普遍开展有着密切关系。作为集家庭照料和机构照料优势于一体的社区照料，在中国目前的发展仍处于起步阶段（2015 年选择社区照料的失能老人比例为 2.5%），未来将是社会化正式照料体系的重要组成部分。

第四，主要照料者意愿越消极的失能老人越倾向于选择社会化养老服务。在中国特定的文化背景下，照料者意愿和长期照料模式的最终选择并不是单纯的因果关系，这印证了“在养老方式的选择上，个人、配偶和子女三方（前三位）起着关键作用，最终要看各方综合平衡的结果”的结论。在崇尚“个人主义”的西方文化里，老年人自己拥有决定用何种方式养老的自主权；而在传统的东方文化里，最终的决策往往是由照料者和被照料者共同决定，甚至在大部分时候，往往是由主要照料者决定。因而，在服务使用的影响因素考量中，照料者的因素绝不可忽略。因此，需要国家以家庭政策为出发点，对主要照料者提供必要的如现金补贴和税收豁免等扶持，由社区提供照料者喘息服务、社区日间服务等措施来减轻照料者的现实负担和精神压力，从而达到继续倡导和鼓励家庭照料的目标。

6.4　完善长期照护服务体系的对策建议

老年人的长期照护问题是迈入小康社会的重要议题之一。其一，在老龄社会中，老年长期照护保障不仅关乎老年人的自身福祉，更关乎代际和谐、家庭发展与社会活力，牵一发而动全身。其二，长期照护保障制度（如资金保障和服务保障）建设是我国经济社会转型发展的重要组成部分，能否处理好两者之间的关系将决定我国的经济发展是否可持续。因此，本章将主要从长期照护评估工具、长期照护影响因素等需求侧角度提出完善长期照护服务体系的对

策建议。

1. 对 ADL 等传统长期照护评估工具的新思考

首先，Katz 在 20 世纪 50 年代提出了 ADL 指数（洗澡、穿衣、上厕所、室内活动、控制大小便、吃饭）来衡量老年人的失能状况和失能程度，在国际上得到了广泛的认同并沿用至今，但传统定义已不能完全适用当下社会发展，凸显其历史局限性。ADL 和 IADL（instrumental activities of daily living，工具性日常生活活动能力）指数主要是基于老年人对自身功能的一种主观判断，也就必然与客观现实存在一定的偏差。作为一种具有普适性的标准，难以涵盖因各国、各地环境气候和生活方式的差异对生活自理能力的判断。我国改革开放以来人们生活水平的迅速提高和生活便利化程度的大幅提升都大大降低了老年人口需要依靠自身体力而实现生活自理的限制，也就是说伴随社会的进步和科技的发展，生活自理能力的生理基础正在发生变化。因此，这种以结果为导向的传统分类方式，并不能完全捕捉到所有真正需要长期照护的人群，忽视了“由不同功能缺损导致的失能对日常生活照料需求是不一样的”的现实。

其次，WHO 对健康的定义为“健康不仅仅是消除疾病或虚弱，而是一种身体、精神与社会环境适应的完好状态”。然而，目前人们普遍关注的是老年人的疾病与虚弱，以及由疾病导致的基本生活能力丧失，而这并非科学完整的大健康概念。传统的 ADL 失能框架测量的主要是老年人的日常活动能力，忽视了老年人认知能力和心理健康状况，也没有涉及老年人社会参与能力的变化和影响，老年人口的心理和社会参与在老年长期照护研究中也处于边缘的地位。其结果是对老年长期照护缺乏科学的整体了解，相关的统计数据存在高估（或低估）长期护理需求的状况，有关政策设计也偏于宽泛而缺乏精准的目标和对策。

最后，本章认为，失能老人的概念本身是会引起歧义的。WHO 对健康老龄化的定义中，强调内在能力和功能发挥这两个核心概念，如何帮助老年人口最大限度地发挥其生理和社会功能应当成为我们研究和设计老年长期照护体系的重要出发点，而不是如传统的长期照护那样只聚焦于为失能老人提供照料服务。老年人口本身蕴藏着巨大的人力和社会资本，即使按照 ADL 等传统指标有一项或者几项功能损伤，但一个智能、便捷和无障碍的年龄友好的社会环境也可以帮助这些老人发挥未丧失的身体功能的社会价值，而不是将所有存在服务照护需求的老人都纳入被抚养的或成为社会负担的范畴。在各地开展的长期照护保险试点工作中，对老年人口照护需求的评估，以及在此基础上的服务分流是一个重要的环节。同时，我们建议在个体评估的基础上，增加社区老人生活和社会参与的环境指标。

基于上述分析，对失能的类型进行深入探究，综合考虑肢体、感官、认知与心理、社会交往等多方面因素，针对不同失能类型制订有针对性的、个性化的照护方案无疑对失能老人的康复护理更有帮助。未来研究中，我们认为可以基于 WHO 的 ICF 健康框架，将评估工具从以下几个维度进行重构——感官（视力、听力）、躯体（四肢活动功能）、认知与心理、社会交往能力，已有研究表明其不仅与传统的失能分类标准具有较高一致性，还能挖掘出被传统标准所遗漏的信息，具有较强有效性。此外，一个科学完整的“大健康”概念应该由以下四个维度构成：没有身体功能损伤（ADL/IADL）、没有认知障碍或心理疾病（抑郁、孤独等）、社会参与功能正常和老年友好型环境的支撑（公共卫生改善、适老化改造）。

2. 以全生命周期视角全面研判长期照护服务的有效需求

从生命周期的视角来看，个体的老化是一个逐步的、因人而异的过程（彭希哲和胡湛，2011）。老年人的智力和机能逐渐衰退最终导致失能，是一个动态演变的过程，而极少在某个时点突然变为失能状态。因此，如果用衰弱（frailty）的视角来看待老年人的失能过程，就能帮助我们更好地了解老年人由于内在机能及外在环境的压力面临的健康恶化的极大风险。事实上，许多医学研究也表明，老年人的失能不仅是由于退行性疾病（大部分是慢性疾病），更多是来自与疾病本身无关的机体功能自然退化，是基于生物层面循序渐进、终身累积的分子和细胞损伤而导致的功能渐进损伤。

因此如果我们将失能干预前移至机体开始衰弱的阶段，那么及早地增强体育锻炼、补充必要充足的营养、加强社会交往等健康行为都能有效地延缓失能的发生时间和病情程度[①]，并尽可能地维持和发挥老年人内在能力，延迟甚至扭转老年人个人能力的下降。国内外学者对老年人在早期的社会参与对后期机体功能即健康、死亡率、主观幸福感和生活满意度等方面的影响有过不少研究（梅陈玉婵等，2012），发达国家在这方面也有大量的实践可供我们借鉴。例如，日本在社区创建了大量廉价的老年运动设施和场所，鼓励年轻的老年人在身体出现问题之前就意识到体育锻炼的重要性，并加强卫生保健和疾病预防知识的普及，以降低疾病特别是与失能相关的退行性慢性疾病的发病率。丹麦政府出台了一项独有的政策——预防性家访（preventive home visits），由政府出资对 65 岁以上的老人进行身体检查并提出相应的预防措施；对 75 岁以上的高龄老人的住所进行安全隐患检查，以减少老人在家中跌倒的发生率（跌倒是老年人失能的最主要原因，50%的跌倒、坠落伤发生在家中）（杜鹏和董亭月，

① 导致老年人失能的主要原因是罹患各种慢性疾病，而慢性疾病的病因多与社会因素有关，特别是个人的生活环境、生活习惯和个性特征。

2015）。这些举措均将“预防为主”的理念深入人心，从而推迟甚至避免使用长期照护服务。

将失能后的照护延至存活时间在 6 个月以内的生命临终期，为临终者提供缓解病痛治疗以使其尊严、体面地离开人世，和对临终者家属进行死亡教育和心理慰藉，以帮助家属客观、平静地接受亲人离世的临终关怀服务，是构筑个体生命周期的最后一道安全网，或者说是社会保障体系的最后一道防线的重要制度安排（林艳等，2009）。至此，个体生命周期的安排就相对较为完整，人生各个阶段都得到了最合适的照护和关怀。

3. 鼓励老年人社会参与，有效释放老年人的活力与潜力

老年人在衰老的过程中逐渐丧失部分生理、心理功能，但这并不代表他仅仅需要全方位的护理照料，合理有效的制度安排要能够激发老年人体能依然存在的那部分能力的发挥，这些能力包括老年人的自我调适功能和自我管理能力。因此，社会政策的设计和制定不仅要为老年人提供所需服务，更要为老年人发挥“复原力”提供机会、创造条件，真正创造“以老年人为中心”的政策实施环境，将老年人从被动接受服务变为主动参与设计服务。

老年人自身蕴含的复原力（resilience[①]）使得老年人在面对健康状况退化、家庭变故等外部风险时，依然能够激发出极强的适应及恢复能力，是“积极适应逆境的动态过程”。老年人群是一个脆弱的群体，在面临失能、失智等健康状况恶化等外部风险时，可以借助内在的乐观积极等性格特征和社会支持支援等外部因素，发挥主观能动性，以更加自主的方式调动自身储备的复原力，保持社会功能。值得庆幸的是，这种能力是可以后天培育的。因此，应为老年人创造一个有利于老年人获取外部帮助的友好型环境和公共政策支持体系，使老年人获得更加完备的公共健康和社会保障服务，鼓励老年人维持较好的家庭互助网络和社会资本支持，有效激发老年人自我照顾、自我服务和自我管理的修复能力。

在目前涉及老年人福利的各种社会政策的实施过程中，仍然以“补缺式”或“应急式”的方式为主，而在老年长期照护方面，老年人自身存在的“未挖掘的潜力”不应被忽视。老年人不仅存在健康问题，他们更是有着不同偏好需求的个体，归属于他们的家庭和社区，需要通过参与决策来真正承担并发挥自身的功能。另外，积极的自我管理能使老年人更好地适应老龄化角色，也更有可能激励老年人继续学习自我健康管理的知识和技能、保持足够的社会参与，

① resilience: the ability to maintain or improve a level of functional ability in the face of adversity through resistance, recovery or adaptation。（复原力：是一种在外部逆境下，通过复原、恢复或适应从而保持甚至提升功能的能力。）

延缓衰老和失能的进程。“以老年人为中心”的政策实施环境，就是要让老年人保有自我管理的权利和能力，成为健康保健规划和自我管理的参与者，还原老年人的主体性和社会性。

4. 利用大数据技术精准识别有效需求，降低供需失衡带来的运行成本

在积极应对人口老龄化的背景下，加快养老服务体系建设的关键在于养老服务供给和需求的有效匹配，这建立在有效需求的精准识别和服务供给的科学拆解上。老年衰弱群体、老年失能群体和老年认知障碍群体的精准识别可以精准定位有效需求群体，避免过度治疗、过度照护带来的社会成本；与此同时，养老服务供给主体的提供方式可以时间为单位进行拆解和分割，充分整合志愿者、义工、散工等供给资源，利用区块链技术实现养老服务供需双方的最佳匹配，达到降低养老服务总需求和提高养老服务供给总效益的双赢结果。

在未来，我们有足够的理由畅想，区块链在养老供应链领域应用的前景将是巨大的。现有的养老供应食品及医药信息数据在存储、传输、展示等环节中都有被篡改的风险。现有的追溯体系严重依赖政府监管措施，无法对监管者的权力进行有效的约束。区块链的去中心化和不可篡改性，可以保证养老供应链追溯系统中信息的可靠性，可以避免数据被篡改。而且，区块链技术如果和物联网技术结合起来，就可以通过机器实现数据的自动采集，既可以提高效率，又避免了数据的作假和隐瞒。由于区块链技术的开放透明和机器自治，消费者、生产者和政府部门可以完全信任养老供应链追溯系统中的数据，这就大大降低了交易过程中的不确定性，降低了很多隐性成本。

此外，将区块链与人工智能（artificial intelligence，AI）养老服务结合，如智养链以区块链技术推动人工智能、智能硬件在养老领域的发展，并在中国率先铺设各类健康养老驿站，真正将区块链技术率先应用于线下场景，用区块链技术提升中国的养老服务水平，帮助更多的老年人安享晚年。利用专属方式激励老年人提供高度连续的、匿名的、可追溯的、不可逆的、可扩展的医养数据。在区块链智慧养老中，信息服务平台通过对老年人的远程监测，能够获得海量的信息数据，包括对老年人的生活状态、身体机能和心理状态的监测数据。在老年人的实时响应中利用智能机器人设备 24 小时实时待命语音交互的特点来满足用户的各类紧急和常规交互需求；利用智能监控设备来保障养老驿站的安全和实时掌握用户的健康状态信息。智慧养老平台的养老服务功能主要体现在对老年人服务需求的主动响应上，在对日常监测数据深度挖掘处理和实时监控的基础上，分析老年人养老服务需求而主动为老年人提供各项服务。

老龄化是未来中国不可逆转的人口新常态，将持续地对社会产生深远的影响。随着中国逐渐步入深度老龄化社会，人口高龄化特征越发明显，老年人罹

患慢性疾病及失能、失智比例逐年升高，长期照护问题成为老龄社会普遍存在而又亟待解决的养老难题。长期照护是世界各国进入老龄化中后期阶段面临的共同难题，加之中国生育政策的干预及社会经济结构的快速变迁形成的家庭少子老龄化等模式变迁、老年人的独居化和空巢化等居住模式（2017 年我国的独居和空巢老人近一亿人），以及“未富先老”和“未备先老”等特殊国情，使得长期照护的问题对于现阶段的中国社会而言显得更为复杂和严峻。失去自我照料能力几乎是每一个人不可回避的生命历程，长期照护服务作为提高老年人生命和生活质量的一项社会公共服务已逐渐被公众接纳。学术界对于长期照护的研究也顺应了社会经济发展的诉求，而从需求角度对该体系的进一步深入研究应当成为重要的议题。

第 7 章　老龄社会的就业与消费形态变迁[①]

进入 21 世纪，科技进步带动全球社会经济形态的变迁，并推动产业形态加快更新换代。中国作为当前全球技术发展的重要参与者，在某些领域中引领着前进方向，科技无疑在改造我国老龄社会的产业形态方面将发挥日益重要的作用，特别是人工智能、生命科学、物联网、云计算、大数据等技术的迅猛发展。与此同时，随着老龄社会中老年人口比重的持续上升，老年人对健康、医疗及康复护理等个性化需求增多，这一需求将传导至各产业链条，从而影响老龄社会的就业、消费乃至产业的方方面面。相较于传统社会，老龄社会的产业形态无疑具有其特殊性，这不仅可归因于社会经济与技术的发展及其所导致的需求结构变动，同时也与整个社会的资源禀赋和政策变迁有关。

本章基于中国人口及劳动力资源的未来趋势，分析中国老龄社会就业形态的变迁与发展，探讨老年消费新态势及其经济发展的引擎功能，并对技术快速发展背景下的老龄产业政策进行再思考。

7.1　老龄社会的劳动力结构格局

从全球范围来看，劳动年龄人口的规模普遍趋于减少。对于中国而言，其劳动力总量变动相对平缓，劳动力年龄结构却变化显著。在这样的背景下，以互联网为代表的技术发展给整个劳动就业市场带来新的契机，并对劳动力资源配置进行重组与调整，形成虚拟劳动力市场，在提升劳动力效率的同时减少劳动力价值的过度磨损。在新的劳动力供给格局下，有必要对劳动力的内涵及外延进行再认识，以有效把握劳动力供给的实际状况，并进一步推动劳动力资源的优化配置。

7.1.1　中国年龄别劳动力参与率变动趋势

劳动参与率是一定年龄的经济活动人口与该年龄人口的比率。1990～2010 年，不同年龄组劳动参与率的变动呈现出两个明显的特点，即 16～25 岁年轻人口劳动参与率显著下降，而 55 岁及以上人口劳动参与率有所增加。年轻人

① 本章作者为：彭聪、龚遥、乐昕。

口劳动参与率显著下降的主要原因是平均受教育年限的延长，尤其是于 20 世纪 90 年代末启动的高校扩招，使得越来越多的年轻人进入就业市场的时间推迟。55 岁及以上人口劳动参与率的上升可以归因于健康状况、工作条件和社会政策等的改善。

本书课题组（朱勤和魏涛远，2017）根据 1997 年以来的劳动参与率变动趋势，综合参考马忠东等（2010）、齐明珠（2010）等的研究，设置了 2010～2050 年中国分年龄人口劳动参与率变动的基准情景。假定 2010～2030 年，由于职业教育与高等教育的进一步普及，16～24 岁年龄段的劳动参与率呈现持续下降的趋势，其中，16～19 岁组从 33.5%匀速降至 20%，20～24 岁组从 72.8%匀速降至 61%，2030 年的水平均接近 2017 年前后日本和韩国该年龄人口的劳动参与状况；考虑未来退休年龄政策调整等因素，55～64 岁年龄段的劳动参与率有所提高，其中，55～59 岁组从 67.1%匀速升至 75%，60～64 岁组从 49.5%匀速升至 57%，其他年龄组保持 2010 年的劳动参与水平。假定 2030 年之后各年龄组劳动参与率保持稳定。

基于上述年龄别劳动参与率预测数据，结合 *World Population Prospects: The 2015 Revision*[①]人口预测的中等生育水平情景，将各 5 岁间隔年龄组的人口数与年龄别劳动参与率相乘，估算出各年龄组劳动力的变动情况。部分年份劳动力变动情况如表 7-1 所示。

表 7-1　1990～2050 年年龄别劳动力变动

年龄	1990 年	1995 年	2000 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年	2025 年	2030 年	2035 年	2040 年	2045 年	2050 年
16～19 岁/亿人	0.75	0.52	0.47	0.41	0.29	0.18	0.15	0.14	0.15	0.14	0.12	0.11	0.11
20～24 岁/亿人	1.19	1.14	0.86	0.81	0.95	0.72	0.50	0.47	0.48	0.50	0.48	0.42	0.38
25～29 岁/亿人	1.00	1.21	1.13	0.86	0.89	1.15	0.94	0.69	0.66	0.69	0.73	0.69	0.60
30～34 岁/亿人	0.81	0.99	1.18	1.10	0.86	0.90	1.16	0.95	0.70	0.67	0.70	0.73	0.69
35～39 岁/亿人	0.84	0.80	0.96	1.15	1.09	0.86	0.90	1.16	0.95	0.70	0.67	0.70	0.74
40～44 岁/亿人	0.59	0.82	0.77	0.92	1.13	1.08	0.86	0.89	1.15	0.94	0.70	0.66	0.69
45～49 岁/亿人	0.44	0.56	0.76	0.70	0.89	1.08	1.03	0.82	0.85	1.11	0.91	0.67	0.64

① https://population.un.org/wpp/Publications/Files/Key_Findings_WPP_2015.pdf，2021 年 4 月 14 日。

续表

年龄	1990 年	1995 年	2000 年	2005 年	2010 年	2015 年	2020 年	2025 年	2030 年	2035 年	2040 年	2045 年	2050 年
50～54 岁/亿人	0.36	0.38	0.48	0.64	0.62	0.76	0.93	0.89	0.71	0.73	0.95	0.78	0.58
55～59 岁/亿人	0.27	0.28	0.31	0.38	0.55	0.53	0.68	0.86	0.85	0.68	0.71	0.92	0.75
60～64 岁/亿人	0.15	0.17	0.20	0.21	0.28	0.39	0.39	0.51	0.66	0.63	0.50	0.53	0.69
65+岁/亿人	0.12	0.12	0.21	0.20	0.24	0.28	0.36	0.43	0.52	0.64	0.74	0.77	0.80
合计/亿人	6.51	6.98	7.32	7.39	7.77	7.93	7.90	7.81	7.67	7.43	7.18	6.97	6.66
劳动参与率	81.6%	80.5%	78.6%	72.7%	71.6%	70.6%	68.8%	66.8%	64.5%	61.9%	60.1%	59.1%	57.7%

资料来源：朱勤和魏涛远（2017）

注：由于数据进行了四舍五入修约，合计数值可能存在偏差

计算结果显示，考虑劳动参与率因素的中国劳动力总量将于 2017 年达到峰值 7.94 亿人，2050 年回落至 6.66 亿人，比峰值减少 16.1%。相比于劳动力总量相对平缓的变动，劳动力年龄结构变化显著。由表 7-1 数据可知，2050 年将有超过半数的劳动力年龄在 45 岁以上，而 21 世纪初尚有近一半的劳动力年龄在 35 岁以下。也就是说，2000～2050 年，中国劳动力年龄中位数将提高 10 岁多。伴随着人口年龄结构的老化，总的劳动参与率显著下降，从 2000 年的 78.6%降至 2050 年的 57.7%，降幅超过 20 个百分点。

7.1.2　互联网赋能与虚拟劳动力市场发展

以往对一个地区人力资源的研究大多聚焦于居住在该地区的劳动力人口，对未来人力资源的预测也较多以一个相对固定的地域范围为基础，近年来以常住人口作为分析依据已经是一个重要的进步。在中国，高铁的发展已经极大地延伸了 2 小时通勤圈的范围，而当前物联网和互联网等最新科学技术的发展更将进一步拓展劳动力（人力资源）使用的地理范围。并不一定必须是居住在固定地域才能成为该地区的人力资源。这种居住地和工作地的分离给我们预测未来的人力资源提供了新的视角，但也使得预测具有很大的弹性和想象的空间。

虚拟劳动力是指依托互联网技术的发展，作为人力资源的劳动力工作地和居住地之间产生分离形式的劳动力供给现象（如网络办公）。构建虚拟劳动力市场为异地知识型人才、技能型人才和部分体力劳动者参与异地劳动分工提供了一个网络接口，使人可实现异地就业，按劳取酬，在某种意义上可大大拓宽各地人力资源的蓄水池，缓解人力资源不足的问题。布局和发展虚拟劳动力市

场的意义重大，借助互联网带来的交易成本的降低来扩展跨区域分工细度和规模可实现各地区的优势互补，打通人才在区域间的流通渠道，实现将全国乃至世界范围内有创新精神的人才纳入虚拟劳动力市场。现阶段发展繁荣的虚拟劳动力市场，中国必须要具有提供相应工作的能力，保障网上工作的技术能力，组织虚拟劳动力就业的管理水平，以及保护虚拟劳动力利益和权利的制度保障。

1. 全球企业的总部经济效应

2013 年世界 500 强企业中，有 56 家企业总部设在纽约。纽约的大企业遍及制造业、金融业、制药业、航空业、电信业等各行各业。纽约成了世界工业、商业和通信业的中心。纽约通过汇集世界 500 强企业的总部产生巨大的总部经济效应，2013 年纽约地区生产总值和人均地区生产总值均居世界城市第一名。中国在今后老龄化的应对中，应当鼓励和支持各类企业的总部入驻中国，并扩大中国头部企业的海外投资，使其发展成为全球性的企业，通过企业总部影响国内及国际资源配置，尤其是将其他区域的劳动力资源纳入中国的人力资源网络。

2. 大力支持互联网产业的发展

中国应争取吸引更多的国际互联网企业入驻，并为中国互联网初创企业的发展和融资提供信息引导甚至资金支持。吸引和扶持互联网企业集聚是中国掌握下一轮产业革命主动权的有效手段，互联网公司不仅会为中国带来领先的互联网技术，更会为中国带来互联网精神，有助于全民创业文化观念的形成和发展。

3. 互联网基础设施的进一步完善

完成人力资源的跨区域配置需要被连接的两地企业能够实时安全稳定地通过互联网进行沟通。随着物联网的兴起，无线互联网的发展显得更为重要。中国应当继续提高移动互联网络发展的速度和覆盖范围，降低个人和企业负担的网络交流和远程管理的成本。

4. 管理方式创新

在通过互联网将其他区域劳动力纳入中国辐射范围的过程中，管理方式创新具有重要意义。以近年来兴起的“社区办公室”为例，纽约市为解决城市通勤拥挤问题，正在探索在居住区内建立社区办公室，使得借助互联网即可完成工作的人员可以在步行距离范围内到提供与母公司相同支持的社区办公室办公。社区办公室是一种介于商务区集中办公和在家办公之间的办公形式，相对于一般的在家办公，社区办公室为白领群体提供了更多的物质支持，也通过办公室监督提供了激励员工工作、监督工作效率的制度安排。

5. 强化制度保障

基于互联网工作的虚拟劳动力，在面对工作中发生的劳务纠纷问题时应得到法律保障。由于工作通过网络发出、完成及交付，劳动合同的签订和出现纠纷时的维权与传统工作方式不同，政府应适当立法保护劳动者和企业的权益。另外，虚拟劳动力在为企业工作期间的社会保障应得到基本保证，这需要政府或者金融机构提供更为灵活的保险产品和相应的制度安排。

7.1.3　新时代和新环境下对劳动力的再认识

劳动力的定义往往与老年人的定义互为表里。换句话说，劳动力何时退出劳动市场是由对老年人的定义决定的。以往的研究实践大多以 60 岁（或 65 岁）作为判定老年人的门槛，与之相对应，所谓的劳动力或劳动年龄人口即 60 岁或 65 岁以下的成人（15～59 岁或 15～64 岁）。

然而，目前的老年人口的标准是联合国在 20 世纪中叶时所推行的，当时无论是发达国家还是发展中国家，其人口的预期寿命远远低于现在的水平，人口的整体健康水平也与当今的状况存在巨大的差距。英国人口学家的研究认为 2011 年时英国 62 岁男人的健康状况相当于 1951 年的 50 岁，2011 年的 84 岁相当于 1951 年的 75 岁。2010 年《科学》杂志发表了奥地利国际应用系统分析研究所人口研究团队的论文，提出要重新定义和测定老年人口，国际学术界对此极为重视，国内的复旦大学和中国人民大学团队均已开展相关研究。概念和定义的变化将可能对劳动力供给和老龄化趋势等议题产生完全不同的判断，并对相关研究实践形成颠覆性和根本性的影响。

不仅如此，对于老年人力资本的重新认识和有效开发也会极大地改变我们的传统判断。以往的人力资本研究大多聚焦于劳动年龄人口，这些劳动力一旦退休，其人力资本在理论上就不复存在或不再利用了。这显然与事实不符，且将越来越无法满足老龄社会的治理需求，个体的人力资本不会随着退休而立即消失，只是我们现有的制度安排极大地限制了其发挥作用。如果我们能够基于制度变革和政策创新，在保障老年人分享社会经济发展成果的同时，也保障其参与社会经济发展的权利，这将结构性地改变我们对未来劳动力格局的判断与评估。

7.2　老龄社会就业形态的变迁与发展

以信息化为基础的人工智能、生命科学、物联网、云计算、大数据等一系列科技变革正与人口老龄化的发展进程相同步，是当前中国经济社会发展的大

背景。中国人口老龄化的深化带来劳动力结构和参与率的变化，技术进步则在促进经济社会发展的同时对就业市场结构调整与发展产生冲击，形成就业替代效应与就业创造效应，并为“老有所为”带来新的契机，有效提升“老有所为”的可实现程度，进而引发制度与政策层面的一系列调整与改革。

7.2.1　数字技术发展背景下的劳动技能迭代

科技革命的演进与发展是若干新技术组合更替迭代和共同作用的结果，当前在网络基础上以数据为关键生产要素的数字化转型，正逐步引发社会生产方式、组织结构形态、政策发展的变革与调整。

1. 持续变化的工作技能需求

技术的发展促进工作技能的持续变化调整。从同一职业工种的劳动技能需求看，截至 2017 年，根据经验约 60%的职业中，至少有 1/3 的组成活动可以自动化。从职业与活动两者之间的关系来看，每一种职业都包含多种活动，而每一种都有不同的自动化需求。基于目前已有的技术，只有很少的职业（少于 5%）有可能实现完全自动化；但几乎每一种职业中的一部分活动都有可能实现自动化。因此，技术的变革与升级，最初始是渗透到职业工种技能的调整与升级过程中的，短期内机器自动化替代的是任务而不是工作。技术正在改变工作对三类技能的需求：第一，对非重复性认知技能和社会行为技能的需求呈现上升的趋势；第二，对重复性任务所需要的具体工作技能的需求呈现下降的趋势；第三，对不同技能类型组合的回报在增加。这些变化不仅体现在新工作取代旧工作这一点上，而且还体现在既有工作技能组合的变化上（世界银行，2019）。

2. 信息技术发展对工作方式与条件的影响

随着互联网与信息技术革命的发展，非传统就业模式应运而生。现代服务业的发展使在家办公、网上服务、远程工作成为可能。智能穿戴、网络管理等正在创造出全新的职业和岗位。弹性工作制度、灵活就业模式等零工经济正在颠覆传统的雇佣关系，促使就业形式转变。部分就业、兼业、分阶段就业等成为劳动者的新就业模式，也为中老年劳动力的就业提供新机遇和新契机。整个产业发展对劳动力和人力资源的需求正在变化，“只求为我所用，不求为我拥有”也可能成为未来企事业人力资源部门的工作原则。其他如从目前年轻时代集中接受教育到全生命周期的终身学习型的教育模式的变革亦会改变人力资本的形成和利用模式。

3. 信息技术发展促进组织结构形态的调整与改变

受人工智能等信息通信技术发展的影响，通过增加人力助力规模扩大的传统组织与机构逐渐变得扁平化，形成信息网络化的管理模式。组织和机构的扩张模式不再局限于组织结构与人数的扩容，而是基于网络化推动企业生产与运营方式向数字化转型。

4. 对社会保障制度的变革与创新提出新的要求

传统的社会保障体系以正规的劳动就业合同为依据开展保障，信息技术的发展模糊了正式工作与非正式工作的界限，自雇佣、未签署书面劳动合同或未纳入社会保障体系的非正式领薪就业逐渐跻身进入主流就业领域。政策制定的滞后性导致这种形式的用工方式处于监管的灰色地带，极易出现保障真空。信息技术发展导致非正式就业人员的社会保障缺失问题，无形中缩小了社会保障范围并减少保障基金的积累，进一步降低非正式就业的抗风险能力。

7.2.2　技术赋能提升老年人力资本开发利用率

信息技术及自动化的发展、部分技术的发展可替代劳动者从事繁重的体力劳动，使人们更新对工作价值的认知，专注于更重要的工作，也为老年人力资源开发提供了一定的便利性和可行性。人力资本由知识、技能和健康组成，是在人的生命发育过程中积累而成的，人力资本使人们实现了人作为社会生产成员所具有的潜力（世界银行，2019）。

1. 老年人在业状况及就业趋势变化

从人力资源供需方面看，在人力资源市场供大于求的情况下，社会往往更注重开发青年劳动力而轻老年劳动力的开发。当人力资源市场出现求大于供的情况时，则需要对所有劳动力资源进行全面开发。当前中国正处于这一时期，按照之前的测算，2000～2050 年，中国劳动力年龄中位数将提高 10 岁多，2050 年将有超过半数的劳动力年龄在 45 岁以上，劳动力平均年龄亦呈现上升趋势。2015～2035 年是中国老龄化进展最快、波动最大的时期，也是未来社会抚养比相对较低、老年人口结构相对年轻的时期，尤其 2018～2022 年还将出现短暂的“底部老龄化”和“顶部老龄化”同时弱化现象，因此其是应对老龄社会的战略和战术储备的最好的机遇期（彭希哲，2018）。《老龄蓝皮书：中国城乡老年人生活状况调查报告（2018）》显示：9000 多万 60 岁及以上老年人仍在业，老年人力资源储量充足。1990 年至今，中国老年在业人口数呈上升趋势，2015 年的 60 岁以上老年在业人口比 1990 年增加了 3188.5 万人，其中，65 岁及以上老年在业人口增加了 1395.4 万人，增长率为 115%。老年在业人口中低

龄健康老人占比较高，60～64 岁老年人数占比 42.8%。

大力发展老年人力资源正逢其时，随着时间的推移老年群体将积攒较丰富的人力资源，并具有较强的经验和技能的比较优势，对老年劳动力资源的利用是老有所为、积极老龄化的充分体现，并能有效促进老年人的社会融合。

1）产业结构调整为老年人进入人力资源市场提供条件

中国已步入工业化发展相对成熟的时期，第三产业的比重已超过一半。随着第三产业的发展，对劳动力的体力要求逐渐减少，对劳动者智力和社会交往能力的要求在不断提高。

2）人口预期寿命延长为老年人力资源开发提供可能

据《中国统计年鉴 2018》数据：截至 2015 年中国人口的平均预期寿命为 76.34 岁，其中男性为 73.64 岁，女性为 79.43 岁。2018 年 6 月 WHO 发布的《2018 世界卫生统计报告》（*World Health Statistics 2018*）数据显示：据 2016 年数据，中国婴儿出生时的健康预期寿命（healthy life expectancy at birth）为 68.7 岁，预示着人们健康状况的改善和具备工作能力的生命时间延长。进入生命周期历程后期的老年人代表着生命之流最充分的流动，其工作经验与社会价值是年轻人无法比拟的，因此，劳动年龄的上限理应相应提高，使个体的社会价值和创造能力得到更充分的发挥，这既是其重要的权利和自身发展的重要条件，也是社会经济健康运行的客观要求。

2. 科技发展助力老年人力资本的开发与延续

2018 年 12 月 4 日宽带发展联盟发布的第 10 期《中国宽带普及状况报告》显示，截至 2018 年第三季度，全国固定宽带家庭普及率为 85.4%，其中，东部、中部、西部地区固定宽带普及率分别为 98.5%、75.6%、78.2%；全国移动宽带用户普及率为 93.1%，其中东部、中部、西部地区移动宽带普及率分别为 107.9%、77.0%、89.7%。同时，随着时间的推移，我国的网民数量亦呈现持续上升的态势，2018 年已达到 8.29 亿（图 7-1），未来仍将持续增长，宽带的普及度与网民的数量是显示信息化创新驱动潜力的指标。

技术赋能背景下老年群体作为社交网络的节点，可与更多人实现联结并强化关系，包括与同辈群体和不同代际群体之间的关系与联络，实现社会参与赋能。借助互联网形成的社交网络，老年人可更深入地参与社会生活和公共生活，同时可获取更多的信息和资源，作为其选择与行动的依据。信息技术与机器自动化的发展促进工作技能的调整、就业模式的多元化、组织结构的调整与变化，可促进老年劳动力资源的利用率提升。网络普及度的持续提升，也为科技革命重构的生产、生活方式奠定了基础。

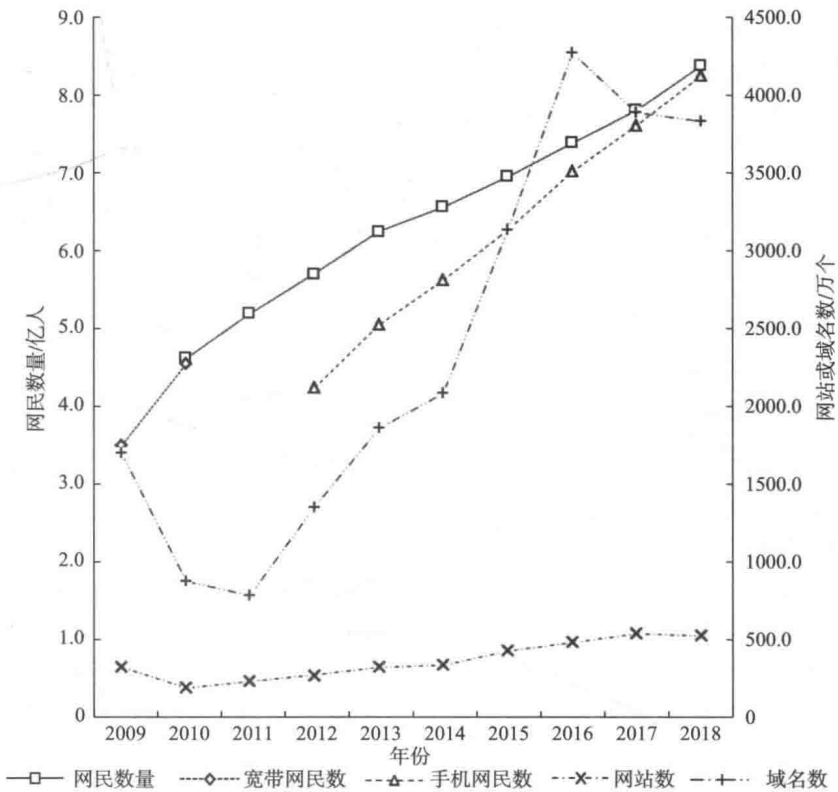

图 7-1　2009～2018 年中国网民数量等情况统计

资料来源：2009～2018 年《中国互联网发展状况统计报告》

互联网普及使人们逐渐突破就业年龄限制的观念，平台经济的发展使人们突破了工作时间和年龄的限制，成为就业变革的趋势和先驱。5G（5th-generation）网络的发展为异地就业与在家办公提供便利条件，可更好地契合老年群体的生理特征。老龄社会面临的挑战之一是老年人的身体功能较弱，这是通过科技创新可以在时间和空间上克服的问题：①科技进步促进老年人生活方式的转变。与以往相比，科技进步降低了基本生活对老年人生理功能的要求。例如，网购、在线支付解决了老年人搬运能力及计算货价能力减弱的问题；为老、助老设备（特别是智慧养老设施）的发展进一步提升老年人的自理水平。②科技进步促进老年人生产方式的转变。借助智能辅助设备可在一定程度上延长劳动者的职业年限，使其为社会创造更大的价值。③科技进步促进老年人知识结构升级和社会定位转变。科技创新的另一个目标是利用老年人的知识应对挑战，拓宽技术新时代的视野。因此，应为未来社会的老龄化与信息社会的融合设计配套的规划与政策。

虽然老龄化是一种客观与可量化的现象，但确切的老年开始是一种主观体

验，在不同的文化和历史中亦各不相同。因此，老龄化被认为是一种社会角色意识的重新建构，它代表着一个时间段内的包括生理和心理变化的转变。当个人处于初老阶段时，需要提供智能辅助技术，让其更充分地参与社会活动或贡献自身价值和力量，强调较强的社会参与感。目前中国大部分信息通信技术（information and communication technology，ICT）发展仅停留在为老服务层面，缺乏对老年人作为劳动力的思量。发展信息通信技术不应仅仅针对行动力不足的老年人，还应为有“发挥余热，为社会再做贡献”意愿的低龄或行动自由的老年人作充分考虑。通过信息通信技术潜在地提升生命的质量，如为老年人提供就业与劳动参与的渠道。

科技进步可从技术层面助益养老产业发展和完善，建议应专注于研发有效提升老年护理效率和专业程度的智能养老设备，赋权老龄化人口，使老年人更好地自立生活、更多地参与社会经济活动成为可能。依据不同世代老年人群的特征，配置不同侧重点的科技适用方式。对于 20 世纪五六十年代出生的准老年人，其接触互联网的时间较晚，对互联网使用的适应性较弱，应提升这一代老年人的数字化技能，提高互联网的普及率；对于 70 后、80 后等在计算机时代成长起来的未来老年人群，相比以往世代，其信息技术的利用能力更高，这部分人口进入老年期后，应该更加侧重于科技与老龄的双向互动与融合进步。促进更多的老年人在科技进步的基础上，实现经济独立和提升社会参与程度。政府应加强顶层设计，给予政策引导与扶持，实现智慧养老相关技术、产品、服务配套发展，促进智能管理服务水平进一步提升，全面提升中国老年人的生命质量和幸福指数。

7.2.3　劳动力结构变动倒逼退休政策改革

老年人力资源开发是当前中国老龄社会发展下的应有之策，其还与退休政策相关联。中国的社会保障制度和工作体系构建历来与退休年龄规定紧密挂钩，在长期的经济发展中，中国的劳动力退休年龄长期未调整。计划经济向市场经济转轨时期（1998～2000 年）还出现国有企业下岗潮，由于人员冗余、人浮于事，劳动供需失衡，相应形成提前退休政策，现在看来，诱因主要是劳动力供过于求，劳动力供需未得到合理调整而形成的应对性政策，这也从一个侧面反映出退休年龄政策实现弹性制度的可行性和必要性。随着改革深入、科技进步、经济结构和人口结构的变化与调整，劳动力供需的相应调整与流动亦会随之发生。当下应未雨绸缪，根据人口年龄结构变迁及经济社会发展实际情况，及时调整劳动力供给政策，加强老年人力资源开发，形成预防性政策应对未来劳动力供给风险。

退休是指劳动者因年老或其他原因退出劳动力队伍并领取基本养老金的

行为。根据 2011 年 3 月国际劳工组织发布的《退休年龄问题研究报告》，中国职工法定退休年龄的规定始于 1951 年，当时政务院颁布的《中华人民共和国劳动保险条例》规定：男职工的退休年龄为 60 岁，女职工为 50 岁。1955 年国务院颁布的《关于国家机关工作人员退休暂行办法》将女干部的退休年龄确定为 55 岁。现行的退休政策修订于 1978 年，《国务院关于安置老弱病残干部的暂行办法》和《国务院关于工人退休、退职的暂行办法》（国发〔1978〕104 号）规定：企业职工退休年龄男年满 60 周岁，女年满 50 周岁，女干部年满 55 周岁。因此，我国目前退休年龄的一般性规定为男性 60 周岁，女性干部 55 周岁，女性工人 50 周岁。

1949 年之前，中国的人均预期寿命为 35 岁，婴儿死亡率高达 200‰（胡鞍钢和王洪川，2016）。我国的退休政策制定于新中国成立初期的 1951 年，因此退休年龄是在当时的人口年龄结构的背景下确定的，具备合理性和科学性。随着中国社会经济的持续发展与居民生活水平的不断提升，医疗保障水平的持续提升促使居民人均预期寿命不断延长，同时劳动力受教育年限持续增加，我国人口年龄结构也相应变迁。从 1949 年的人均预期寿命 35 岁到 2019 年 77.3 岁，我国的人均预期寿命持续提升（表 7-2），2018 年人均健康预期寿命为 68.7 岁。虽然中国的劳动力年龄中位数正在上升，但人均健康预期寿命的提升亦可有效地弥补劳动年龄层面的上移引发的劳动力供给问题，老年人力资源的开发具备客观条件和现实基础。

表 7-2　中国人均预期寿命变化（单位：岁）

年份	均值	男	女
1981	67.77	66.28	69.27
1990	68.55	66.84	70.47
2000	71.40	69.63	73.33
2010	74.83	72.38	77.37
2019	77.30	—	—

资料来源：国家统计局 2010 年第六次全国人口普查汇总资料、《2019 年我国卫生健康事业发展统计公报》等

随着人口预期寿命的提高，缴费年龄相对减小而领取养老金时间相对延长，对社会保障体系的均衡提出了挑战。延长退休年龄，并实行弹性的、具有灵活性的退休和社会保障政策是应对挑战的策略之一。尽管经济社会发展背景已发生系列变化，但长时期践行并无调整的退休年龄政策使人们形成思维惯性和定式，同时对退休年龄政策的调整牵涉较多影响因素，由于各方利益博弈，延迟退休年龄政策的调整与改革相对缓慢，难以平衡。2013 年国务院发布《中共中

央关于全面深化改革若干重大问题的决定》，指出：研究制定渐进式延迟退休年龄政策。至此，我国退休年龄政策方向大致确定。在新的宏观经济与人口年龄结构背景下，延迟退休年龄的研究重点已不应仅仅聚焦于是非判断问题，而应更加关注日后政策制定及评估的有效性问题（王克祥和于凌云，2016）。

社会对老龄化消极的观念和态度，会使老年无用论成为社会的主流观念，对老年人能力的低估导致老年群体丧失对自身的控制感和掌握感，并导致他们的选择和权利会因年龄增长而被剥夺。当下主流观念中常把“老”等同于“衰弱”，随着时代的变迁，实际上老年人由于年龄的增长发生的机体退行性变化而产生的再就业的身体条件限制已逐渐通过技术的发展得到了一定程度的弥补或消除。信息通信技术产业的发展能够有效提高社会生产力，同时可提高劳动力效率，这在一定意义上可减缓老年群体工作生活的“被剥夺感”。

社会政策制度层面的调整滞后于社会经济环境与人口结构的变化，政府应主动采取一些辅助措施，如鼓励终身学习、改善工作条件与环境和减少就业性别与年龄歧视，作为未来公共政策的着力点。目前在推迟退休政策大思路已出台的背景下，政府可以首先尝试把“退休年龄”的提法逐步转变为“领取全额养老金的最低年龄”，以将“退休”的概念与“衰老”的意象脱钩，并与相关政策互动，为重新定义老年及老龄化做好铺垫，对老年内涵进行重构（胡湛和彭希哲，2018）。在理念转变的基础上，逐步提升科技介入程度，全方位支持老年群体的劳动再参与。延迟退休年龄与社会保障制度可持续运行、国家财政负担密切相关，但仍需充分考虑群体存在的异质性赋予其在退休方面充分的自主选择权。并可大力开拓老年就业领域，规划成立老年就业指导中心以支持老年人再就业或提升老年就业率。

7.3 老年消费新态势及家庭消费结构变化

老年人力资源充分发挥的同时，老年人口占比不断提升亦预示老年消费的持续升级，老年消费是老龄化研究的热点问题之一。对于这一问题，国内已有研究认为我国老年人口经济状况总体欠佳、消费需求较低、消费行为较节俭、消费心理较为成熟与理性（王涤，1999；何纪周，2004），因而总体认为我国老年人口相比其他年龄人口的消费水平较低，甚至被极端地归为“零”消费人群（张岭泉等，2008）。这些认知大多来源于对老年消费心理和老年消费习惯的定性研究对我国老年消费的认识更多地建立于对老年人群特质的理解之上，而非直接针对老年消费本身。我们国家正在经历前所未有的经济发展与社会进步，现在的老年人已不再是过去的老年人，无论是自身经济能力还是养老生活

方式都与过去有所不同（杜鹏和武超，2006）。这些不同意味着我国老年人口本身及其消费特征是动态变化的，如果我们囿于以往对我国老年人群特质的传统认识，则可能对我国老年消费产生严重的认知滞后，也会干扰我们正确判断人口老龄化对经济增长的影响。有鉴于此，本章尝试借助 CHARLS 对我国 60 岁及以上老年人口的消费与收入进行合理测算，从而获得我国老年消费的一系列新特征，在此基础上重新理解老年消费及其对经济发展的影响。

7.3.1　当前老年人群体的消费特征

1. 年龄越高、消费越多

我国老年消费随年事增长递增，超高龄老人的人均消费水平为老年人口中最高。据 CHARLS 数据，2011 年我国老年人均消费约 1.18 万元，其中 60～74 岁组人均消费 1.16 万元、75～89 岁组 1.18 万元、90 岁及以上组 2.15 万元。低龄、中龄与高龄初期的老年人口消费水平差异不大，处于在波动中稳步增长的态势，而从 90 岁开始，特别在 95 岁以上的超高龄阶段，老年人均消费急剧增长。90 岁及以上年龄段的人均消费数量几近 60～89 岁年龄段的 2 倍。当社会中处在高龄阶段的老年人口数量增加，老年人均消费会因此提高，老年人口的高龄化会使老年人均消费随之增长。2011 年我国老年人口年龄别人均消费与收入见图 7-2。

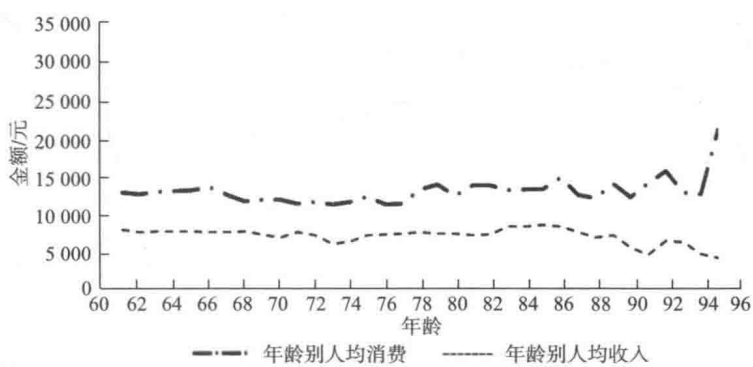

图 7-2　我国老年人口年龄别人均消费与收入（2011 年）

“越高龄、消费越高”的现象是我国的特例还是一种共性特征？Lee 和 Mason（2011）的研究发现，不同发展阶段的国家，生命周期消费与收入之间的数量关系有所不同。贫穷国家（我国被归为此类国家）老年人口与劳动力人口之间的人均消费基本持平，接近生命周期终点时的人均消费有所下滑，老年人均消费略微超出生命周期的平均水平。富裕国家老年消费模式与贫穷国家不同，富裕国家老年人均消费远远超越劳动力人口，也超越生命周期的平均水平，

并且在高龄阶段表现出越发强劲的消费势头。可见，“越高龄、消费越高”这一现象在发达富裕国家、老龄化程度深的国家中具有共性。现阶段我国老年消费的整体模式仍未脱离贫穷国家之列，但高龄老人的消费特征意味着我国老年消费模式已开始向发达富裕国家转型。这一转型预示未来我国老年消费随年龄增长而增长的特征将越发明显，高龄阶段将毋庸置疑成为消费水平最高的人生阶段。

2. 需求水平呈增长态势

我国老年消费的需求水平呈现跨期增长态势。依据 2008 年和 2012 年 CHARLS 浙江、甘肃两省跟踪调查数据，两省老年消费从 2008 年的人均 1.16 万元增至 2012 年的 1.52 万元，四年间增幅约为 31%。这四年间物价水平总体增幅约为 17.5 个百分点[①]，在去除物价因素之后两省老年人口的人均消费仍然具有显著增幅。这表明老年消费需求本身具有增长性。

年龄组的增幅显示，90 岁及以上组和 60～64 岁组的人均消费增幅位居前二。短期内，低龄老人和高龄老人的人均消费上升幅度超过中龄老人。在老年阶段初期，临近退休的劳动力人口逐渐替代原本的低龄老人，新老低龄老人的替换过程也是新老消费方式的替换过程。新的低龄老人相比原本的低龄老人更容易（或已经）接受新的消费，如电子产品、网络购物、老年旅游、有偿老年服务等。老年消费品供给的增加也更容易拉动新的低龄老人进行消费，当然新的低龄老人更好的经济条件无疑为其更高的消费需求提供了经济保障，而在老年阶段尾部人均消费的显著增幅主要由“高龄老人更高龄”的寿命延长态势所致。超高龄老年人口消费水平在短期的增长主要源于刚性需求的提高，特别在于照料、护理、医疗等因生理退化而增加的刚性消费需求，当然也包括因生命周期最后几年失去同住老伴而增加的分担缺失型消费需求。无论是低龄阶段供给拉动型和收入拉动型消费需求的增加，还是高龄和超高龄阶段刚性消费需求和分担缺失型消费需求的增加，都表明了我国老年消费需求的内在增长趋势。

3. 释放财富的非保守型消费

老年阶段各年龄组的人均消费普遍高于人均收入，各年龄阶段均处于不同程度的现期收不抵支状态。2011 年我国老年人均收支赤字约为 0.52 万元，其中 90 岁以上超高龄老人的收支赤字为最高，接近 2 万元，这一赤字几近同组人均收入的 4 倍。超高龄老人巨大的收支赤字由超高龄阶段消费数量的急剧上升和收入水平的下滑所致，前者起了主要作用。生命周期假说有助于理解老年消费超越老年收入的现象。其基本观点是：生命周期中每一时间段的消费是由

① 根据《国家统计年鉴》中总体物价水平（以上一年度为 100 进行标准化）的数据进行换算，得出 2012 年的物价水平相当于 2008 年物价水平的 117.5%。

其整个生命周期总收入水平决定的（Modigliani，1986），个人往往会在年轻时储蓄得多一点，以便当他年老时可以有平稳的消费路径（Ando and Modigliani，1963）。从生命周期假说的逻辑出发进行思考，老年消费本质上并不保守，老年阶段是生命周期中释放往期储蓄进行消费的人生阶段，利用财富储备来平衡老年阶段的收支。相反，年轻人会因财富储备压力与子女抚养压力而属于相对保守型消费群体。这似乎超出了传统的认知，我们总认为老年人口因退出劳动力市场而收入减少、生理衰退而需求下降等因素消费欲望不高、消费行为保守。然而无论是生命周期理论所揭示的理论原理，还是从 CHARLS 数据中得到的老年消费现实，都在说明：我国老年消费并不受老年收入的制约，过去的财富储备是老年消费的重要经济支撑。

我们不能仅仅关注老年收支赤字的表面含义，认为老年人口现期收支缺口势必会制约老年人口的消费。实际上，老年消费的经济来源要比年轻时期渠道更多也更灵活，再加上财富积累与养育子女的“任务”已基本完成，老年消费的后顾之忧小于年轻人。现阶段老年消费所面临收支状况，并不代表老年消费本身的保守主义，而更多的是供给市场的种种落后与制约所造成的。类似“以房养老”等利用老年人口固定资产收益对老年生活进行改善的做法，尽管在我国目前还没有盛行，但在未来随着老年金融产品的创新与丰富、老年人口金融参与度的加深、养老观念的更新，利用固定资产收益改善老年生活的做法会在未来的中国逐步流行，届时老年人口运用自身财富储备填补老年收支赤字的途径将会更多元化。考虑到农村老年人可利用的固定资产较为单薄，固定资产往往无法成为填补老年收支赤字的经济来源，因此加快完善农村老年人口养老金制度、进一步提高农村老年人口养老金水平是改善农村老年收支状况的最有效方法。

7.3.2　老年消费新特征的经济寓意

1. 老龄社会 VS 年轻社会：消费水平只增不减

现阶段我国老年消费水平已超越生命周期的平均值，2011 年我国老年人均消费约 1.18 万元（CHARLS 数据测算结果），城乡居民加权平均的人均消费约 1.03 万元[①]。由此推论，当人口结构中老年人口的比重增加，居民人均消费并不会降低，反而会增加，老龄社会的消费水平会超越年轻社会。

我们有必要转变对老年消费的陈旧认识，如认为老年人口消费需求和消费欲望相比年轻人较低，老年人口消费习惯上相比年轻人较为节俭和保守，老年

① 我国居民人均消费水平利用城镇居民家庭人均现金消费和农村居民家庭平均每人消费加权而得。数据来自国家统计局：https://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01，2021 年 3 月 20 日。

人口因逐渐退出经济活动而财力状况相比年轻人较薄弱，因而即便有消费需求也无法兑现，等等。种种现实已表明，传统观点只能形容我国过去的老年人口的消费状况，已无法正确描述现阶段及未来我国老年消费的态势与走势。现在和未来的我国老年人口，其消费水平已不亚于年轻人口，老年消费水平在未来将继续增长并更大幅度地超越年轻人口的消费水平。只不过，老年人的消费内容、方向、结构会与年轻人有所不同，老龄社会的消费结构与年轻社会相比也会有所不同，但老龄社会与年轻社会在消费结构上的差异并不代表前者在消费水平上会有所落后。认识到这一点有助于我们树立正确的老龄社会观，有助于我们科学认识老龄化对经济发展的影响。

2. 人口老龄化与经济增长：从消费的角度

有关人口老龄化对经济增长的影响在学术界已有较多讨论，尽管观点各有偏重也不完全统一，但倾向于将老龄化视为经济发展的负能量（莫龙，2011；王金营和付秀彬，2006），甚至认为是经济高增长的终结因素（董志强，2013）。然而从消费的视角看待人口老龄化对经济的影响，利好多于利空。基于对我国老年消费新特征的理解，老年消费本身并不拖累消费水平的增长，甚至是促进消费水平增长的有力武器。步入老年并不意味着人均消费进入下坡道，随着经济发展水平的提高、老龄化与高龄化程度的加深，步入老年意味着人均消费进入健步增长的阶段，消费水平将会随年事增长不断提高，老年消费超越生命周期其他阶段的幅度将会不断扩大。我们有理由以积极的态度看待老龄化对消费、对经济的影响，老年消费甚至可成为未来我国经济增长的新引擎。

7.3.3　推动老年消费成为经济增长新引擎

老年消费促进产业发展并倒逼劳动力市场结构的调整，同时有别于年轻社会的消费结构及特征，需要对部分弱势老年群体进行兜底保障，确保老年消费经济的协调发展。

1. 劳动力市场如何应对老龄社会的高消费需求

上文提到老龄社会的消费水平并不亚于年轻社会，因而从数量角度出发，老年消费对整个居民消费增长是有促进效应的。但必须注意，我们所指的消费水平是指实际产生的消费，如果这种消费只停留在消费需求，并没有真正变成实际消费的话，这样的消费就是虚空的，这一部分未能被满足的消费需求对消费增长的促进效应也是不存在的。为了真正落实老年消费在数量上对消费增长的促进作用，充分满足老年人口的高消费需求至关重要。人口结构老化将会使劳动力市场出现数量短缺，以及劳动力人口本身的结构老化，这在很大程度上

将会使消费供应端承受劳动力不足的压力，最终反映到消费需求端，就会导致需求无法满足的结果。通过提高劳动力质量来弥补劳动力数量上的欠缺，是维持老龄化社会劳动力市场活力的有效方法，也是老龄社会劳动力市场可持续发展的必由之路。只有将老年人口的高消费需求落到实处，才能在真正意义上发挥老年消费对消费增长乃至经济增长的引擎作用。

2. 老龄社会消费结构与年轻社会的不同应引起重视并予以应对

保持老年消费在结构上的供需平衡有助于老龄社会消费市场的健康发展。现阶段老年消费结构状况及其未来的变化趋势都应引起重视，现阶段我国老年消费结构已显示出一些超越传统认知的态势（从 CHARLS 数据中获得），如中高龄老年人相比低龄老年人享受型消费（文化娱乐消费、旅游消费和美容消费）的比重更大，2011 年我国老年人均享受型消费比重为 2.8%，而 90 岁以上高龄老年人的享受型消费比重高达 7.6%；又如，我国老年人口交通和通信消费的比重非常可观，2011 年我国老年人均消费中有 18%的消费开支用于交通和通信，各年龄段人均交通和通信开支比重均高于 14%。未来我国老年消费中享受型消费（乃至奢侈型消费）、文化型消费、养生型消费、照料型消费、跨越年龄界限消费、超前消费的比重将会进一步提高。经济条件的改善、养老负担的减轻、文化素质的提高、涉老消费品与服务产品的供给拉动等多方面因素将共同促成未来我国老年消费结构的重大变革。

老年消费的结构性变革要求消费市场做出相应的调整，消费市场的供需关系须与老龄社会的消费结构相适应。尽管从消费水平来看，老年消费并不会成为我国消费增长和经济增长的阻碍因素，但消费市场供需关系是否能够与老年消费的结构性变化相同步，决定了老年消费是否能够成为经济增长的新引擎。人口老龄化和高龄化对居民消费结构的影响将会是持续的、颠覆的，我们应就老龄化与高龄化对老年消费结构的潜在影响做好长期的应对准备，主动形成社会、政府、家庭等主体间的协同合作，逐步消除产业结构与消费结构之间的不匹配。老龄社会的消费结构与年轻社会大有不同，重视老龄社会消费结构的变革是发挥老年消费对消费增长促进效应的关键。

3. 老年消费弱势群体的困境需要政府、社会与家庭的共同支持

老年消费的弱势群体有多种类型，如高龄老人、低收入老人、独居老人、农村老人、老年女性等。老年消费的弱势群体往往因经济能力低下、家人陪伴的缺失、身体状况极度退化等因素，其消费需求往往无法得到充分满足，我们也把这一情形称为陷入消费困境。在这些老年消费的弱势群体中，高龄阶段的消费困境几乎发生在所有弱势群体身上，高龄老人是最需要政府、社会和家庭

帮助的老年群体。老年消费的弱势群体受制约的消费需求集中于医疗、护理、照料、家政等。就这些消费需求而言，以需求为导向的帮扶方式相比以收入为导向的方式更为直接有效，如提供由政府购买的照料、家政服务，以及来自社会组织和志愿者的医疗、护理服务等。

帮助老年弱势群体走出消费困境，政府与社会的帮扶至关重要，而家庭的支持也不可或缺，重塑家庭的养老支持功能十分必要。家庭是老年消费需求的重要供给者，家庭的支持具有及时性和周全性，大部分弱势老年人口的生活所需都能依托家庭得到改善，如由家庭成员提供的生活照护、经济资助、精神慰藉等。家庭的养老支持对于农村高龄老人更为重要，城市地区高龄老人的日常所需尚可在一定程度上由同一社区的“老伙伴”互助、社工服务、志愿者服务等形式提供，而农村地区这些扶持形式几乎为零。然而农村年轻劳动力迁往城市的同时，也带走了其作为低龄农村老人的父母，无论是为子女照料家务还是抚养孙辈都有用武之地。在这一“护小”行为的背后遭冷落的是农村高龄老人，低龄老人归向子女家庭，无暇顾及留守老家的高龄父母。回归家庭成为迫切之需，回归哪个家庭也成为新的命题。在“护小”行为盛行的当下，我们是否应打破这种观念，提倡低龄老人回归高龄父母家庭，减少老龄社会中陷入消费困境乃至生活困境的高龄老人，这值得全社会深思。处理好老龄社会弱势群体的消费问题有助于提升老龄社会的消费活力，是对积极老龄化的实践，也为老年消费这一新引擎增添动力。

7.4　老龄化背景下产业结构形态变迁及发展

老年消费的增加必然引发老年相关产业的联动发展，产业结构的变动和所处的经济社会环境的变化息息相关，库兹涅茨指出，生产技术与社会需求是产业结构变化的重要驱动力，首先，科学技术产生及应用提升了劳动生产率，降低了单位劳动力要素投入量，同时，技术进步引发的产业发展阶段的变化将对产业结构产生重大影响。着眼于中国，产业形态受资源禀赋与政策的影响，一方面，人力资源、自然资源作为经济发展的重要资源，丰富的资源有助于地区经济的发展，若当地科技水平较低，则该地区更易形成与当地优势资源相称的劳动密集型或资源供给型产业；另一方面，政府政策对产业结构的变化具有重要影响，特别是对于中国来说，包括产业发展规划在内的政府政策对产业结构变化的作用不容忽视。

在老龄化趋势越发明确的未来中国，产业结构的变动同样受到这些方面的重要影响，人工智能、物联网、5G 科学技术的高速发展与老龄化趋势所带来

的结构性变化将成为影响未来社会产业结构变动的重要因素。

7.4.1　技术进步对产业结构形态的影响

第一次工业革命以来，技术进步对产业结构的重构效应是显而易见的，特别是对于类似蒸汽机、电力、互联网等颠覆性技术的发明与应用来说，这一重构效应的表现尤为突出。一方面，作为新兴行业本身，动力机器、能源、互联网生产行业的诞生丰富了行业领域，蒸汽机、内燃机生产，电力系统生产与发电，互联网相关设备制造等行业从无到有的过程，是新兴基础行业不断扩展行业范围的过程，不论是从产业占比还是从就业占比来看，这类行业都是同阶段经济发展的关键产业；另一方面，作为产业发展的基础性技术，动力机器、能源、互联网的应用推动了传统产业内部结构的重构，以及劳动的分工与产业的进一步分化，从行业的发展阶段看，一大批新兴行业产生的同时，传统行业被逐渐淘汰，大量如汽车、娱乐、网店等以此为基础而形成的行业取代了传统行业，成为不同时期产业结构的重要组成部分。

近年来在人工智能、物联网等技术领域的进步，也将对老龄社会的产业结构形态产生重要影响，作为当前世界相关技术创新应用的重要参与者，未来中国老龄社会的产业结构形态将受到来自技术进步的广泛影响。

具体来说，首先，技术的进步将导致传统产业中不同行业的劳动力需求变化，以就业比重衡量的产业结构形态将与当前社会的产业结构形态存在显著差异。基于当前人工智能技术发展水平预测职业的潜在替代风险的研究表明（图 7-3），从三次产业看，未来人工智能技术应用对第一产业、第二产业相关职业冲击最大，

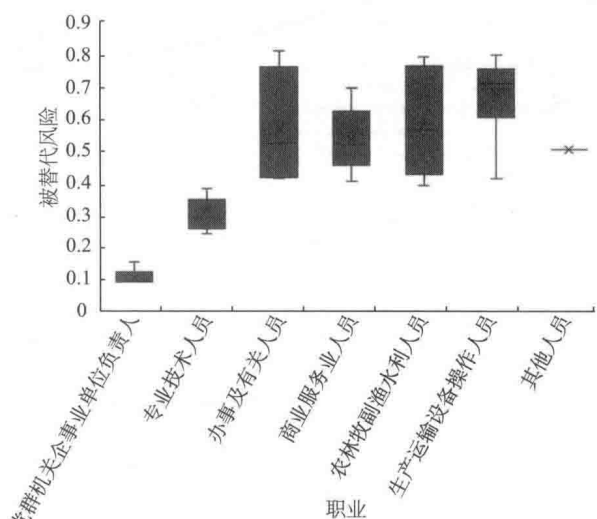

图 7-3　中国职业（职业大类）的被替代风险分布图

大量潜在被替代风险高于 70%的当前职业分布在第一产业、第二产业，相比较而言，第三产业的总体职业潜在被替代风险仍较低。因此，在未来老龄社会中，第一产业、第二产业的劳动力需求将进一步降低，更多劳动力将进入第三产业的相关行业中，以就业结构衡量的产业结构重心将延续向第三产业转移的趋势。

从职业特点看，管理、培训教育、专业技术、宗教职业等社交性、专业性要求较高的职业的潜在替代风险较低，而生产制造、物流运输等重复性、程序性任务较多的职业的潜在替代风险较高，如第三产业中的邮政和电信业务人员、仓储人员，第二产业中的烟草及其制品加工人员，金属冶炼、轧制人员，第一产业中的畜牧业生产人员，其他农、林、牧、渔、水利业生产人员等职业（职业中类层面）的潜在被替代风险超过了 70%，同时，企业负责人、科学研究人员、法律专业人员等职业中类的潜在被替代风险则不到 30%（图 7-4）。因此，从行业的劳动力需求角度来说，更高的潜在被替代风险往往意味着相关行业更低的劳动力需求，更多的岗位将可能被技术替代，在以就业占比衡量的产业结构中，未来老龄社会的此类行业就业比重也将显著降低，这将引发产业结构形态的进一步调整。

其次，技术的进步将导致产业中资本密集型行业的增加，以人均资本衡量的产业资本结构形态将与当前社会的产业资本结构形态存在显著差异。长期以来，劳动生产率稳步提升的重要前提是技术进步带来的生产设备的更新换代，在更高效生产机器的支持下，基于生产分工的劳动力在单位时间内能够生产出更多的产品，马克思在阐述资本积累过程时指出，资本有机构成逐步提高是生产过程的普遍规律，一方面，资本技术构成不断提高，表现为生产资料数量相对于生产劳动力数量比例的增加；另一方面，资本价值构成不断提高，表现为生产资料价值即不变价值相对于生产劳动力价值即可变资本比例的增加。随着人工智能等技术与产业和生活的深度结合，以智能机器或机器人形式存在的货币资本将替代大量的人力，使各个行业的资本比例显著提升，完全机器人生产的无人化工厂可能成为老龄社会工业产品生产的重要形式。

7.4.2　产品需求对产业结构形态的影响

大量研究围绕人口的年龄结构对产业结构的影响展开探讨，肯定了年龄结构变动对产业结构调整的影响，但在具体影响方向上存在差异，Orzechowska-Fischer（2004）在分析日本老龄化过程与产业结构调整过程时指出，老龄化增加了第一产业的就业比重，降低了第二产业、第三产业的就业比重，而 Siliverstovs 等（2011）则认为，人口老龄化对第三产业的发展具有促进作用，同时限制了第一产业的发展。在国内学者的研究中，杨晓奇（2013）

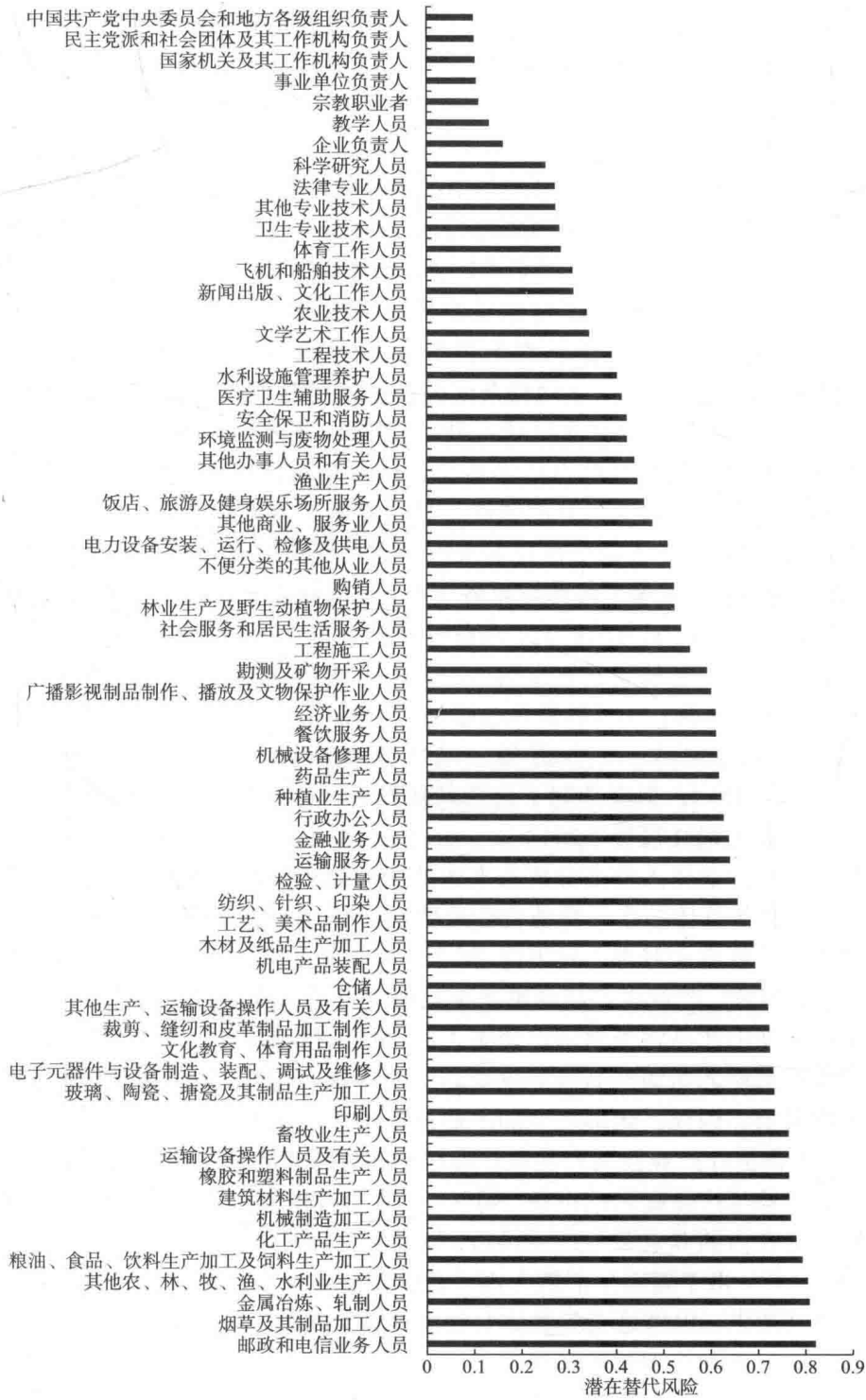

图 7-4　分职业（职业中类层面）的职业潜在替代风险

认为人口老龄化是促使我国产业重心从劳动密集型向资本和技术密集型产业转移的重要因素，而张斌和李军（2013）则从人口老龄化的需求效应与供给效应的对比出发，认为当需求效应更大时，老龄化将提高第三产业的比重，限制第二产业的发展。

从另一角度看，年龄结构对产业结构形态的影响，可能是通过需求结构影响消费结构，进而影响产业结构的路径进行传导的。在市场经济中，产品生产的最终目的在于消费，因此，消费者的需求是影响产品生产的重要因素，具体来说，不同消费者的消费特征存在显著差异，这种差异性也将对产品生产，进而对产业的结构形态产生影响，在某种产品上的旺盛需求将刺激更多的产品生产，集聚更多的生产厂商，从而提升这类行业的产值与就业比重。对老龄化社会来说，由于老年人口的比重持续上升，一方面，作为一个纯消费者，老年人口比重的上升将降低社会的总体储蓄率，从而相对抑制了整体的产业投资水平，影响了资本有机构成提升的速度；另一方面，将可能提高社会消费总量，相较于传统社会，老年人的个性化需求将日益受到消费品市场上产品供给者的重视，相应地，这一需求也将传导至各个产业，从而影响老龄社会的产业形态。

具体来看，相比于当前社会，老龄社会的消费特征有其特殊性，为满足老年人需求而产生的老龄产业将逐渐进入高速发展期，这将对产业结构形态产生影响。一般研究认为，人口老龄化会增加与老年人需求相关的产品需求，促进医疗保健、老年家政、老年旅游、老年教育等行业的发展（Nikitina and Vorontsova，2015），但也抑制了包括其他教育、生活日常用品服务和新能源等行业的发展（倪红福等，2014）。

基于当前的老年人特征分析未来老龄社会的产业发展方向可以推断，一方面，从满足老年群体的生活性消费需求看，首先，相对于年轻人，老年人对新鲜事物的接受程度和好奇心将下降，对于产品的质量要求可能高于对产品新颖性的要求，因此，产业中产品的更新换代速度可能下降，同时，更多老年人成长历程中出现的产品将能够满足老年人的回忆的精神需求，因此，具有精神属性的传统产品而非新颖产品可能更受老年人青睐。其次，由于老年群体客观存在的医疗需求，因此，老龄社会的产业形态将更加注重满足老年的医疗需求，相应地，生物医疗产业及其产品在产业中的重要程度也将上升，更多的医疗服务及产品将被生产并提供给市场，同时，老年群体的养老需求将催生更多的包括机构养老在内的养老服务产品供给，以及包括养老器具、食品在内的老年产品供给。最后，出于健康生活的考虑，老龄社会将对健康食品在内的产业的环保提出更高要求，以满足老年群体对健康饮食、健康环境的需求，因此，老龄社会的产业将更加注重绿色环保相关产业的发展，崇尚健康生活、环境友好型、资源节约型产业将成为这一社会发展的主导思想。

另一方面，从满足老年群体的生产性消费需求看，自 1990 年以来，中国老年在业人口的数量快速增加，2015 年，全国 60 岁以上老年在业人口为 9235.3 万，25 年间增长了 115%，老年在业人口以低龄、健康老人为主，60～64 岁占了 42.8%。而在老龄社会中，由于劳动年龄人口规模的下降，健康余寿与预期寿命延长，更多在传统社会中本已退休的 60～70 岁老年人将会进入就业市场，发挥其人力资源在经验等晶体智力方面的优势，因此，帮助这部分老年劳动力弥补体力、身体方面劣势的技术产品的需求量将显著提升，传统社会中的这类产品的技术水平无法达到市场化销售的成本与能力需求，随着人工智能技术等软件与处理器等硬件性能的持续进步，满足需求的低成本、高技术产品的应用将在可预期的未来成为可能，这将强化未来产业形态在技术知识领域的要求，老龄社会的产业将更加重视高技术产品的生产，同时通过提高生产、管理效率，降低产品生产成本。

7.4.3　未来老龄产业的发展趋势分析

围绕满足未来老龄社会中老年群体的消费需求，学界与业界展开了对老龄产业的探讨，但就目前来看，对于何为老龄产业，以及老龄产业的内涵与外延等问题，仍然存在一定争议，根据《中国老龄产业发展报告（2014）》对老龄产业的界定，老龄产业是面向全体公民老年期生产提供产品和服务的各相关产业部门组成的业态总称，它涵盖了老龄金融业、老龄用品业、老龄服务业和老龄房地产业四个部分（表 7-3），其范围横跨了三大产业，服务对象具有动态性，既包括当前的老年人，也包括即将进入老年阶段的中年群体。

表 7-3　老龄产业的基本框架

老龄产业板块	细分市场
老龄金融	证券类老龄金融产品，组合型老龄金融产品，房地产类老龄金融产品，信托类老龄金融产品
老龄用品	老年日用品，老年医疗器械，老年护理用品，老年服饰用品，老年医药用品，老年文化用品，老年辅助生活器具，老年康复器材，老年丧葬用品，老年助行器材，老年电子器材，老年保健用品
老龄服务	日常生活服务，旅游交往服务，临终关怀服务，经济理财服务，精神生活服务，长期照护服务，健康服务，法律服务，医疗服务，康复护理服务
老龄房地产	社区老龄服务设施，二手房市场，综合型养老社区，老年病医院、护理院，农村老龄房地产市场

资料来源：《中国老龄产业发展报告（2014）》

根据这一老龄产业的分类，老龄产业将涉及未来老龄社会的方方面面，其

中，老龄用品主要涉及第二产业，老龄服务、老龄金融和老龄房地产涉及第一产业、第三产业，绝大多数的细分行业又与其他行业息息相关，产业关联度较高，因此具有典型的综合性特征；同时，考虑到老龄社会中未来服务对象的主体性特点，老龄经济的发展将关乎未来经济发展的前景，通过金融业、制造业与服务业，将整个经济社会串联起来，具有牵一发而动全身的基础性作用，因此，存在明显的支柱性特征。

根据《中国老龄产业发展报告（2014）》的预测，至2050年，我国将成为全球老龄产业市场潜力最大的国家，老年人口的消费潜力将从4万亿元左右提升至106万亿元左右，呈几何级数增长，占GDP的比例也将从8%左右增长到33%左右（吴玉韶等，2014）。已有研究通过系统动力学仿真模拟发现，2012～2020年全国老龄产业市场规模可能从2012年标准基期的1万亿元上升至3.1万亿元，年均增速在15%以上（陈俊华等，2015）。在GDP增速放缓的经济新常态下，老龄产业对于带动消费、拉动内需、调整消费结构有重要意义，是具有极大市场价值和发展潜力的朝阳产业。

虽然在政策支持方面，中国政府相继印发了包括《关于推进养老服务发展的意见》《"十三五"国家老龄事业发展和养老体系建设规划》等多项政策文件，改革涉老管理机构，各地方亦出台相应政策，从政策和制度上对老龄社会的涉老事业进行政策布局与支持，但是，由于老龄产业仍处于产业发展的早期，产业的内涵、特征等问题尚待进一步研究，因此，在满足老龄产业的发展要求，推动产业升级方面仍有较大的政策研究和应用空间。

值得注意的是，随着物联网、大数据、高速铁路、人工智能、机器人等技术的发展，以及网络经济与共享经济等经济形态的创新，传统经济活动、经济组织及就业模式将经历巨大冲击，因此，老龄社会的产业结构、就业模式等发展存在较大不确定性，现有的统计方法及统计口径可能无法准确反映当前社会的真实形态。

在此背景下，公共政策应统筹政府、市场和社会的力量，创造有利的制度和政策环境，积极推动老年产业的快速发展，在此过程中为数量巨大的中老年劳动力提供适合老年人体力和脑力特征、匹配老年群体人力和社会资本的就业岗位，并尽量避免卷入同年轻劳动力的竞争。鼓励老年人口推迟退休，或在退休以后能够继续通过灵活就业和志愿者服务等方式最大限度地参与社会经济的发展与公共服务的供给。需要指出的是，尽管老年人力资源开发成本较低，但发展适合老年人就业的产业仍然需要对老年人（尤其是年轻老年人）进行必要的教育投资和技能培训，以提升老年劳动力的就业能力。这不仅是学习型社会的应有之义，也是中国从人力资源大国发展成人力资本强国的重要举措，我们的全民教育体制应当也完全能够为此而进行必要的改革（胡湛和彭希哲，2018）。

第 8 章　养老公共服务资源配置的区域均衡[①]

我国养老公共服务资源配置存在区域发展不均衡的问题，主要表现为城乡之间发展不均衡，农村养老公共服务更为短缺（杜鹏等，2016；刘晓静和张楠，2013），地区之间发展不平衡，东部地区整体优于中西部（丁志宏和王莉莉，2011；晏月平和赵冉冉，2013）。同时，我国不同区域的人口老龄化及高龄化水平也存在显著差异，一些地区较高的老龄化程度与较低的养老服务供给水平叠加，进一步加剧了养老公共服务的供需失衡。城乡之间、地区之间在养老公共服务方面的显著差异与供需匹配问题，已成为事关老龄社会健康发展的重要议题。

本章通过构建养老公共服务资源供给的评估指标体系，测度我国省级层面养老服务供给水平的差异，评估服务供给的均等化水平；结合人口老龄化和老人高龄化水平的区域差异，评估分析区域养老公共服务供给与需求的匹配程度；并提出促进我国区域养老公共服务资源配置均衡发展的对策建议。

8.1　养老公共服务资源供给水平测度

8.1.1　公共服务均等化与养老公共服务

养老公共服务作为老年人特有的一种社会福利，对于保障老年人的基本生活及积极应对老龄化至关重要。陈英姿和满海霞（2013）认为养老公共服务是以政府为主体，通过协调公共资源投入提供的公共产品和公共服务，以满足老年人的生存、生活和发展需求，保障老年人口的生活质量。

西方国家对公共服务均等化的研究开始较早，主要从经济视角切入。Buchanan（1950）认为公共服务差距产生的主要原因在于各地方政府财力水平不同，而财政转移支付制度是解决这一问题的最有效的途径。这一结论也在各国的实践中得到验证（Boadway et al.，1982；崔惠玉和孙靖，2010）。Buchanan（1950）认为在财政能力横向均衡方面，每一个地位平等的人都应该得到平等的财政对待，政府的财政政策必须有利于地区财政能力均衡；在纵向均衡方面，

① 本章作者为：郭静、朱勤。

他认为事关国家整体利益、外溢性强的支出责任应由中央政府承担；相反，影响较小、外溢性弱的公共服务支出应该由地方政府承担；基于此，Boadway等（1982）在加拿大设计出横向转移支付模型。Wildasin（1984）、Bergvall等（2006）的研究也验证了这一政策，中央政府对地方政府的财政转移支付有助于实现地区之间财力配置的横向均衡，减轻区域间公共服务不均衡带来的资源配置的负外部性问题，减少区域间恶性税收竞争，缩小区域间经济社会方面的差距，促进区域公平和政治稳定（Keen and Marchand，1997；Oates，1999；Egger et al.，2010）。

面对人口老龄化和高龄化趋势加快带来的养老服务问题，西方学者更加注重对老龄人口长期照护问题的研究。各国的调查研究发现居家和社区养老是老年人更愿意接受的照护方式（Colombo et al.，2011；Eckert et al.，2004；Keenan，2010）；但随着身体和认知功能的下降，老年人“在地老化”的偏好会逐渐降低（Guo et al.，2015；Wolff et al.，2008）。为满足老龄人口的长期照护需求，同时控制费用支出，各国主要从经济激励和供需调控政策入手解决这一问题。经济激励主要是通过增加对居家和社区养老的医疗补助和福利待遇（Feng et al.，2011；Wiener et al.，2009）来扩大居家社区养老服务供应，供需调控主要是通过完善相关法律法规和标准体系来缓解供需矛盾。部分国家，如芬兰、捷克、匈牙利分别明确了居家养老和机构养老服务对象的接收条件和标准；瑞典通过制定法案来促进居家和社区资源的平衡和有效利用。部分亚洲国家，如日本、新加坡和泰国也通过设立长期照护服务酬金和补助来提高家庭和社区养老服务的供给能力（Ikegami et al.，2003；Colombo et al.，2011）。

国内关于公共服务区域均衡的研究主要集中在教育、医疗等领域（熊才平等，2013；高萍，2013，2015；陈丽等，2012）。在养老公共服务的城乡差异方面，廉超等（2018）通过对2013～2016年中国城乡居民人均收入和2010～2016年中国城乡医疗卫生资源分布情况的分析，得出我国城乡居民养老服务水平差异大，农村居民养老服务供给的结构性问题突出；而城乡制度差异、财政转移支付力度和规模、农村经济发展水平和农村居民养老需求是造成城乡居民养老服务不均等的主要因素。贾显维（2014）对陕西省养老服务非均等化的研究也得出了相一致的结论。

关于养老公共服务省际差异研究，陈英姿和满海霞（2013）基于各省统计数据，利用均等权数测算养老公共服务供给指数发现，我国养老公共服务具有供给水平低、规模增长慢、省际差异显著的特点；尤其是西部经济欠发达地区养老公共服务供给能力较差。丁志宏和王莉莉（2011）利用2006年中国城乡老年人口状况追踪调查数据，引入利用差和需求差的概念来分析社区居家养老

服务的需求、供给与利用之间的关系，研究发现我国社区居家养老存在着明显的不均等，中西部地区的服务需求更高，但服务供给率却低于东部地区；东部地区居家养老资源相对过剩。

西方国家社会福利水平较高，主要从老年人的养老服务需求出发，通过财政和政策调控措施来促进养老服务的可持续发展。而我国面临着“未富先老”和城乡二元体制的问题，促进养老公共服务均衡化发展仍然面临着较大的障碍。目前国内对养老公共服务资源供给均衡性问题的研究主要关注城乡之间的均等化，着重强调农村养老公共服务的发展，较少关注不同区域之间的均等化。一方面，由于养老服务资源供给评估指标构建的难度较大，尚未形成一致的观点；另一方面，囿于数据的可获得性，已有的养老公共服务评估指标的可操作性低，导致对养老公共服务资源配置区域均衡的深入研究相对较少，这对区域养老公共服务均衡化从理论探讨上升到政策实践产生了阻碍。

养老公共服务作为一种公共产品，不仅关系到老年人口的自身权益，也关系到我国老龄事业的健康发展。由于我国区域之间本身就存在着自然条件和社会条件的差异，区域养老公共服务供需失衡将不利于公共服务供给的公平性和公正性。因此，结合中国国情，定量测度我国养老服务供给水平的区域差异，评估服务资源配置的均等化水平及供需匹配程度，分析其影响因素并给出对策建议，对于促进我国养老事业的顺利发展，探索健康中国的建设路径具有积极的理论与实践意义。

8.1.2　养老公共服务资源供给指标选取

养老公共服务资源供给主要是指通过政府部门供给或政府授权其他组织提供有关养老的公共产品和公共服务。王建丰（2012）认为，公共服务的区域均等化主要包括权利均等、机会均等和结果的相对均等。本节在充分借鉴已有养老公共服务衡量指标的基础上，着重考察区域养老公共服务资源供给结果的相对均等性，从养老保险、医疗保险、服务设施、服务人员、老年福利五个维度构建区域养老公共服务资源供给的评估指标体系，如表 8-1 所示。

表 8-1　养老公共服务资源供给指标体系

综合指标	一级指标	二级指标
养老公共服务资源供给指标	养老保险（E）	城镇职工养老保险保障水平（E_1，元/人）
		城乡居民养老保险保障水平（E_2，元/人）
		城镇职工养老保险可持续水平（E_3，月）
		城乡居民养老保险可持续水平（E_4，月）

续表

综合指标	一级指标	二级指标
养老公共服务资源供给指标	医疗保险（M）	城镇职工医疗保险保障水平（M_1，元/人）
		城镇居民医疗保险保障水平（M_2，元/人）
		城镇职工医疗保险可持续水平（M_3，月）
		城镇居民医疗保险可持续水平（M_4，月）
	服务设施（F）	每千老人老年医疗护理机构床位数（F_1，张/每千老人）
		每千老人养老服务机构床位数（F_2，张/每千老人）
		每千老人社区留宿收养床位数（F_3，张/每千老人）
	服务人员（P）	每千老人养老机构年末职工数（P_1，人/每千老人）
		每千老人社区养老服务年末职工数（P_2，人/每千老人）
		每千老人卫生技术人员（P_3，人/每千老人）
	老年福利（W）	高龄补贴保障水平（W_1，元/人）
		护理补贴保障水平（W_2，元/人）
		养老服务补贴保障水平（W_3，元/人）

其中各二级指标的操作性定义如下。

城镇职工养老保险保障水平（E_1）=城镇职工养老保险基金支出/参保离退休人员年末人数。

城乡居民养老保险保障水平（E_2）=城乡居民养老保险基金支出/实际领取待遇人数。

城镇职工养老保险可持续水平（E_3）=城镇职工养老保险累计结余/每月城镇职工养老保险基金支出。

城乡居民养老保险可持续水平（E_4）=城乡居民养老保险累计结余/每月城乡居民养老保险基金支出。

城镇职工医疗保险保障水平（M_1）=城镇职工医疗保险基金支出/年末参保人数。

城镇居民医疗保险保障水平（M_2）=城镇居民医疗保险基金支出/年末参保居民人数。

城镇职工医疗保险可持续水平（M_3）=城镇职工医疗保险累计结余/每月城镇职工医疗保险基金支出。

城镇居民医疗保险可持续水平（M_4）=城镇居民医疗保险累计结余/每月城镇居民医疗保险基金支出。

每千老人老年医疗护理机构床位数（F_1）=老年医疗护理机构床位数/60 岁及以上老年人口数 × 1000。

每千老人养老服务机构床位数（F_2）=养老服务机构床位数/60 岁及以上老年人口数 × 1000。

每千老人社区留宿收养床位数（F_3）=社区留宿收养床位数/60 岁及以上老年人口数 × 1000。

每千老人养老机构年末职工数（P_1）=养老机构年末职工数/60 岁及以上老年人口数 × 1000。

每千老人社区养老服务年末职工数（P_2）=社区养老服务年末职工数/60 岁及以上老年人口数 × 1000。

每千老人卫生技术人员（P_3）=卫生技术人员数/60 岁及以上老年人口数 × 1000。

高龄补贴保障水平（W_1）=高龄补贴/80 岁及以上老年人口数。

护理补贴保障水平（W_2）=护理补贴/60 岁及以上老年人口数。

养老服务补贴保障水平（W_3）=养老服务补贴/60 岁及以上老年人口数。

8.1.3　分省养老公共服务资源供给水平

本章所使用的 2016 年中国省级行政区（数据不包含台湾、香港、澳门）有关养老公共服务资源供给的数据，依据《中国劳动统计年鉴 2017》《中国民政统计年鉴 2017》《中国人力资源和社会保障年鉴 2017》等加以整理获得。相关人口方面的数据主要来自《中国统计年鉴 2016》《2015 年全国 1%人口抽样调查资料》。

为消除因量纲不同对评价结果的影响，采用极值法对指标进行无量纲化处理。极值法对指标原始数据信息依赖较少，转换后的值为 0～1。由于本章所选取的指标均为正指标，因此，无量纲化处理的计算公式如下：

$$x'_{i,k}=\frac{x_{i,k}-\min\left\{x_k\right\}_{k=1}^{n}}{\max\left\{x_k\right\}_{k=1}^{n}-\min\left\{x_k\right\}_{k=1}^{n}} \tag{8-1}$$

其中，$x_{i,k}$ 为第 i 个省区市的第 k 项评价指标的数；$\min\left\{x_k\right\}_{k=1}^{n}$ 为各省区市中第 k 项评价指标的最小值；$\max\left\{x_k\right\}_{k=1}^{n}$ 为各省区市中第 k 项评价指标的最大值；$x'_{i,k}$ 为其无量纲化后的数值得分。通过专家评分法的三轮评估，得到我国养老公共服务资源供给评估中各级指标的权重，如表 8-2 所示。各省区市养老公共服务资源供给综合指数的计算，即由各个指标加权汇总后得到。

表 8-2　养老公共服务资源供给指标权重

一级指标	养老保险（E）				医疗保险（M）				服务设施（F）			服务人员（P）			老年福利（W）		
权重	0.3				0.3				0.15			0.15			0.1		
二级指标	E_1	E_2	E_3	E_4	M_1	M_2	M_3	M_4	F_1	F_2	F_3	P_1	P_2	P_3	W_1	W_2	W_3
权重	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.1	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.03	0.02	0.05

2016 年全国分省养老公共服务资源供给水平的计算结果如表 8-3 所示。

表 8-3　2016 年各省区市养老公共服务资源供给指数

省区市	养老保险	医疗保险	服务设施	服务人员	老年福利	综合指数
北京	0.497	0.522	0.468	0.602	0.221	0.488
上海	0.373	0.683	0.499	0.436	0.113	0.468
新疆	0.308	0.446	0.219	0.393	0.231	0.341
天津	0.339	0.391	0.330	0.264	0.277	0.336
广东	0.446	0.382	0.226	0.299	0.067	0.334
浙江	0.204	0.452	0.527	0.246	0.119	0.325
江苏	0.220	0.365	0.574	0.194	0.217	0.312
福建	0.197	0.498	0.366	0.158	0.115	0.299
山东	0.235	0.284	0.393	0.158	0.498	0.288
山西	0.274	0.319	0.173	0.280	0.327	0.279
宁夏	0.220	0.417	0.109	0.265	0.241	0.271
云南	0.255	0.380	0.251	0.136	0.189	0.267
四川	0.185	0.348	0.446	0.066	0.241	0.261
陕西	0.168	0.341	0.263	0.240	0.244	0.253
安徽	0.215	0.291	0.523	0.055	0.125	0.251
河北	0.149	0.369	0.210	0.159	0.266	0.237
河南	0.136	0.277	0.383	0.159	0.266	0.232
内蒙古	0.131	0.337	0.250	0.252	0.142	0.230
黑龙江	0.059	0.315	0.473	0.215	0.130	0.228
湖南	0.153	0.295	0.249	0.116	0.376	0.227
湖北	0.136	0.282	0.313	0.182	0.261	0.226
贵州	0.211	0.276	0.335	0.127	0.103	0.226

续表

省区市	养老保险	医疗保险	服务设施	服务人员	老年福利	综合指数
海南	0.192	0.321	0.072	0.278	0.182	0.225
江西	0.136	0.281	0.283	0.137	0.308	0.219
广西	0.144	0.397	0.200	0.103	0.005	0.208
吉林	0.077	0.301	0.270	0.178	0.192	0.200
重庆	0.126	0.308	0.239	0.054	0.175	0.192
甘肃	0.196	0.277	0.141	0.098	0.115	0.189
辽宁	0.091	0.221	0.179	0.176	0.212	0.168

注：按各省区市养老公共服务资源供给综合指数由高到低排序。由于西藏、青海两地的部分数据缺失，以上计算剔除了这两个省区

从计算结果来看，各地区在养老公共服务资源供给水平方面差异明显。全国各省区市养老公共服务资源供给水平综合指数平均得分为 0.268。按综合指数得分从高到低排列，排在前五位的依次是北京、上海、新疆、天津和广东；得分最低的 5 个省区市依次是辽宁、甘肃、重庆、吉林和广西。低于全国平均值的省区有 18 个，占此次测量的省级区划的 62.1%。北京地区综合指数得分最高，是平均值的 1.82 倍，并且 2 个一级指标——即养老保险和服务人员——的供给指数均处于全国最高水平。上海、新疆、天津和广东地区综合指数得分较高，主要得益于这 4 个省区市的养老保险、医疗保险、服务人员的养老资源供给水平均较高。

辽宁、甘肃、重庆、吉林和广西的一级指标供给指数得分均较低。其中，辽宁省医疗保险供给指数得分最低，为 0.221；重庆市服务人员供给水平最低，为 0.054；广西地区老年福利供给指数小于 0.01，处于最低水平。从养老保险供给水平来看，黑龙江地区养老保险供给水平最低，得分为 0.059，其次是吉林和辽宁地区，供给指数得分分别为 0.077、0.091；从养老服务设施的供给来看，海南、宁夏和甘肃地区供给水平排名位于最后三位。

8.2　养老公共服务资源供给的区域差异分析

8.2.1　养老服务供给的均等化水平

本节采用基尼系数作为我国养老公共服务资源供给区域均等化的测度指标。基尼系数取值范围在 0 和 1 之间，基尼系数为 0 或者 1 表明资源分配的完全公平和完全不公平。国际上通常将 0.4 作为基尼系数的警戒线，基尼系数小

于 0.3，表明资源供给比较公平；在 0.3～0.4，表明资源供给处于相对合理区间；在 0.6 以上，表明资源分配高度不公平（安建民等，1997；龚向光和胡善联，2005；张彦琦等，2008）。

基尼系数计算方法如式（8-2）所示。其中，G 为基尼系数；W_i 为各地区人数占总人口数的比例；Y_i 为各养老公共服务资源指标量占总资源的比重；V_i 为 i=1,2,…, n 的累计比；i 为各养老公共服务资源供给水平从小到大的排序序号。

$$G=\sum_{i=1}^{n}W_iY_i+2\sum_{i=1}^{n-1}W_i^*\left(1-V_i\right)_i-1 \qquad (8\text{-}2)$$

对 2016 年我国养老公共服务供给区域均等化水平的评估结果如表 8-4 所示。在我国养老公共服务资源供给中，养老保险和老年福利资源配置较不公平。这与养老公共服务资源供给的区域测算结果相互印证。医疗保险、服务人员和服务设施资源配置较为合理，各二级指标基尼系数均低于警戒线。其中，医疗保险和服务人员资源配置比较公平，基尼系数均小于 0.3；在养老服务设施配置中，每千老人老年医疗护理机构床位数、每千老人社区留宿收养床位数的基尼系数均在 0.3～0.4。在养老保险供给中，城镇职工养老保险可持续水平配置较不合理，基尼系数为 0.404。在老年福利资源中，护理补贴保障水平最不公平，基尼系数接近 0.6。

表 8-4　各类养老服务资源供给水平的基尼系数

一级指标	二级指标	基尼系数
养老保险（E）	城镇职工养老保险保障水平(E_1)	0.111
	城乡居民养老保险保障水平(E_2)	0.185
	城镇职工养老保险可持续水平(E_3)	0.404
	城乡居民养老保险可持续水平(E_4)	0.222
医疗保险（M）	城镇职工医疗保险保障水平(M_1)	0.141
	城镇居民医疗保险保障水平(M_2)	0.142
	城镇职工医疗保险可持续水平(M_3)	0.187
	城镇居民医疗保险可持续水平(M_4)	0.253
服务设施（F）	每千老人老年医疗护理机构床位数(F_1)	0.327
	每千老人养老服务机构床位数(F_2)	0.217
	每千老人社区留宿收养床位数(F_3)	0.348
服务人员（P）	每千老人养老机构年末职工数(P_1)	0.244
	每千老人社区养老服务年末职工数(P_2)	0.284

续表

一级指标	二级指标	基尼系数
服务人员（P）	每千老人卫生技术人员(P_3)	0.122
老年福利（W）	高龄补贴保障水平(W_1)	0.260
	护理补贴保障水平(W_2)	0.572
	养老服务补贴保障水平(W_3)	0.192

8.2.2　养老服务供给水平的区域差异

按照我国四大区域（即东部地区、中部地区、西部地区、东北地区）的划分，进一步了解我国养老公共服务资源配置的区域特征（图 8-1）。从各一级指标的区域分布来看，医疗保险、服务设施和服务人员供给水平的区域差异相对较小；养老保险和老年福利供给水平的区域差异较大。东部地区养老保险、医疗保险、服务设施和服务人员的供给均处于最高水平，老年福利供给水平仅次于中部地区，位居第二。其次是西部地区养老保险和医疗保险供给水平相对较高，但服务设施和老年福利供给水平最低。中部地区和东北地区医疗保险和服务设施供给水平均较低，相差较小，中部地区供给水平略高于东北地区；且东北地区养老保险供给处于最低水平，但东北地区服务人员供给水平要优于中部、西部地区。

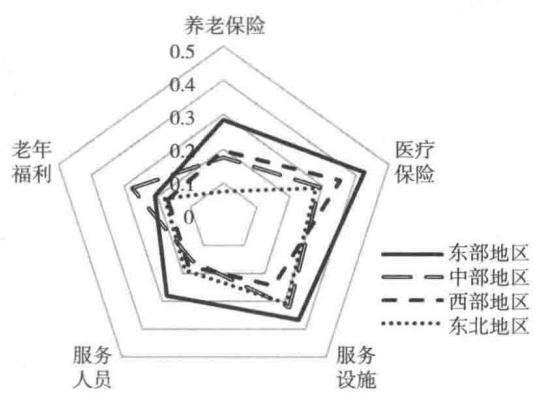

图 8-1　养老公共服务资源供给水平的区域差异

本节采用泰尔（Theil-L）指数定量评估我国东部、中部、西部和东北地区养老公共服务资源供给配置的区域差异，包括区域内的资源配置差距和区域之间的资源配置差距。泰尔指数的计算公式如下：

$$T=\sum_{i=1}^{n}P_i\log\left(P_i/Y_i\right) \tag{8-3}$$

其中，T 为泰尔指数；n 为地区序号；P_i 为各地区人口数占总人口数的比重；Y_i 为各地区养老公共服务资源占总资源量的比重。泰尔指数得分越高，表明养老公共服务资源供给水平的差异越大。

运用泰尔指数分解公式[式（8-4）～式（8-6）]可以计算组内和组间差异。其中，m 为区域的个数；P_k 为各区域人口数占总人口数的比重；Y_k 为各区域资源数占总资源数的比重；$T_{组内}$ 表示组内差异；$T_{组间}$ 表示组间差异。进一步地，根据差异结果计算各部分差异对总泰尔指数的贡献率，见式（8-7）、式（8-8）。

$$T=T_{组内}+T_{组间} \tag{8-4}$$

$$T_{组内}=\sum_{k=1}^{m}P_kY_k \tag{8-5}$$

$$T_{组间}=\sum_{k=1}^{m}P_k\log\left(P_k/Y_k\right) \tag{8-6}$$

$$组内差异贡献率=T_{组内}/T \tag{8-7}$$

$$组间差异贡献率=T_{组间}/T \tag{8-8}$$

根据式（8-3）和式（8-8），计算 2016 年我国养老公共服务资源配置区域分布的泰尔指数，将泰尔指数分解为组内差异和组间差异，并计算养老公共服务资源组内和组间差异对总泰尔指数的贡献率，计算结果如表 8-5 所示。

表 8-5　2016 年我国养老公共服务资源配置区域分布的泰尔指数

指标	东部	中部	西部	东北	组内	组间	总泰尔指数	组内差异贡献率	组间差异贡献率
城镇职工养老保险基金支出	0.052	0.018	0.040	0.018	0.037	0.015	0.052	71.5%	28.5%
城镇职工养老保险累计结余	0.128	0.034	0.039	0.018	0.071	0.049	0.121	59.0%	41.0%
城乡居民养老保险基金支出	0.004	0.004	0.005	0.006	0.005	0.011	0.015	30.5%	69.5%
城乡居民养老保险累计结余	0.030	0.005	0.020	0.002	0.019	0.021	0.039	47.4%	52.6%
城镇职工医疗保险基金支出	0.074	0.014	0.030	0.020	0.042	0.036	0.078	53.7%	46.3%
城镇职工医疗保险累计结余	0.083	0.012	0.041	0.003	0.046	0.050	0.096	48.0%	52.0%
城镇居民医疗保险基金支出	0.061	0.021	0.105	0.037	0.061	0.073	0.134	45.7%	54.3%
城镇居民医疗保险累计结余	0.094	0.024	0.026	0.016	0.051	0.010	0.060	84.0%	16.0%

续表

指标	东部	中部	西部	东北	组内	组间	总泰尔指数	组内差异贡献率	组间差异贡献率
老年医疗护理机构床位数	0.086	0.023	0.057	0.311	0.081	0.022	0.103	79.0%	21.0%
养老服务机构床位数	0.024	0.032	0.042	0.000	0.029	0.008	0.037	79.4%	20.6%
社区留宿收养床位数	0.091	0.110	0.049	0.106	0.086	0.008	0.093	91.7%	8.3%
养老机构年末职工数	0.038	0.010	0.023	0.003	0.024	0.021	0.044	53.2%	46.8%
社区养老服务年末职工数	0.100	0.030	0.061	0.047	0.067	0.004	0.071	93.8%	6.2%
卫生技术人员	0.010	0.007	0.014	0.003	0.010	0.001	0.010	93.1%	6.9%
高龄补贴	0.029	0.100	0.035	0.314	0.071	0.040	0.110	64.2%	35.8%
护理补贴	0.349	0.283	0.240	0.000	0.272	0.704	0.976	27.9%	72.1%
养老服务补贴	0.038	0.013	0.022	0.172	0.039	0.040	0.078	49.5%	50.5%

注：本表数值均由原始数据计算得出

我国东部、中部、西部和东北地区养老服务资源配置差异较大。主要体现在城乡居民养老保险基金支出和护理补贴的组间泰尔指数分别为 0.011、0.704；其泰尔指数组间差异贡献率均约是组内差异贡献率的 2.5 倍。东部地区城镇职工养老保险基金支出和累计结余、城乡居民养老保险累计结余、城镇职工医疗保险基金支出和累计结余、城镇居民医疗保险累计结余、养老机构年末职工数、社区养老服务年末职工数、护理补贴泰尔指数较大，说明资源配置较不均等。中部地区资源配置较为均等，仅有社区留宿收养床位的泰尔指数高于其他地区。西部地区城镇居民医疗保险基金支出、养老服务机构床位数、卫生技术人员资源供给区域内部差异较大。东北地区老年医疗护理机构床位数、高龄补贴和养老服务补贴配置较不均等。

区域内差异是造成城镇职工养老保险基金支出和累计结余、城镇居民医疗保险累计结余、老年医疗护理机构床位数、养老服务机构床位数、社区留宿收养床位数、社区养老服务年末职工数、卫生技术人员和高龄补贴资源配置不均等的主要原因；尤其对社区留宿收养床位数、社区养老服务年末职工数与卫生技术人员配置的影响较大，组内差异贡献率是组间差异贡献率的 11～15 倍。而城乡居民养老保险累计结余、城镇职工医疗保险基金支出和累计结余、城镇居民医疗保险基金支出、养老机构年末职工数、养老服务补贴的泰尔指数组内差异贡献率和组间差异贡献率差距较小，这表明区域内和区域间差异是造成该类养老公共服务资源指标分布不均等的主要原因（表 8-5）。

8.3　区域养老服务资源的供需匹配分析

吕炜和王伟同（2008）认为公共服务提供的不均等主要是公共服务供给和需求在结构上失衡导致的。因此，对养老公共服务资源供给不均等的分析需要进一步考察供给和需求的匹配问题。本节通过对区域养老公共服务资源供给水平与实际养老需求的测度，分析养老需求与养老资源供给水平的匹配程度，并进一步探寻提高我国区域养老服务资源供给与需求匹配程度的可能路径。

简化起见，以区域人口老龄化和老人高龄化程度作为区域养老服务需求的替代性指标变量。

8.3.1　我国人口老龄化的区域差异

根据 2015 年全国人口抽样调查数据，考察人口老龄化和高龄化程度的区域差异。老龄化程度取值为 60 岁及以上人口占总人口的比例；老人高龄化程度取值为 80 岁及以上人口占老年人口的比例。

从各地区老龄化水平来看，2015 年全国有两个省市——重庆和辽宁——已经进入中度老龄化阶段。东部地区老龄化水平存在较大差异，上海、江苏、山东地区老龄化水平即将发展到中度老龄化阶段，但福建、广东和海南地区老龄化水平仍低于全国平均水平，老龄化水平最高（上海）和最低（广东）地区相差 8.6 个百分点[①]（表 8-6）。中部地区老龄化水平差异较小，其中，安徽、湖北和湖南地区的老龄化水平略高于全国平均水平。相较于其他省区市，西部地区的西藏、青海、新疆老龄化程度较低，60 岁及以上人口占总人口比重均小于 11%；仅有四川和重庆两个省市老龄化程度高于全国平均水平，且四川省老龄化水平即将发展到中度老龄化阶段。东北地区整体老龄化程度较高。辽宁、重庆、上海、四川、江苏地区老龄化水平位居全国前五。

表 8-6　2015 年各省区市人口老龄化和老人高龄化状况

省区市	老龄化水平	老龄化排名	老人高龄化水平	老人高龄化排名	平均预期寿命/岁	预期寿命排名
北京	16.4%	15	14.3%	5	82.0	2
天津	16.7%	12	11.1%	15	79.3	3
河北	16.5%	14	9.6%	25	75.4	16
山西	14.6%	19	10.5%	19	75.1	22

① 表 8-6 展示的老龄化水平为四舍五入之后的数值，本处为原始数据计算得到。

续表

省区市	老龄化水平	老龄化排名	老人高龄化水平	老人高龄化排名	平均预期寿命/岁	预期寿命排名
内蒙古	15.3%	18	9.7%	23	74.8	24
辽宁	20.6%	1	12.0%	11	76.8	8
吉林	17.8%	8	9.3%	27	76.6	10
黑龙江	17.8%	7	8.8%	30	76.4	11
上海	19.9%	3	17.4%	1	82.8	1
江苏	19.2%	5	12.9%	8	77.0	5
浙江	17.0%	11	14.4%	4	78.1	4
安徽	16.6%	13	12.8%	9	75.5	15
福建	13.9%	24	13.8%	7	76.2	12
江西	14.0%	23	11.4%	14	75.3	18
山东	18.1%	6	12.3%	10	76.9	7
河南	15.7%	17	10.5%	20	75.0	23
湖北	17.4%	9	10.6%	18	75.3	19
湖南	17.0%	10	11.7%	12	75.1	21
广东	11.2%	28	14.8%	3	76.9	6
广西	14.4%	20	14.2%	6	75.5	14
海南	12.3%	26	16.7%	2	76.7	9
重庆	20.2%	2	11.1%	17	76.1	13
四川	19.6%	4	11.1%	16	75.2	20
贵州	14.1%	22	10.4%	21	71.5	28
云南	12.7%	25	11.6%	13	69.9	30
西藏	8.5%	31	9.8%	22	64.8	31
陕西	16.0%	16	9.6%	26	75.3	17
甘肃	14.1%	21	8.8%	29	72.6	27
青海	10.8%	29	8.1%	31	70.4	29
宁夏	11.5%	27	9.0%	28	73.8	25
新疆	10.5%	30	9.6%	24	72.8	26

各省老人高龄化水平与其人口老龄化进程并不一致。各省 60 岁及以上人口占总人口的比重和 80 岁及以上人口占老年人口比重这两个变量的 Pearson

相关系数仅为 0.18。高龄化与老龄化水平差距较为突出的 6 个省市依次为广东、海南、黑龙江、吉林、福建和重庆。东部地区的海南（16.7%）、广东（14.8%）和福建（13.8%）的老人高龄化水平排名分别位于第 2 名、第 3 名和第 7 名，但老龄化水平均较低，排名分别位于第 26 名、第 28 名和第 24 名；其主要特征表现为老年人口比例虽小，但老人群体的高龄化程度较深。与之相反，东北三省老龄化水平排名要远高于高龄人口占比。其中，辽宁省老龄化水平（20.6%）在全国排名第 1，但高龄人口占比（12.0%）排名位于第 11；黑龙江（17.8%）和吉林（17.8%）老龄化水平排名分别是第 7 名和第 8 名，但高龄化水平（8.8%、9.3%）排名较靠后，分别位于第 30 名和第 27 名；整个东北地区呈现出老年人比例高，但老年人人口相对年轻的特征。重庆地区老龄化水平（20.2%）和高龄人口占比（11.1%）也表现出同样的特点，老人高龄占比排名（第 17 名）比老龄化水平（第 2 名）靠后了 15 个名次（图 8-2）。

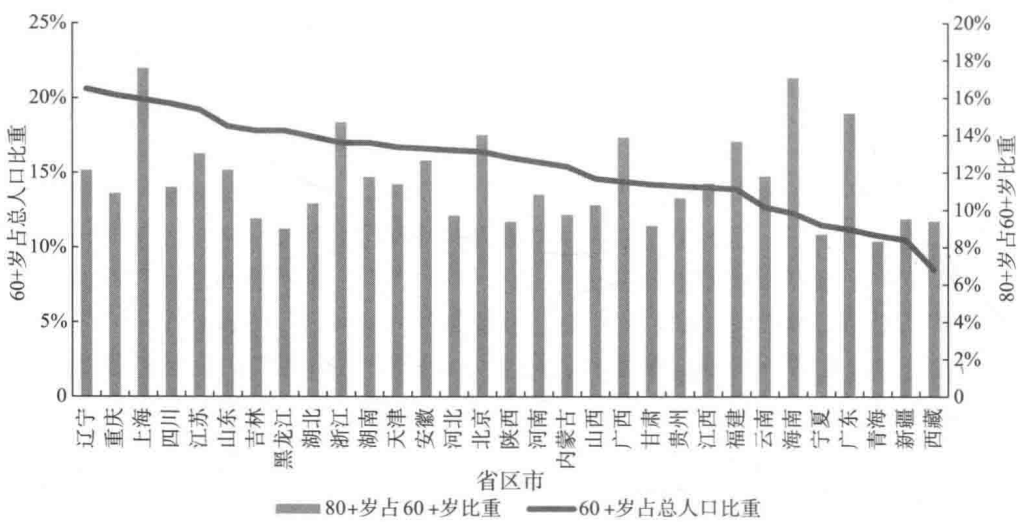

图 8-2　2015 年分省人口老龄化与高龄化状况

各省区市按 60 岁及以上人口占比从高到低排列

对于不考虑迁移流动的封闭人口，老年人口的高龄化程度会很大程度上受到其人均预期寿命水平的影响。一般而言，预期寿命长的地区，老人高龄化程度相应较高。但比较各省区市高龄化水平与预期寿命可以发现，两者之间的相关程度很低。例如，高龄化程度较低的东北三省和重庆市，其平均预期寿命水平在全国 31 个省级行政区中均排在前 13 位，处于中上水平（表 8-6）。朱勤（2014）的研究亦显示，农村人口向东南沿海城市的迁移流动，是影响区域城乡人口老龄化的重要因素。这提示我们，我国部分地区人口老龄化与高龄化水平的不一致性受到人口迁移流动的重要影响。

8.3.2　区域养老服务供给与人口老龄化的匹配程度

比较各省区市养老公共服务资源供给水平与老龄化程度的相互关系，可以发现养老保险和医疗保险供给水平与老龄化水平的匹配程度较低。如图 8-3 和图 8-4 所示，老龄化程度较高的上海、北京和天津等地匹配程度较高，但东北地区，特别是辽宁省匹配程度最低。前文的研究已经表明，辽宁省老龄化程度高，但城镇职工养老保险保障水平、城乡居民养老保险保障水平和可持续水平较低，导致养老保险供给水平较低；同时，辽宁省城镇职工医疗保险保障水平和可持续水平、城镇居民医疗保障水平也较低，这也导致了辽宁省医疗保险供给水平与老龄化程度匹配较差。相较于辽宁省，吉林和黑龙江老龄化程度略低，但养老保险供给也处于较低水平，医疗保险供给水平则相对较高。重庆市也存在老龄化程度高、养老保险和医疗保险供给水平低的问题。老龄化程度相对较低的广东、新疆和宁夏等地养老保险和医疗保险的匹配程度较高。

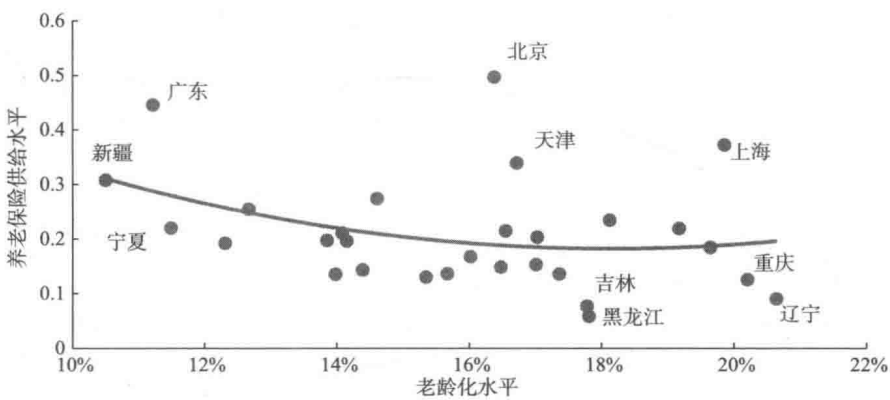

图 8-3　养老保险供给水平与老龄化水平

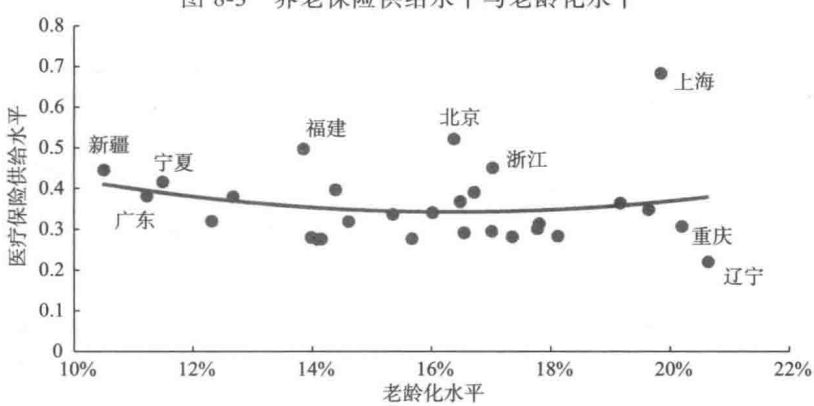

图 8-4　医疗保险供给水平与老龄化水平

高龄人口是养老服务需要重点关注的对象。一般而言，高龄人口占比越高，则表明地区养老公共服务需求越大，对养老服务设施、服务人员及老年福利补贴的需求也就越高。各省区市老年服务供给水平与老人高龄化水平的相互关系如图 8-5～图 8-7 所示。从供需匹配程度来看，东部地区服务设施供给水平总体上要高于其他地区，如上海、浙江、北京、江苏地区高龄老人占比较高，相应的服务设施供给水平相对较好。甘肃、宁夏等老人高龄化比重较低的省区市，服务设施供给水平也相对较低。海南省老人高龄化程度处于很高的水平，但服务设施供给水平却处于很低的水平，供需严重失衡（图 8-5）。服务人员的供需匹配程度相对较好，其中，北京和上海服务人员供给水平与老人高龄化水平的匹配程度相对较高；重庆、安徽、四川、广西服务人员供给水平与老人高龄化程度的匹配程度较低（图 8-6）。在老年福利供给水平中，山东、辽宁等地匹配程度较好；上海、海南、广东、浙江老年福利供给水平与老人高龄化水平的匹配程度较低，尤其是广西匹配程度最低（图 8-7）。

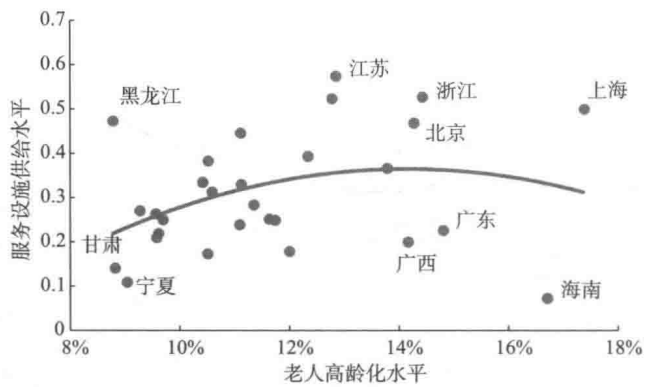

图 8-5　服务设施供给水平与老人高龄化水平

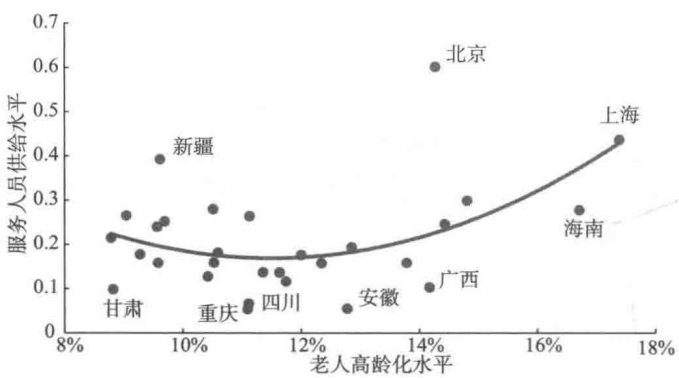

图 8-6　服务人员供给水平与老人高龄化水平

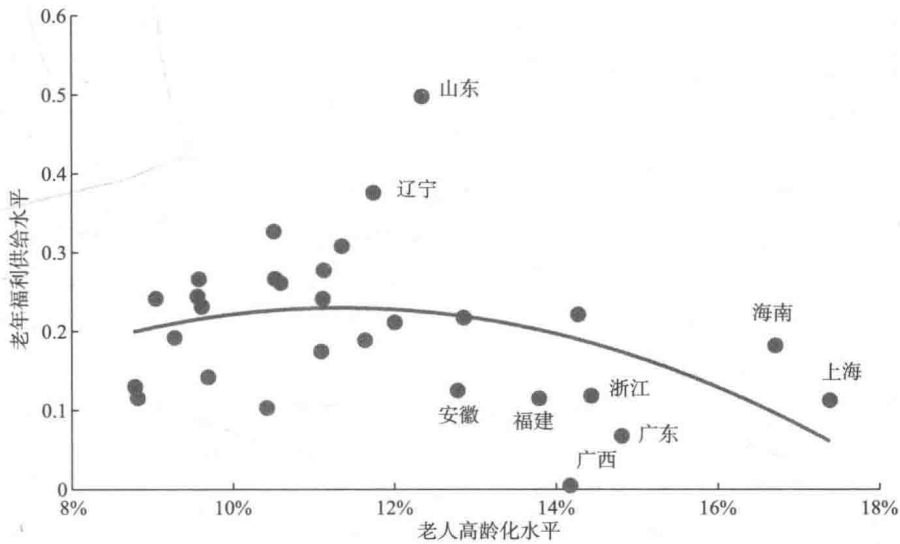

图 8-7　老年福利供给水平与老人高龄化水平

8.3.3　养老服务供需匹配的区域差异分析

一般而言，生育率、死亡率及期初年龄结构是影响人口老龄化的自然因素。但随着城镇化进程加快，人口乡-城转移成为影响我国乡村人口老龄化的主导因素，也是影响区域老龄人口结构的重要原因。人口的乡-城流动为城镇带来了大量青壮年劳动力，且这些劳动力多数被城市吸纳，往往具有不可逆转性；这在一定程度上缓解了城镇的老龄化程度，也加剧了乡村的老龄化速度，导致人口老龄化城乡倒置。但从长远来看，随着经济、人口和政策等环境因素的优化，这一现象将呈现阶段性特征；人口乡-城转移给乡村地区带来的老龄化问题最终会反映在城市人口老龄化过程中（朱勤，2014）。因此，在促进养老公共服务资源配置均等化发展的过程中，不仅应考虑地方经济发展水平和老龄人口结构的影响，也应关注人口流动造成的区域养老服务差异问题。

首先，经济和社会发展水平决定了地方政府的养老公共服务供给能力。我国各区域内部养老公共服务资源配置差异与地方经济发展水平紧密相关。不同学者的研究发现也验证了这一结论。刘细良和刘迪扬（2011）以浙江、湖南和贵州为代表省份测算区域基本公共服务均等化水平，也发现东部地区社会保障水平较高。翟秋阳和崔光胜（2015）通过对上海、湖北和贵州三个省市基本公共服务均等化的研究发现，东、中、西部地区在医疗卫生技术人员、床位数及养老保险方面差距较大；上海地区基本公共服务各方面供给水平均较好，且城乡差距较小；这一现象主要受到城乡二元经济体制、地方经济基础及政府财政支出偏好的影响。本章研究结果中上海、湖北和贵州三个省市的养老公共服务

资源配置也遵循这一规律，上海地区养老保险、医疗保险、服务设施和服务人员整体供给水平均优于湖北和贵州地区。东部地区的北京、上海、江苏、浙江等地经济发展水平较高，又作为全国养老服务先行试点地区，养老保障和服务基础设施供给水平优于山东、福建等地。

其次，老龄人口结构影响养老公共服务的供需匹配程度。在养老公共服务资源的供给中，养老服务资源供给水平较低的辽宁省和重庆市老龄化水平已经进入中度老龄化阶段；且东北三省中的辽宁省养老公共服务资源供给水平较低，供需失衡问题较为突出。但与吉林和黑龙江不同，辽宁省老龄化水平和老人高龄化水平均较高，且农村老龄化程度远高于城镇地区（沈毅，2016）；因此，其养老服务需求要高于吉林和黑龙江地区。而重庆虽然地处西部地区，但其政策优势并没有西藏、青海和新疆等西部地区明显；且重庆市人口老龄化程度仅次于辽宁省，已进入中度老龄化阶段，老龄化程度超过了北京、上海、广东等东部经济发达地区。与辽宁地区相反，近些年重庆市规模大、年轻化的人口跨省流动导致人力资本严重流失，这在一定程度上抑制了经济增长（姜玉等，2016；李晓阳等，2015），加速了重庆地区老龄化速度（易莹莹，2015）；但养老服务基础设施并没有随老龄化程度的加剧而改善，这也就导致了重庆地区养老服务人员资源短缺的问题。

最后，人口流动加剧了养老公共服务资源配置的供需失衡。同处东部沿海地区的上海市和海南省在养老服务资源的供需匹配方面呈现出不同的特征。上海市老龄化水平和老人高龄化水平分别为 19.9%、17.4%；海南省人口老龄化和老人高龄化水平分别为 12.3%、16.7%。两地老人高龄化水平差距较小，但上海市作为中国最主要的人口迁入地之一，大量青壮年劳动力的流入在促进了当地经济发展的同时，也缓解了老龄化加剧带来的问题。与上海市人口迁入不同，海南拥有“世界长寿之乡”称号，高龄人口较多；因其独特的区位环境优势，每年 10 月至次年 4 月会吸引大规模的“候鸟式”养老者，而这一规模仍在不断攀升（涂爱仙和魏品，2015）；这也意味着其对养老服务设施和服务人员的需求将不断增加。但目前海南省养老公共服务还存在着供给水平较低、服务设施不足及养老服务体系不完善等问题，高龄群体规模的急剧扩大给养老公共服务基础设施带来了较大压力。

8.4　促进区域养老服务均衡发展的对策建议

本章定量测度我国省级层面养老服务供给水平的差异，评估区域服务供给的均等化水平及养老服务供需匹配程度。研究有如下主要发现。

1. 养老公共服务资源供给水平省际差异显著

从各省区市养老服务供给水平来看，甘肃、重庆和吉林地区五项指标得分均低于全国平均水平；高于全国平均水平的地区主要分布在东部，如北京、上海、天津、广东、浙江、江苏等地。辽宁省养老公共服务资源综合供给指数得分最低，特别是养老保险和医疗保险供给均处于较低水平。西部地区中，广西、重庆、甘肃养老公共服务资源供给指数要低于新疆、宁夏和云南等地。

2. 养老公共服务资源配置均等化水平不高

从各区域养老资源供给水平来看，东部地区养老保险、医疗保险、服务设施和服务人员的供给水平要远远优于中西部和东北地区，但老年福利供给水平要低于中部地区；东北地区养老保险和医疗保险供给处于最低水平，其中辽宁省低供给水平最为突出；中西部地区养老服务人员供给水平低于东部地区和东北地区。特别是养老保险和老年福利供给水平区域差异较大，尤其是城镇职工养老保险可持续水平和护理补贴保障资源配置较不公平。泰尔指数与基尼系数的测算结果也保持一致，城镇职工养老保险和护理补贴不均等问题突出。根据养老公共服务资源均等化水平的测算结果，城乡居民养老保险基金支出和护理补贴配置不均等主要在于区域间差异，如北京、浙江、江苏等东部地区资源配置均等化水平明显优于其他地区。但养老保险、服务设施和服务人员配置不均等主要表现为区域内差异；特别是相较于其他区域来说，东部地区养老资源配置区域内部差异更大，其中上海、广东、海南和山东等地的差异较为明显，不均等主要体现在城镇职工养老保险和医疗保险、城乡居民养老保险累计结余和城镇居民医疗保险累计结余，以及养老服务人员配置方面。

3. 区域养老服务供给与需求匹配程度较低

以区域人口老龄化和老人高龄化程度作为养老需求的替代性指标进行衡量，我国养老服务供需匹配具有区域差异大、匹配程度不高、可持续水平低的问题。一是我国养老保险和医疗保险的可持续水平较差，与老龄化水平匹配度较低，特别是辽宁和重庆地区的这一问题尤为突出，而北、上、广等东部经济发达地区的匹配程度相对较高。二是服务人员供给水平与高龄化水平整体较为匹配，但重庆、四川、广西等西部地区的供给水平仍然较低。三是随着高龄化趋势的加剧，服务设施和老年福利资源与老人高龄化水平匹配程度下降，存在供不应求的现象；其中，海南省养老服务设施资源十分紧张；老人高龄化水平分别居全国第 10、第 11 位的山东、辽宁两省的老年福利资源供需匹配度最高，而上海、广东、浙江、广西等老人高龄化水平较高的地区匹配程度较差。造成这一差异的原因与老年人口年龄结构、社会经济发展水平和人口迁移流动有

关。虽然上海、北京、天津等东部经济发达地区养老公共服务能力较强，但在未来老龄化速度加快、高龄化形势加剧的情况下，养老服务的资源供给问题仍不容乐观。

基于以上结论，本章提出促进我国区域养老公共服务资源配置均衡发展的对策建议。

1. 优化财政转移支付制度，缩小养老服务资源配置省际差异

在老龄化趋势日益严峻，失能、失智老人数量不断攀升的情况下，加大对养老服务的财政投入是满足老龄人口基本生存和发展需要的物质基础。对于公共服务的省际差异问题，政府间财政转移支付是解决我国区域公共服务均等化问题的主要对策（吴旭东和李静怡，2010；刘细良和刘迪扬，2011），因此促进养老公共服务的区域均衡化发展也应进一步完善一般性转移支付制度和横向转移支付制度。一方面，政府应根据各地的经济发展水平，通过提高一般性转移支付的比例来解决各地政府之间因财政收入较低产生的养老公共服务能力不足的问题，特别是经济欠发达的中西部地区，保障欠发达地区政府有履行养老公共服务责任的基本财力，改善养老公共服务资源供给区域不均等的现状。同时，以缩小省际差异为目标实施专项转移支付制度，在完善相关政策措施和明确各地方政府职责的基础上，合理配置财力和赋予财权，重点解决养老公共服务区域内部的省际差异；针对东、中、西部和东北地区区域内经济发展水平较低但老龄化水平较高的省区市，加大对其有关养老服务的基础设施、服务人员和服务产业的专项资金支持。

另一方面，由于我国人口流动量大且具有不确定性的特点，纵向转移支付难以促成均等化效果的实现。因此，在实施纵向转移支付的同时，还应弥补人口流动带来的养老公共服务外部性问题；明确划分地方政府的财权、税权及资金流向，鼓励东部经济发达地区在享受经济欠发达地区提供的人口红利的同时，将过剩的养老公共服务资源向经济欠发达地区横向流动（刘大帅和甘行琼，2013），从而帮助经济欠发达地区改善养老服务现状，提升我国养老公共服务资源供给的可持续性。

2. 加快社保跨省转移接续改革，促进区域养老经济保障均等化

针对目前我国养老金的可持续性问题，可以通过劳动力跨区域的自由流动来促进区域间均衡发展，而在影响劳动力自由流动的制度性障碍中，养老金的异地转移接续问题尤为突出。我国养老保险体系架构具有制度分割和地区分割特点，由于各统筹区经济发展水平不同，社保缴费基数、标准、保障水平、公共服务层次等存在差异，在跨省结算和支付时，异地之间转移与接续保险的政

策执行不够顺畅，甚至存在人为设置社保转移壁垒的情况。

从政策设计层面推进社保转移接续改革，可以借鉴欧盟一体化经验，通过“养老权益累计+待遇分段发放”方案对我国现行的养老保险制度进行改革和创新。在现有养老保险统筹层次的基础上，通过权益累计来计算各地区劳动者的养老保险。劳动者的个人账户应随人转移，社保中统筹部分要在参保者的原工作地进行记录和保存。待参保人员达到法定退休年龄后，各地根据参保人员的参保记录，以集中或分散方式向其支付养老保险待遇。这一方案一方面能使劳动者在不同时期形成的养老保险权益都能得到承认，减少流动人口养老保险权益的损失；另一方面，由于不影响当地政府养老保险制度的根本利益，可以规避各转入转出地因自身利益设置的转接障碍，有效化解养老保险关系转移接续的利益冲突（郭秀云，2009）。当然，社保跨省转移接续改革不失为一种过渡时期的可行方案，但最根本的解决之道还是应尽早实现基本养老保险的全国统筹（寇明风，2017），建立起有利于全国统一的成本共担、利益共享的协调和补偿机制，最终为化解地区之间政策不一、待遇不一的难题提供制度保障。

3. 完善养老服务体系，提高养老资源供需匹配水平

完善养老服务体系，需要动员社会力量的积极参与。首先，各地方政府应根据地方经济发展水平和实际养老服务需求，适当引入市场机制，鼓励社会组织参与到养老服务中去，扩大养老服务补贴的筹资渠道；加大对社会力量参与养老服务的政策支持力度，可以给予税收、供地等优惠政策，解决审批难、融资贷款难等问题，激发养老市场的活力。其次，要加强养老服务基础设施建设，整合社会养老资源。在增加养老基础设施供给的同时，提高床位利用率，避免出现“一床难求”与“资源闲置”并存的现象；可以通过社区嵌入式养老，缓解机构养老资源紧张，以及低收入老年群体得不到专业照护的问题；整合正式照料和非正式照料资源，将居家、社区和机构三者有效统一。再次，可以发挥社区专业养老机构和服务组织的作用，加大对养老服务人员的教育培训投入力度，加强养老服务人才队伍建设。对非正式照护者进行专业的指导和基本照护技能培训，以机构参访或社区教育宣讲等形式，帮助家庭成员和志愿者了解和掌握有关老年照护的基本知识和技能，增强其对老人的精神和心理关怀。最后，要建立健全养老服务人才激励机制。其中，提高养老服务人员的薪酬待遇水平是首要解决的问题，对于非正式照护者，可以通过给予一定的经济补贴、发放服务优惠券或推广实施由“时间银行”累计服务时间等措施来提高其为老服务的积极性。对于正式照护者，在机构内部可以通过增设晋升机会来提高岗位吸引力，以稳定养老服务队伍。

第 9 章　中国老龄社会治理的政策选择[①]

不难看出，老龄社会的治理绝不是一系列应急策略的集成，必须更加注重多元主体的整合参与和经济社会的长远发展，在保证治理模式和公共政策可持续性的基础上，将短期目标和中长期发展战略结合起来。有鉴于此，本章将在分析完善老龄社会治理格局的要点的基础上，分析当前战略部署中不可回避的政策议题，进而凝聚关于老龄社会治理和政策选择的共识。

9.1　完善老龄社会的治理格局

目前国家为应对短期的现实养老压力而出台的一系列政策措施无疑是非常必要的，但考虑到人口老龄化已经成为我国社会的常态，对其全面应对不仅要聚焦于 5～10 年内的应急策略，更需要为中长期发展战略做好铺垫，不宜轻易“舍远求近”。根据新时代我国全面深化改革和大力发展民生的重大需求，本书认为构建新时代老龄社会的治理格局应首先重视以下四个议题。

1. 立足于我国人口态势及老龄化发生发展规律进行战略配置

作为一个人口大国，我国人口发展不仅涉及国计民生，甚至关系到民族兴衰。从人口学的研究视角出发，积极应对中国人口老龄化应遵从人口发展规律，重视以下三个阶段：2020～2025 年是未来社会抚养比相对较低、老年人口结构相对最年轻的时期，期间还会出现“底部老龄化”和“顶部老龄化”同时弱化的暂时性现象，这是应对老龄化的战略储备期和政策落地期；2030～2035 年的社会抚养比相对较低、老年人口结构相对较年轻，但抚养比重点已显著地向老年人口倾斜，且 20 世纪 50 年代“婴儿潮”期间出生人口开始进入高龄阶段，这是应对老龄化的政策适应及强化期；2050 年至 2055 年前后的抚养比将提升至目前水平的两倍以上，高龄化群体庞大，人口老龄化将到达峰值（2050～2060 年），区域均衡问题在这一时期内也将需要妥善对待，这是应对人口老龄化的攻坚期，并最终夯实使中国社会在老龄化的前提下继续健康持续发展的基础。

---

① 本章作者为：彭希哲、胡湛。

2. 在文化和制度传承的基础上更新理念和创新制度

积极应对人口老龄化的核心在于构建起整个社会的积极老龄观。人口老龄化是社会经济发展的必然结果，当前老龄治理面临的许多问题都在于传统以中青年人口为核心的社会所形成的观念、文化和制度政策安排不适应老龄社会的发展，因而在社会经济生活中或有意或无意地形成了对老年人的排斥乃至歧视，这样既使老年人利益受损，又导致老年人力资本的极大浪费。不仅如此，传统观念及文化还习惯性地将“老”与“衰弱”画上等号，这不仅是缺乏对生命伦理的现代解读，也不利于老年人自强观的建立和自身能力的发挥，更滋养了孕育悲观论和政府全能全责论的土壤。因而应在制度和政策安排的层面上确立年龄平等的原则，在继续弘扬尊老爱幼的文化传统的基础上重新定义老年与老龄，对教育制度、就业制度、薪酬制度、退休和社会保障制度等进行深刻改革，并在更广泛的政治、经济、社会、文化、军事等方面的变革和发展中强调年龄平等，消除现有治理格局中存在的固有障碍及歧视，实现不同年龄群体之间的公平竞争和共同发展。

3. 在多元共治和可持续发展的基础上构建兼顾整体性和动态性的社会经济支持体系

在目前的经济格局下，老龄化不仅会对社会保障体制、劳动力市场、储蓄、税收、投资消费和产业结构等形成冲击，而且从长远来看，老龄化使中国人口结构优势趋于减弱，将直接影响中国未来经济增长的可持续性。在社会层面，老龄化将影响阶层分布与代际关系、城乡与区域结构、家庭模式、住房与迁徙等，并对卫生与医疗保健体系提出新的要求。传统研究及实践较多强调为老年人提供更多的社会和经济支持，但在老龄化常态化的社会背景下必须跳出这一定势，在多元共治和可持续发展的基础上构建兼顾整体性和动态性的社会和经济支持系统，调动并整合政府、社区、家庭、社会组织和企业等不同社会系统主体的作用，在重视社会和经济体系整体均衡的基础上协调不同群体和世代之间的需求和福利平衡，并通过创新的制度和政策安排（尤其是就业政策和产业政策）赋予老龄社会以新的活力。

4. 重视并加强对老年人群体演化和未来老龄社会发展的研判

中国社会在人口转变、社会转型和经济转轨并举的特殊时期迎来了老龄化，这一人口年龄结构的重大变化将伴随其实现现代化的全过程。中国未来老年人口的特征和变化规律如何，未来老年群体的内部异质性和行为模式差异如何，未来老龄社会的形态和演化趋势如何，庞大的老年人口规模将如何重塑未来社会经济乃至文化政治格局，这些问题不仅已大大超出了人类现有的历史经

验，而且给中国的人口老龄化治理带来了更多变数。不仅如此，以信息技术为代表的科技革命亦正在深度改变现有的生产生活方式、产业格局、社会结构及政治形态，其对老年人行为模式和老龄政策设计空间的影响应得到战略性重视。一方面，中国的人口老龄化进程与信息技术的飞速发展相同步，这些技术产业发展能够有效提高社会“老而不衰”的程度，不仅可以降低老年人自理的生理门槛，而且可以促进老年人生产方式和社会角色的转变。我国已初步形成了包括医疗健康电子产品制造、系统集成、服务运营等在内的智慧健康养老产业链，未来无疑需要更多的政策扶持。随着人工智能和机器人技术的发展，人口老龄化将激发服务机器人需求的增长，从而有效弥补因劳动力减少而出现养老护理人才缺失与结构失衡等现象。另一方面，科学技术的发展，尤其是人工智能和机器人技术的升级，尽管会缓解老龄社会劳动力减少的困境并有效提升生产力水平，但也会对传统就业市场产生结构性冲击，并进而影响整个社会应对老龄化的资源格局。人工智能、物联网、生命科学在改变当今和未来世界的生产和生活方式的同时，也极大地重构着我们应对老龄社会的战略格局和政策工具，对此应未雨绸缪。

此外还须指出，在人类社会走向持续而普遍老龄化的过程中，中国的人口老龄化有着举足轻重的作用和特殊的发展进程。随着中国老龄化的深化，其对人口及劳动力格局的重塑将逐渐转化为对产业结构和经济形态升级的强烈诉求，并进一步对全球产业布局和贸易结构产生影响，届时的老龄化治理将突破国境限制而演变为全球治理问题，进而寻求全球范围内的治理资源，因而中国的老龄社会治理应尽快形成全球视野。

9.2　战略部署要点及其政策选择

具体而言，联系当前的实际，本书认为以下几个方面是当前战略部署中不可回避的重要主题。

9.2.1　更新老年定义，扩展政策应对空间并创造理性社会氛围

老龄政策的性质和内涵取决于对老年人及老龄化的界定，以某一年龄为尺度的老年定义的长期执行，使老龄社会的真实影响无法得到有效估计，一些误导性的认识更导致应对老龄化的诸多策略失之偏颇。随着人口健康素质的不断改善，工业化和城市化带来产业结构及工作性质的不断转型，目前有必要对“老年”和“老龄”进行重新审视，突破传统上聚焦于生理年龄的单一静态标准，形成可准确反映人口动态和社会现实的界定标准和分类依据，并在此基础上调

整有关的制度安排和政策体系。学界对此已做尝试（翟振武和李龙，2014）[①]，为缩小“老年人”概念的边界及外延奠定了较好的学术基础。在学界研究的基础上，政府涉老机构及统计部门应适度跟进，以形成官方定义和指标体系。目前在推迟退休政策大思路已出台的背景下，政府可以首先尝试把“退休年龄”的提法逐步转变为“领取全额养老金的最低年龄”，以将“退休”的概念与“衰老”的意象脱钩，并与相关政策互动，为重新定义老年及老龄化做好铺垫。事实上，随着现代社会的技术发展和生活方式变迁，养老金作为一种公共资源，其配置规则将日趋精确化和精细化，而与此同时人类有效工作时间的提升空间亦日趋萎缩，因而应逐步将“退出劳动力市场”的权利（或部分权利）交由个体选择，以支持老年人口（特别是相对健康年轻的老年人口）相对自主地参与社会发展过程并分享社会发展成果。

更新定义的另一个重要作用是改变人们的传统理念并进行文化升级，推动建立积极老龄化的理性社会氛围。政府、高校、社区和媒体应当积极引导社会公众参与应对老龄化的讨论，消除对老龄化的过度解读，弱化对老龄社会的不必要的担忧甚至恐惧。当突破原有的理论和传统羁绊，我们将会对老龄社会有全新的认识，而且这种认识会不断深化和更新，由此产生全新的应对策略和可用的应对资源。此外，中国文化中包含的死亡忌讳还导致与衰老和死亡相关的公众参与不足、制度设计趋于保守，学界和政府有必要引导公众正视生命伦理，在关注“优生”的同时也要关注“优死”，高等教育与行业、职业教育中的相关专业应设置涉及生命与死亡伦理的课程，并加强社会宣传教育。

9.2.2　构建常态统筹机制，夯实整体性治理的行政基础

目前从国家部委到地方涉及老龄化治理的政府机构众多，民政、人保、发改、教育、公安、财政、宣传、党工青妇团等大量部门都具备相关职能，这体现了国家对老龄工作的重视，但也可能导致多头审批、盲目设置、重复建设和无序竞争的局面，还可能使得政策接轨困难，应对老龄化的许多基础性工作难以开展、源头性问题难以解决。现有的老龄事务协调机制亟须创新及升级，进一步充实和提高其效能，为实现老龄社会的整体性治理进行必要的统筹。为此，有必要全面梳理我国各级政府、各类机构和各地区在老龄化治理上的资源投入、职权内涵、政策积累和发展目标，建立健全在信息交换与沟通、资源投入

① 例如：通过综合测量生理、心理和社会经济参与指标，编制反映“年轻”状态随年龄变动轨迹的生命表，将“非年轻状态的人”定义为老年人；通过余寿后推对老龄化进行逆向推算，并结合健康状态生命表测算预留健康年限，将“非健康状态的人”定义为老年人；通过编制自理状态生命表，将“非自理状态的人”定义为老年人；通过对老年人认知功能的测量，以及衰退机制和个体差异的研究，探讨缩小“老年人”概念范畴的可能性等。

和共享、权力与责任调整、决策咨询与参与、政策实施支援体系与网络建设、政策效果评估等方面的跨部门和跨区域协作的行政统筹机制。

以社区养老服务体系建设为例，社区在养老服务供给上具有天然的地缘优势，目前政府已经投入了大量的养老服务资源。然而由于条块分割的体制制约，这些服务管理难以形成部门间的联动与合力，资源浪费与资源短缺并存，资源整合利用效率低，信息碎片化严重。同时，由于养老服务行业存在投资大、经营利润空间小、回收周期长等问题，市场主体或社会力量介入社区养老服务领域的动机、动因缺乏，养老服务的市场参与和社会参与不充分，服务专业化程度低。因而有必要在资源下沉和数据融合的基础上加强社区养老服务平台建设，实现社区养老资源的有效整合和服务供需双方的精准对接，以破除碎片化并增强社区的辐射性，首先要做到的包括：强制性和自主性的信息公开、强制性或法定的决策咨询与过程参与、共享数据库建设、跨部门的标准制定及协同研究和培训等。这些工作的有效运作需有具备社会工作专业资质的养老服务管理人员，即既熟悉养老相关的政府政策，又具备较完善的医疗知识储备和基层沟通经验。基于老龄社会对这一专业人才队伍的需求预测，有必要在高等教育培养体系中扩充福利社工培养方向，并在专业设置与培养方向上聚焦社区养老服务。

此外，目前一些城市社区推行的如“时间储蓄银行”“老伙伴计划”“为老服务券”“爱心呼唤铃”等社会工作实践，以及一些农村的“村办养老”尝试，这些项目大多不需要政府投入很多政策成本和资金成本，并对政府服务进行了有益补充，在满足老年人实际需要的同时，有效提高了老龄工作的社会参与度，还有很好的宣传教育功能，具备很大的推广及扶持价值。将下沉在社区的政府投入与民间资源相整合、协同并统一管理，无疑是对整体性治理的生动注解。

9.2.3　重新诠释计划生育内涵，加快放开生育限制

中国的人口老龄化因计划生育的催生而提前出现（蔡昉和王美艳，2006），当前我国人口变动的主要矛盾已从过去的人口总量过大转向人口结构快速老化，未来人口发展的风险聚焦于生育率和生育意愿的“双低”，且育龄人群持续缩减已成定局。随着老龄化的不断深化，如果生育率继续过低，那么任何制度安排都很难具有持续性。因此应当对计划生育基本国策做全新的诠释，基于目前的全面二孩生育政策尽快从“有计划的按政策生育”转型为“有计划的家庭自主生育”。新时代的人口战略不应将计划生育狭义化，计划生育不等同于“只生一个好”或“只生两个好”，更不等同于限制生育和控制生育，它依然是有计划的，即在制度层面将强调公民义务转变为尊重公民权利，倡导夫妇根据个体条件、家庭状况，以及对社会经济环境的判断而自主地决定其生育计划，

包括生育子女的数量和生育间隔。与此同时，还应适时推出生育友好型家庭政策以优化生育、养育环境，确立“有责任的家庭养育”这一政策立场，支持家庭更好地承担养育、培育子女的责任，阻断愚昧的代际传递，从而在帮助家庭合理实现其生养计划的同时维持世代更替的相对平衡。在未来的十多年间，中国育龄人群（特别是生育高峰期人群）的数量将快速减少，这为尽快调整生育政策提供了有利的时间窗口。生育政策的进一步调整可以有效地遏制出生人口数的大幅下滑，平缓人口结构的过度波动，同时也将降低政府用于限制生育的行政成本，提高民众对政府政策的获得感。必须指出的是，尽管依靠放开生育数量限制并不能扭转人口老龄化的基本趋势，但可以为中国人口长期均衡发展创造更为有利的条件，并为未来世代赢得应对时间。近期应当尽快启动对《中华人民共和国人口与计划生育法》的修订工作，尽快取消有关计划生育“一票否决制”和征收社会抚养费等制度安排，以尽可能地减少限制生育的法规条例。

此外，政府还需要尽快将生育政策调整与家庭政策及相关社会经济政策协调配套起来，以家庭为基础完善生育政策的整体性配套政策措施[①]，让育龄人群不仅“能生”，而且“敢生”和“想生”，以进一步挖掘生育潜力，真正实现人口政策的中长期目标。不仅如此，生育政策调整的目标之一本就是增加人力资本储备以应对老龄化，良好的家庭功能是形成和发展优质人力资本的首要环境，尤其人力资本在新形势下的新内涵（如社会能力、精神品质等因素）更与家庭有着千丝万缕的联系，生育政策和家庭政策有必要对此特别关注。

9.2.4　加强代际转移支付研究，并强化对劳动人口的投资

在未来一个相对较长的时期内，老龄化财政压力的焦点将在很大程度上从筹资上转移到分配上，尤其是代际之间。我国劳动收入的峰值年龄从 2002 年的 40 岁提前至 2007～2009 年的 30～32 岁，年轻劳动力劳动收入的增幅显著超过中老年劳动力[②]。与此同时，受益于近二十年来的经济发展，中老年一代在此过程中积累了大量财富，这是下几代人都无法比拟的。未来随着高等教育普及率和城镇化水平的进一步提高，经验积累和社会资本对劳动收入的贡献度将不断提高，中老年劳动收入的增幅会明显提速，人力资本提升、产业结构升级将成为政府财政收入扩张的新引擎。因此，尽管目前年轻人享受了更高的收入，但在财富积累方面不敌他们的父辈，伴随之后劳动收入峰值年龄的逐步回

① 例如：目前政府几乎没有正式地针对 1～3 岁幼儿的公共服务，托幼机构的减少又使 3～6 岁儿童入园率不断降低，这些因素都直接影响家庭的生育意愿。不仅如此，大量独生子女家庭面临较大的脆弱性，其养老风险正随老龄化而不断凸显，亟须政策关注。特别对于失独家庭，应尽快推出相应的税收减免或现金补助计划。

② 其中两个重要因素：一是年轻劳动力接受大学教育比例大幅上升，二是年轻的农村劳动力大量转移至城市从事收入更高的非农行业。

升[①]，将为未来应对老龄社会财政压力同时创造出空间与时间。

目前世界大多数国家实行的养老保险从实物经济的视角来看都是一种靠后代养老的计划，筹资模式的不同仅区别于未来老年人向年轻人索取物质产品（包括商品和劳务）的方式[②]，养老金增长的物质基础始终是下一代就业人口的增长及其劳动生产率的提高。我国当前的社会保险系统正面临“系统老龄化”（何文炯，2018）[③]，因此亟须开展前瞻性的制度设计研究，以保证我国社会保障体系在深度老龄化的过程中长期持续平衡。毫无疑问，投资人力资本和推动产业升级应成为我国老龄化应对中最重要的制度安排之一，即所谓“以质量换数量”的发展战略。为实现这些目标并为制度创新及变迁提供条件，政府（特别是地方政府）应将已收获的“人口红利”更多地投资于教育、卫生和福利等直接关乎未来人口劳动生产率的部门，并推动建立真正意义上的终身教育（学习）体系，将教育和学习贯穿于各个年龄阶段的群体及个体生命周期的各个阶段，使劳动力始终保持与社会经济发展相适应的知识和技能水平，以真正落实“积极老龄化”的战略目标。近期来看的话，一方面需要首先改革现有教育体系，加快落实工程技术和职业类大学的转型，并将相关院校的专业设置和教学内容与未来老龄社会的产业和职业需求相关联；另一方面，还应通过公共政策鼓励和推动 50～59 岁的“围老年期”和 60～69 岁的“低龄期”老年人口更多参与到生产性的经济社会活动之中，并对整个劳动力市场进行必要的结构优化，以进一步充分享受人口红利的后续效益。

9.2.5　正视就业模式多元化现象，并加快老年人力资本有效开发

在当今社会的经济活动中，出现了许多传统就业概念所无法涵盖的就业形式，现有的统计方法及统计口径已无法准确反映当前社会的真实就业形态，就业模式多元化的现象将长期存在。尽管这会给政府管理带来困难，但也是中国社会欣欣向荣的突出表现，是在新的经济常态和新的人口发展态势下所呈现的一种新的劳动就业动态。随着物联网、大数据、高速铁路、人工智能、机器人等技术的发展，以及网络经济与共享经济等经济形态的创新，传统经济活动、经济组织及就业模式将经历巨大冲击，并可能在未来的 20～30 年重组现有劳动就业市场，这为中老年劳动力的“再就业”和老年产业的发展提供了巨大的发展机遇。事实上，目前与老龄化相关的产业要素已经初见端倪，如老年金融、

① 美国、日本和欧洲国家的劳动力收入峰值年龄在 45～50 岁。

② 在现收现付制下，老年人口通过政府的征税权向年轻人口索取物质产品，其索取权表现为政府以隐性债务形式对老年人口的承诺；在基金积累制下，老年人口则通过其在工作期间进行养老储蓄所积累的货币权利来索取物质产品，其索取权表现为显性的个人账户所提供的货币权利。

③ 即在社会保险参保人群中，待遇享受人群相对增加、缴费人群相对减少的现象。

老年照料及护理智能化等领域正在创造出大量全新的职业及岗位，有些工作甚至并不属于传统就业概念，而是以今天看来仍“非常规”的形式存续，现有的统计方法及统计口径已无法准确反映当前社会的真实就业形态。未来的“就业”与“失业”概念在很大程度上可能仅存其社会福利含义，而无关收入。在这样的背景下，公共政策应依据“积极老龄化”行动框架，统筹政府、市场和社会的作用，创造有利的制度和政策环境，积极推动老年产业快速发展，在此过程中为数量巨大的中老年劳动力提供适合老年人体力和脑力特征、能利用老年人所拥有的人力和社会资本的就业岗位，并避免卷入同年轻劳动力的竞争。鼓励老年人口推迟退休，或在退休以后能够继续通过灵活就业和志愿者服务等方式最大限度地参与社会经济的发展。

需要特别说明的是，当前我国 50～59 岁的“围老年期”和 60～69 岁的“低龄期”老年人口群体具有规模大且持续增加、健康水平和受教育水平相对较高等特点。束缚老年人力资本潜能发挥的主要障碍来自具体的制度及政策安排，以及传统观念、技能培训等因素的制约。提升人力资本含量的传统套路及措施在开发老年人力资源方面可能力有不逮，因而须根据我国低龄老年人口的具体特征和诉求予以动态调适。有鉴于此，除了应有效转变老年人意识和社会观念之外，可考虑如下具体的政策落脚点。①消除老年人就业的制度性障碍，并推动弹性退休制度夯实。在改革退休制度的同时完善企事业单位的返聘制度，加快出台“老年人就业保障条例”等法律法规，并针对低龄老年人群体的现实诉求逐步推进弹性退休制度。②建立老年人口的终身教育和“人才蓄水池”机制。政府应引导整个社会形成终身教育观，从政策层面鼓励“围老年期”人口和低龄老年人口接受再教育，提高其与现代经济社会和科学技术发展的适配性，并通过建立老年人才储备机制形成“池塘效应”，以随时对接产业与职业发展需求。③强调老年人的社会参与，重新评估家庭事务的社会经济价值。在当今的大量中国家庭中，如果没有老年人放弃闲暇而参与孙子女抚育和家务劳动，不仅难以充分释放年轻一代的生产力，更使未来劳动力在年幼时欠缺呵护，老年人仅此所创造的经济社会价值尚未在国民经济统计中得到反映，其间接效益便绝难估量，政府理应加强对其引导并有效支持。

9.2.6　强调“医养康护结合”，优先并重点解决失能、失智老年人长期照护

从中长期来看，人口老龄化造成的最大压力不是老年人的生活费用，而是

医疗费用[①]。自 2015 年底[②]以来，“医养结合”和“医养融合”的话题日趋升温。然而对于老年人口中的绝大部分而言，最为迫切需要的并不是以诊断、治疗和手术为主的医疗服务，而是日常生活照料和非治疗性康复护理（如延缓慢性病发展或维持生理机能等），即长期照护服务。尤其当前我国老年人口的年龄结构仍非常年轻[③]，20 世纪 50 年代“婴儿潮”期间出生人口进入高龄（80+岁）阶段还有 10 年左右，这是完善我国养老服务体系的重要窗口期。在此期间，国家应在“健康中国”的大战略中着重发展老年长期照护服务，强调“医养康护结合”，并将其定位于社会服务而非医疗服务。西方发达国家的大量实践已表明，通过社会服务和医疗服务的不同途径提供同样的公共服务内容，前者费用平均比后者降低 30%左右。具体而言，当前可考虑以下切入点：①在相关教育体系和职业设置中重视护理人才储备和培养，转变传统机构“重医疗、轻护理”的倾向，推动“注册护士”[④]等制度发展并以其作为养老机构的专业核心；②避免形式主义地要求养老机构配置全职医生和医疗设施，可因地制宜地推行如与邻近的对口医院签订合作协议，以利用其优质医疗资源并预设紧急抢救的绿色通道等；③尽早全面推行长期照护保险和老年人意外伤害险；④鼓励并大力支持轻资产型的老年服务运营商。

还需要指出的是，我国目前养老制度安排的一个误区是过于追求面面俱到，但缺乏重点突破。本章认为当前长期照护服务的重点对象应首先聚焦于失能、失智老人，尤其是中重度失能、失智老人[⑤]。老年人失能、失智状态的出现和中重度失能、失智老人的生存期都有较稳定的规律，且老年人在生命最后阶段的生活需求相对稳定和有限，这都为提高政策命中率和有效性奠定了基础。政府应考虑以下切入点。①着力推动机构、社区和家庭等多元化服务主体参与长期照护体系的运作，根据老年人失能、失智水平设计不同的照护模式与之对应，如由家庭和社区承担大部分轻微失能、失智和部分失能老人的照护，而通过机构养老重点解决完全失能老人的照护问题。②我国养老机构的床位数从 2010 年的 315 万张急速增长到了 2014 年的 551 万张，但空床率却从 23%

① 2009～2014 年退休的医保参保人数从 5527 万增至 7255 万，同期的医保费用支出从 2865 亿元增至 7083 亿元，医疗总支出则从 1.6 万亿元增至 3.5 万亿元，医疗费用的增幅远大于参保人数的增幅。

② 2015 年国务院办公厅转发了国家卫生和计划生育委员会等部委联合发布的《关于推进医疗卫生与养老服务相结合的指导意见》。

③ 2010～2015 年我国 60～65 岁老年人口比例为 35%，70 岁以下低龄老年人口比例为 59%，80 岁及以上高龄老年人口比例仅 11%。

④ 按国际惯例，“注册护士”即通过专业注册获得部分处方权的护士。

⑤ 目前对于老年人失能状态的评价尚无统一标准，但一般而言都以基本生活能力为基础进行判定，如吃饭、控制大小便、在室内走动、上下床、上厕所、穿衣、洗澡等，有 1～2 项无法完成为轻度失能、3～4 项为中度失能、5 项及以上为重度失能。从实践来讲，中重度失能者大多卧床不起，需要实时看护。中度失能的经验性判断即卧床不起，重度失能则指丧失自主进食等多项基本自理能力。

升至 48%。政府应将对养老机构的补贴从“按床位补贴”（补贴供给）转变为“按人头补贴”（补贴需求），并加大对失能个体的补贴力度。③充分考虑不同类型家庭的支付能力，灵活使用补贴、税收优惠及政府直接购买服务等政策工具，将潜在需求转化为有效需求。④特别关注农村地区（尤其是中西部）的失能、失智老人照护问题，并逐步加大投资补贴力度。

9.2.7　在重构家庭政策的基础上引导并支持现代家庭建设

支持家庭应当成为我国老龄化应对中的一个特色及重点。这样做不仅能短期收效，而且有助于政策体系的可持续发展。然而遗憾的是，我国现有的家庭政策及项目存有诸多缺陷，并大体上呈现“去家庭化”与“再家庭化”相博弈的矛盾特征，不仅不能适应在家庭规模小型化、形式多样化、功能网络化等基本条件下的现代家庭建设，更不利于家庭在应对老龄化中发挥作用。前文已提及须尽快将生育政策调整与家庭政策完善协调起来，并强化家庭的人力资本积累功能，除此之外，老龄社会的家庭政策重构还可考虑以下切入点。

（1）尝试推行以家庭整体为对象的政策或项目。我国现有社会政策大多以“个人”为基本单位，即便是养老保险、医疗保险等对家庭功能进行补充的保障政策，也主要以个人就业为准入门槛，且在家庭成员之间不得转移，无法为老年人和未就业、非正规就业的家庭成员提供有效保障，因而很难有效支持家庭承担应有的养老责任。

（2）为承担养老责任的家庭提供直接援助。政府应在经济上支持承担养老责任的家庭，为其提供直接援助或优惠。对有养老需求的中低收入特别是低收入家庭给予直接的资助，将是中国巩固脱贫成果的重要内容，也是在新型城镇化过程中平衡新农村发展的一个重要方面。第一代独生子女已经到了兼具养老和育儿需求的阶段，政府理应为这一群体提供支持，同时还可消除更多的伦理诟病。

（3）扶持家庭服务业，并将其与社区建设、社会组织培育紧密结合。当代中国家庭的很多功能必须依赖其亲属网络才能完成。大量调查已表明，目前儿童照护服务和老年居家陪护服务等均供需失衡，尤其是多数城市青年夫妇都不得不依靠老年父母帮带孩子，这不仅凸显家庭服务缺位，还极大制约了老年人力资本的有效开发，甚至在一定程度上导致了推行“延迟退休年龄”政策的困难。政府应着力扶持和规范家庭服务业，论证政府购买服务的可操作性，研究家庭服务业专业化和职业化发展的策略，总结各地已有实践，测试政策和项目的抗压性、宽容性、可持续性和加总效应，并由此逐步建立效果评估体系，适时推广完善。此外，政府应以社区为依托，把增强家庭功能的家庭服务作为目前社区建设的最重要切入点之一，支持引导各种社会组织将帮助不同类型家

庭行使责任作为其重要功能。

9.2.8 善用人口红利，并加强基本公共服务供给的区域均衡研究

按照经典的人口红利理论，收获人口红利的机会窗口还在中国开启着，并将一直延续至 2030 年左右才会最终关闭。尽管尚处于收获人口红利的最后窗口期，但城乡和地区间人口转变进程和经济发展水平的差异令这两类地区常常面临无法同时满足收获人口红利所需条件的困境，从而使得机会窗口开启的时间在城乡和地区间依次推移，并主要以农村年轻劳动力向城市的流动作为桥梁来兑现人口红利。基于此，本章认为为了有效促进城乡、地区收获人口红利条件的形成，政府应当在新型城镇化和户籍制度改革等基础上进一步鼓励有序的人口流动与迁移，而不应当将劳动力人口重新固化在每一地区。就具体的地区而言，利用各地老龄化程度的差异，采取相应的错位发展策略，有可能使各地区均可延长人口机会窗口的开启时期，最大限度地收获人口红利，并为未来解决农村人口负债问题积累资源[①]。

需要特别指出，传统人口红利的收获条件是充分就业和足够多的年轻劳动力，尽管我们已开始不再完全具备这些条件，但全球范围内还有很大比重的人口红利。随着中国改革的深化和发展的继续，国力正日益增强，市场体量又使其具有足够的就业机会，利用有利的国际贸易和政治经济环境，以及“一带一路”等合作倡议及相关的“走出去”战略部署，中国将在全球化的背景下收获新的人口红利。在过去的 30 多年中，发达国家借助对外直接投资等方式从我国的人口红利中获益巨大。在未来的几十年中，我们有理由认真思考如何才能从对发展中国家大量年轻人口的有效利用中获益，并同时带动当地经济发展实现双赢。目前年轻劳动力资源丰富的国家大多在非洲和拉丁美洲，与西方国家相比，中国在这些地区的长期投入已形成了相对有利的环境。在一个全球化的时代，尽管存在贸易保护主义的回潮，但全球经济日益融合，对经济利益和发展资源的争夺在一定意义上也就是各国为应对老龄社会而进行资源配置的过程。中国有必要也完全可能突破国内经济资源的限制，从全球化的高度思考我们的老龄社会应对战略。

此外，未来随着中国人口红利的逐渐衰减，人口老龄化与基本公共服务供给的区域差异将可能在不同区域的不同时期产生叠加效应，使其面临人口加速老化、基本公共服务供需矛盾突出的双重挑战。因此，有必要深入探讨人口老龄化与人口流动及城镇化互动发展的时期规律，以及区域基本公共服务供需矛

① 为有效错位解决不同地区及城乡的人口负债问题，须尽快推进社会保险统收统支式的全国统筹。以基本养老保险为例，目前各地区社会保险的系统老龄化程度不一，提高统筹层次有助于解决各地区抚养负担畸轻畸重的矛盾，缓解财政压力，并利于各地区未来劳动力成本的统一。

盾的阶段性特征，由此统筹分析与设计基本公共服务供给的区域协调与整合机制，并在综合考虑社会公平与成本效率的基础上协调众多的资源要素和政策变量[①]，进而形成操作化政策工具。这既是一种针对现有可能存在的资源错位的纠偏机制，也可以作为一种规范与引导未来基本公共服务资源有序流动的优化配置机制，从而努力把握和适应区域人口年龄结构变动及公共服务资源供给矛盾的规律与节奏，通过积极稳妥的制度安排前瞻性地应对人口老龄化挑战，促进区域均衡发展。

9.2.9　借力科技发展，推进智慧养老和老龄产业发展

以互联网/物联网、人工智能、大数据等为代表的科技革命正在极大改变我们现有的生产生活方式、产业结构、社会格局乃至政治形态，为老龄社会治理提供了新的应对资源和可能路径。充分利用这些技术红利，打造高效优质“智慧养老”服务体系，为老年人提供实时便利、互联化、智能化且低成本的养老服务，将有效提升老龄社会“老而不衰”的程度，不仅可以降低老年人自理的生理门槛，而且可以促进老年人生产方式和社会角色的转变。我国已初步形成了包括医疗健康电子产品制造、系统集成、服务运营等在内的智慧健康养老产业链，未来无疑需要更多的政策扶持。随着人工智能和机器人技术的发展，人口老龄化还将激发服务机器人需求的增长，从而有效弥补因劳动力减少而出现养老护理人才缺失与结构失衡等现象。与此同时也应注意到，科学技术的发展，尤其是人工智能和机器人技术的升级，尽管会缓解老龄社会劳动力减少的困境并有效提升生产力水平，但也会对传统就业市场产生结构性冲击，并进而影响整个社会应对老龄化的资源格局。人工智能、物联网、生命科学在改变当今和未来世界的生产和生活方式的同时，也极大地重构着我们应对老龄社会的战略格局和政策工具，对此应未雨绸缪。

此外，老年人及老龄社会发展对技术进步和服务升级的需求也将传导至产业领域，从而影响老龄社会的产业形态，并对资源禀赋和政策安排提出新的诉求。人口老龄化导致储蓄增加而加速资本积累进而形成所谓“第二次人口红利”、随着经济禀赋更好的人口梯队进入老龄阶段而刺激消费形成银发经济、因老龄产业发展而创造出新的行业与职业进而重振就业市场，这些可能性都客观存在。政府应尽快制定以新技术为支撑、适合老龄社会发展的产业规划和配

① 例如：如何合理界定中央政府与地方政府的基本公共服务事权和支出责任？将哪些资源因素纳入动态配置的范围？如何确定与区域人口老龄化相匹配的公共服务供给总量与结构，以及区域间的反哺机制？采用何种转移支付的渠道与方式？如何确定资源分配的时机与周期？不同的政策组合会对区域经济社会产生何种影响？

套政策措施，动员企业和社会力量参与老年产业开发，特别是老龄健康、养老服务、老龄制造、老龄宜居、老龄金融及文化教育等领域。需要特别指出的是，老龄产业并不特指为老年人提供产业及服务的产业形态，老年人自身也可以成为老龄社会产业格局中的开拓者和创新者，老龄产业也有可能成为未来的朝阳产业并深刻改变中国未来的消费市场格局，这将成为“不分年龄人人共建共治共享”[①]的有力注脚。

9.2.10　老龄社会治理不能离开对不平等现象的持续关注

尽管目前学界对于各类不平等现象（如收入、性别等）在老龄化背景下到底趋于恶化还是趋于弱化尚无定论，但对于这一动态议题无疑需要特别关注，并尤其重视当前的弱势儿童和性别平等问题。

在全生命周期的视角下，老龄社会的治理应致力于创造条件使所有人得到全面发展，尤其是年轻一代。现有政策仍较多关注如何通过调整生育政策鼓励年轻育龄夫妇多生，但对如何提高已出生少年儿童的健康素质和人力资本的关注则相对较少。中国现有的几千万名留守儿童、残疾儿童的生存和发展状况均堪忧，如果不能尽快改变这一状况，对我国应对人口老龄化的挑战将是一个不利因素。儿童发展并不仅仅依赖于社会经济和家庭收入的快速增长，更需要系统性的公共干预及更大的社会公平。应当始终坚持儿童优先的原则，坚持儿童成长早期干预的基本方针，以健康和教育为战略重点，以困难家庭为主要扶持对象（Zeng et al.，2017），加强政府部门、政策和资源的统筹整合。对于西部地区的残障儿童、留守和流动儿童，首要解决的是其生存问题；对于东部地区儿童，考虑更多的则是如何使其更好地发展。不同地区与不同的儿童群体，需要有不同取向的政策主题与项目设置，从而适应儿童生存和发展的实际需要。从看重生育到关注养育，逐步完成从“多生”到“善养”的过渡，从而实现政府、社会和家庭对儿童发展的全程关怀和全面保障。这在进一步调整完善我国生育政策的过程中将更为急迫和重要。

在老龄社会的应对中还需要关注女性群体的权益，社会分配的不均等往往与性别不平等问题相互交织。由于女性在生理寿命方面的优势，目前我国各地女性平均预期寿命大多较男性长 5 岁左右，高龄女性的身体状况和寡居模式又加重了老年女性对公共服务和社会支持系统的依赖，但相关的公共政策对此却

① 联合国于 1995 年针对全球社会发展问题制定了“不分年龄人人共享”的行动纲领，1999 年又将其作为“国际老年人年”的主题，它呼吁不同年龄的人与人之间和谐相处。2017 年中共十九大报告明确提出要“打造共建共治共享的社会治理格局”[（参见《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》：http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm，2017 年 10 月 27 日）]，高度重视社会治理问题。此处针对老龄社会治理将两种提法予以结合。

基本保持了所谓性别中立。有研究发现，男性在医疗与养老公共转移支付方面相对女性有绝对优势，特别是在老年（65+岁）时期，男性享受的医疗与养老转移支付远高于女性（Shen et al.，2016），这主要源于相对更多的老年男性曾在城镇正规部门就业，因而能享受相对慷慨的城镇职工医疗保险与城镇职工养老保险。不仅如此，当前老年低收入群体正在趋于以女性为主，这在农村地区尤甚，部分农村中老年低收入女性的生存状况较为恶劣，已成为地下宗教势力渗透的重要目标，这一问题亟待关注。因此，在制度和政策设计时应加强社会性别的研究，避免女性长寿的生理优势转化为老年贫困的社会劣势。值得欣喜的是，在青少年时期（尤其是在 18～22 岁年龄段），女性享受的教育转移支付已开始反超男性，这主要得益于女性高等教育入学率已超过男性。随着女性在人力资本积累方面的优势逐渐显现，劳动力市场上的性别差异有望进一步缩减，但公共政策对此仍须特别关注并予以推动，以保障未来医疗与养老转移支付的性别差异得以大幅缩减乃至消弭。

不难看出，为了达到真正的“善治”，任何治理演进和政策优化都不会一蹴而就，老龄社会的治理注定是一条蜿蜒的长路，我们的整个社会需要在不断的调整、调节、调试及重构中适应老龄化，并使老龄社会依然能继续健康发展。有鉴于此，在前述治理模式转型和公共政策应对要点的基础上，笔者认为还应进一步凝聚其共识。

首先，人口老龄化给中国社会带来挑战的同时亦蕴藏机遇。中国在应对人口老龄化上具备后发优势，与西方发达国家不同，我们是在信息化、网络化的时代背景下进入老龄社会的，尤其随着中国特色社会主义进入新时代，中国乃至全球的社会经济形态和结构已和西方发达国家进入老龄社会的时代截然不同，这一方面为中国积极应对老龄化提供了空前的契机与资源，另一方面也使传统制度和政策操作的空间越来越小，必须深化改革不断创新，而这些改革与创新亦将进一步挖掘和利用老龄社会的潜在机遇。

其次，中国人口老龄化的治理模式须基于中国思考形成中国方案。中国的老龄化有其独特的社会、经济和文化背景，发展进程也有别于其他国家的经验。治理模式应立足于中国社会、经济和环境的现实，在全球化、市场化、信息化、新型城镇化的时代背景下，按照推进国家治理体系和治理能力现代化的要求，基于中国思考提出适合中国实践的社会改革和制度重构方案，并逐步将中国特征转化为中国优势。

再次，中国当前老龄社会治理需要新理念、新文化和新制度，并始终将整体性和可持续性作为其治理格局的核心。老龄化的问题不等于老年人的问题，甚至老龄化本身亦并不构成所谓的“问题”，只是现有社会结构和制度安排对人口年龄结构的变化仍缺乏必要的反应、适应和调整。传统建立在年

轻人口占绝对主体基础之上的社会治理模式和制度安排架构都需要根据老龄化的发展态势做出相应调整及重构。每一个个体、家庭、社区、组织，乃至整个市场、社会和政府都必须在适应这种人口学变化的前提下更新或改变原有的生产生活方式、资源配置方式和制度安排结构，原有治理理念和治理模式涉及重新选择，传统文化和制度安排亦需要升级。但考虑到当前的现实情境，应将整体性和可持续性作为其治理格局转型的切入点和落脚点。可持续性已毋庸赘述，而整体性则有三层含义：一指治理主导者——政府自身的政策整合和机构联动机制，二指政府、市场、社会、家庭等不同主体的多元共治格局，三指不同群体和不同世代的共同参与，三者相辅相成，互构而共生。

最后，正如本书所不断强调的，作为一种全新且难以逆转的人口和社会形态，人口老龄化已成为新的基本国情。历史一次次地证明，机遇往往与挑战共存。中国人口老龄化演进的过程与实现中国社会主义现代化强国的进程在时间上基本同步，中国梦的实现将以老龄化为时代背景之一，随着其间全球社会经济形势的快速变化和现代科学技术的迅猛发展，中国的政治体制、经济体量、人口规模、区域差异、文化传统、家庭伦理等基本国情为我们应对人口老龄化提供了丰沛的资源禀赋和多元化的治理路径。笔者坚信，未来的中国老龄社会必将是一个“不分年龄人人共建共治共享”的社会，只有在这样的社会治理格局下才能真正化解“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”[①]。

① 《习近平：决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告》：http://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm，2017 年 10 月 27 日。

参 考 文 献

安建民, 丁晓沧, 许汉年. 1997. 英国卫生资源配置方法进展和评价. 国外医学(社会医学分册), (3): 107-109.

白晨, 顾昕. 2018. 中国基本养老服务能力建设的横向不平等——多维福祉测量的视角. 社会科学研究, (2): 105-113.

比尔基埃 A, 克拉比什-朱伯尔 C, 雪伽兰 M, 等. 1998. 家庭史 第一卷: 遥远的世界, 古老的世界. 袁树仁, 姚静, 肖桂, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.

波齐 G. 2007. 国家:本质、发展与前景. 陈尧, 译. 上海: 上海人民出版社.

布热津斯基 Z. 1995. 大失控与大混乱. 潘嘉玢, 刘瑞祥, 译. 北京: 中国社会科学出版社.

蔡昉, 孟昕. 2004. 人口转变、体制转轨与养老保障模式的可持续性. 比较, (10): 68-79.

蔡昉, 王美艳. 2006. “未富先老”对经济增长可持续性的挑战. 宏观经济研究, (6): 6-10, 51.

长春市人力资源和社会保障局办公室. 2015. 关于印发《长春市失能人员医疗照护保险实施办法(试行)》的通知(长人社〔2015〕21号). http://12351.ccgh.org.cn/template/10002/file.jsp?aid=311[2017-10-01].

陈皆明. 1998. 投资与赡养——关于城市居民代际交换的因果分析. 中国社会科学, (6): 131-145.

陈俊华, 黄叶青, 许睿谦. 2015. 中国老龄产业市场规模预测研究. 中国人口科学, (5): 67-80, 127.

陈丽, 姚岚, 舒展. 2012. 中国基本公共卫生服务均等化现状、问题及对策. 中国公共卫生, 28(2): 206-209.

陈淑芬. 2006. 家庭功能分析的理论体系简介——家庭功能分析的相关概念. 中国全科医学, (2): 167-169.

陈卫. 2006. 中国未来人口发展趋势: 2005～2050年. 人口研究, (4): 93-95.

陈卫民. 2012. 我国家庭政策的发展路径与目标选择. 人口研究, (4): 29-36.

陈英姿, 满海霞. 2013. 中国养老公共服务供给研究. 人口学刊, 35(1): 22-26.

陈映芳. 2010. 国家与家庭、个人——城市中国的家庭制度(1940—1979). 交大法学, (1): 145-168.

陈友华. 2012. 关于人口老龄化几点认识的反思. 国际经济评论, (6): 7, 110-123.

陈振明, 薛澜. 2007. 中国公共管理理论研究的重点领域和主题. 中国社会科学, (3): 140-152, 206.

崔惠玉, 孙靖. 2010. 公共服务均等化: 国际经验与借鉴. 地方财政研究, (2): 70-74.

戴利 H E, 汤森 K N. 2001. 珍惜地球: 经济学、生态学、伦理学. 马杰, 钟斌, 朱又红, 译. 北京: 商务印书馆.

党俊武. 2018. 老龄蓝皮书: 中国城乡老年人生活状况调查报告(2018). 北京: 社会科学文献出版社.

丁志宏, 王莉莉. 2011. 我国社区居家养老服务均等化研究. 人口学刊, (5): 83-88.
董志强. 2013. 老龄化背景下中国经济增长及收入分配格局. 探索与争鸣, (1): 71-76.
杜鹏. 1994. 中国人口老龄化过程研究. 北京: 中国人民大学出版社.
杜鹏, 董亭月. 2015. 促进健康老龄化: 理念变革与政策创新——对世界卫生组织《关于老龄化与健康的全球报告》的解读. 老龄科学研究, (12): 3-10.
杜鹏, 孙鹃娟, 张文娟, 等. 2016. 中国老年人的养老需求及家庭和社会养老资源现状——基于 2014 年中国老年社会追踪调查的分析. 人口研究, (6): 49-61.
杜鹏, 武超. 2006. 1994～2004 年中国老年人主要生活来源的变化. 人口研究杂志, (2): 20-24.
杜鹏, 翟振武, 陈卫. 2005. 中国人口老龄化百年发展趋势. 人口研究杂志, (6): 90-93.
费孝通. 1998. 乡土中国 · 生育制度. 北京: 北京大学出版社.
封婷, 郑真真. 2015. 老年人养老负担和家庭承载力指数研究. 人口研究, (1): 50-62.
弗里德曼 T. 2006. 世界是平的. 何帆, 肖莹莹, 郝正非, 译. 长沙: 湖南科学技术出版社.
高萍. 2013. 区域基本公共教育均等化现状、成因及对策——基于全国各省(市、自治区)面板数据的分析. 宏观经济研究, (6): 91-97.
高萍. 2015. 区域基本医疗卫生服务均等化现状、成因及对策——基于全国各省面板数据的分析. 宏观经济研究, (4): 90-97, 152.
龚向光, 胡善联. 2005. 卫生资源配置的公平性分析. 中华医院管理杂志, 21(2): 73-77.
古德 W J. 1986. 家庭. 魏章玲, 译. 北京: 社会科学文献出版社.
郭德君. 2018. 传统孝道与代际伦理: 老龄化进程中的审视. 北京: 中国社会科学出版社.
郭秀云. 2009. 借鉴欧盟流动劳动力社保与福利体系设计的经验. 中国人力资源开发, (10): 81-83, 99.
郭秀云. 2019. 上海老年人口失能水平与平均照料时间研究——基于多个数据来源的考察. 南方人口, 34(3): 1-12.
郭秀云, 邵明波. 2019. 养老保险基金中央调剂制度的省际再分配效应研究. 江西财经大学学报, (3): 73-84.
郭震威, 齐险峰. 2013. 人口老龄化另一种测量指标. 人口研究, (3): 51-55.
郭志刚. 1995. 当代中国人口发展与家庭户的变迁. 北京: 中国人民大学出版社.
郭志刚. 2008. 关于中国家庭户变化的探讨与分析. 中国人口科学, (3): 2-10,95.
郭志刚. 2011. 六普结果表明以往人口估计和预测严重失误. 中国人口科学, (6): 2-13, 111.
郭志刚. 2012. 重新认识中国的人口形势. 国际经济评论, (1): 6, 96-111.
国家人口发展战略研究课题组. 2007. 国家人口发展战略研究总报告. 北京: 中国人口出版社.
国家统计局. 2001. 第五次全国人口普查公报(第 1 号). http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/rkpcgb/qgrkpcgb/200203/t20020331_30314.html[2001-05-15].
国家统计局. 2018. 2018 年国民经济和社会发展统计公报. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201902/t20190228_1651265.html[2019-02-28].
国家统计局人口和就业统计司. 2009. 中国人口和就业统计年鉴 2009. 北京: 中国统计出版社.
国家应对人口老龄化战略研究总课题组. 2014. 国家应对人口老龄化战略研究总报告. 北京: 华龄出版社.

海德格尔 M. 1999. 存在与时间. 陈嘉映, 王庆节, 译. 北京: 生活·读书·新知三联书店.
何纪周. 2004. 我国老年人消费需求和老年消费品市场研究. 人口学刊, (3): 49-52.
何文炯. 2018. 社会保险的系统老龄化. “民生-治理”高峰论坛.
赫拉利 Y. 2018. 今日简史: 人类命运大议题. 林俊宏, 译. 北京: 中信出版社.
亨廷顿 S P. 2017. 文明的冲突. 周琪, 刘绯, 张立平, 等译. 北京: 新华出版社.
胡鞍钢, 王洪川. 2016. 为人民创造健康红利. http://epaper.gmw.cn/gmrb/html/2016-10/26/nw.D110000gmrb_20161026_4-01.htm?div=-1[2016-10-26].
胡宏伟, 李延宇, 张澜. 2015. 中国老年长期护理服务需求评估与预测. 中国人口科学, (3): 79-89, 127.
胡湛, 彭希哲. 2012. 家庭变迁背景下的中国家庭政策. 人口研究, (2): 3-10.
胡湛, 彭希哲. 2014. 中国当代家庭户变动的趋势分析——基于人口普查数据的考察. 社会学研究, (3): 145-166, 244.
胡湛, 彭希哲. 2018. 应对中国人口老龄化的治理选择. 中国社会科学, (12): 134-155, 202.
贾显维. 2014. 人口老龄化背景下陕西省城乡养老服务均等化研究. 智富时代, (12): 95.
姜玉, 刘鸿雁, 庄亚儿. 2016. 东北地区流动人口特征研究. 人口学刊, (6): 37-45.
靳诺, 等. 2017. 全球治理的中国担当. 北京: 中国人民大学出版社.
景跃军, 李涵, 李元. 2017. 我国失能老人数量及其结构的定量预测分析. 人口学刊, (6): 81-89.
敬乂嘉. 2009. 合作治理: 再造公共服务的逻辑. 天津: 天津人民出版社.
敬乂嘉. 2014. 从购买服务到合作治理: 政社合作的形态与发展. 中国行政管理, (7): 54-59.
敬乂嘉, 陈若静. 2009. 从协作角度看我国居家养老服务体系的发展与管理创新. 复旦学报(社会科学版), (5): 133-140.
寇明风. 2017. 养老保险全国统筹: 社保与财税体制改革的重要抓手. 地方财政研究, (11): 1.
李强. 2014. 怎样理解“创新社会治理体制”. 毛泽东邓小平理论研究, (7): 43-48, 91-92.
李晓阳, 林恬竹, 张琦. 2015. 人口流动与经济增长互动研究——来自重庆市的证据. 中国人口科学, (6): 46-55, 127.
厉以宁. 2018. 中国道路与人口老龄化. 北京: 商务印书馆.
廉超, 刘慧, 林春逸. 2018. 以人民为中心的中国城乡居民养老服务均等化研究. 改革与战略, (8): 13-19.
梁治平. 1997. 寻求自然秩序中的和谐. 北京: 中国政法大学出版社.
林卡, 吕浩然. 2016. 四种老龄化理念及其政策蕴意. 浙江大学学报(人文社会科学版), (4): 136-143.
林艳, 党俊武, 裴晓梅, 等. 2009. 为什么要在中国构建长期照护服务体系?. 人口与发展, 15(4): 52-64.
刘大帅, 甘行琼. 2013. 公共服务均等化的转移支付模式选择——基于人口流动的视角. 中南财经政法大学学报, (4): 13-20, 158.
刘骥. 2008. 阶级分化与代际分裂: 欧洲福利国家养老金政治的比较分析. 北京: 北京大学出版社.
刘骥. 2009. 找到微观基础——公共选择理论的中国困境. 开放时代, (1): 100-119.
刘军. 2012. 国内家庭功能研究述评. 社科纵横(新理论版), (3): 139-141, 157.
刘细良, 刘迪扬. 2011. 我国区域基本公共服务均等化实证研究. 统计与决策, (5): 96-98.

刘晓静, 张楠. 2013. 城乡统筹视角下中国养老服务体系构建. 河北大学学报(哲学社会科学版), 38(3): 111-115.
刘晓梅. 2012. 我国社会养老服务面临的形势及路径选择. 人口研究, (5): 104-112.
罗素 B. 1982. 我的哲学的发展. 温锡增, 译. 北京: 商务印书馆.
吕思勉. 2007. 中国社会史. 上海: 上海古籍出版社.
吕炜, 管永昊. 2008. 公共财政构建中的路径依赖与体制创新. 财经科学, (4): 68-76.
吕炜, 王伟同. 2008. 我国基本公共服务提供均等化问题研究——基于公共需求与政府能力视角的分析. 财政研究, (5): 10-18.
马春华. 2013. 欧美和东亚家庭政策: 回顾与评述//唐灿, 张建. 家庭问题与政府责任: 促进家庭发展的国内外比较研究. 北京: 社会科学文献出版社: 49.
马春华, 石金群, 李银河, 等. 2011. 中国城市家庭变迁的趋势和最新发现. 社会学研究, (2): 182-216, 246.
马忠东, 吕智浩, 叶孔嘉. 2010. 劳动参与率与劳动力增长: 1982～2050 年. 中国人口科学, (1): 11-27, 111.
麦克伊涅斯 J, 斯皮伊克 J. 2014. 公共政策怎么应对老龄化?. 中国经济报告, (2): 75-76.
梅陈玉婵, 莫罗-豪厄尔 N, 杜鹏. 2012. 老有所为在全球的发展: 实证、实践与实策. 北京: 北京大学出版社.
孟宪范. 2013. 家庭: 百年来的第三次冲击及我们的选择. 小康, (10): 45-47.
莫龙. 2011. 中国的人口老龄化经济压力及其调控. 人口研究, 35(6): 27-42.
莫斯 M. 2002. 礼物. 汲喆, 译. 上海: 上海人民出版社.
穆怀中. 2001. 老年社会保障负担系数研究. 人口研究, (4): 19-23.
南通市人力资源和社会保障局. 2016. 关于印发《南通市基本照护保险实施细则》的通知. http://nt.bendibao.com/live/201719/39593.shtm[2017-01-09].
倪红福, 李善同, 何建武. 2014. 人口结构变化对消费结构及储蓄率的影响分析. 人口与发展, 20(5): 25-34.
帕斯卡尔 B. 1985. 思想录. 何兆武, 译. 北京: 商务印书馆.
潘允康, 林南. 1987. 中国城市现代家庭模式. 社会学研究, (3): 54-67.
潘允康, 阮丹青. 1995. 中国城市家庭网. 浙江学刊, (3): 66-71.
彭希哲. 2014. 2013 年长三角地区社会变迁调查(FYRST)报告. 内部资料.
彭希哲. 2018. 改革开放 40 年 | 彭希哲:人口模式变化下的中国老龄化. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_2131375[2019-12-19].
彭希哲, 郭德君. 2016. 孝伦理重构与老龄化的应对. 国家行政学院学报, (5): 35-41, 142.
彭希哲, 郭德君. 2018. 老龄化应对与当代社会基础性孝伦理体系的构建——基于传统“二十四孝”的批判性分析. 探索, (2): 159-165.
彭希哲, 胡湛. 2011. 公共政策视角下的中国人口老龄化. 中国社会科学, (3): 121-138, 222-223.
彭希哲, 胡湛. 2015. 当代中国家庭变迁与家庭政策重构. 中国社会科学, (12): 113-132, 207.
彭希哲, 卢敏. 2017. 老年人口死亡概率时代变迁与老年定义的重新思考. 人口与经济, (2): 1-10.
彭希哲, 王伟. 2019. 中国认知障碍老人照护支持面临的风险及政策应对. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 40(12): 40-47.

彭希哲, 邬民乐. 2009. 养老保险体系可持续性与劳动生产率增长. 人口与经济, (2): 92-96.
普雷斯顿 S, 霍伊维兰 P, 吉略特 M. 2012. 人口统计学: 人口过程的测量与建模. 郑真真, 等译. 北京: 社会科学文献出版社.
齐明珠. 2010. 我国 2010～2050 年劳动力供给与需求预测. 人口研究, 34(5): 76-87.
青岛市人力资源和社会保障局. 2016. 关于长期医疗护理保险医疗护理服务实行标准化管理的通知(青人社办字〔2016〕81 号). http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n24626255/n24626269/n24626283/160617105920833558.html[2017-10-01].
青岛市医疗保障局. 2019. 《关于长期护理保险“失智专区”协议管理有关问题的通知》政策解读. http://www.qingdao.gov.cn/n172/n24624151/n31284614/n31284615/n31284623/190403173733418461.html[2019-04-03].
《人口研究》编辑部. 1998. 百年回眸: 马尔萨斯人口论的再评价. 人口研究, (1): 24-34.
森 A. 2002. 以自由看待发展. 任赜, 于真, 译. 北京: 中国人民大学出版社.
沈奕斐. 2013. 个体家庭 iFamily: 中国城市现代化进程中的个体、家庭与国家. 上海: 上海三联书店.
沈毅. 2016. 养老保险制度城乡统筹影响因素及发展对策——以辽宁为例. 地方财政研究, (11): 40-47.
石智雷, 杨云彦. 2014. 符合“单独二孩”政策家庭的生育意愿与生育行为. 人口研究, (5): 27-40.
世界银行. 2019. 2019 世界发展报告——工作性质的变革. https://www.shihang.org/zh/publication/wdr2019[2019-12-02].
孙常敏. 2010. 完善和创新我国家庭政策, 统筹解决人口问题. 社会学, (1): 170-181.
唐灿. 2010. 家庭现代化理论及其发展的回顾与评述. 社会学研究, (3): 199-222, 246.
唐灿, 陈午晴. 2012. 中国城市家庭的亲属关系: 基于五城市家庭结构与家庭关系调查. 江苏社会科学, (2): 92-103.
唐灿, 张建. 2013. 家庭问题与政府责任: 促进家庭发展的国内外比较研究. 北京: 社会科学文献出版社.
陶涛, 杨凡, 张浣珺, 等. 2014. 家庭幸福发展指数构建研究. 人口研究, (1): 63-76.
田雪原. 2013. 人口老龄化与“中等收入陷阱”. 北京: 社会科学文献出版社.
田雪原, 王金营, 周广庆. 2006. 老龄化: 从“人口盈利”到“人口亏损”. 北京: 中国经济出版社.
涂爱仙, 魏品. 2015. 海南省养老服务社会化的困境与出路. 特区经济, (8): 93-96.
王涤. 1999. 老年人消费特征与“银发市场”开发. 市场与人口分析, (5): 24-26.
王丰, 李中清. 2002. 摘掉人口决定论的光环——兼谈历史人口研究的思路与方法. 历史研究, (1): 55-61.
王建丰. 2012. 区域间基本公共服务均等化的内涵、特征及目标模式选择. 内蒙古大学学报(哲学社会科学版), 44(4): 71-75.
王金营, 付秀彬. 2006. 考虑人口年龄结构变动的中国消费函数计量分析——兼论中国人口老龄化对消费的影响. 人口研究, (1): 29-36.
王克祥, 于凌云. 2016. 关于渐进式延迟退休年龄政策的研究综述. 人口与经济, (1): 57-65.
王思斌. 1987. 经济体制改革对农村社会关系的影响. 北京大学学报(哲学社会科学版), (3): 26-34.

王天夫, 王飞, 唐有财, 等. 2015. 土地集体化与农村传统大家庭的结构转型. 中国社会科学, (2): 41-60, 203.
王跃生. 2000. 十八世纪中后期的中国家庭结构. 中国社会科学, (2): 167-177, 209.
王跃生. 2006. 当代中国家庭结构变动分析. 中国社会科学, (1): 96-108, 207.
王跃生. 2007. 中国农村家庭的核心化分析. 中国人口科学, (5): 36-48, 95.
王跃生. 2010. 个体家庭、网络家庭和亲属圈家庭分析——历史与现实相结合的视角. 开放时代, (4): 83-99.
王跃生. 2014. 中国城乡老年人居住的家庭类型研究——基于第六次人口普查数据的分析. 中国人口科学, (1): 20-32,126.
邬沧萍, 王萍. 2009. 积极应对人口老龄化. 求是, (7): 55-57.
吴帆. 2008. 认知、态度和社会环境: 老年歧视的多维解构. 人口研究, (4): 57-65.
吴帆, 李建民. 2010. 中国人口老龄化和社会转型背景下的社会代际关系. 学海, (1): 35-41.
吴帆, 李建民. 2012. 家庭发展能力建设的政策路径分析. 人口研究, (4): 37-44.
吴淑琼, 庄坤洋. 2001. 在地老化: 台湾二十一世纪长期照护的政策方向. 台湾公共卫生杂志, 20(3): 192-201.
吴旭东, 李静怡. 2010. 改善我国公共服务不均等状况的财政政策着力点探讨. 现代财经(天津财经大学学报), (2): 10-15.
吴玉韶. 2018. 上海论坛观点集萃: 老龄化是社会发展的巨大机遇. https://finance.sina.cn/2018-05-31/detail-ihcikcev5092685.d.html[2019-01-21].
吴玉韶, 党俊武, 刘芳, 等. 2014. 老龄蓝皮书: 中国老龄产业发展报告(2014). 北京: 社会科学文献出版社.
肖群忠. 2001. 孝与中国文化. 北京: 人民出版社.
谢立中, 孙立平. 2002. 二十世纪西方现代化理论文选. 上海: 上海三联书店.
熊才平, 杨文正, 张文超. 2013. 技术支持下的基础教育信息资源公共服务均等化. 教育研究, (11): 107-113.
徐安琪. 1995. 城市家庭社会网络的现状和变迁. 上海社会科学院学术季刊, (2): 77-85.
徐会奇, 齐齐, 李辉. 2014. 我国城乡居民消费行为研究中的分歧及原因——基于文献综述. 南京审计学院学报, 11(1): 46-53.
徐勇. 2013. 中国家户制传统与农村发展道路: 以俄国、印度的村社传统为参照. 中国社会科学, (8): 102-123, 206-207.
徐月宾, 张秀兰. 2005. 中国政府在社会福利中的角色重建. 中国社会科学, (5): 80-92, 206.
燕继荣. 2017. 社会变迁与社会治理——社会治理的理论解释. 管理学研究, (6): 2, 69-77.
晏月平, 赵冉冉. 2013. 中国老年人口经济性保障来源的东西部比较——基于全国第六次人口普查资料的分析. 社会保障研究, (5): 36-45.
杨笛. 2011. 聚焦中国家庭变迁, 探讨支持家庭的公共政策: “中国家庭变迁和公共政策国际研讨会”述评. 妇女研究论丛, (6): 89-94, 104.
杨善华, 侯红蕊. 1999. 血缘、姻缘、亲情与利益: 现阶段中国农村社会中“差序格局”的“理性化”趋势. 宁夏社会科学, (6): 51-58.
杨晓奇. 2013. 基于人口老龄化视角下的产业结构调整. 老龄科学研究, 1(5): 30-36.
杨雪冬, 王浩. 2015. 全球治理. 北京: 中央编译出版社.
姚远. 1998. 对中国家庭养老弱化的文化诠释. 人口研究, (5): 48-50.

姚远. 1999. 老年人社会价值与中国传统社会关系的文化思考. 人口研究, (5): 44-50.
易莹莹. 2015. 人口流动对重庆人口老龄化的影响——基于重庆市“六普”数据. 人口与社会, 31(3): 34-42.
俞金尧. 1996. 马尔萨斯人口理论的社会文化基础. 历史研究, (6): 115-129.
俞可平. 2002. 全球治理引论. 马克思主义与现实, (1): 20-32.
虞晓芬, 傅玳. 2004. 多指标综合评价方法综述. 统计与决策, (11): 119-121.
郁建兴, 关爽. 2014. 从社会管控到社会治理——当代中国国家与社会关系的新进展. 探索与争鸣, (12): 7-16.
曾毅. 1987. 关于生育率下降如何影响我国家庭结构变动的探讨. 北京大学学报(哲学社会科学版), (4): 73-86.
翟秋阳, 崔光胜. 2015. 我国城乡基本公共服务均等化研究——基于东、中、西部若干省市的比较分析. 求实, (7): 49-56.
翟振武, 陈佳鞠, 李龙. 2017. 2015～2100 年中国人口与老龄化变动趋势. 人口研究, (4): 60-71.
翟振武, 李龙. 2014. 老年标准和定义的再探讨. 人口研究, (6): 57-63.
张斌, 李军. 2013. 人口老龄化对产业结构影响效应的数理分析. 老龄科学研究, 1(6): 3-13.
张国刚. 2007. 中国家庭史. 广州: 广东人民出版社.
张岭泉, 邬沧萍, 段世江. 2008. 解读农村老年人的“零消费”现象. 甘肃社会科学, (1): 211-214.
张文娟, 杜鹏. 2009. 中国老年人健康预期寿命变化的地区差异: 扩张还是压缩?. 人口研究, (5): 68-76.
张文娟, 魏蒙. 2015a. 中国老年人的失能水平到底有多高？——多个数据来源的比较. 人口研究, (3): 34-47.
张文娟, 魏蒙. 2015b. 中国老年人的失能水平和时间估计——基于合并数据的分析. 人口研究, (5): 3-14.
张秀兰, 徐月宾. 2003. 建构中国的发展型家庭政策. 中国社会科学, (6): 84-96, 206-207.
张秀兰, 徐月宾, 梅志里. 2007. 中国发展型社会政策论纲. 北京: 中国劳动社会保障出版社.
张彦琦, 唐贵立, 王文昌, 等. 2008. 基尼系数和泰尔指数在卫生资源配置公平性研究中的应用. 中国卫生统计, 25(3): 243-246.
张艳荣, 马冬梅. 2018. 健康中国背景下医养结合服务运行效果评价研究——基于银川市的调查. 老龄科学研究, 6(3): 47-61.
赵东霞, 李赖志. 2013. 独生子女时代我国养老产业发展的 SWOT 分析. 财经问题研究, (1): 30-34.
郑秉文. 2009. 中国社会保障制度 60 年: 成就与教训. 中国人口科学, (5): 2-18, 111.
中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 2009. 马克思恩格斯文集. 第十卷. 北京: 人民出版社.
中国老龄问题全国委员会办公室. 2002. 联合国老龄问题资料汇编. 内部资料.
中国社会科学院社会学研究所. 2007. 社会蓝皮书. 北京: 中国社会科学文献出版社.
中国现代化战略研究课题组, 中国科学院中国现代化研究中心. 2003. 中国现代化报告 2003: 现代化理论、进程与展望. 北京: 北京大学出版社.
中华人民共和国国家统计局. 2009. 中国统计年鉴 2009. 北京: 中国统计出版社.

周福林. 2014. 我国家庭结构变迁的社会影响与政策建议. 中州学刊, (9): 83-86.
周晓虹. 2008. 冲突与认同: 全球化背景下的代际关系. 社会, (2): 20-38, 220-221.
朱铭来, 贾清显. 2009. 我国老年长期护理需求测算及保障模式选择. 中国卫生政策研究, (7): 32-38.
朱勤. 2014. 城镇化对中国城乡人口老龄化影响的量化分析. 中国人口科学, (5): 24-35, 126.
朱勤, 魏涛远. 2017. 老龄化背景下中国劳动供给变动及其经济影响: 基于 CGE 模型的分析. 人口研究, 41(4): 8-21.
竺乾威. 2008. 从新公共管理到整体性治理. 中国行政管理, (10): 52-58.
沈潔, 澤田ゆかり. 2016. ポスト改革期の中国社会保障はどうなるのか. 京都: ミネルヴァ書房.
Ando A, Modigliani F. 1963. The "life cycle" hypothesis of saving: aggregate implications and tests. The American Economic Review, 53 (1): 55-84.
Autor D. 2015. Why are there still so many jobs? The history and the future of workplace automation. Journal of Economic Perspectives, 29(3): 3-30.
Bergvall D, Charbit C, Kraan D J, et al. 2006. Intergovernmental transfers and decentralised public spending. OECD Journal on Budgeting, 5(4): 111-158.
Bix A. 2000. Inventing Ourselves Out of Jobs? America's Debate over Technological Unemployment 1929-1981. Baltimore: Johns Hopkins University Press: 1-8.
Boadway R, Flatters F, Norrie K H, et al. 1982. Financing confederation: rejoinders. Canadian Public Policy, 8(4): 621-632.
Briar-Lawson K, Lawson H, Hennon C, et al. 2001. Family-Centered Policies and Practices: International Implications. West Sussex: Columbia University Press.
Buchanan J M. 1950. Federalism and fiscal equity. The American Economic Review, 40(4): 583-599.
Colombo F, Llena-Nozal A, Mercier J, et al. 2011. Help wanted? Providing and paying for long-term care. http://dx.doi.org/10.1787/9789264097759-en[2012-02-10].
Cox D, Jakubson G. 1995. The connection between public transfers and private interfamily transfers. Journal of Public Economics, 57(1): 129-167.
CPP. 2017. China's Population Prospects Database. http://cpp. fudan.edu.cn[2021-03-10].
CSPI. 2016. We disclose the commandments placed on society by Islamic doctrine. Brno: CSPI.
Davis D S, Harrell S. 1993. Chinese Family in the Post-Mao Era. Berkeley: University of California Press.
DESA of United Nations. 2002. World Population Aging: 1950-2050. New York: UN Publications.
Eckert J K, Morgan L A, Swamy N. 2004. Preferences for receipt of care among community-dwelling adults. Journal of Aging & Social Policy, 16(2): 49-65.
Egger P, Koethenbuerger M, Smart M. 2010. Do fiscal transfers alleviate business tax competition? Evidence from Germany. Journal of Public Economics, (3/4): 235-246.
Esping-Andersen G. 1990. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Princeton University Press.

Feng Z L, Fennell M L, Tyler D, A, et al. 2011. The care span: growth of racial and ethnic minorities in US nursing homes driven by demographics and possible disparities in options. Health Affairs, 30(7): 1358-1365.

Frey C B, Osborne M A. 2017. The future of employment: how susceptible are jobs to computerisation?. Technological Forecasting and Social Change, 114: 254-280.

Glinskaya E, Feng Z. 2018. Options for Aged Care in China: Building an Efficient and Sustainable Aged Care System. Washington D.C.: World Bank.

Glosser S. 2003. Chinese Visions of Family and State, 1915-1953. Berkely: University of California Press.

Goode W. 1963. World Revolution and Family Patterns. New York: The Free Press.

Guo J, Konetzka R T, Magett E, et al. 2015. Quantifying long-term care preferences. Medical Decision Making, 35(1): 106-113.

Ikegami N, Yamauchi K, Yamada Y. 2003. The long term care insurance law in Japan: impact on institutional care facilities. International Journal of Geriatric Psychiatry, 18(3): 217-221.

Jackson R, Nakashima K, Howe N. 2009. China's long march to retirement reform: the graying of the middle kingdom revisited. Washington D.C.: CSIS.

Janssens A. 1993. Family and Social Change: The Household as a Process in an Industrializing Community. Cambridge: Cambridge University Press.

Keen M, Marchand M. 1997. Fiscal competition and the pattern of public spending. Journal of Public Economics, 66(1): 33-53.

Keenan T. 2010. Home and community preferences of the 45+ population. https://assets.aarp.org/rgcenter/general/home-community-services-10.pdf[2010-11-29].

Korinek A, Stiglitz J. 2017. Artificial intelligence and its implications for income distribution and unemployment. https://www.nber.org/papers/w24174.pdf[2018-01-17].

Lee R, Mason A. 2011. Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective. Cheltenham: Edward Elgar Publishers.

Lindert P. 2004. Growing Public: Social Spending and Economic Growth Since the Eighteenth Century. New York: Cambridge University Press.

Litwak E. 1960. Geographic mobility and extended family cohesion. American Sociological Review, 25: 386-394.

Macfarlane A. 1978. The Origins of English Individualism: The Family, Property and Social Transition. Cambridge: Cambridge University Press.

Mason A, Lee R. 2004. Reform and Support Systems for the Elderly in Developing Countries: Capturing the Second Demographic Dividend. Beijing: International Seminar on the Demographic Window and Health Aging: Socioeconomic Challenges and Opportunities: 1-20.

Midgley J, Tang K L. 2001. Introduction: social policy, economic growth and developmental welfare. International Journal of Social Welfare, 10(4):244-252.

Mishra R. 1984. The Welfare State in Crisis. Brighton: Wheatsheaf Books.

Modigliani F. 1986. Life cycle, individual thrift, and the wealth of nations. Science, 234(4777):

704-712.

Mokyr J, Vickers C, Ziebarth N L. 2015. The history of technological anxiety and the future of economic growth: is this time different?. Journal of Economic Perspectives, 29(3): 31-50.

Moroney R M. 1979. The issue of family policy: do we know enough to take action?. Journal of Marriage and the Family, 41(3): 461-463.

Nikitina O, Vorontsova G. 2015. Aging population and tourism: socially determined model of consumer behavior in the "senior tourism" segment. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 214: 845-851.

Oates W E. 1999. An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3): 1120-1149.

OECD. 2002. Governance for Sustainable Development. Five OECD Case Studies. Washington D.C.: OECD Publishing.

Orzechowska-Fischer E. 2004. Labour force ageing: its impact on employment level and structure-the cases from Japan and Australia. Canberra: A Paper Presented at the Australian Population Association's 12th Biennial Conference.

Osborne D, Gaebler T. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Boston: Addison-Wesley Publishing Company Inc.

Osborne S, Radnor Z, Nasi G. 2013. A new theory for public service management? Toward a (public) service-dominant approach. American Review of Public Administration, 43(2): 135-158.

Parsons T. 1943. The kinship system of the contemporary United States. American Anthropologist, 45(1): 22-38.

Perri 6, Leat D, Seltzer K, et al. 2002. Towards Holistic Governance: The New Reform Agenda. London: Red Globe Press.

Pifer A, Bronte L. 1986. Our Aging Society: Paradox and Promise. New York: W.W. Norton & Company.

Powell M, Boyne G. 2001. The spatial strategy of equality and the spatial division of welfare. Social Policy & Administration, 35(2): 181-194.

Putnam R, Leonardi R, Nonetti R. 1994. Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton: Princeton University Press.

Rowe J W, Kahn R L. 1997. Successful aging. The Gerontologist, 37(4): 433-440.

Sanderson W C, Scherbov S. 2005. Average remaining lifetimes can increase as human populations age. Nature, 435: 811-813.

Sanderson W C, Scherbov S. 2008. Rethinking age and aging. Population Bulletin, 63(4): 3-16.

Sanderson W C, Scherbov S. 2010. Remeasuring aging. Science, 329(5997): 1287-1288.

Savas E S. 2000. Privatization and Public-Private Partnerships. New York: Chatham House.

Scanzoni J. 1987. Families in the 1980s: time to refocus our thinking. Journal of Family Issues, 8(4): 394-421.

Scherbov S, Sanderson W C. 2016. New approaches to the conceptualization and measurement of age and aging. Journal of Aging and Health, 28(7): 1159-1177.

Schultz P. 2001. Population matters: demographic change, economic growth, and poverty in the

developing world. Journal of Economic History, 63(3): 889-890.

Shen K, Wang F, Cai Y. 2016. Patterns of inequalities in public transfers by gender in China. The Journal of the Economics of Ageing, 8: 76-84.

Siliverstovs B, Kholodilin K, Thiessen U. 2011. Does aging influence structural change? Evidence from panel data. Economic Systems, 35(2): 244-260.

Spijker J. 2014. Policy brief for flexible aging: new ways to measure the diverse experience of population aging in Scotland. Scottish Longitudinal Study Development & Support Unit, 3: 1-4.

Stock C, Ellaway A. 2013. Neighbourhood Structure and Health Promotion. New York: Springer.

Tullock G. 1965. The Politics of Bureaucracy. Washington D.C.: Public Affairs Press.

UNFPA. 2009. World Demographic Trends: Report of the Secretary-General. https://digitallibrary.un.org/record/647866[2010-01-13].

United Nations. 2007. World Population Prospects: The 2008 Revision. https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/un_2008_world_population_prospects-2008_revision_volume-ii.pdf[2008-09-12].

United Nations. 2017. World Population Prospects: The 2017 Revision. https://population.un.org/wpp/Publications/Files/WPP2017_DataBooklet.pdf[2017-10-25].

Wang F, Shen K, Cai Y. 2019. Expansion of public transfers in China: who are the beneficiaries?. The Journal of the Economics of Ageing, 14: 1-9.

Weeks J. 2011. Population: An Introduction to Concepts and Issues. 11th ed. Cambridge: Wadsworth.

WHO. 2002. Active Ageing: A Policy Framework. Geneva: WHO.

WHO. 2015. World Report on Ageing and Health. https://www.who.int/ageing/publications/world-report-2015/en/[2015-01-03].

WHO. 2018. The Global Network for Age-friendly Cities and Communities: Looking Back over the Last Decade, Looking Forward to the Next. Geneva: WHO.

WHO Regional Office for Europe. 2018. Age-friendly environments in Europe: Indicators, monitoring and assessments (2018). Copenhagen: WHO Regional Office of Europe.

Whyte M K. 2005. Continuity and change in urban Chinese family life. The China Journal, 53: 9-33.

Wiener J, Anderson W, Brown D. 2009. Why are nursing home utilization rates declining?. Report Prepared for the Centers for Medicare and Medicaid Services.

Wildasin D E. 1984. The welfare effects of intergovernmental grants in an economy with distortionary local taxes: a simple general equilibrium analysis. Journal of Public Economics, 25(1/2): 103-125.

Woirol G. 1996. The Technological Unemployment and Structural Unemployment Debates. Westport: Greenwood Press.

Wolff J L, Kasper J D, Shore A D. 2008. Long-term care preferences among older adults: a moving target?. Journal of Aging & Social Policy, 20(2): 182-200.

World Bank Group, PwC. 2017. Paying Taxes 2018. Washington D.C.: World Bank Group.

Xie J, Sreenivasan S, Korniss G, et al. 2011. Social consensus through the influence of committed minorities. Physical Review E, 84(1): 1-9.

Zeng Y, Feng Q S, Hesketh T, et al. 2017. Survival, disabilities in activities of daily living, and physical and cognitive functioning among the oldest-old in China: a cohort study. The Lancet, 389(10079): 1619-1629.

[General Information]
书名=中国老龄社会的治理与政策选择
页数=186
SS号=15031931

封面
书名
版权
前言
目录
第1章　对中国人口老龄化的再认识
1.1　人口老龄化的常态化
1.2　治理视角下的中国人口老龄化
第2章　老龄社会的治理理念与战略构想
2.1　反思老龄社会治理的研究困境
2.2　研究实践中的认知误区及偏差
2.3　应对老龄化的治理格局和战略思路转变
第3章　老龄社会的治理体系与政府角色
3.1　老龄社会治理特征及政府定位
3.2　中国老龄社会治理体系的发展
3.3　未来老龄社会治理的政府工作要点
第4章　老龄社会的中国家庭与家庭政策
4.1　当代中国家庭变迁与家庭政策
4.2　老龄化背景下的中国家庭发展困境
4.3　中国家庭养老的承载能力评价
4.4　老龄社会的家庭政策重构要点
第5章　老龄社会的社区环境与社区养老服务
5.1　社区环境对老年人的影响
5.2　老年友好型社区建设
5.3　社区养老服务体系的构建
第6章　老龄社会中的长期照护服务
6.1　老年长期照护需求的宏观变化趋势
6.2　我国老年长期照护需求的现状与问题
6.3　长期照护服务影响因素的实证研究
6.4　完善长期照护服务体系的对策建议
第7章　老龄社会的就业与消费形态变迁
7.1　老龄社会的劳动力结构格局
7.2　老龄社会就业形态的变迁与发展
7.3　老年消费新态势及家庭消费结构变化
7.4　老龄化背景下产业结构形态变迁及发展
第8章　养老公共服务资源配置的区域均衡
8.1　养老公共服务资源供给水平测度
8.2　养老公共服务资源供给的区域差异分析

8.3　区域养老服务资源的供需匹配分析
8.4　促进区域养老服务均衡发展的对策建议
第9章　中国老龄社会治理的政策选择
9.1　完善老龄社会的治理格局
9.2　战略部署要点及其政策选择
参考文献